

专科专病
名医临证经验丛书

风湿病

陶晓华 · 主编



人民卫生出版社

专科专病名医临证经验丛书

风 湿 病

主编 陶晓华

副主编 张银柱 孟凡红 李 锦

编写人员

陶晓华 张银柱 孟凡红 李 锦
邬洪波 王 琦 张 林 刘夕明
贾鹰珏 李 颖

141046 4 05

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

风湿病/陶晓华主编. —北京: 人民卫生出版社, 2001
(专科专病名医临证经验丛书)

ISBN 7-117-04657-0

I. 风... II. 陶... III. ①风湿病-中医学临床-
经验 ②风湿病-验方 IV. R259.932.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 088706 号

专科专病名医临证经验丛书

风 湿 病

主 编: 陶晓华

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph@pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

印 刷: 北京市安泰印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 **印张:** 12.75

字 数: 279 千字

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 00 001—3 000

标准书号: ISBN 7-117-04657-0/R·4658

定 价: 21.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

出版者的话

为了进一步抢救、挖掘、继承和发扬名老中医、著名中西医结合医学术思想和宝贵经验，不断提高中医、中西医结合诊疗水平，满足广大中医、中西医结合工作者学习需要和加强中医专科专病建设的要求，我社特组织全国有关专家学者编写了《专科专病名医临证经验丛书》。本丛书是在广泛收集近现代国家级和部分省部级名医临床诊疗经验和学术成果的基础上，经过精选、整理研究、汇编而成的系列丛书。该丛书共12个分册，包括呼吸病、心脑血管病、脾胃病、肝胆病、肾脏病、糖尿病、风湿病、血液病、肿瘤、妇科病、儿科病、皮肤病等分册。每一分册均包括两个部分，即疾病篇与方剂篇。其中疾病篇所选医家诊疗经验以病为纲，以人为目；每一疾病均按概述、名医经验、按语三部分来阐述。方剂篇所选医家诊疗经验以病为纲，以证为目，下分列临证有效的专病专方。本丛书作者均为长期在临床第一线从事相关专科专病医疗的工作

2 出版者的话

者，对名医的诊疗经验和学术思想学习理解颇深，故所收名医经验突出名医在诊疗疾病方面的独到之处，而不是面面俱到、泛泛而谈；其中也选录了少量对某一疾病有独到认识和经验的专家体会，以提高本书的实用性。按语是作者结合个人临证体会加以阐述，对名医辨证思维、遣方用药心得进行挖掘、归纳、提炼，指出各名医诊疗疾病的特点所在，语言精练，客观公允，具有画龙点睛的作用，以便于读者理解和掌握。该丛书资料翔实，内容丰富，重点突出，切合临床实际，为各科临床医生提高诊疗水平提供借鉴。本丛书所收病种一律采用西医病名，所选病种为中医或中西医结合治疗疗效好，有优势、有特色者。本丛书对各级中医和中西医结合医师、中医药大专院校师生、中医药专业研究生学习提高参考价值颇大。

人民卫生出版社

2001年10月

内 容 提 要

本书是《专科专病名医临证经验丛书》之一种，是一部汇集全国名中医诊治经验的中医风湿病临床专著。本书着重反映建国以来对风湿病病学造诣较深，长期从事中医风湿病临床工作的名中医的临床诊治经验。

全书分疾病篇和方剂篇。疾病篇以病种为目，共介绍了17种风湿病常见病、疑难病的名中医诊治经验；方剂篇也以病种为目，介绍了17种风湿病常见病、疑难病名中医屡试不爽、确有疗效的经验方药。

本书来自名中医临床经验之精华，既可丰富中医学风湿病中医文献宝库，又可进一步推进中医药学术之传播与发展，并可直接指导从事风湿病临床工作者临床实践，提高诊疗技术和水平。

编写说明

风湿病是一类病因复杂、病程漫长、颇易复发的常见病、多发病，治疗较为棘手，长期以来被列为疑难疾病之一。据初步调查推算，我国类风湿性关节炎患病率为0.3%~0.5%，强直性脊柱炎患病率为0.2%~0.4%，干燥综合征患病率为0.29%~0.77%，系统性红斑狼疮患者约1 000万~2 000万人。随着人民生活水平的提高和饮食结构的改变以及人口老龄化等社会问题的出现，我国在1亿老年人的庞大队伍中，骨关节炎患者至少在5 000万以上，痛风性关节炎亦日益增多。尽管80年代后中华医学会、中国中医药学会和中西医结合学会均相继成立了风湿病专业委员会，使我国风湿病的研究进展较快，并不断向纵深发展。但是，由于我国风湿病学研究起步较晚，基层医疗机构的诊疗水平普遍不高，加之风湿病常识的匮乏，导致患者乱求医、滥用药，造成患者抱病日久，重者终生残疾，丧失劳动力甚至威胁生命的现象时有发生，给家庭和社会带来沉重负担。

中医对于风湿病的研究，源远流长，积累了精辟的理论和丰富多彩的防治方法。两千多年来，无数医家对其病因病机 and 治疗方法等进行了广泛深入的探讨，并积累了许多独特而有效的经验。如《黄帝内经》有“痹论”专篇，《金匱要略》有“中风历节病脉证并治”专篇，其中的“历

节病”和现代风湿病临床症状极为类似。书中还提出了“风湿”之名，在“痉湿喝病脉证并治”篇中指出：“病者一身尽疼，日晡所剧者，名风湿……。”尤其自20世纪80年代我国医药界相继成立中医及中西医结合风湿病学科体系后，随着理论研究的开展和临床实践的深入，诊疗水平不断提高，出现了一批令人瞩目的成果、著作。中医药治疗风湿病以其疗效好、副作用小、方法简便易行而倍受青睐，在风湿病的防治中越来越显示出其优势。

建国后，随着中医药整体事业的健康发展，在中医药防治风湿病方面亦诞生了许多著名的医家。他们通过自己多年的探索，在中医药理论和临床方面均作出了很大的贡献。大凡名医治病，都是以中医理论为指导，在继承前人经验基础上，通过家传、师授和本人的不断探索、长期实践，形成了具有不同特点的诊疗方法，这决不是一般年轻人在数年或十数年间所能做到的。因此继承和学习名中医临床经验，博采众长，吸取精华，不断提高医疗水平，更好地为人民健康服务，是当前发展中医药学术的重要内容之一。

除少数专著之外，当今众多名医诊治风湿病的丰富经验多散见于报刊杂志之中，披阅既难，选取掌握运用尤为不易。有鉴于此，我们组织北京中医药大学的有关教师、科研人员、临床医生在广泛搜集风湿病研究资料的基础上，编写了这本《专科专病名证经验丛书·风湿病》，以奉献给从事中医和中西医结合风湿病医疗、教学、研究的医界同仁和所有热爱风湿病防治事业的人们。由于编者水平有限，书中肯定存在遗珠之憾甚或错误之处，敬希读者鉴谅。在此并对本书所摘引文献资料的原作者表示衷心的感谢！

北京中医药大学 陶晓华

2001年11月22日

目 录

疾 病 篇

类风湿性关节炎	1
风湿性关节炎	50
强直性脊柱炎	57
痛风	78
系统性红斑狼疮	89
系统性硬皮病	107
血栓闭塞性脉管炎	116
腰椎间盘突出症	133
坐骨神经痛	139
白塞病	152
大动脉炎	164
干燥综合征	176
骨坏死	198
过敏性紫癜	213
肩关节周围炎	231
颈椎病	238
雷诺综合征	248

方剂（药）篇

类风湿性关节炎	260
风湿性关节炎	276
强直性脊柱炎	285
痛风	297
系统性红斑狼疮	303
系统性硬皮病	311
血栓闭塞性脉管炎	316
腰椎间盘突出症	326
坐骨神经痛	330
白塞病	340
大动脉炎	345
干燥综合征	348
骨坏死	355
过敏性紫癜	360
肩关节周围炎	375
颈椎病	381
雷诺综合征	393

疾 病 篇

类风湿性关节炎

【概述】

类风湿性关节炎（简称“类风关”或 RA），是一种以关节和关节周围组织的非感染性炎症为主的全身性自身免疫性疾病。如果及其它脏器，可引起心包炎、心肌炎、间质性肺炎、肾淀粉样变以及眼部疾患（如巩膜炎、虹膜炎），还可并发血管炎以及末梢神经损害等，因此又称作类风湿病。其关节症状特点为关节腔滑膜发生炎症、渗液、细胞增殖、血管翳（肉芽肿）形成，软骨及骨组织破坏，最后关节强直，关节功能丧失。任何年龄均可发病，以 25~55 岁最常见，女性发病率高于男性，男女发病率之比约为 1:3.5。

本病典型的临床表现为反复发作的、对称的多发性小关节炎。以手、腕、足、膝等关节最常受累。早期可有红、肿、热、痛及关节功能障碍，晚期关节可出现不同程度的强直和变形，并有骨腐蚀和骨骼肌的萎缩。本病常为对称性，呈慢性过程，发作与缓解交替，对人体消耗大，致残率

高。由于全身多系统受损，又认为它是一种免疫系统调节紊乱所致的炎症反应性疾病。也属结缔组织疾病，是典型的胶原性疾病之一。

本病属于中医“痹证”。多由于人体正气不足，气血不盛，腠理疏豁，致使风寒湿三气合而为痹。若素体阳虚，风寒湿三气侵袭机体，阻滞经络，多发为寒湿痹。若素体阴虚，阴虚火旺，与外邪相搏，损伤肝肾之阳气，筋骨失于濡养，或风寒湿久而化热，烁津为痰，痰湿壅滞关节，灼伤经络，发而为痹，名之为风湿热痹。痹证日久深入血络，瘀血与痰浊相互胶结，侵入人体筋骨可形成瘀血痹。又因为本病可损及多系统，故近年来统属于“痹病”范畴之中。不少学者认为本病更近似于“历节病”，或改称“顽痹”、“尪痹”，以区别于其他痹证。

【名医诊治经验】

1. 朱良春诊治经验

(1) 益肾壮督：对于痹证的治疗，经过五十年的临床探索，从创制舒络合剂开始，发展为蠲痹通络丸，最后成熟于益肾蠲痹丸，使痹证（特别是顽痹）的治疗，有了较大的进展。其中最重要的一点，就是通过益肾壮督，提高机体抗病能力，使正胜邪却；另一方面，蠲痹通络之剂，多辛温宣散，走而不守，药力难以持久。通过益肾壮督，使药力得以加强，药效得以延长，从而发挥了最佳的治疗作用，使治疗效果有了很大提高。益肾壮督包含两个涵义：一是补益肝肾精血，二是温壮肾督阳气，阴充阳旺，自可驱邪外出。

(2) 妙用虫药：临床经常使用虫药，治疗顽痹更是如此，痹证日久，邪气久羁，深经入骨，气血凝滞不行，变生痰湿瘀浊，经络闭塞不通，非草木之品所能宣达，必借虫蚁之类搜剔窜透，方能浊去凝开，气通血和，经行络通，深伏之邪除，困滞之正复。虫类药的临床应用，除应注意各药的特性以发挥其特长外，还必须掌握辨证论治的原则，善于与其他药物密切配合，同时还要注意炮制、用量、服法等。常选用咸温之蕲蛇（或乌梢蛇）祛风通络，寒湿甚者，并配以川乌、苍术、桂枝、蚕沙；化热者，用地龙，并配以寒水石、萆薢；夹痰者，用僵蚕，并配以胆南星或白芥子；夹瘀者，用地鳖虫，并配以桃红、红花；痛甚者，用全蝎或蜈蚣（每日 3g，研末分 2 次吞服），并配以玄胡或乌头；关节红肿热痛者，用羚羊粉或山羊角，配以忍冬藤、透骨草；关节僵肿变形者，合用蜂房、僵蚕、蜣螂虫；背部剧烈疼痛，因气滞不行者，用九香虫温阳理气，配以葛根、秦艽；病变在腰脊者，合用乌蛇、蜂房、地鳖虫，并加入川断、狗脊。背脊强直而痛，伛偻驼背者，用鹿角片、乌梢蛇壮肾通督，并配以鹿衔草、骨碎补；经脉拘挛活动不利者，用穿山甲通经舒挛，并配以苏木、伸筋草。另外，其他动物药也常采用，如用紫河车填精补髓；鹿角通利督脉；穿山甲治疗拘挛疼痛忽作忽止；水牛角配赤芍、丹皮治疗环形红斑或皮下结节等。

(3) 顽痹证治：顽痹一般分为五型，即风寒湿痹证、郁久化热证、痰瘀阻络证、瘀热浊毒证、肾督亏虚证。

① 风寒湿痹证：症见全身关节或肌肉酸痛，游走不定，得温痛减，气交之变增剧，关节肿胀，但局部不红不热，苔薄白，或薄白腻，脉沉细，或细弦，或濡细。治以祛风散寒，除湿通络。药用：制川乌 10g（先煎），桂枝 10g

(后下), 仙灵脾 15g, 鹿衔草 30g, 当归 10g, 熟地 15g, 炙乌蛇 10g, 甘草 6g。

风盛者加寻骨风 20g, 或钻地风 20g; 寒盛者加制草乌 10g, 或熟附片 10g; 湿盛者加生熟薏仁各 5g, 或苍、白术各 10g; 痛甚者加炒玄胡 15g, 或炙全蝎 3g 研末吞服; 关节肿胀明显者加炙僵蚕 10g, 或蜂房 10g。

②郁久化热证: 症见四肢关节肿痛, 局部灼热, 初得凉颇舒, 稍时仍以温为适, 口干而苦, 舌质红, 苔薄黄, 或黄腻, 脉细弦, 或微数。治以辛通痹闭, 清化瘀热。药用: 制川乌 8g, 桂枝 8g (后下), 当归 10g, 生地 15g, 白芍 20g, 知母 10g, 忍冬藤 30g, 广地龙 12g, 炙僵蚕 12g, 乌梢蛇 10g, 甘草 6g。

痛剧者加蜈蚣 3g 研末吞服, 或六轴子 2g; 关节焮红肿热者加黄柏 10g, 晚蚕沙 10g (包煎); 有环形红斑及皮下结节者加水牛角 30g, 丹皮 10g。

③肾督亏虚证: 症见身体羸瘦, 汗出怯冷, 腰膝酸软, 关节疼痛, 反复发作经久不愈, 筋挛骨松, 关节变形, 甚至尻以代头, 脊以代踵, 苔薄质淡, 脉沉细软弱, 治以益肾壮督, 蠲痹通络, 药用益肾蠲痹丸: 生熟地各 150g, 全当归 100g, 鸡血藤 200g, 仙灵脾 100g, 鹿衔草 100g, 淡苡蓉 100g, 炙乌蛇 100g, 炙全蝎 20g, 炙蜈蚣 20g, 炙蜂房 100g, 炙僵蚕 100g, 蜣螂虫 80g, 广地龙 100g, 地鳖虫 100g。共研细末, 另以老鹳草 120g, 徐长卿 120g, 苍耳子 120g, 寻骨风 120g, 虎杖 120g, 甘草 30g, 煎浓汁泛丸, 如绿豆大, 每服 6~8g, 日服 2 次, 食后服, 妇女经期或妊娠忌服。阴虚咽干口燥者, 另加生地 10g, 麦冬 10g, 石斛 10g, 泡茶饮服。

分型论治最忌死搬硬套, 刻舟求剑, 因为人有异禀,

病有殊变，证可兼夹，型可分合，所以在临床上，既要有高度的原则性，又要有灵活性，因人因证，或一法独用，或两法兼施，才能得到理想的治疗效果。如肾督亏虚证，不是痹证晚期才可出现，而是存在于疾病的初、中、末各期，以及各型之中，只不过证情轻重有异，治疗主次有别而已。临床上既需分型而治，又要灵活多变，随证加减用药。

(4) 辨证与辨病：临证时将两者结合起来，把现代医学理化检查指标借用过来作为诊断时的参考依据，并且在辨证论治的前提下，对某病加用一些具有针对性的药物进行治疗，如类风湿性关节炎属自身免疫性疾病，常用仙灵脾、露蜂房来调节机体免疫功能，同时对偏寒湿型者，用川乌、桂枝；偏湿热型者，用寒水石、虎杖，来降低血沉、抗“O”、粘蛋白三项指标，使之恢复正常。

朱氏通过长期实践，明确指出：类风湿性关节炎久治不愈者，既有正虚的一面，又有邪实的一面；且其病变在骨质，骨为肾主，故确定益肾壮督以治其本，蠲痹通络以治其标。组方用药时，又强调“虫蚁搜剔，钻透驱邪”的特性，集中使用，有协同加强之功。故特立益肾蠲痹丸，由熟地黄、仙灵脾、鹿衔草、淡苡蓉、全当归、蜂房、蕲蛇（缺时可由乌梢蛇代）、地鳖虫、僵蚕、蜣螂、炮山甲、全蝎、蜈蚣、广地龙、甘草等组成，共研极细末，泛丸如绿豆大，每服6g，1日2次，饭后服。

本方除选草木之品以补肾强本之外，又藉虫类血肉有情之品搜风逐邪，散瘀涤痰，标本兼顾。经临床系统观察，发现该丸对类风湿性关节炎的疗效比较满意。平均服药1~2周后关节疼痛开始减轻，一月后关节肿胀开始消退，活动度增大，功能得到相应的改善或恢复。如坚持服用3~6

个月者，可以达到病情稳定，基本治愈。凡间断服药，或症状缓解后过早的停药者，其疗效则不稳定，说明必须坚持服药，不可间断。对长期服用水杨酸制剂、消炎痛、激素等药物的患者，改服本丸后，可以逐步递减，直至撤除。长期服用此丸后，患者普遍反应食欲增加，精神振奋，体质增强，有转弱为强之功。

此丸服用后一般无副作用，仅少数患者服后胃脘嘈杂，嘱在饭后服用，症状即趋消除。对偏阴虚、偏湿热者服后有口干、咽燥现象，加用沙参、麦冬、石斛各 10g 代茶泡服后，可以改善。个别患者服后有肤痒或皮疹现象，乃动物异体蛋白质过敏现象，另用徐长卿 15g，地肤子 30g 煎汤服用即可消除。

临床观察发现，益肾蠲痹丸治疗类风湿性关节炎疗效好、奏效快、价格廉（每日只需 0.25 元），服用方便，无毒副作用，是目前治疗类风湿性关节炎较为理想的药物之一。

益肾蠲痹丸是朱良春根据数十年的临床实践而总结出来的治疗“顽痹”的有效处方，具有温阳、益肾、壮督、增强机体免疫功能、调整骨质代谢的功效。方中侧重运用虫类搜风之品，以达到抗炎、消肿、止痛之功。研究表明，益肾蠲痹丸能使滑膜组织炎症减轻，胶原纤维沉着减少，软骨细胞增生修复，对实验性痹证有较好疗效。^{[1],[2],[3],[4]}

2. 焦树德诊治经验

焦氏根据有关中医典籍的论述，经多年研究，创立了“尪痹”病名，并进行了系统研究。

（1）病名：尪即指胫曲不能伸，关节肢体弯曲变形，骨质受损，身体羸弱等废疾而言。即张仲景《金匱要略》

中所说“诸肢节疼痛，身体尪羸”之意。焦氏提出的“尪痹”之名，补充了历代之不足，使中医学的痹证理论渐趋完善。

(2) 病因病机：尪痹乃痹病之一，具有痹病共同的病因病机，即“风寒湿三气杂至合而为痹也”。此外，还具有与其他痹病不同的特点：①寒湿之邪深侵入肾。由于先天禀赋不足，或后天失养，房室过度以及妇女月经病、产后而致肾虚，如三邪侵入寒湿偏盛，则寒湿之邪与肾同气相感，乘虚深袭，入肾入骨，痹阻经络，血气不行，关节闭涩，肾不荣肝，筋乏淖泽，筋骨失养，渐成筋挛骨松，关节变形不得屈伸，终成废疾。②冬季受邪，寒湿入肾，肾气旺于冬，寒为冬季主气，冬季感受三邪，肾先应之，邪气伤肾入骨，致骨重不举，酸削疼痛，久而关节肢体变形，渐成尪羸。③痹病久而不愈，复感三邪，致寒湿深侵。痹久不愈，恰值冬春寒冷之时，复感三邪，寒湿偏盛，内舍所合之肾肝二脏，筋骨同病，其人尪羸，难以行走。由此可见尪痹的发病特点主要是寒湿偏盛深侵入肾，骨质受损，关节变形。三邪未侵入肾者，虽久痹不愈也不会使骨质受损变形。所以尪痹的发病机理较风、寒、湿、热诸痹更为复杂，病邪更为深入，症状更为严重，常波及于肝肾致骨损筋挛肉削。且病程绵长，寒湿、贼风、痰浊、瘀血互为交结，凝聚不散，遂使病情不断加重。

临床上，属于“尪痹”范围的强直性脊柱炎患者以青年男性为多，而类风湿性关节炎的发病则以女性为多见。焦氏认为，尪痹发病之关键在于风寒湿邪入肾伤骨。而女性的经、带、胎、产皆与肾、肝、冲任二脉相关。经、带、胎、产常可伤肾，所以三邪乘虚而入的机会比男子多，且女性属阴，同气相求，故类风湿性关节炎女性发病率高于男

性。督脉督一身之阳，在腰部与肾相连，青年男性常常过劳伤肾，或房劳伤肾，督脉受损，复感寒湿，在脊强直。因而强直性脊柱炎的发病率青年男性为高。

(3) 辨证论治

①临床证候：尪痹除具有风寒湿痹共有的症状如关节疼痛、肿胀、沉重及游走性窜痛等外，还具有病程长、疼痛剧烈、痛发骨内、骨质受损、关节变形、僵直蜷挛、屈伸不能的特点。因病邪深侵，久病入血，血属阴，寒湿之邪亦属阴，故本病多在夜间疼痛剧烈，临床上多见沉弦、弦滑、沉弦滑等脉象；因肾虚为病之本，故有70%左右的痹证患者，表现出尺脉弱小。临床上尪痹常见三种证候（即肾虚寒盛证、肾虚标热轻证、肾虚标热重证）。

②治疗原则：补肾祛寒为主，辅以化湿散风、养肝荣筋、活瘀通络。若出现邪欲化热之势，则减少燥热之品，加用苦坚清润之品；若出现化热之证，则暂以补肾清热法治其标热，待标热得清后，再渐转为补肾祛寒之法治其本。另外，还要注意调护脾胃以保后天之本。

③处方用药

补肾祛寒治尪汤：适用于肾虚寒盛证。本方从《金匱要略》桂枝芍药知母汤合《和剂局方》虎骨散加减化裁而成。方中用川断 12~20g，补骨脂 9~12g，熟地黄 12~24g，制附片 6~12g；此为补肾祛寒、填精补血、滋养肝肾、强壮筋骨的主药。用骨碎补 10~20g，淫羊藿 9~12g，狗骨 30g（代炙虎骨），白芍 9~12g，桂枝 9~15g，独活 10~12g，威灵仙 12~15g；此为助肾阳、壮筋骨、散风寒、通经络、缓急舒筋的辅药。用防风 10g，麻黄 3~6g，苍术 6~10g，知母 9~12g，炙山甲 6~9g，伸筋草 30g，赤芍 9~12g，松节 15g，地鳖虫 6~10g；此为散风寒、祛

湿浊、活血化瘀、通经散结、舒筋活络、滋肾清热的佐药，更以牛膝 12~18g 为强筋骨、散瘀血、引药入肾肝的使药。

如上肢病重者，去牛膝加片姜黄 9~10g，羌活 9~10g；瘀血明显者，加血竭 0.7~0.9g（分冲），或加活血止痛散 1/3 管冲服，或加制乳香、没药、皂刺各 6g，或加红花 10g，或加苏木 15~20g；腰腿痛明显者，去松节、苍术，加桑寄生 30g，并加重川断、补骨脂用量，且随汤药嚼服炙胡桃肉 1~2 枚；肢体关节蜷挛僵屈者，去苍术、防风、松节，加生薏米 30~40g，木瓜 9~12g，白僵蚕 10g；脊柱僵弯者，可去牛膝、苍术，加金毛狗脊 20~40g，僵蚕 6~12g，鹿角胶 9g（烊化）；关节疼重者，加重附片用量（15g 以上时需先煎 20 分钟），并加草乌 6~9g，七厘散 1/3 管随药冲服；舌苔白腻者，去熟地加砂仁 3~5g，或加藿香 10g；脾虚不运，脘胀、纳呆者，去熟地加陈皮、焦麦芽、焦神曲各 10g，或加千年健 12~15g；有低热，或关节发热者，减少桂枝、附子用量，去淫羊藿、苍术，加黄柏 10~12g（须黄酒浸 3~4 小时，取朱丹溪“潜行散”之意），地骨皮 10~12g，或知母加至 12~20g，或加秦艽 15~30g。

加减补肾治痹汤：适用于肾虚标热轻证。肾虚寒盛证经过治疗和休养后阳气渐振，部分邪气有欲化热之势，则会出现肾虚标热之证。此时应在补肾祛寒治痹汤中减去温燥之品（即制附片 3~5g，桂枝 6~9g，麻黄 2g）；若汗多者可以去掉麻黄、熟地、淫羊藿、苍术、防风、松节，加入苦以坚肾，活络舒筋之品（即加生地 15~20g，酒浸黄柏 12g，忍冬藤 15~30g，络石藤 20~30g，红花 9~10g，桑寄生 30g，生薏米 30g）；但方中仍需保留川断、补骨脂、

骨碎补、知母、赤芍、白芍、独活、威灵仙、炙山甲、地鳖虫、伸筋草等补肾、祛风寒湿的治本之药。

补肾清热治痿汤：适用于肾虚标热重证。本方为急则治其标热之邪的暂用方剂。方中用川断 15g，骨碎补 15g，生地 15~20g，知母 12g，炒黄柏 12g，地骨皮 10g，赤芍 12g 为补肾清热的主药；以桑枝 30g，秦艽 20~30g，忍冬藤 30g，络石藤 30g，蚕沙 10g，威灵仙 15g 为清热、祛风、除湿、通经络的辅药；以羌、独活各 6~9g，白僵蚕 9g，制乳、没各 6g，地鳖虫 9g，红花 10g 为祛风胜湿除僵、活血散瘀、解痉散结的佐药；用透骨草祛风除湿，引诸药深透骨中搜剔入骨之邪气。待标热之邪清除后，仍以补肾祛寒法为主治本收功。

焦氏还强调：①因虎骨现为禁用之品，常以狗骨 30g，或透骨草 15~20g、寻骨风 15g，自然铜 6~9g 合用来代替。②痿痹病情严重，病程长，只要辨证无误则应坚持服药，可把汤药 4~5 剂共研细末，每日 3 次，每次 2~3g，用温黄酒，或酒水各半，或温开水送服，以便长期服用，巩固疗效。^[3]

3. 姜多峰诊治经验

(1) 病因病机：在前人认识的基础上，概括为“虚”、“邪”、“瘀”三个字，并提出“瘀血”也可致痹。临床所见之痹证，三者是紧密联系，相互影响，往往是不可分割的。就病因而言，邪是致痹的外因，虚、瘀则是致痹的内因，外因通过内因才能起作用。

(2) 临床体会：

①辨证

根据痹痛的性质、部位，辨病邪之偏胜：以痹痛性质

辨：疼痛呈游走性、放射性、闪电样者多属风邪偏胜；痛有定处，疼痛剧烈，局部欠温，遇暖则舒，多属寒性偏胜；疼痛重着，属湿。

以疼痛的部位辨：上肢、全身多个部位疼痛多属风邪偏胜；下肢疼痛多属湿邪偏胜；腰部冷痛多属寒邪偏胜；局部疼痛不移多属瘀血。

也有人主张根据初感病邪的外界因素，辨邪之偏胜者，似属欠妥。

根据病史、兼证，定虚实及瘀血：痹证，新病多实。实者，往往发病急，早期正气尚盛，脉有力。久病多虚。虚者，往往遇劳累即发。有外伤史，局部皮色紫暗，或痹证反复发作，经久不愈，关节僵硬，肿大变形，皮肤甲错，舌质紫暗，或有瘀斑，脉弦涩，夜痛甚者属瘀血。

以上所述征象，均属痹证虚、邪、瘀的典型证候。但是根据临床长期观察，多难各证悉具。例如，病初很少见虚象；瘀血除疼痛外，其它特征也见之不多；即使明显属风痹、寒痹、湿痹，一些患者也难自述清楚孰之偏胜。这是因为痹证的病变部位重点在肌表、经络、筋骨，未直接涉及脏腑；或病程长久，正邪在体内几经变化之故。因此，临床要谨守病机，把握特征，结合兼证，辨证施治。

②施治：在守法施治的同时，用药应注意以下三方面：

祛邪、活血，勿忘益气养血：气血运行于经脉之中，为人体重要的营养物质。痹证病邪久恋，往往导致气虚血瘀。另外，治痹之药多辛燥，过服则耗气劫血……临床多选用既能祛邪活血，又有养血功能之药；如当归、丹参、鸡血藤等。血虚者加白芍；阴血亏虚者，重用生地。此增水行舟，既缓急止痛，又制诸药之辛燥。若一味祛邪活血，轻视益气养血，临床疗效多难理想，甚则愈治愈重。故祛

邪、活血，应重视益气养血。

正气尚可，宜大剂驱邪：治痹证，对正气尚可者，宜大剂驱邪（先小量，渐增大量。因病人禀赋不同，对药物耐受、反应各异。不可骤用大量，以防药物反应）。其道理在于痹证病变部位在肌肤经络，小剂小调，难达病所；痹证为病邪、瘀血阻闭，临床常须应用大剂，经络血脉方能通达；痹证患者疼痛为主要痛苦，缓解疼痛为当务之急，小量微剂，多难速解痛苦；新病初得，正胜邪实，宜速用大剂将邪驱出，否则邪久恋必伤正，使疾病缠绵难愈。

临床选用大剂，个别患者首次服用可出现轻微的胃肠道反应，此和体质有关（因胃肠骤不耐受之故），一般3剂之后即可适应，反应多能消失。若不消失者，可改为饭后服药。

辨证既确，有方有守：痹证非同急暴之病，其病势多相对稳定，病理变化、证候演变一般较慢，尤其久病患者，治疗时即使方药对证，初投也不一定必见效果。个别患者，初服几剂，反而可出现症状加重。此乃药达病所，正邪相搏之佳象。若医者不明病变之规律，加之患者要求速效，必改弦易辙，使前功尽弃。但是，守方决不是死守不变，证变而药应随更，切忌“刻舟求剑”。

类风湿性关节炎病至Ⅲ期，关节畸形、骨损筋缩，多数人认为此时瘀血顽痰凝结，以虫类药搜风剔络，破瘀除痰为主要治则。

根据临床所见，病之Ⅲ期的治疗指导思想为改善症状，提高生存质量。所以除个别患者体质尚可，适当选用虫类攻逐药外，主要当扶正固本。该用当归、丹参、鸡血藤活血养血药为主，辅以炒山甲行血止痛；独活、千年健、木瓜、桂枝、川牛膝为祛风除湿散寒之平剂，祛邪而不伤正。

气。陈皮、甘草为佐使。使该方养血活血，调痹通络，缓缓调之，收效确佳。^{[6]、[7]}

4. 王为兰诊治经验

(1) 病机与基本法则：基本病变是“瘀”，基本病机是“闭”，“瘀”、“闭”均有寒热虚实。寒热是病性，虚实定病情。虚包括气血、阴阳、津精之不足；实包括内寒、内热、内风、气滞、血瘀等的出现。因此，“通”是治疗类风湿性关节炎之基本法则。要有针对性的通，寒凝者要温而通之，热结者要清而通之，虚闭者要补而通之，实坚者要攻而通之。

(2) 辨证分类治则

①寒凝：王氏善用辛温大热的麻、桂、乌、附、细辛等以达散寒除痛的目的。他认为：寒凝之痹痛非大剂量辛温药物不能胜其寒，如离照当空，则寒凝自化。但此类药性偏燥，有伤阴耗气之弊。故王氏用生芪以补之，白芍酸寒以缓之，甘草以和之。如此不但温经散寒之力强，而且燥烈之性去，使寒邪得除，络脉通行，气血调和，痹通痛消。

②热结：常见于类风湿性关节炎早期或中、晚期，是急性发作，在治疗上王氏十分重视养阴清热止痛法，用自拟养阴清热祛湿汤（桑枝 15g，银花藤 15g，青风藤 15g，土茯苓 15g，白鲜皮 20g，粉丹皮 10g，生地 30g，葛根 15g，半枝莲 15g，虎杖 15g，白花蛇舌草 15g，人工牛黄 1g（分冲）治疗，疗效颇著。

③实坚：此类证型王氏以法半夏、胆南星、炒山甲、天竺黄、海藻、皂刺、夏枯草、生牡蛎等药燥湿化痰，软坚散结；当归、桃仁、红花、丹参、赤芍、川芎、三棱、

莨菪、水蛭等活血、化瘀通络、养血；并配伍虫类之品如全蝎、蜈蚣、僵蚕、地龙等镇痉止痛，搜剔络邪。但值得注意的是，此类药多辛温，不宜多用久服，否则会耗气伤阴，加速关节僵直畸形。此期除治痰、治瘀外，必须重视扶正。

④虚闭：本证型包括气血虚、阴虚、阳虚等。若病久不愈，邪侵入里，致使肝肾不足，气血亏损，经脉痹阻，而致遍身关节隐隐作痛，四肢麻木，体酸无力，关节僵直，功能丧失，苔薄白，舌质淡，脉沉细。治法当以补气养血，通经活络，补益肝肾。王氏常用当归、白芍、阿胶、首乌、二地、枸杞子、菟丝子、川断、杜仲之类养血补肝肾；生芪、太子参、党参、白术、云苓健脾益气；鸡血藤、络石藤、海风藤、忍冬藤、秦艽、丹参、赤芍等通经活络。血充痛自除，经通痹自消。王氏告戒说：凡风湿痹，切忌风药频投。因风药燥血，虚闭用燥药必造成血虚络涩、疼痛不止。^[8]

此外，王氏诊治类风湿关节炎还注意如下几方面的问题：

①重视营卫气血在痹证中的作用：王氏认为痹证的整个发病过程中均伴有气血失调现象。如痹之初起由外邪引起者，除关节疼痛、肿胀等症状外，多伴有营卫失调，故治疗上，除根据病情予疏风、散寒、除湿、清热、通络止痛外，多用调和营卫之剂，首选方剂桂枝汤，其应用率甚高，而气血辨证则贯穿于痹证的各个时期。气血是人体重要的组成部分，运行全身，无处不到，以滋养全身，维持脏腑、经络、关节、肌肉的功能活动，痹证中的各种临床症状，如：关节疼痛、肿胀、麻木、屈伸不利、红斑、结节等，均与气血失调有很大的关系。其病机多为：气血两

虚、气虚血瘀、气滞血瘀、寒凝血脉、热伤血络、气虚湿阻、瘀血化热等。常用方剂：黄芪桂枝五物汤、桃红四物汤、四物汤、四君子汤、当归补血汤、防己黄芪汤、身痛逐瘀汤、通脉四逆汤。临床上王氏将调和气血应用于治疗痹证的全过程，成为痹证治法的重要内容。

②久痹、顽痹从脏腑论治：痹证日久不愈，或晚期病人，主要表现为阴阳的偏衰及脏腑的虚损和功能失调，故当从脏腑论治。其中以肝、脾、肾三脏最为密切。肝藏血、主筋、体阴而用阳，肝血不足不能荣养筋脉及四末，则出现四肢麻木、疼痛，血虚生风则关节疼痛日久，走窜不定，治疗当以养血柔肝法。王氏以此法为主加减治疗各种神经痛，多收止痛之效。脾居中焦，主运化，主四肢肌肉，若脾虚生化无源可致气血两虚；脾虚失运，水湿不化，湿浊内聚，痰饮内生，流于四肢关节，引起关节疼痛、重着、晨僵，关节肿胀等病证，治疗当以健脾益气养血及健脾利湿为主，临床均伴有面色苍白、纳差、周身乏力，或便溏、舌淡有齿痕，脉沉细，或沉缓。肾居下焦，主藏精，为人体元阴元阳之根本，肾精不足，根本不固，最易感邪为痹，也是某些特殊病变发生的根本原因。王氏经过临床观察及治疗，提出了强直性脊柱炎是以肾精不足为发病基础，以补肾填精、强壮筋骨、通调督脉，系统治疗百余例，疗效显著。痹证晚期不同程度上都有阴阳失调的表现。是以肾阴、肾阳为基础的。肝肾同居下焦、精血互生，临床多表现为肝肾阴虚，阴虚内热，见关节疼痛以夜间为著，不恶寒或有灼热感，屈伸不利，骨节刺痛，关节变形，低热，消瘦乏力，治疗以补肝肾为主；若肾阳不足，阳虚阴盛，寒凝血脉，痰浊内生则关节肿痛，畏寒怕冷，腰膝冷痛，活动不利，舌淡苔白滑，脉沉弱，治疗当温肾助阳。肾阳

不足，脾阳亦虚，阴损及阳，阳损及阴。痹证晚期肝、脾、肾三脏俱虚，筋骨失养，而关节变形、屈伸不利、骨质疏松、活动障碍等。其具体病情各有侧重，如：类风湿性关节炎中晚期非急性发作期，王氏分三型治疗，阴虚内热型、阳虚寒湿型、寒热错杂型；老年性骨关节病以补肝肾为主治疗；慢性腰腿痛从肾论治；而慢性风湿性关节炎多从脾肾入手；强直性脊柱炎用益肾通督法治疗。常用药物：养血柔肝多用白芍、当归、何首乌、熟地、鸡血藤；健脾多以苍术、白术、黄芪、炒薏米、陈皮；补肾多用鹿角胶、鹿角霜、仙灵脾、狗脊、桑寄生、女贞子、旱莲草、山萸肉、牛脊骨、猪脊髓等，充分体现了久痹、顽痹从脏腑辨证为主的治疗思想。^[9]

5. 盛国荣诊治经验

盛氏临证擅长应用虫类药物，精思妙悟，不拘一格，独具匠心，并积累了丰富的经验。如对痹证的治疗，他在辨证论治的基础上加入虫类药物。如蜈蚣、全蝎、蕲蛇、地龙等等，运用得心应手，疗效倍增。盛氏说：“虫类诸药，多具有搜风剔邪，通络祛瘀之功。善能推陈出新，活血祛瘀，改善气血循环而达到愈病的目的，远非一般草木之药所能比拟。”在治疗本病时，常配合赤芍、川芎、当归等养血和营之药，意寓于“治风先治血，血行风自灭”之义。痹证初病在经，久病入络，可用活血祛瘀加虫类药物治之，此乃对实证而言，是常。盛氏认为，虚证只要用之得法，配伍得宜，同样可以收到如期效果。以归芍养血、黄芪益气基础上加川芎、乳没活血祛瘀，配蜈蚣等祛风通络这是变。一般以虫类药物治疗痹证有中毒之虑，不敢重用多用，而盛氏掌握“常”与“变”，常同时并用二、三

味，量重效著。他认为：蜈蚣辛温入肝经，性善走窜，有搜风定搐、治病疗惊、消散肿毒等作用，敷治一切外证。他的经验，蜈蚣不去头足，以毒攻毒，须药病相当，权衡轻重。若发生中毒者，可用蚯蚓、桑皮煎汤服而解。^[10]

6. 吴志成诊治经验

治疗方法，采用经过选择和品种鉴定的野生拟黑多刺蚁（也称鼎突多刺蚁 *poeyrhachis Vieina Roger*）为君药（占 50%~70%），佐以老鹳草、七叶一枝花、秦艽、穿山龙、白术、千年健、牛膝等中药制成蚂蚁类风湿灵 1 号散剂；纯蚂蚁粉佐以炮山甲、全蝎、蜈蚣、白花蛇、三七、狗脊等中药制成蚂蚁类风湿灵 2 号胶囊；在 2 号基础上加制川乌、制草乌制成蚂蚁类风湿灵 3 号胶囊。

一般以 1 号为基本方，成人每次 5g，每日 3 次，饭后用温开水冲服，对胃肠功能减弱者加适量蜂蜜，儿童及老人量酌减，同时配服蚂蚁类风湿灵 2 号和 3 号胶囊，成人每次 3~4 粒，每日 3 次，饭后服用，儿童和年老虚弱者慎用 3 号胶囊。对长期依赖激素的病人可在服用蚂蚁类风湿灵药物一段时间，待病情稳定后，逐渐缓慢撤除激素。蚂蚁类风湿灵服用 3 个月为 1 个疗程，一般治疗需服用 2~3 个疗程，少数病程较长，病情较重者，疗程更长一些。^[11]

7. 张琪诊治经验

张氏认为：虫类药透骨搜风之作用远非草木之品所能及，其中尤以白花蛇、乌梢蛇、全蝎、蜈蚣、山甲珠效力为著。白花蛇、乌梢蛇透骨搜风、通经络，《本草经疏》谓白花蛇“性走窜，亦善行而无处不到，故能引诸风药至病所，自脏腑而达皮毛也”。即言其搜剔风邪之力；全蝎、蜈

蚣驱风通络止痛；穿山甲散瘀通经络，《本草纲目》谓其“除风痺强直疼痛，通经脉”。张氏善用诸虫类药物透骨搜风，通经络止痛。

在应用虫类药物的同时，张氏还强调，此类病证大多病程长，气血亏耗，肝肾亏损，关节受累变形，为此在搜剔风湿湿邪基础上，必用补肾益气血之品，扶正祛邪兼顾，方能取效。如偏热者，可用生石膏、大黄、黄柏等；偏寒者用川乌、桂枝；寒热互见则寒热药并施，并应辅佐以活血通络之品。正虚邪实寒热兼顾，方能切合病机。^[12]

8. 刘志明诊治经验

类风湿性关节炎的急性期，常出现湿热痹证候，其病因多以湿热为源，风寒为兼，因此临床表现有热偏盛与湿偏盛之异，亦可兼见寒象而呈寒热错杂之证。且热邪最易伤阴，素体阴虚阳盛者，感受风、寒、湿邪，容易发为湿热痹，故又常兼有阴虚见证。刘氏治疗湿热痹，注重清热利湿，强调务使湿热之邪分消，同时佐以调畅气血之品，以宣痹通络。因湿性缠绵，为有形之邪，风热病邪往往借湿为留踞之所，因此又注重对湿邪的治疗。常取李东垣当归拈痛汤与吴鞠通宣痹汤为基本方，随证加减，根据多年临床实践观察，疗效满意。若热偏胜，多增黄芩、连翘、知母、山栀、忍冬藤、生甘草等；湿偏盛，多增防己、半夏、苦参、滑石、生苡仁等；兼寒者，可加制附子、白术；气阴不足，酌情增入黄芪、太子参、生地、白芍等，以扶正祛邪。^[13]

9. 赵绍琴诊治经验

类风湿关节炎初期，关节尚未肿大，可按一般痹证辨

治；若关节肿大疼痛一旦形成，则应从痰论治。凡关节肿大疼痛多属有形之邪留滞其间，痰浊、水饮、瘀血皆其类也。类风湿之关节肿大，或为梭形肿大如指关节病变，成为漫肿凸起一块如腕踝关节病变，然其并无骨质增生，但有关节腔水肿或软组织增生。况其肿胀可反复发作，其为痰饮甚明。此皆因外邪久留，经络闭阻，致气血津液停滞而为痰为饮。此等痰饮生于经络之中，留于骨节之内，徒以健脾燥湿化痰亦不能速去。当治以涤痰通络之法，选用性滑利善走窜之品，组成开窍通关之猛剂，以涤除骨节之留痰浊饮。方名五子涤痰汤（自拟），即三子养亲汤加冬瓜子、皂角子而成。方用苏子 10g，白芥子 6g，莱菔子 10g，冬瓜子 10g，皂角子 6g（或用皂角代皂角子亦可）。

若病在早期，表现为四肢关节游走性疼痛，关节并无肿胀，或略显微肿，或其痛忽作忽止，悠悠往来者，皆是痰饮留注欲作窠穴之象，治宜祛风胜湿通络剂中加入三子养亲汤，以祛除经络中流痰，方用大豆卷 10g，秦艽 10g，威灵仙 10g，丝瓜络 10g，桑枝 10g，苏子 10g，莱菔子 10g，白芥子 6g。方中白芥子用量虽小，却是重要的引经药，因其性通利透达，善祛皮里膜外之痰，走于经络之中，故为必用之药。

若其病已成，四肢关节肿胀明显，疼痛较剧，触之痛甚，此为痰饮留蓄于骨节间，已成窠穴之势。舌苔白腻水滑，脉象沉细滑，或濡滑，皆是痰饮深伏之象。此时痰饮聚于骨节，聚成窠穴，难于速去，三子养亲汤已力所不及，可用五子涤痰汤加味。方用苏子 10g，莱菔子 10g，白芥子 6g，冬瓜子 10g，皂角 6g，海风藤 10g，络石藤 10g，天仙藤 10g，丝瓜络 10g，桑枝 10g。方中五子合用，善能涤除骨节间痰饮湿浊，合以三藤及桑枝、丝瓜络，更能通利经络，祛风胜

湿，则痰饮不致复留为患。方中皂角一味，至关重要，其味辛辣猛烈，走窜力强，善开窍通关，涤痰除垢，与白芥子协力，领诸药直达痰饮窠穴，而奏涤痰消肿之功。

若症见关节肿胀迅速增加，疼痛剧烈，手不可近，是痰饮之势猖獗，非峻剂无以遏其势，宜用上方合控涎丹，装胶囊服 2~3 分，服后泻下痰水样便，即收肿消痛止之效。

其证属阳气衰微，寒痰凝滞，漫肿作痛，屈伸不利，六脉沉微，舌淡苔白水滑，面色㿔白，形寒畏冷，是阳衰不能温化所致。宜上方合三淡汤，即淡干姜、淡附片、淡吴萸各 6g，重者用 10g，以温阳逐饮。

若肾阳不足，虚弱证现，伴见腰膝酸软，神疲乏力，头晕耳鸣，腰以下冷感明显，舌淡胖大，苔白且润，脉沉弱无力者，可于方中加入杜仲 10g，川续断 10g，补骨脂 10g 以补肾壮骨。

病至晚期，症见关节肿大变形，周围肌肉萎缩，屈伸不利，运动受限。此属痰瘀互结，治疗较为棘手。治宜涤痰化瘀并举，上方参入补阳还五汤意，加生黄芪 30g，炒地龙 10g，再酌用乳香、没药、桃仁、红花、赤芍、当归、川芎、茜草等化瘀之品，或为丸服，缓以图效。

依赵氏经验，从痰论治类风湿可获良效，但临床上尚需要病人加强患部功能锻炼和走路运动，避免寒冷刺激，注意清淡饮食等。^[14]

10. 谢海洲诊治经验

(1) 祛邪尤重除湿，治痹勿忘外感：痹证乃风寒湿邪侵袭人体，造成气血运行不畅所致。无论寒痹、热痹、风痹每每兼夹湿邪，治疗当祛风散寒除湿。然风可骤散，寒

因温可去，惟湿浊难以速除。湿邪不仅在痹证的发生发展转归中起重要作用，而且也是痹证所以迁延不愈的原因之一。临床多见关节肿痛、关节酸沉、屈伸不利等症。谢氏对此注重调节水液的代谢，气机的畅通；采用宣肺、理脾、温肾之法，而把理脾放在首位，健脾则湿无内生之源。如治类风湿性关节炎见手肿、手痛时，生苡仁用量达45g，正是体现了健脾祛湿的思想。根据病位的不同，湿在上当发其汗，湿在下当利其小便，使邪有出路。在病性上，谢氏认为湿邪为病常兼寒邪，治疗当偏于温化。此外病情的反复发作与迁延不愈还与外感有关，不少痹证患者往往有咽部红肿之症，不可轻视，治疗时可加入射干、玄参、山豆根、板蓝根之类。若外感明显，咽喉肿甚，可急则治标，往往起到控制病情，改善疗效之功；表虚之人，常因表卫不固而诱发痹证，治疗时应固表和祛风散寒同用，方用玉屏风散加味。

(2) 散寒每兼温阳，清热酌培养阴；谢氏认为，阳虚则寒，而寒邪袭人又每致阳虚。因此可以说寒痹的发生与阳气（卫阳、肾阳）的盛衰有着内在的联系，其根本在于肾阳不足。若卫阳不足，或素体阳虚，则易感寒邪发为寒痹，治宜温阳，方用乌头汤，或麻黄附子细辛汤，配以补骨脂、巴戟天、狗脊等。麻黄宣肺祛邪，附子温阳散寒止痛，细辛辛散走窜通达内外，外加温肾之品则阳盛而寒自退。

然风寒湿邪为病，郁久亦可化热而为热痹。此外类风湿性关节炎初期，或急性发作期也可表现为热痹之证，如手足小关节红肿胀痛，局部灼热、汗出、口渴、高热，或伴有全身低热不适等症，治疗宜宣痹清热，方用白虎加桂枝汤、白虎加苍术汤。但必须看到，热胜则津伤，且久痹

热证临床上常兼有阴虚之表现。谢氏治疗热痹尤重护阴，在清热的同时常加养阴之品如生地、白芍、玄参、白薇等，使清热不伤阴，滋阴可退热，相得益彰。

(3) 寒热错杂宜通，气血亏虚从补：谢氏认为，寒热痹当寒温并用，寓通于中，选方多用桂枝芍药知母汤加减，并加用桑枝、路路通、丝瓜络、鸡血藤等，使经络通、气血调。散寒清热，诸症可解。在诊治痹证过程中，谢氏还发现产后妇女在痹证发病中占有一定比例，因妇女产后气血多亏，易遭风寒湿邪侵袭。这种痹证往往虚实夹杂，治疗当攻补兼施，扶正祛邪，常用玉屏风散加养血药，或八珍汤加祛风湿之品。

(4) 久病虫类搜剔，顽痹谨守温肾：关节疼痛为痹证之主症，痹证日久而致痰瘀互阻，血络不通，关节疼痛固定。活动受限甚或变形，泛泛活血之药收效甚微，非搜风透脉之虫类不可，如全蝎、蜈蚣、僵蚕、地龙、穿山甲、蜂房等，也常使用蛇类药如乌梢蛇、白花蛇、蕲蛇等。此类药物多有毒性，不宜多用和久用，同时应配伍培补肝肾之品。因肝主筋，肾主骨，久痹累及骨骱，肿痛变形，屈伸不利而成顽痹、尪痹之证。因此谢氏治疗痹证尤其是顽痹、尪痹时特别重视肝肾，强调温补肾阳，强筋壮骨，则往往使症状易于缓解，常用药物有熟地、补骨脂、牛膝、川断、杜仲、狗脊、仙灵脾、巴戟天等。临床上谢氏对痹证有一些独具匠心的用药经验，如手痛、手肿用生苡仁 45g，青风藤 20g；脚踝肿痛用熟地 20g；小腿痛、足腓转筋用白芍 20g，木瓜 10g 等。^[15]

11. 周仲瑛诊治经验

对本病的分证，一般可分风寒湿痹、风湿热痹、痰瘀

痹阻、气血虚痹、肝肾亏虚。然各证之间病因病机每多错杂相关，且可变异转化。论治立法风、散寒、除湿、清热、化痰、祛瘀、补虚七法，但又当据证参合应用。

(1) 寒热既应分治，也须相机合伍：风寒湿痹，寒湿伤表，用麻黄加术汤；寒湿偏盛可选乌头汤；三气杂感可选薏苡仁汤作为基本方，量其偏盛配药；内寒明显者，可取麻黄附子细辛汤加味，温经散寒；若寒湿伤阳，阳虚阴盛可予阳和汤助阳消阴。

风湿热痹，急性期身热明显而有表邪者，多选石膏配剂，风热偏盛，用白虎加桂枝汤；风热与湿相搏，用越婢加术汤；湿热痹阻用加减小防己汤；湿热在下者可取四妙丸。湿热痰瘀互结者，用上中下通用痛风方。若风热火化，湿热酿毒，则合犀角（清热）地黄汤，加漏芦、土茯苓、忍冬藤、地龙、苍耳子、海桐皮。邪热伤阴另用秦艽、功劳叶、白薇、生地、石斛、知母、赤芍、白芍等养阴而清络热。

至于寒热错杂者，又当温清并用，寒初化热，应温中有清，用桂枝芍药知母汤；寒湿已趋热化，可予白虎加苍术汤，或选用热证诸方。由于风湿痹每见热与风邪相搏，或湿遏热郁，故总当配伍辛通之品以助疏散宣化，分消三气，不得误认为必具寒热错杂之证，方能配合辛散宣通，如石膏之分别与桂枝、麻黄、苍术配伍，即寓此意。

(2) 顽痹化痰祛瘀，当用虫类搜剔：顽痹虽属久病，但未必皆虚，反因三气与痰瘀相搏结为患，外内合邪，愈益深伏骨髓，缠绵难愈。

痰瘀痹阻者，当审两者的偏盛配药。痰盛则肢节肿胀僵硬，重滞麻木；瘀甚则骨节疼痛，强直畸形；祛瘀活血可取桃红饮加穿山甲、土鳖虫、姜黄、乳香、没药；化痰

通络用青州白丸子。风痰加僵蚕，寒痰加白芥子，热痰改天南星为胆南星。如关节漫肿而有积液可加用小量控涎丹祛痰消肿，日服1.5g，连服7~10日为1疗程。

痰瘀固结，深伏血络，非借虫类药不足以走窜入络，搜剔逐邪。前人所谓：“风邪深入骨髓，如油入面，非用虫蚁搜剔不能为功”，即是此意。但虫类药功用同中有异。活血行瘀用穿山甲、土鳖虫，其中穿山甲“走窜之性无所不至，”尤善疗痹；搜风剔络，用全蝎、蜈蚣，其中蜈蚣对僵挛肿痛又胜一筹；祛风除湿用乌梢蛇、白花蛇，乌梢蛇效虽略逊，而性平无毒；此外僵蚕之祛风痰，地龙之清络热，露蜂房之祛风毒，单味蚂蚁之温壮强补，均各有所长，应予辨证选择应用。临证应用虫类药必须谨慎掌握，密切观察，切忌孟浪，以知为度，中病即止。因虫类药毕竟大都有毒或小毒，有破气耗血伤阴之嫌，故量不宜重，一般不宜过于持续久服，可间歇给药，或数药交替选用，体虚者应与扶正药配合使用。亦有体虚患者或产后得病用之而痛反剧者。

(3) 久痹治本顾标，益肾补气养血：尪痹日久，反复消长，多见骨质疏松及破坏，活动功能障碍，腰脊僵痛，关节强直变形，筋萎骨弱废用，胫瘦腿软而膝部肿大，舌淡，脉细。治当培补肝肾，强壮筋骨。

肝肾同源，补肾即可养肝，故扶正薙痹尤重益肾。益肾当以温养精气，平补阴阳，强壮肾督为基础，忌燥热及滋润。独活寄生汤、三痹汤均为扶正兼以祛邪之方。若阴虚湿热，腰酸胫瘦足弱，筋骨萎软，又可参照虎潜丸意。药如仙灵脾、地黄、白芍、水牛角（胶）、杜仲、川续断、狗脊、桑寄生、怀牛膝、鹿衔草、骨碎补、千年健、石楠藤等。

若气血虚痹，关节疼痛时轻时重，劳倦活动后为甚，神疲乏力，腰膝酸软，肌肤麻木，肌肉萎缩，舌淡红，脉细。当益气固表，养血祛风。肌肤麻木不仁，用黄芪桂枝五物汤，气血虚血脉滞而风湿不尽，用蠲痹汤。药如当归、白芍、熟地、黄芪、白术、甘草等。由于气血因邪、因虚皆可致痹，故当同时佐以行气和血之品，如红花、川芎、姜黄、鸡血藤、天仙藤之类。此即“气血流畅，痹痛自己”之意。

(4) 注意病位、病证特点及辨病用药，谨慎掌握应用剧毒药物：痹证病在肢体关节而部位不一，故应注意病位所在选药。如痛在上肢项背用羌活、防风、葛根、片姜黄、桂枝；痛在下肢腰背，用独活、防己、木瓜、蚕沙、川续断、牛膝；痛及全身关节筋脉，用松节、千年健、伸筋草、威灵仙、路路通。同时还应选用相应的藤类药物通络引经，以增药效。如祛风通络用青风藤、海风藤、络石藤、丝瓜络；清热通络用忍冬藤、桑枝；补虚和血通络用石楠藤、鸡血藤、天仙藤等。它如针对病机病证特点，组合配药，亦有助于疗效的提高，如地黄、仙灵脾阴阳相济益肾而蠲痹；石楠藤、鹿衔草补虚而祛风湿；功劳叶、白薇治阴虚络热；鬼箭羽、凌霄花化瘀通络；苍耳子、蔓荆子祛风除湿；松节、天仙藤祛湿消肿；透骨草、威灵仙通利关节；漏芦、土茯苓清解湿毒等。

川乌、草乌为治寒痹之要药，但大辛大热有毒，一般均应制用，若症状仍难改善，可改用生川乌、生草乌，宜由小量开始递增，先各用 1.5g，如无反应可渐增至各 3~5g，煎煮时间应长，约 1~1.5 小时，可与甘草同煎以缓解毒性。若药后出现唇舌发麻、头晕、心悸、脉迟有歇止者，皆为毒性反应，即应停药。

番木鳖苦寒有毒，善通经络，消肿散结止痛，治痹有专功，多为炮制后入丸散中用，单用散剂日 0.3g。

雷公藤有大毒，为治尪痹专药，可从小量开始，从 5g 递增至 15g，去皮先煎 1 小时减毒，再兑入全方中复煎为好，持续服用过久，对肝肾功能及造血系统有损害，妇女可致闭经，故以间歇应用为宜。^[16]

12. 高辉远诊治经验

(1) 强调内因，扶正是根本：高氏认为，类风湿性关节炎的发病与整体防御机能密切相关，外邪必须在正虚的情况下才能致人于病。正如《内经》云：“正气存内，邪不可干”，“邪之所凑，其气必虚”。机体如抵抗力降低，营卫气血失调，肌表经络遭受风寒湿热等邪的侵袭，气血经络为邪闭阻而引起经络、肌肤、关节筋骨疼痛、酸楚、麻木、重着、曲伸不利，关节肿大、僵直、畸形，肌肉萎缩，活动障碍，严重可影响脏腑，是类风湿性关节炎发病的内因之根本。高氏通过多年的临床实践体会，在治疗类风湿的过程中扶正乃是治病之根本，应贯穿始终。

①调补气血：类风湿性关节炎常有面白唇淡，神倦无力，自汗心悸，食少纳差，头晕目眩，舌淡苔腻，脉细等气血两虚的表现。治疗时补益气血至关重要，但又不能峻补，以防温多化热，气壅血滞之弊，应根据病情的需要，以调补为宜。常用药如：太子参、黄芪、白术、白芍、红枣等。

②滋养肝肾：肝肾不足亦是类风湿性关节炎之根本，临床上常表现为烦躁易怒，筋惕肉跳，失眠多梦，腰膝酸软，男子遗精，妇女月经不调，舌红少苔，脉细弦等症。高氏认为及时应用滋养肝肾之品及治本之法，但不宜专于滋补，应在滋补之中佐以温阳、清热、消导之药，以免滋

膩恋邪、碍胃。常用药如：生地、女贞子、旱莲草、五味子、鹿角胶、仙灵脾等。

③强筋壮骨：类风湿与一般痹症不同，属于顽痹，病程长，病位深，日久不愈，邪留筋骨。临床常见关节肿胀，僵直畸形，屈伸不利，筋膜拘挛，肌肤麻木不仁，不能行走，舌暗淡，苔白，脉沉细等证。高氏认为强筋壮骨是治疗类风湿性关节炎的重要一环，但临证时必须审正邪之盛衰，要邪正兼顾，分别祛邪扶正或扶正祛邪，才能真正发挥强筋壮骨的作用。常用药如：狗脊、续断、骨碎补、龟甲、千年健、龙骨等。

(2) 重视外因，祛邪有偏重：《素问·痹论》云：“风寒湿三气杂至合而为痹也”，宋·严用和以及明·李挺又有发展，提出毒邪的外因，张子和则阐明了风寒湿入侵机体的条件是：“濒水之地，劳力之人，辛苦失度，触冒风雨，寝处由湿……”。高氏认为类风湿性关节炎是外邪引动内邪，内外合邪而发病。虽外因通过内因起作用，但风寒湿热等外邪确是致病的重要条件，不可轻视。但临床上风寒湿诸邪并不是等量致病的，因某一种病邪在合邪中所占比重不同，故高氏强调要有偏重。

①祛风散寒：外感风寒之邪由表及里，邪入日深，阻滞经络之风寒偏胜者，关节游走性疼痛较剧，关节肿胀，屈伸不利，得热痛减，遇寒痛增，苔薄白，脉弦紧。常用药如：防风、麻黄、蕲蛇、制川乌、桂枝等。

②清热利湿：外感风热或寒湿不解，郁而化热，湿热交蒸，浸淫于皮肉筋脉、经络，关节之湿热偏胜者，关节红肿热痛，有沉重感，活动障碍，口渴喜饮，小便黄浊，舌红苔黄，脉弦滑数。应湿热两清分清其势，才能湿去热解，若只清热则湿不退，只祛湿则热愈炽。常用药如：银

花、连翘、黄柏、知母、苡仁、萆薢等。

③化痰散结：外感风寒湿热诸邪，内因运化失司，水湿不化，凝聚生痰，随气升降，滞于经络关节之痰结者，关节肿胀疼痛，关节或关节周围出现增生、结节，屈伸不利，伴呕恶纳呆，舌质淡暗，苔白粘腻，脉弦滑。应软坚散结、燥湿化痰并施。常用药如：夏枯草、穿山甲、白芥子、半夏、茯苓、陈皮等。

(3) 尤重治瘀，活血且温经：《内经》虽无血瘀之名，但有“恶血”、“留血”等名称，其内容与血瘀相同。《素问·调经论》云“孙络外溢，则有留血”，又“寒独留，则血凝泣，凝则脉不通”。关于血瘀的治疗原则，《素问·至真要大论》有“疏其气血，令其调达，而致和平”之记载。高氏认为风寒湿热等邪侵蚀筋骨，流注经络，着而成瘀，是形成类风湿性关节炎活动的病理关键。故在治疗上注重祛瘀，采用由浅入深，先温经活血通络，后益气活血化瘀的方法，使经脉流通，气血周流，筋骨强健。

①温经活血通络：邪客经络，留而不行，阻滞气血，不通则痛，即所谓“久病人络”。常见关节疼痛呈刺痛感，伴麻木不仁，得热则舒，遇寒加重，舌质暗淡，苔白，脉沉紧。常用药如：桂枝、细辛、川附片、当归、鸡血藤、桑枝等。

②益气活血化瘀：类风湿性关节炎是一种久病顽疾，“久病多瘀”，“久瘀多虚”，互为影响。常见关节疼痛，痛有定处，固定不移，兼见肌肤甲错，口渴不欲饮，神疲乏力，舌质紫暗，或有瘀斑，脉细涩等。常用药如：太子参、黄芪、赤芍、丹参、桃仁、红花等。

(4) 合参中西，防治应分期：高氏认为古人对类风湿性关节炎的治疗，提供了丰富的经验，但当前还要摒弃因

循守旧的门户之见，大胆运用现代化科学技术手段，借鉴西医学实验检查的指标，从症状、化验、舌象等诸多方面探讨本病的规范化及疗效的“量化指标”，才能使临床治疗研究类风湿性关节炎更严谨、更科学、更具有可重复性。类风湿性关节炎是一种慢性而又顽固的疾病，病程长，治疗时间长，疾病过程中临床表现千变万化，故不主张守一法一方来治疗，倡导根据临床表现、实验室检查等诸多方面的不同，分型分期辨治。

①湿热毒瘀旺盛型（急性发作期）：高氏认为，此期多因湿热化毒，蕴于筋脉，气血瘀阻，流注关节，故临床上常表现为关节红肿热痛，如刀割虎啮，夜重昼轻，僵硬，晨起明显，活动受限，伴发热，汗出不解，烦躁不安，口渴喜饮，小便黄赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦滑数等。实验室检查可见血色素偏低，多为亚细胞正色素性贫血，白细胞轻度增高，血沉较快，血清 γ 球蛋白增高。治宜清热解毒，祛瘀通络，消肿止痛。药用：银花藤、知母、栀子、桂枝、防风、赤芍、桑枝、灵仙、木瓜、甘草。若热盛加生石膏、土茯苓；湿重加生薏苡仁、萆薢；血瘀明显加丹参、桃仁；病久气阴两虚加太子参、生地。

②寒湿瘀热错杂型（慢性活动期）：高氏认为，此期常因寒湿热瘀交错，经络阻滞，关节失利，临床上多表现症状错综复杂，病程长短不一，关节肿痛，或有畸形，可有低热，或上身怕冷，或下肢发凉，病情反复，变化无常，舌质红，或边红，苔白，或薄黄，脉弦数，或弦滑等。实验室检查可见血沉略快、白细胞正常、血清 γ 球蛋白偏高，免疫球蛋白IgG、IgA、IgM略高，血清粘蛋白略增高，类风湿因子阳性但效价不高。治宜寒热并用，清热祛湿，温经化瘀。药用：连翘、桂枝、白芥子、赤芍、鹿角霜、薏

苡仁、桑枝、延胡索、鸡血藤等。若热象明显加银花藤、丹皮；寒象明显加细辛、麻黄；湿象明显加萆薢、木瓜；血瘀明显加地龙、红花。

③阴阳虚损夹瘀型（稳定缓解期）：高氏认为此期，多为久病多虚，久痛入络，致气血阴阳虚损，临床上表现病情相对稳定，关节无明显红肿痛，或稍痛不肿，或稍肿不痛。可有关节畸形，无明显发热，但可有畏寒，自汗或手足心热，腰膝酸软，舌质淡苔白，脉缓，或沉细等症。实验室检查：血沉、血清粘蛋白、免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM，血清 γ 球蛋白均为正常，类风湿因子可阳性，可阴性。治宜调补气血，滋养肝肾，活血通络。药用：黄芪、赤芍、防风、薏苡仁、桂枝、炙甘草、桑枝、骨碎补、木瓜、大枣等。若偏气虚加太子参、白术；偏血虚加当归、首乌；偏阴虚加生地、枸杞；偏阳虚加仙灵脾、肉苁蓉；兼痰加鸡血藤、延胡索；兼痰湿加薏苡仁、白芥子。^[12]

13. 汪履秋诊治经验

类风湿性关节炎病因总由风、寒、湿、热、痰、瘀所致，故治法多宗祛风宣湿、化痰消瘀，视寒热偏盛，寒盛者重在温化，热盛者予以清热。根据上述病因辨证，汪氏喜用下列一些药物：祛风药：羌活、防风、白芷、川芎；散寒药：麻黄、桂枝、乌头、附子；宣湿药：苍术、苡仁、川朴、晚蚕沙；清热药：石膏、知母、黄柏；化痰药：南星、白附子、白芥子；消瘀药：桃仁、红花、三棱、莪术、制乳没。还有二类也是每方必用，即虫类和藤类，认为顽风痼疾，非虫类不祛，肢末病变，非藤类不达。虫类药如僵蚕、全蝎、蜈蚣、水蛭、虻虫、土鳖虫，以及乌梢蛇、蕲蛇等，藤类药如雷公藤、青风藤、络石藤、鸡血藤、海风藤。上述

八类药物斟酌选用，临床每能收到较好疗效。^[18]

14. 李恒敏诊治经验

中西医有关类风湿性关节炎的分型颇不一致，李氏认为应按病理分型，即依据 X 线病理学，将其按骨质改变，结合临床症状及化验室检查进行分期。这样中西医就可统一起来，二者之间可有一个统一的参照指标。中西医均在一个指标下观察研究一种疾病，更为实际，更有可比性。

第 I 期：骨质疏松期（RA 早期）

①一般症状：急性起病，关节明显肿胀，局部肌肉、关节红肿热痛，疼痛剧烈，有沉重感，遇热则痛剧，发热口渴喜冷饮，心烦，溲黄赤热，关节活动受限，或完全不能活动，舌红、苔黄少津，或黄糙，脉弦数，或滑数。

②晨僵：不超过 1 小时。

③病程：2~6 周，或已确诊为类风湿性关节炎，新发病的关节，肿痛在 3~6 周内。

④化验：血沉快； α_2 球蛋白明显升高；类风湿因子阴性或阳性。

⑤X 线检查：关节周围软组织肿胀，关节间隙增宽，骨质疏松。

⑥辨证：邪热偏盛，肝肾阴虚。

⑦治法：清热除湿通经络，兼补肝肾。

⑧方药：白虎加桂枝汤加减（加补肝肾之品）煎汤内服。外用仙人掌适量，捣泥外敷患处，严重者可再加如意金黄散同捣敷。

第 II 期：骨质破坏期（RA 中期）

①一般症状：多关节肿胀疼痛，或呈刺痛感，痛有定处，反复发作，局部畏寒，遇寒痛剧，得热痛减，舌体胖，

舌质暗，或有瘀斑、瘀点，苔白腻，或白滑，脉弦紧，或弦缓，或沉细涩。

②晨僵：在1~6小时内。

③病程：1~3年。

④化验：血沉持续增快，血清粘蛋白 α_1 、 α_2 、 γ 球蛋白升高，Ig升高，细胞免疫指标轻度降低或正常。

⑤类风湿因子：阳性。

⑥X线检查：出现局灶性骨质破坏，明显的骨质疏松或囊状变，关节间隙轻度狭窄。

⑦离不开抗风湿止痛药，当药量小，或间隙时间较长（6小时以上）时，不能有效止痛或缓解僵硬症状。一旦停药，关节痛与全身症状迅速恶化，血沉回升，类风湿因子转阳。

⑧辨证：肾虚寒盛，寒凝气血痹阻经络。

⑨治法：补肾祛寒，活血化瘀，祛湿通络。

⑩方药：身痛逐瘀汤加减，或瘀血痹冲剂加金匱肾气丸。

第Ⅲ期：骨质严重破坏期（RA晚期）

①一般症状：多由Ⅰ、Ⅱ期转变而来，多关节肿痛相继发生，除关节肌肉肿痛外，关节逐渐发生脱位、变形、僵直，关节周围肌肉萎缩，屈伸不利，肌肉消瘦，畏寒喜暖，手足不温，或骨蒸潮热，自汗盗汗，腰膝酸软，舌质红或淡，苔白或黄，脉沉细尺弱，或沉滑数。

②晨僵：6小时以上。

③病程：3年以上，可持续10~50年之久。

④化验：血沉增快或正常； α_1 、 α_2 、 β 和 γ 球蛋白及免疫球蛋白持续升高，细胞免疫功能低下；类风湿因子持续阳性。

⑤X线检查：骨质疏松广泛，骨质破坏明显，且为多关节面侵蚀融合，关节间隙显著狭窄或消失，关节脱位、变形、增生、强直。

⑥病理：肉芽肿侵入软骨及骨，软骨及骨组织严重破坏，纤维化和骨化性增生。

⑦此期治疗困难，应进行综合治疗，中西医结合，并配合理疗，延缓和控制病变的进展。

⑧辨证：肝肾两虚重证，气血阴阳俱虚。

⑨治法：补肝肾益气血，祛寒湿通经络。

⑩方药：补肾祛寒治尪汤或尪痹冲剂：川断 15g，补骨脂 10g，骨碎补 15g，仙灵脾 12g，熟地 12g，牛膝 15g，炙山甲 10g，丹参 15g，生苡仁 30g，紫肉桂 3g，桂枝 10g，甘草 6g，红花 10g。

第Ⅳ期：缓解静止期

①主要症状：此期是经过前三期有效治疗后，多数可以缓解。

②晨僵：小于 30 分钟。

③关节肿胀消退，疼痛显著减轻，可有轻度压痛，肌肉萎缩与关节活动受限好转，或部分好转。

④血沉指标降低或明显好转。

⑤X线检查：骨质破坏基本静止，或有所改善，或出现修复和增生。

⑥不需抗风湿药，或只需小剂量止痛药，或只服中成药可以维持疗效。

⑦辨证与治疗：应视其在何期静止，可根据具体情况进行调治，但始终应保护胃气，病久必有瘀，故可再配合活血、化瘀、益气等治疗法则调理之。且注意病情稳定后，不能马上停药，还要服用一段时间药物巩固疗效，最好服

一些扶正固本之品，以提高机体抵抗力，加强免疫力。^{〔19〕}

15. 肖茂森等诊治经验

(1) 气机郁滞与痹证：风寒湿邪杂至合而为痹，与肝脾肾不足，或血虚血瘀痰滞密切相关。然肝胆郁结，气机不利与痹证也有密切关系，不可不辨。既可气机不利关节痹痛，也可气郁兼风湿痹痛，或风湿痹痛而气滞邪阻。其特点是关节痹痛，走窜不定，或关节胀痛而时肿时消，肢体沉重发麻，伴易怒，善太息，两胁胀痛，胸闷胃脘不适，症状每于情志不舒后诱发或加重，脉弦。治宜舒肝解郁，调气通络，祛风除湿，可选用逍遥散加减；或治宜调畅少阳枢机利气机，调和营卫祛风湿，可选用小柴胡汤合桂枝汤加减，或小柴胡汤合四妙散加减。

(2) 新痹也有瘀：久病多瘀，治痹需活血，血行风自灭，但又不可拘泥“久病才入络”，新痹也有瘀，总以辨证为主，随证选用活血化瘀之品治新痹，可见良效。

(3) 阴虚痹痛：脾肾阳虚不足，气血亏虚为痹证常见病机，阳虚痹痛多见，较易辨证，而痹证伴阴虚，或阴虚痹证并非少见，因辨识较难，故易辨为风痹或风湿痹痛。

形成阴虚痹痛常见原因有如下几种：或素体阴虚，阴虚内热，肝阳偏亢，化风入络而成痹；或痹痛日久，伤及真阴，阴伤亦可致血脉涩而不利，筋脉日益痹闭；或过用久用温燥之品而伤阴，渐成阴虚痹痛。阴虚痹痛多见于指趾关节，或阴虚臂痛，关节痹痛日轻夜重，全身筋脉挛痛，伴有头晕、头痛，咽干耳鸣，少寐，大便干燥，舌红。若兼有湿热未清，舌苔黄腻，治宜柔肝滋肾，养阴清热为主，温通香燥走窜之品均非所宜。待阴液复，气血畅行，则风湿易祛，脉络得通，痹痛可除。兼有湿热者，又当清热利

湿，凉血养阴。

(4) 似痹非痹：在临证时，有一些似痹痛，但并非风寒湿杂至合而为痹之痹证，治疗用药与一般痹证有别。如脾气不升，气血不营之气虚臂痛，用补中益气汤合二陈汤。产后气血大伤，经脉空虚，邪由内生，即使杂以风寒湿邪之关节痹痛，治疗用药也与一般痹证有别。遍身游走痛，有因气虚血瘀引起的血瘀身痛，而非痹痛。肝肾气血不足，不能应时流畅而夜半腿痛也非痹证，治当补肝活血。

(5) 更年期关节炎：更年期因天癸竭，阴阳两虚冲任不调，故此期关节炎宜补肾扶阳，滋肝肾，调冲任以治本，通络止痛以治其标，不宜滥用温燥辛散、苦寒清泄之品，与常人关节痹痛自当有别。^[20]

16. 金实等诊治经验

(1) 先表后里：本病初起呈急性活动阶段，外邪壅滞肌表筋脉，病势较盛，必先开腠发汗，因势利导，驱邪外出。《金匱要略》指出：“风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解。”根据病情的轻重，轻者用羌、防、独活之类，重则必投麻、桂、细辛等峻猛之品。我们体会，类风湿性关节炎与一般风湿病不同，患者大多无汗、少汗或汗出不爽，得汗后疼痛减轻，较长时间服用麻黄、桂枝类药亦极少有汗出过多现象。一般待汗出较畅，疼痛缓解后（时间约2~3周至数月不等），方可减少表散药物，重点转向祛寒、除湿、化痰、行瘀或益肾诸法。

(2) 先清后温：本病急性活动期常见关节红肿热痛，身热烦渴等表现，属风湿热证无疑。通过临床实践，我们进一步认识到，在急性活动期“无寒即是热”，亦即急性活动，病势较急，肿痛骤增，血沉迅速升高之时，只要无明显

显关节疼痛、畏寒喜温等寒象，即可作热证处理，酌用一段时间清热和络药物，有利于抑制病势，缓解病情，常用药如知母、生石膏、银花藤、鬼箭羽、黄柏、水牛角、丹皮、赤芍、生地、木通等。其中，木通泻火行水，《本经》谓其能“通利关节”，临床用以利湿热，消关节肿胀捷效。生石膏疗热壅痛剧者效果颇著。曾治一患者，关节肿痛灼热，伴有低烧，血沉 124mm/h。先投桂枝芍药知母汤未效，后加入生石膏 40g，病情很快得到控制，热退痛减，血沉减趋正常。

此外，急性活动期间往往关节红肿，发热烦渴，兼见畏寒喜温，关节疼痛，舌苔或黄或白，舌质或红或淡，辨证系属寒热错杂。我们诊治的 197 例类风湿关节炎患者，其中急性活动期 144 例，呈风湿热型 71 例（占 49.3%），寒热错杂型 62 例（占 43.1%），风寒湿型 14 例（占 7.6%）。寒热错杂证宜温清并用，如知母、赤芍并用桂枝、附子，麻黄、乌头并用生石膏、鬼箭羽，苍术、独活并用黄柏、牛膝等。

（3）先攻后补：《景岳全书》谓“痹者，闭也。以气血为邪所闭不得通行而病也”。关节肿痛时的治疗重点在于除邪气，疏通脉络。所谓邪气，不外风、寒、湿、热、痰、瘀六端。病起急骤，疼痛游走者属风；关节拘急冷痛，畏寒喜温者属寒；关节红肿灼热，身热烦渴者属热；关节肌肉酸楚重者，肿胀散漫者属湿；关节肌肉肿胀局限或见皮下结节者属痰；疼痛固定日久难除，骨节僵硬畸形者属瘀。197 例患者中，肿胀局限，或见皮下结节者 67 例（占 34.1%），肿痛日久，骨节僵硬畸形者 112 例（占 56.3%），提示瘀血、痰浊是本病重要的致病因素。化痰消浊常用僵蚕、南星、白芥子；活血行瘀常用桃仁、虎杖、炮山甲、

地鳖虫等；关节肿痛缓解后，宜攻补兼施，补益有补阴、补阳、补气、补血之不同。若以脏腑划分，有益肝补肾，健脾养心之异，其中补肾最为紧要。我们认为补益有扶正祛邪，强化蠲痹止痛的效果；有扶正固本，抵御外邪，减少发作的作用；有调和脏腑，改善体质，促进药物吸收的效应。

(4) 配合强效药物：本病各种证型，均可选用穿山龙、徐长卿、青风藤、雷公藤、川草乌、马钱子、蜈蚣、全蝎等长效药物。穿山龙、徐长卿祛风除湿止痛之力较强，副作用少。青风藤去风湿、通经络、防肢节肿痛。但所含青风藤素是目前所知植物中最强的组织胺释放剂之一，可引起皮疹、瘙痒等反应。笔者将防风、甘草与其配用，试用近百例尚未见皮疹瘙痒出现。雷公藤蠲痹止痛效果显著，但长期较大剂量使用副作用较多。我们用于复方之中，使药量减少（6~15g）效果增强。我们体会，配合广木香可减少消化道反应；配合地黄、芍药、白术、甘草可减少肝损伤；配合当归、桃仁、鳖虫，可减少闭经等副作用。大凡疼痛剧烈，均可加入炙川草乌镇痛。配合赤芍、甘草可行瘀和营，缓解毒性。张锡纯赞马钱子“开通散结，透达关节之力，远胜于他药”。应注意炮制，严格控制剂量，丸散内服当在1g以内。顽痹不已，虫蚁透剔，将二、三种联用，可加强效果。其中，搜风剔络之力，全蝎、蜈蚣最强。穿山甲“咸寒善窜，专能行散，通经络，达痹所……防风湿冷痹”，功效独特，与它药配伍有协同作用，单用炮山甲粉3g，温酒送服，亦有较强止痛效果。^[21]

17. 傅盛澄等诊治经验

(1) 治实痹，祛邪通络调营卫：此型患者多以四肢关

节肿痛、僵硬等邪气阻络之证为主，兼有发热恶寒，鼻塞，咳嗽，脉浮等营卫失和，风邪袭表之象，而无明显肝肾不足、气血亏虚之象。方用五藤二龙汤：青风藤 15g，海风藤 15g，地龙 15g，忍冬藤 15g，乌梢蛇 12g。

寒盛者，尤见痛剧喜热，形寒肢冷，脉浮紧，常加麻黄、附子、细辛、姜黄、乳香等化裁，以散寒通络除痹。

热盛者，尤见关节红肿热痛，口干便难，脉浮数。常加桑枝、连翘、石膏、知母、苡仁、丹皮等化裁以清热通络除痹。

(2) 疗虚痹，强筋健骨益肝肾：此型患者除有肢体关节肿痛僵硬，尚有明显的肝肾不足气血亏虚之象，骨或骨骼肌萎缩，腰困酸重，神疲纳差，心悸气短，不得久立，常用：党参 10g，黄芪 10g，桑寄生 15g，伸筋草 20g，龟甲 20g，川断 15g，杜仲 10g，山药 15g。脾胃气虚者，又有筋骨萎缩而肌疲纳差，肌肤麻木，脉缓，常加茯苓、草薢、白术、砂仁、仙灵脾等化裁，以培土固本和络。

肝肾阴虚者：又有筋骨酸软麻痛，五心烦热，口燥咽干，腰膝酸困，脉细数，常加熟地、阿胶、旱莲草、当归、制首乌、全蝎等化裁，以养血滋阴通络。

肝肾阳虚者：又有筋骨酸软冷麻，四肢不温，脉沉细，常加附子、肉桂、鹿角霜、补骨脂、川椒、地龙等化裁，以温阳益气通络。

(3) 克顽痹，行瘀化痰和经脉：此型患者痹久难愈，各个关节肿痛僵硬，甚则功能丧失，舌暗，本虚标实较为明显，多呈持续或反复性发作，方用通化蠲痹汤：白附子 10g，马钱子 1g，党参 15g，白术 10g，雷公藤 12g，伸筋草 30g，蜈蚣 8g，胆南星 7g。

痰盛者，尤见肢体关节肿痛，晨僵，四肢沉重，肌肤

麻木，苔腻，脉滑，常加白芥子、天麻、半夏、茯苓、苡仁、竹沥、桂枝、海桐皮等化裁，以化痰通络除痹。

瘀盛者尤见肢体关节肿痛，固定不移，夜重昼轻，或有皮下结节，瘀斑，舌暗，脉沉涩，常加蜂房、全蝎、牛膝、乌蛇、附子、黄芪、血竭、路路通等化裁，以行瘀通络祛痹。

(4) 临床对症加减用药：

肿胀：刘寄奴、苏木、苡仁。湿热者加黄柏、白茅根等；寒湿者加麻黄、附子、细辛等；气虚者加黄芪、茯苓、革藓、姜黄等。

疼痛：乌蛇、全蝎、蜂房、玄胡。寒痛加附子、川椒、肉桂等；热痛加连翘、桑枝、生地等；上肢痛加羌活、姜黄、威灵仙等；下肢痛加独活、牛膝、革藓等；腰痛加杜仲、川断、桑寄生；痛久难愈加炙马钱子、雷公藤等。

经脉挛急：芍药、甘草、伸筋草等。

肌肤麻木不仁：海桐皮、路路通、天麻、防己、地龙等。

皮下结节：浙贝、胆南星、土茯苓、昆布、半枝莲、坤草等。

增强关节活动功能：党参、龟甲、伸筋草、鸡血藤、牛膝、路路通等。

(5) 治疗思路和体会：

①诊痹着眼寒热，治痹不忘虚实：历代医家治痹分型繁多，然究其脉证，寒热而已，查其病体，虚实而已。有鉴于此，笔者诊痹，首辨虚实，再分寒热。

②除痹以通为用，顽痹尤重虫药：通则不痛，故除痹止痛以温通为大法，清热需顾阳气，以防伤正邪滞之弊。顽痹病久者，重用搜风通络之虫类药，往往有较好效果。

③治痹以平为期，温肾不忘育阴：温通大法，常可见效，久用不愈当兼以滋阴，屡可见功，以阳得阴助而生化无穷故也，然切戒滋腻而致闭门留邪。

④护理配合需得当，复元锻炼甚重要：介绍本病的基本知识，解除患者的恐惧心理，帮助患者解决具体困难，创造良好的治疗环境，以及病情稳定后的功能锻炼，往往也是病体复元的有力手段。

⑤中西医结合新途径，验方新法采众长。^[22]

18. 陈芳诊治经验

1. 湿热阻络型：多见于类风湿关节炎早期。

主证：关节不利，晨起僵硬，可涉及一个或多个小关节，或关节疼痛游走不定，发热，口干口苦，舌质红，苔薄白或黄，或少苔，脉滑数

治法：清热祛湿，通经活络。

方药：忍冬藤、桑枝、络石藤、萆薢、地龙、连翘、黄柏、防风、黄芪、防己等。

2. 寒湿阻络型：本型多见于类风湿关节炎中期。

主证：肢体关节剧痛，酸困，或肿胀变形，僵硬麻木，局部畏寒，皮色不红，触之不热，遇寒痛增，得热痛减，舌质淡暗，苔白腻，或白滑，脉弦，或弦缓。

方药：附子、黄芪、桂枝、麻黄、白术、白芍、当归、威灵仙、木瓜、细辛、炙甘草等。

3. 寒热错杂型：可见于类风湿关节炎早中晚各期，以中晚期为多。

主证：肌肉关节疼痛、肿胀或变形、僵硬，局部触之发热，但自觉畏寒；或触之不热，但自觉发热；有时上肢不温，下肢发热；或下肢发冷，上肢灼热。舌红，苔黄，

或黄白相兼，脉弦数，或细数。

治法：寒热并用，清热散寒，通经止痛。

方药：桂枝、白芍、知母、附子、白术、防风、红花、皂角刺、狗脊、地龙、黄芪、桑寄生等。

4. 肝肾两虚型：多见于类风湿关节炎中晚期，病情相对稳定时。

主证：肌肉关节疼痛，屈伸不利，关节无红肿，或关节肿大而不红不热，僵硬畸形，肌肉消瘦，舌脉正常。

治法：攻补兼施，强筋健骨，通阳行痹。

方药：生熟地、附子、川断、骨碎补、桑寄生、威灵仙、狗脊、白芍、鸡血藤、红花、黄芪等。

陈氏认为：临床上早期类风湿关节炎多见湿热阻络型，病初活动期以祛邪为主治疗，待热退肿消，病情好转，用滋补肝肾之药善后，以巩固疗效，预防复发。中晚期病人，一般都用过抗风湿西药，甚至长期用激素，我们用中药治疗须逐步减少直至撤掉抗风湿西药或激素，但不能突然停药，否则病情会加重。如果关节肿痛明显，部位固定不移，局部皮色暗紫，有结节瘀斑等气滞痰阻血瘀症状，可加香附、乳香、没药、土鳖虫、蜈蚣等理气活血、通络止痛药和虫类药。中晚期病人治疗时间长，须坚持服药。病情稳定后须服用较长时间的滋补肝肾、强筋健骨药以增强机体抵抗力，使病情不向坏的方向发展，甚至骨质破坏有不同程度的改善。^[23]

19. 陈之才诊治经验

陈氏认为类风湿关节炎可概括四字：即“痛、肿、强（强直）、变（变形）”。而最主要的症状为痛，其痛如刺如裂，甚者痛如钻心，犹如虎啃，令人坐立不安，夜不成寐，

时有汗出，饮食不馨，久则形消瘦立，因之患者最迫切的要求是止痛，其次是消肿胀。为此治法以止痛为首要，消肿减轻病人痛苦则为第二重点。

按照目前临床经验，中医也普遍认为风寒湿痹及历节病疼痛的原因，是由于寒邪偏胜，所谓“寒胜则为痛痹”，故止痛大多用祛寒散寒的药物，如用麻桂发汗以散寒，乌、附等温阳以祛寒。但古人认为，痹之病因是“风寒湿三气杂至”，因此在散寒、祛寒的同时，亦不应忽略风、湿两端，如乌头汤中用黄芪以制麻黄，恐过汗则风去湿存；麻黄加术汤、白术附子汤在用麻桂同时配白术健脾化湿以助药效。

从临床实践来看，风寒湿痹，历节病疼痛并不完全一样，有些病人关节疼痛，按之热，皮色焮红，患者自觉关节内如火烧，欲就冷处，说明确实不能一概以“寒”字来解释，其理有二：

一是寒邪初入表，或逢阳虚体质，寒邪凝聚，是以“寒”为主，但日久病邪由表入里，寒邪并非一成不变，可郁久化热，出现红肿热痛；可以阻遏气机，使气血痹阻而出现血瘀之象，不通则痛。此时则不单是“散寒”一法可以解决。

二是痹之病因并非单纯，如感受湿热或风热之邪，热盛可使脉满而痛，热甚可以伤津耗液，甚至热毒鸱张。而且痹证难治，皆因与湿有关，因湿性粘腻，湿留关节，诸邪夹湿，则病必缠绵难愈。湿甚可肿，肿甚可使气血受阻，而肿与痛必相兼。此时不能仅着眼于一个“寒”字。

类风湿关节炎病人肢体、关节肿胀颇为常见。有时忽肿忽退，有时持久不消，有时随天时阴晴而增减。陈氏在临床上常将肿胀分为红、白、冷、热四者来辨证，先望其肿处皮肤色泽，再问病人自觉肿胀处冷热之感觉，然后按

其肿处之温度是凉是热。

如寒入经脉，日久化热，或感受风热，湿热之邪，或内热之体产生肿胀者，皮色往往焮红，抚之有热感，患者自觉有灼热感，则治须清热，常用黄柏、知母、连翘、赤芍，并重用忍冬藤以退肿。

若肿胀持久不退，自觉重滞，肿处肤色不变，或色滞，脉涩，苔腻者，则利湿退肿，常用防己、茯苓、泽泻、车前子（草）。下肢肿甚可加牛膝、木瓜。

有些肿胀，肿而不坚，患者动则汗出，视之不红，抚之不热，脉无力，苔不腻，则可以益气以退肿，陈氏常用防己黄芪汤加茯苓皮等，往往见效。

但临床上亦有患者自觉局部冷，视之色不变，抚之却热，则非真寒；而抚之不热，皮色不变，但病人自觉关节内有灼热感，且欲就凉，则必须尊重患者之主诉，考虑热在深部；如肿而皮色不变，抚之不热，病人喜包裹取暖，则必须再结合舌诊，如舌质红或绛、少津，亦不能过用温热之药，此乃病久化热伤阴之象，不可忽视。

总之，类风湿关节炎的病情往往以痛、肿开始，以强直、变形为后果，如能在治疗中抓住止痛、退肿这两个环节，既可解除病人痛苦，又能截断强直、变形的途径。因为强直、变形一般都在肿消之后，还须注意治本。根据“治风先治血，血行风自灭”、“气为血帅，气行血行”、“肝主筋”、“肾主骨”等理论，按患者具体情况采用养血活血、益气补血、补益肝肾等方法扶其正，以增强御邪能力。这样，方能使病情稳定、疗效巩固。^[24]

20. 谢建华等诊治经验

(1) 清热祛风，利湿活络，消肿止痛法：本法治疗湿

热阻络型的类风湿，临床主要症状见肌肉关节红肿热痛，晨僵，发热，口渴或渴不欲饮，汗出恶风或皮下结节，神疲乏力，食少纳呆，小便短赤，舌质红，舌苔白腻，或黄燥，脉滑数，或濡数，方中石膏、知母以用白虎汤之义清热，湿热阻络，仅清热不祛湿，则湿粘腻使热不退，故加二妙以祛湿，鸡血藤、忍冬藤、羌独活以通经活络。

(2) 疏风散寒化瘀通络法：此法治疗风寒型类风湿病。临床主要症状：关节肿痛，痛有定处，遇寒则重，舌淡苔白，脉沉。处方为：制川乌 15g（先煎 30 分钟），麻黄 10g，桂枝 12g，羌独活各 12g，细辛 4g，威灵仙 15g，姜黄 20g，鸡血藤 12g，豨莶草 20g，甘草 10g，炙没药 6g。痛甚加全蝎 3 只，蜈蚣 2 条。

(3) 清热散寒并用，通经活络止痛法：治疗寒热错杂型。其临床特点为寒热并存，虚实并见，错综复杂，既有阴寒之见症，又有毒热之见症，畏寒喜暖，关节疼痛或灼热。^[25]

21. 王拥军诊治经验

王氏采用辨证分型分三阶段治疗激素抵抗性类风湿性关节炎。

第一阶段治标，分三型：①湿热胶结型：多为用激素后副作用严重，常有继发感染，或过敏反应者，药用土茯苓、生苡仁、白花蛇舌草各 30g，银花、连翘各 20g，泽泻、威灵仙、牛膝各 15g，黄柏、苍术各 10g，生甘草 5g；②寒热错杂型：多为停药后反跳者，药用灵仙、鸡血藤、苡仁各 30g，知母、生地、首乌、秦艽各 20g，羌独活各 15g，桂枝、川芎各 10g，生甘草 5g；③血瘀痰凝型：多为激素治疗无效者，药用丹参、黄芪、鸡血藤各 30g，雷公

藤、龟甲各 20g，胆南星、地龙、地鳖虫各 15g，桂枝、桑枝、川芎各 10g，生甘草 5g。

第二阶段标本兼治，在第一阶段辨证治疗的基础上加入健脾补肾药物。

第三阶段缓则治本，停用前两阶段用药，用金匱肾气丸以温肾助阳，滋补肾阴。

一般第一阶段用药 8 周，第二阶段用药 6 周，第三阶段用药 4~6 周。治疗 34 例，总有效率为 91.18%。^[26]

22. 李义德等诊治经验

李氏等总结出激素撤减过程中中药的三梯级疗法取得显著疗效，具体方法为：①重剂辛温发汗以治标，药用麻黄 20g，桂枝 10g，荆芥 30g，防风 10g，羌活 10g，独活 10g，川芎 20g，白芷 10g，葛根 60g，此阶段用药时间为 1 周左右，服药 3~5 剂；②养血益气滋阴以扶正，经第一阶段治疗后用之，药用麻黄 10g，桂枝 10g，荆芥 10g，防风 10g，羌活 10g，独活 10g，川芎 10g，白芷 10g，葛根 20g，生熟地各 30g，白芍 15g，当归 15g，知母 15g，黄芪 30g，阿胶 10g，炙甘草 10g，此期用药时间为 2~3 周；③补肾坚骨壮督以固本，药用麻黄 6g，桂枝 10g，葛根 20g，防风 10g，生熟地各 30g，白芍 15g，当归 15g，黄芪 30g，怀牛膝 15g，杜仲 15g，川断 15g，补骨脂 15g，骨碎补 12g，鹿角胶 10g，制川乌 6g，全蝎 10g，蜈蚣 2 条。第三阶段要长期坚持服用，一般服汤剂 10 余剂后易为丸，续服一年，以冀根治。^[27]

【按语】

类风湿性关节炎是风湿病中最常见的疾病之一，有关

文献资料也较为丰富。本文所选取的二十多位医家的学术经验，从不同的侧面充实了该病的辨证论治内容。其要点反映在如下几方面：

(1) 病因方面重视虚、瘀、闭、痰、湿等：如焦树德认为寒湿、贼风、痰浊、瘀血互为交结，凝聚不散，进而发为本病。王为兰认为基本病变是“瘀”。赵绍琴注重从痰论治类风湿，善用五子涤痰汤（苏子 10g，白芥子 6g，莱菔子 10g，冬瓜子 10g，皂角子 6g）加减用于本病获得较好的疗效。

(2) 病机方面注重肾和督脉在发病学上的意义：如朱良春、焦树德均在治疗本病时重视益肾壮督，创制益肾蠲痹丸和尪痹冲剂，使疗效有了很大的提高，中医痹病理法方药体系更为完整。

(3) 擅长使用虫蚁类药物（如蜈蚣、全蝎、蕲蛇、地龙、蜂房、僵蚕、蛭螂、地鳖虫、蚂蚁、白花蛇、穿山甲等）：痹证日久，邪气久羁，深侵入骨，气血凝滞不行，变生痰湿瘀浊，经络闭塞不通，非草木之品所能宣达，必借虫蚁之类搜剔窜透，方能浊去凝开，气通血和，经行络通，深伏之邪除，困滞之正复。持此观点的医家有朱良春、焦树德、娄多峰、盛国荣、吴志成、张琪、谢海洲等，现代研究证实：虫蚁类药物具有搜风通络，缓解症状的重要作用。但在应用虫类药物搜剔风寒湿邪的基础上，必须应用补肾益气血之品，扶正祛邪兼顾，方能取效。同时虫蚁类药物大都具有毒性，使用时应注意药量和配伍方法，并须适可而止。

(4) 尪痹方面的系统研究：焦树德对尪痹的病名、病因病机、辨证论治、处方用药等进行了系统论述，极大的丰富了中医学痹病理论宝库。根据其处方研制的产品——

祛痹冲剂，投放市场后产生了可观的社会效益和经济效益。

(5) 有毒药物的应用：如蜈蚣、全蝎、川乌、草乌、雷公藤、马钱子等，这是采用“以毒攻毒”的原理，可迅速减轻有关症状。如蛇能外彻皮肤，内走脏腑，无处不到，有透骨、搜风、截惊、定搐之功，凡风毒壅于血分之疾，非此不除；蚂蚁是一种广谱的免疫增效剂，有报道称，蚂蚁风湿灵系列药物无毒副作用，能改善关节疼痛和晨僵，并能消肿；雷公藤毒性大，但毒性含量主要在根皮部，皮去则毒性低，但疗效也受影响，其有效量和中毒量较为接近。因此，对这类药物应谨慎应用，注意炮制，严格掌握有关剂量，以免发生毒性反应。

(陶晓华 王 琦)

参 考 文 献

- [1] 史宇广，单书健主编. 当代名医临证精华·痹证专辑. 北京：中医古籍出版社，1998.
- [2] 朱建华，朱良春. 虫类药应用发挥. 中国医药学报，1993，8 (1)：46
- [3] 江苏省南通市中医院痹证科研组 (朱良春指导，朱琬华整理). 益肾蠲痹丸治疗顽痹 (类风湿性关节炎) 200 例疗效观察. 北京中医学院学报，1985，8 (3)：21
- [4] 吕爱平，王安民，等. 益肾蠲痹丸对大鼠实验性痹证影响的病理学研究. 中医杂志，1988，29 (6)：49~51
- [5] 闫小平. 祛痹三悟. 中国医药学报，1993，8 (5)：47
- [6] 娄多峰. 痹证治验. 郑州：河南科技出版社，1983. 4~6，9~12
- [7] 娄多峰. 立虚邪痹说的治痛名家娄多峰-名家评析，类风湿性关节炎血瘀邪凝集. 中国名老中医药专家学术经验集. 贵阳：贵州科技出版社，1994.

- [8] 李文芳, 卢海涛, 朱巨才, 王为兰论治类风湿性关节炎. 河南中医, 1992, 12 (3): 36
- [9] 齐岩, 王德敏. 王为兰治疗痹证学术思想初探. 北京中医杂志, 1992, (11): 1
- [10] 黄文东, 朱杰, 戴山. 著名中医学术家的学术经验 (中国现代医学家丛书之二). 长沙: 湖南科技出版社, 1984
- [11] 吴志成, 嵇顺初, 凌华浓. 等. 蚂蚁类风湿灵的临床应用——附治疗类风湿性关节炎 1 260 例疗效分析. 江苏中医, 1997, 18 (3): 13
- [12] 张少麟, 李宏伟. 虫类药在类风湿性关节炎中的应用. 黑龙江中医药, 1992, (2): 1~2
- [13] 刘志明. 痹证证治 (专题笔谈). 中医杂志, 1989, (4): 5
- [14] 彭建中, 杨连柱. 赵绍琴教授从痰辨治类风湿性关节炎的经验. 中国医药学报, 1994, 9 (5): 57
- [15] 廖欣, 谢海洲诊治痹证的临床特色. 中国医药学报, 1998, 13 (2): 48
- [16] 周仲瑛口述, 周宁整理. 尪痹辨治探讨. 新中医, 1992, (6): 5
- [17] 于有山, 王发渭. 高辉远治疗类风湿性关节炎的经验. 辽宁中医杂志, 1993, (9): 7~9
- [18] 范小珍, 汪履秋教授治疗胶原病经验拾萃. 杏苑中医文献杂志, 1994, (1): 30
- [19] 李恒敏. 类风湿性关节炎临床分期探讨. 北京中医学院学报, 1990, 13 (3): 23
- [20] 肖茂森, 彭永开, 廖声俊编著. 百家验案辨证心法. 北京: 中国中医药出版社, 1998. 490
- [21] 金实, 汪悦. 类风湿关节炎证治体会. 实用中医内科杂志, 1993, (4): 19~20
- [22] 傅澄洲, 宋艳杰. 类风湿关节炎的论治体会. 黑龙江中医药, 1994, (2): 10~11
- [23] 陈芳. 类风湿关节炎的中医论治. 上海中医药杂志, 1994, (4)

- [24] 陈之才. 类风湿关节炎的治疗重点与法则. 上海中医药杂志, 1987, (11): 12~13
- [25] 谢建华, 等. 中医辨证论治类风湿关节炎体会. 内蒙古中医药, 1994, (4): 12
- [26] 王拥军. 标本兼顾治疗激素抵抗性类风湿性关节炎 34 例. 四川中医, 1991, (11): 46~47
- [27] 李义德, 等. 类风湿性关节炎应用激素撤减过程中的中药三梯队治疗. 山西中医, 1993, (3): 24~26

风湿性关节炎

【概述】

风湿性关节炎是风湿热的主要症状之一，属于全身性结缔组织炎症，是一种与溶血性链球菌感染有关的变态反应性疾病。其特点是以侵犯四肢大关节为主，在关节局部出现红、肿、热、痛，或肿痛，经治疗炎症消退后，关节功能恢复正常，不留畸形，但具有反复发作的倾向而形成慢性风湿性关节炎。发病以儿童及青年居多数。

中医学认为本病属“痹证”、“历节”范畴。《素问·痹论》指出“风寒湿三气杂至合而为痹”。但此病发病多呈热痹。正如《金匱翼·热痹》云：“热痹者，闭热于内也……脏腑经络，先有蕴热，而复遇风寒湿气客之，热为邪郁，气不得通，久之寒也发热，则痹翕然而闷也。”

【名医诊治经验】

1. 盛国荣诊治经验

盛氏治疗痹证辨证用药方面的经验，可归纳为十法：

(1) 祛风宣痹法：适用于肢体关节疼痛，游走不定，关节屈伸不利，或见恶风发热等表证，舌苔薄白，脉浮，证属行痹者。常用药物有：防风、羌独活、细辛等，盛氏

尤喜用防风、细辛，盖因防风味辛甘温，功能发表祛风，胜湿止痛，细辛性味辛温故尔。盛氏尚根据痹证所涉及的部位，酌情予以引经药物，如头部加羌活、藁本；颈部加葛根；上肢加桑枝、桂枝；下肢加一条根、牛膝；胸背部加郁金、枳壳；腰部加续断、狗脊。

(2) 散寒逐痹法：适用于关节疼痛较剧烈，痛有定处，遇寒加剧，不可屈伸，痛处皮色不红、不热，苔白滑，脉弦紧，证属痛痹者。常用药物有：桂枝、川乌头、花椒及三虫丸（自拟方：全蝎 20g，蜈蚣 10g，蕲蛇 30g，与大米共炒微黄，去大米，研细末，装入胶囊，每粒 0.5g，每次服 4 粒，1 日服 3 次）。盛氏喜用桂枝、花椒，乃因桂枝不仅擅长发汗解肌，更具温经通脉之功。花椒辛温，除温中散寒之功外，其除寒湿、止痹痛之力尤著。

(3) 清热胜痹法：适用于关节疼痛，局部灼热、红肿，得冷则舒，痛不可触，活动不利，小便短赤，大便坚或秘结，舌苔黄燥，脉滑数，证属热痹者。常用药物有：忍冬藤、地龙干、石膏、知母等，盛氏喜用忍冬藤、地龙干，二药均性寒，具清热通络之功。惟二药药力平和，对热痹者须用较大剂量，一般为 15~20g。

(4) 化湿除痹法：适用于关节重着，肿痛有定处，肌肤麻木不仁，肢体困重不舒，舌苔白腻，脉濡缓，证属着痹者。常用药物有蚕沙、秦艽、苍术、苡仁、海桐皮等。盛氏喜用蚕沙、秦艽，二药除能祛风除湿外，尚有和血活血之功。

(5) 利水渗痹法：适用于着痹患者，因见水湿潴留，颜面及四肢浮肿，肢体肿胀困顿，小便短赤，大便溏薄，舌淡体胖有齿印，苔厚腻或滑，脉沉滑，或沉细。常用药物有：赤小豆、防己、桑枝、茯苓皮、猪苓、泽泻等。盛

氏喜用赤小豆、防己、桑枝，三药除具有祛风除湿作用外，尚有利水之功。

(6) 活血蠲痹法：适用于痹证日久，瘀血内停，关节疼痛顽固不愈，入夜尤甚，或关节肿大变形，活动不灵，或局部青紫瘀斑，面色晦暗，舌质青紫，或有瘀斑，舌腹静脉怒张，或颞粘膜征阳性，脉沉细涩。常用药物有：乳香、没药、桃仁、红花、三七、穿山甲等，盛氏喜用乳香、没药、穿山甲，盖乳没皆入肝经，均具活血散血，消肿止痛之功，临证二药多相辅为用，穿山甲又善搜风活络。

(7) 温经通痹法：适用于寒湿、痰凝瘀滞络脉，静脉循环不畅，症见肢节挛痛，不能屈伸或麻木不仁，冰冷不温，患部漫肿，不红不热，或兼有咳痰粘稠，舌淡胖苔白滑，脉沉滑或细紧。常用药物有：附子、白芥子、鹿角霜、炮姜等，盛氏喜用附子、白芥子，盖因附子辛甘热，具有回阳温经，散寒除湿之功，白芥子辛温，功能温中散寒，通络止痛。附子有毒，虽经炮制后毒性减弱，然如用量较大还是应先煎为妥，盛氏每剂用量一般在6~10g。

(8) 养气血舒筋法：适用于痹证日久，风寒湿邪未净而营卫气血空虚。治疗应以益气养血为主，祛邪舒筋为辅。盛氏临证恒选用参芪益气，四物养血，尤喜用鸡血藤一药。

(9) 滋肝肾通络法：适用于痹证日久，肝肾虚损，筋脉为之不利而症见头晕目眩，耳鸣腰酸，筋骨活动不利，或动则关节作响等。常用药物有：桑寄生、续断、杜仲、牛膝、枸杞、木瓜等，盛氏喜用桑寄生、续断、牛膝，盖因三药均入肝肾经，功能滋肝肾外，尚有调血脉，通利关节之效。

(10) 外用祛痹法：痹证每多致使关节筋络疼痛酸楚，活动受阻，常给患者日常生活带来诸多痛苦和不便。所以

迅速解除患者局部痛苦，也为治痹当务之急，除可配合针灸治疗外，盛氏临证每配合自拟的外用风湿驱痛膏及外用蠲痹方，常收相得益彰之效。

自拟外用风湿驱痛膏：生姜汁 30g，乳没各 10g，木鳖子（去壳）10 枚，蓖麻仁（去壳）12 粒，川花椒 20g，樟脑 10g，白芥子 20g。上药各研细末，用姜汁调匀，以凡士林或粘香适量搅匀，摊膏。将膏药烤热软化贴患处，12 小时换药 1 次。

自拟外用蠲痹方：归尾、红花、桃仁、赤芍、木香各 15g，桂枝、香附、小茴、山奈各 20g，泽兰、益母草各 30g。水煎洗，每次煮沸 10 分钟后加白酒 1 汤匙，熏洗患处；或将上药捣粗末，和粗盐 500g 同炒，热敷患处。每剂药可连续使用 2 天。^[1]

2. 赵长立诊治经验

痹证古今治法，沿习相传，多用温经散寒，从外表散之法，方药多属辛热之品。但从多年临床观察体验，这种治法其效果并不令人满意。赵氏认为这种病即使是风寒湿邪从外袭入，侵害四肢，但要知道正邪相搏，日久则气血瘀闭，经络不通，以致酝酿而成热毒，留滞羁结于关节，故有红肿发热之征，这就是从寒化热之理。故赵氏在临床治疗上，大多不用温经散寒，驱逐风邪，外散之法，而多采取通经活络，化瘀解毒，活血消风，以荣筋节，使风湿热毒从内而消。

药用自制方：防己 14g，乳没各 8g，地龙 23g，红花 17g，银花 20g，蝉蜕 18g，僵蚕 14g，乌梢蛇 15g，蜈蚣 5 条，甲珠 12g，土鳖虫 9g，木瓜 16g，怀牛膝 16g，稀莪草 13g，海桐皮 11g，大贝母 14g，黄柏 14g，元参 25g，赤芍

14g, 郁金 13g, 秦艽 13g, 甘草 6g, 明天麻 (研面三次冲服)。以上诸药, 用水四大碗 (相当 1 000ml), 煎成药汁八分碗一大碗 (相当 250ml), 一次服下, 日 2 服, 每剂药可煎 3 次。小儿量年龄以此方酌减。^[2]

3. 路志正诊治经验

同一痹病, 所患部位不一, 用药应选其善走经脉者: 手臂疼痛者加片姜黄、桑枝、秦艽、山甲珠、桂枝; 下肢疼痛者加松节、木瓜、牛膝; 湿重加防己、木通、黄柏、晚蚕沙; 颈部背部疼痛加羌活、独活、葛根、蔓荆子、防风; 小关节疼痛加丝瓜络、忍冬藤、鸡血藤、天仙藤; 有瘀阻者加白芥子、僵蚕、胆南星; 有瘀血者加桃仁、红花、乳香、没药、片姜黄、赤芍、泽兰; 腰部疼痛加羌活、麻黄、狗脊、杜仲、桑寄生; 关节变形者加骨碎补、自然铜、生牡蛎、补骨脂等。^[3]

4. 赵明锐诊治经验

对于痹证的治疗, 赵氏将其归纳为八法。

(1) 祛风通络法: 用以治疗风盛者。以防风汤 (防风、葛根、羌活、秦艽、桂枝、甘草、当归、杏仁、黄芩、赤芍、生姜)、独活寄生汤、疏风通痹汤 (桂枝、红花、白芷、葛根、羌活、防风、桃仁、防己、秦艽、麻黄、当归)、小续命汤、加味羌活胜湿汤等方剂加减。

(2) 温寒祛湿法: 用以治疗寒盛者。以乌头汤、黄芪桂枝五物汤、桂枝附子汤、术附汤、当归四逆汤、五灵散 (五灵脂、川芎、乳香、没药)、温经通痹汤 (附子、牛膝、桂枝、麻黄、桃仁、红花、没药、千年健、追地风、羌活、防己、苡仁、苍术、川芎、炙甘草)、史国公药酒、大小活

络丹等加减。

(3) 祛湿蠲痹法：用以治疗痹证湿盛者。以薏苡仁汤、蠲痹汤、除湿通痹汤（苍术、防风、羌活、苡米、茯苓、防己、秦艽、茵陈、木瓜、通草、海桐皮、黄柏、牛膝、桑枝、槟榔）、加味行湿流气饮（党参、苍术、白术、当归、茯苓、熟附块、肉桂、羌活、独活、橘皮）等化裁。

(4) 清化湿热法：用以治疗热痹。以白虎桂枝汤、二妙丸、三妙丸、桂枝芍药知母汤、甘露消毒丹等加减。

(5) 益气养血、舒筋通络法：用以治疗痹病虚证。以人参白虎汤、三痹汤、加味虎潜丸、黄芪桂枝五物汤、四君子汤、独活寄生汤、加味黄芪赤风汤（黄芪、当归、赤芍、防风、追地风、千年健、威灵仙、桑枝、桂枝、牛膝、稀莩草、红花、防己）、加味四物汤、蕲蛇蛤蚧汤（蕲蛇、蛤蚧、防风、当归、黄芪、白芍、木瓜、独活、五加皮、威灵仙、桂枝、木香、羌活、川朴）等方化裁。

(6) 祛痰通络法：用以治疗风痰入络者。以加味二陈汤、阳和汤等加减。

(7) 祛瘀通络法：用以治疗瘀血阻络者。以身痛逐瘀汤、加味四物汤（生地、当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、茯苓、牛膝、黄柏、木瓜）等加减。

(8) 补养肝肾法：用以治疗肝肾亏损者。以加味鹿角胶丸（党参、熟地、当归、菟丝子、白术、茯苓、杜仲、枸杞子、肉苁蓉）、狗脊鹿角膏等加减。^[4]

【按语】

风湿性关节炎和类风湿性关节炎的主要区别在于：本病多见于青少年，无明显性别差异，起病急，病变以侵犯

大关节为主，发热、关节红肿热痛、游走性显著。关节肿胀时间短，多在1~6周内自然消肿。无晨僵和肌萎缩，愈后不遗留关节畸形。中医药治疗方法两者有很多相同之处，可以互参。但风湿性关节炎在初期多以热痹为主要表现，因此治疗方药也多从这点着手。盛国荣的治痹十法和赵明锐的治痹八法，简明扼要，对两种类型关节炎的治疗均有指导意义。赵长立采取通经活络、化瘀解毒、活血消风以荣筋节的方法，使风湿热毒从内而消，在治疗上又开辟了一条新路。路志正为治痹名家，从理论到临床都有很大的贡献，此篇节录其在治疗痹病时，根据经脉循行情况而加减用药，颇切临床实用。

(陶晓华)

参 考 文 献

- [1] 柯联才，盛云鹤，盛国荣教授治痹10法，福建中医药，1993，24(5):1
- [2] 赵长立，痹证证治，中医杂志，1989，(4):9
- [3] 路志正，路志正医林聚腋，1版，北京：人民卫生出版社，1990.157
- [4] 赵明锐，用桂枝芍药知母汤加减治疗关节痛，上海中医药杂志，1965，(1):30

强直性脊柱炎

【概述】

强直性脊柱炎又名类风湿脊柱炎。本病为脊柱各关节及关节周围组织的侵袭性炎症。一般先侵犯骶髂关节，其后由于病变发展逐渐累及腰、胸、颈椎，出现小关节间歇模糊、融合消失及椎体骨质疏松破坏、韧带骨化，终至脊柱强直，或驼背固定。主要症状为发病部位疼痛，活动受限。是一种病因不明的常见病。本病多发于我国北方，南方少见。男性发病率约占90%，好发于16~30岁的青壮年。

本病多逐渐发作，初发症状常为反复发作的腰、臀、髋部疼痛及腰僵，间歇性或两侧交叉性出现坐骨神经痛，阴天或夜间加重。病变继续发展则腰臀部疼痛和腰僵变为持续性，腰椎生理弯曲消失。病变累及胸椎和肋椎关节时，可出现背痛，或伴有束带样疼痛，胸椎呈明显后凸的弧形驼背畸形，胸廓的扩张运动受限制。颈椎受累后颈部疼痛及活动受限。约30%的患者四肢关节也被累及，但远端小关节则极少受累。X片骶髂关节的变化最早，呈双侧性，可见骨质疏松，软骨下骨质模糊，关节边缘硬化，关节间隙变窄，软骨下骨呈锯齿状破坏，晚期关节发生骨性强直。脊柱X片可见关节面模糊不清，关节附近骨质疏松，前后纵韧带及其它椎间的韧带钙化或骨化，使脊柱呈竹节样变。

中医学认为，本病属于“骨痹”、“顽痹”的范畴。《黄

帝内经》中就有对本病病机及症状的论述。《素问·痹论》篇云：“骨痹不已，复感于邪，内舍于肾。”“肾痹者，善胀，尻以代踵，脊以代头。”肾主骨，生髓，主藏精，精生髓，髓居骨中，骨赖髓养。肾精充足，骨得髓养，则骨骼坚实；由于素体阳虚，肝肾阴精不足，督脉失养，风寒湿邪乘虚而入，邪恋经脉，痰瘀阻闭经脉，损伤筋骨，气血不畅则发为骨痹。

【名医诊治经验】

1. 朱良春诊治经验

朱氏认为本病的本质是肾督亏虚，其病变部位主要在脊柱、腰尻。腰为肾之府，腰以下为尻，尻亦属肾；又脊柱乃一身之骨主，骨的生长发育又全赖骨髓的滋养，而骨髓乃肾中精气所化生，故肾中精气充足，骨髓充盈，则骨骼发育正常，坚固有力；肾中精气不足，骨骼空虚，则骨质疏松，酸软无力。督脉“循背而行于身后，为阳脉之总督”，“督之为病，脊强而厥”，故本病与肾督密切攸关。由于先天禀赋不足，或后天调摄失宜，致肾督亏虚，则卫阳空疏，风寒湿热之邪乘虚侵袭，深入骨髓骨髓。肝肾精亏，肾督阳虚，使筋挛骨弱而邪留不去，痰浊瘀血逐渐形成，壅滞督脉，邪正混淆，如油入面，胶着难解，终至脊柱疼痛（腰尻、脊背、臀痛），脊椎骨质疏松，脊柱强直，不能直立弯腰，无力支撑躯干，出现龟背畸形的虚实夹杂证候。盖其病理特点是以肾督亏虚为本，寒湿痰瘀阻于经脉为标，治疗宜标本同治，在益肾壮督、荣筋强骨的基础上，蠲痹通督、泄浊祛瘀，俟肾督阳气壮，肝肾精血足，则髓生、

骨健、筋荣，机体抗病能力增强，病情始可逆转。这是本病不同于风寒湿痹治疗之处，临床实践亦证明了这一点。如若片面强调脊柱的强直、变形而专司攻邪，则适得其反，欲速而不达，只有在大力扶正的基础上攻逐痰浊瘀血，方可奏效，且疗程愈长，疗效愈佳。

根据临床经验，朱氏将其分为两大证型。

(1) 肾督阳虚，寒湿瘀阻证：背脊深部冷痛，或刺痛，腰尻处疼痛尤著，可上行至颈及胸椎，下涉臀腿酸痛，得温则痛减；或背脊僵硬、挛痛，活动不利；甚或脊柱严重强直、畸形，不能直立、弯腰、平视；或伴有其它关节疼痛，活动受碍。较常人畏冷，神疲乏力，或纳少便溏，或带下清稀，舌淡紫，苔薄白腻，脉沉细。治宜温肾壮督，散寒通络。处方：鹿角霜、仙灵脾各 10g，生黄芪 30g，补骨脂、骨碎补各 10g，生熟地各 12g，露蜂房 10g，制川草乌各 8g，川桂枝、炙蜈蚣各 10g，炙蜈蚣 3g（研细末分两次吞服），鹿衔草 15g，甘草 6g。每日 1 剂，早晚各服 1 次。另服益肾蠲痹丸（见“类风湿性关节炎”篇），每次 8g，1 日服 3 次，饭后服。加减：寒湿重者，制川草乌改为各 10g 以上，加炙乌梢蛇 15g；背脊拘挛疼痛加白芍 30g，宣木瓜 12g；脊柱刺痛，痛位固定，舌紫，或有瘀斑者加桃仁、红花各 10g；颈椎疼痛明显者加葛根 30g；腰椎痛剧者加地鳖虫 10g，川断 12g，金狗脊 10g；脊柱僵硬、强直者加醋山甲 10g，威灵仙 30g；脊柱畸形者加炒白芥子 12g，皂角刺 15g；对停用激素出现畏寒肢冷者加淡附片、巴戟天各 10g。

(2) 肾督阴虚，湿热瘀滞证：背脊部钝痛，腰、尻、髋部酸着板滞，甚或掣痛欲裂，脊柱强直、畸形，活动严重障碍，形体消瘦，五心烦热，或有低热、口干、肌肉萎

缩，舌红苔薄或薄黄腻，脉细，或细数。治宜滋养肝肾，清化湿热瘀滞。处方：生熟地、败龟甲各 15g（先煎），枸杞子、肉苁蓉各 10g，紫河车、全当归、赤白芍各 15g，鸡血藤 30g，广地龙、炙僵蚕各 10g，川桂枝 8g，青风藤 30g，炙全蝎 3g（研细末分两次吞服），甘草 6g。每日 1 剂，早晚各服 1 次。另加服益肾蠲痹丸，每次 8g，日服 3 次，饭后服。加减：累及其它关节肿痛，舌苔黄腻，湿热邪重者去熟地、龟甲，加土茯苓、生苡仁各 30g，草薢 15g；发热，热毒邪重者，加寒水石 30g，知母 15g，或水牛角 30g；兼见血沉、抗“O”异常者加葎草、虎杖各 30g；阴虚内热明显者，生地用 30g，加炙鳖甲（先煎）、左秦艽各 15g；肝肾精血亏虚明显者，加阿胶（烊服）、山萸肉各 10g；脊柱疼痛明显者加炙乌梢蛇 15g，炙蜂房 10g；强直者加炮山甲 10g。

除内服药物外，尚须配合外治法。对阳虚寒湿型，采用药袋热敷法，具有温经散寒、祛瘀止痛之功效。药袋处方：山柰、羌活、独活、川芎、白芷、徐长卿、青木香、苏木、桂枝、当归、制乳香、制没药、细辛各等分，冰片少许。上药研细末，与淘洗干净的细砂 2 份拌匀，装入布袋内，放锅内隔水蒸半小时取出，叠在另一未蒸之药袋上，放于疼痛处，留置 30 分钟至 1 小时，每日 1 次，10 日为 1 疗程。对阴虚湿热型患者，一般采用中药离子导入法，用自制定痛液（生半夏、生南星、生草乌、生川乌、青风藤等）作药液，每次治疗 30 分钟左右，1 日 1~2 次。此类患者，若局部疼痛虽有灼热感，但仍以温为适者，亦可用药袋热敷法，热敷时间可短些。

此外，指导患者正确的锻炼，对治疗本病具有非常重要的临床意义。让患者有意识地保持生理姿势，站立时尽

量挺胸、收腹或两手叉腰，避免习惯了的伛偻驼背姿势，坐时尽量挺直腰板，写字时椅子要低、桌子要高，宜卧硬板床，用低枕头，注意经常更换姿势，或稍事活动，切忌长时间固定一个姿势。另外，每日做两次矫正畸形操，包括深呼吸、扩胸，颈椎、腰椎的旋转，脊柱的弯曲、侧体，下肢的抬腿伸肌等。通过以上活动可以减轻患者痛苦，改善功能活动，避免和纠正畸形，当然须根据患者的具体情况，从少量、短时间至逐步增量适应，循序渐进，持之以恒，必能收效。^[1]

2. 娄多峰诊治经验

娄氏认为本病的病理关键是肝肾亏虚，复受风寒湿邪侵犯，致经脉（主要是督脉）受阻，发为该病。治疗必须以滋补肝肾，疏督壮骨，通络祛邪为主。早期应偏重祛邪，拟用强脊宁一号汤（经验方）；中、晚期以上以壮补肾督为主，拟用强脊二号汤（经验方）。

娄氏对于强直性脊柱炎主张采取分期治疗：早期：病程较短，体质较好，邪实较突出。此时病邪以风寒湿或风湿热为主，肝肾虚征象不太突出（但补肾这一大法仍不能忽视）。痰瘀表现也不太明显。治以祛风除湿、舒筋通络、活血定痛、滋补肝肾。用经验方强脊一号汤加减。中晚期：病程长，病人体质较差。以正虚为主，病邪相对不突出。腰椎及其它关节功能明显受限。X线见病变骨关节明显破坏或融合。此时病人以肝肾亏虚或兼气虚为主，痰瘀征象已见端倪，病邪相对不突出（多为虚中夹实）。治以补益肝肾、强筋壮骨、养血活血、祛风除湿、通络止痛。方用强脊宁二号汤加减。

对本病的治疗，除药物外，娄氏提出还应注意以下几

点：①避风寒湿邪侵袭及精神刺激；②注意姿势：行走时应注意挺胸、抬头，保持正常人直立姿势，不要弓腰、叩肩。要睡硬板床，不要睡“席梦思”等软床。卧睡时不要侧卧、弓腰、屈膝（尽管这种姿势使人感到舒服），应采取仰卧或俯卧位。③劳逸适度：过度劳累，使骨关节破坏，易形成残废；过度强调休息，易使骨关节丧失活动功能，也将造成残废。根据临床经验，在疼痛能忍受的情况下，注意保持关节的功能活动，这样既有利于疾病的恢复，又有利于保持关节的功能，防止或减少残废的发生。病人一般不要全休，应该作一些一般性的工作。④饮食：少食动物油脂。⑤综合治疗：包括内治与外治、理疗与按摩等。^[2]

3. 高根德诊治经验

高氏采用内外合治并结合功能锻炼的方法治疗本病，具体方法是：①内治方：露蜂房 10g，白芥子 6g，海藻 9g，昆布 9g，炒牛蒡 9g，山甲片 6g，血竭 3g，生黄芪 60g，当归 12g，葛根 12g，桂枝 6g，枸杞子 30g。每日 1 剂，水煎内服，早晚各 1 次。一般以 30 剂为 1 疗程，连服 2 个疗程。②外治方：川椒目 30g，羌活、独活各 15g，制川乌、制草乌各 5g，制半夏 15g，海藻 30g，昆布 15g，木瓜 15g，鸡血藤 30g，胆南星 9g，制扶筋 30g，桂枝 15g。上药纱布包之，用水 3kg，煎 20 分钟，倒入浴缸温水中，水量以能浸泡整个人体为度。每次浸浴半小时，每周 2 次。每料中药可用 3 次。无不良反应者，可连续浸浴 16 次。③功能锻炼：痹患者每日作脊柱的伸、屈、按跷转动练习。晚上卧硬板床，以防脊柱后凸畸形强直。

强直性脊柱炎属于中医学的骨痹、龟背。患者体内气血津液运行失常，痰浊内生，流于经络，伏于督脉则病发

龟背。痰浊流于骨节筋络，阻滞气流通，不通则痛，故引起腰脊疼痛。正气不足则多有畏寒、面色㿔白之虚象。治宜扶正化痰，脊柱诸韧带的慢性进行性骨化，此乃“结”也。用中药软坚散结，为一独特疗法。运用露蜂房、白芥子、炒牛蒡祛痰；海藻、昆布软坚散结；山甲片性专行散，能通经络；血竭味咸能消、行瘀止痛；生芪、当归补虚，其配伍与本方甚切。高氏还用外治法配合内治法。外治法在祛痰软坚药的基础上加入温通祛风之药，主要针对本病患者多有转侧不利、畏寒、抽筋感等表寒证，治标可速效。病人药浴后均觉诸韧带松弛舒服，这样也利于功能锻炼。^[3]

4. 朱晓鸣诊治经验

(1) 祛风散寒法：发病早期，主要表现为骶髂关节、脊柱及四肢疼痛，痛处固定，遇寒加重，夜间尤甚，活动受限，翻身困难，晨僵，脉弦紧。病变活动时，可见血沉增快，细胞反应蛋白增高。朱氏认为此期主要为风寒湿邪侵袭，气血痹阻不通，以邪实为主，故治以祛风散寒除湿法，常用制川乌、防风、威灵仙、豨薟草、透骨草、千年健、寻骨风、苡仁、石楠藤、桑寄生、川芎等。

(2) 活血祛风法：本病具有痛处拒按，部位固定，日轻夜重，转侧不利，翻身困难，清晨或坐后起立时腰背僵硬尤甚，活动后可缓解等证候特点，说明本病存在不同程度的气血凝滞和经络不通，处方用药时应酌加活血药，取其“治风先治血，血行风自灭”之意，既可缩短疗程，又有显著的止痛作用。朱氏常用川芎、红花、当归、血竭、穿山甲、乳香、土元等药。

(3) 补益肾督法：本病病变主要在腰骶部及脊柱，随着病情的发展，骨质受损严重，易出现脊柱强直和畸形，

发生功能障碍。腰为肾之府，肾主骨生髓；督脉总督一身之阳，贯脊直上，故肾督空虚是本病的内因，风寒湿邪乘虚侵袭是外因，内外合邪形成本病。因此，补益肾督应贯穿于治疗过程始终。朱氏常用生熟地、山萸、桑寄生、淫羊藿、狗脊、杜仲、续断、鹿角胶、制附子等药。

(4) 搜风通络法：强直性脊柱炎发病后既有腰脊强痛，转侧不利，又有遇风寒则痛甚等症状，说明风邪不但客入足太阳经、足少阴经，也入督脉。发病后往往内外合邪，表里俱病，因此，部分病人病情顽固，邪伏较深。经络闭塞不通者，草木之品难以宣达，朱氏常于方中加入虫蚁之类搜风通络，使经络通行，邪去不复，疗效大增，常用白花蛇、蜈蚣、全蝎等药搜剔窜透。

(5) 化痰通络法：部分病人由于反复不愈，久病人络，经络不通，气血壅滞，致津液不能正常输布，凝聚成痰，痰瘀互结，阻闭经络，深入骨髓，故可见到关节肿胀、畸形，舌淡紫，苔白腻，脉沉涩等痰瘀交阻症状。配伍化痰药物可有助于消除关节肿胀等症状，常用白芥子、半夏、南星、白术等药。^[4]

5. 幺远等诊治经验

(1) 肾主骨生髓，督脉行于背正中，总督一身之阳气，肾气不足，骨髓不充，督脉失养，风寒湿邪乘虚而入，内外合邪，使气血运行不畅而致腰背、关节疼痛，活动不利。小儿脏腑娇嫩，形气未充，卫外不固，更易受风寒湿邪侵袭。因此，肾气先虚是致病之本。

(2) 成人强直性脊柱炎是以脊柱的疼痛、僵硬、强直甚或畸形为主要表现。当即中医的骨痹、龟背风、肾痹。而儿童强直性脊柱炎主要以下肢关节炎为主，多表现髋、

膝、踝关节肿胀疼痛、活动受限，腰背症状表现轻微，很少发生僵硬强直，故属强直性脊柱炎早期阶段，应为“骨痹”。其本质是肾气亏虚，而多表现寒湿或湿热阻络所致关节肿痛、活动受限的标实之象，所以中医治疗既要遵循“急则治其标”的原则，祛风散寒，除湿通络，又要本着“治病必求其本”的理论，补肾壮骨，强壮腰脊，标本兼治。

(3) 根据中医理论及临床证候特点，我们选用独活寄生汤加减治疗。以独活、寄生、青风藤祛风除湿，活络通痹；川断、杜仲、狗脊补肾填精，强腰壮督；佐以桂枝、生苡仁温经化湿通络；秦艽、威灵仙祛周身风寒湿邪。诸药合用，风寒湿邪得去，经脉血气得充，肾气充实，督脉通畅，标本兼顾，正扶邪祛，则诸证自愈。再针对病因加减，寒湿加附子、细辛通阳散寒开痹，湿热加用生地、知母清热除烦。“久痹多瘀”，“痹多夹瘀”，酌情选用活血及虫类药物可化瘀通络，剔除顽邪。^[5]

6. 陆肇中诊治经验

陆氏根据中医辨证，强直性脊柱炎多属于正虚邪实之“骨痹”症，主要病机为肾虚，外感风寒湿邪，痰瘀痹阻等作为辨证论治基础，将之分为以下几种类型：

(1) 阳虚型：辨证要点：面色㿔白，畏寒肢冷，气短多汗，腰骶部痛，小便清利，大便溏，舌质淡嫩，苔白，脉沉细。治则采取扶正固本，温阳补气，化痰通痹。方以阳和汤、真武汤合方化裁。用药：熟地黄、肉桂、炮姜炭、鹿角胶、太子参、白术、云苓、甘草、炮附子、白芍、牛膝、川断、威灵仙、白花蛇舌草、鸡血藤、蜈蚣、山甲、生姜，随症加减。

(2) 肝肾阴虚型：辨证要点：形体消瘦，腰膝酸软，肢体有热感，咽干舌燥，五心烦热，重者盗汗，便燥溲赤，舌质红绛瘦小，苔薄，脉沉细，或弦数。治则：滋肾柔肝，健脾补血，活血化瘀，搜风通痹。方以左归饮、二至丸、当归补血汤合方化裁。用药：熟地黄、山药、枸杞、云苓、女贞子、旱莲草、山萸肉、炙黄芪、当归、元参、贝母、鹿角胶、郁金、鸡血藤、秦艽、蜈蚣，随症加减。

(3) 寒湿型：辨证要点：关节肿胀，腰骶冷痛，遇寒及阴天加重，肢体沉重僵麻，小便不利，恶风不欲去衣，神疲乏力，舌质淡胖，苔白或腻，脉弦紧或濡。治则：温经助阳，搜风散寒，健脾利湿，化痰蠲饮，活血通痹。方以甘草附子汤、防己黄芪汤、苓桂术甘汤合方化裁。用药：炮附子、云苓、桂枝、白术、防己、黄芪、白花蛇舌草、郁金、三棱、莪术、白芥子、蜈蚣、牛膝、川断、炙甘草、大枣、生姜，随症加减。

(4) 风胜型：辨证要点：腰膝酸痛，痛无定处，恶风，舌淡苔薄或腻，脉浮缓或弦。治则：搜风补血，活血化瘀止痛，益肾壮骨。方以羌活胜湿汤化裁。用药：羌活、独活、防风、全虫、僵蚕、蜈蚣、当归、黄芪、五加皮、鸡血藤、细辛、地龙、杜仲、枸杞、牛膝、川断、青风藤、威灵仙，随症加减。

(5) 痰瘀痹阻型：辨证要点：病程一般很长，关节僵直疼痛伴麻木，或关节活动受限、强直变形，舌质紫暗有瘀斑，苔白或腻，脉弦涩，或小，或滑。治则：扶正固本，软坚散结，搜风化痰，活血化瘀通痹。方以大活络丹化裁。代表方药：胆南星、木香、白附子、白芥子、云苓、虎杖、威灵仙、枸杞子、竹叶、青风藤、伸筋草、蜈蚣、全虫、僵蚕、牛膝、狗脊、鸡血藤、炙甘草、大枣、生姜。

(6) 寒热错杂型：辨证要点：有腰骶四肢关节痛且固定，遇寒加重等寒证，但同时又有口苦或酸、目赤等上焦火盛，舌质红，苔黄，脉弦数，或舌质淡胖，苔白，脉迟缓，脉症不符等证候。单纯的寒证或热证均少见，临证多见寒热错杂证候。此型又可细分为以寒为主或以热为主两小型。治则：清上焦火，温下焦寒，并酌予搜风、活血、利湿。方以桂枝芍药知母汤、清心莲子饮合方化裁。用药：桂枝、芍药、知母、附子、防风、麻黄、白术、太子参、地骨皮、麦冬、石莲子、枯芩、秦艽、竹叶、牛膝、蜈蚣、大黄、土元、大枣、生姜，随症加减。^[6]

7. 尹玉茹诊治经验

尹氏认为强直性脊柱炎在病程上可分为早、中、晚期，但根据临床实际分隐匿期、活动期、稳定期三期辨证论治更为适宜。

(1) 隐匿期（风寒湿邪侵袭）：患者多由感受风寒湿热之邪而发，表现为腰骶部酸楚疼痛，活动不便，或痛连项脊，或下肢关节肿痛，痛呈游走性，晨起明显，舌淡红，苔薄白，脉弦。病变 X 线表现多不明显，常需 CT 确诊。实验室检查多无异常。治法：祛风化湿，散寒通络。处方：秦艽 20g，独活 20g，羌活 15g，土茯苓 20g，薏苡仁 20g，威灵仙 15g，川牛膝 18g，川芎 12g，王不留行 15g，细辛 6g。若恶风寒等表证明显，加防风、桂枝；项背强痛，加葛根。

(2) 活动期（湿热毒瘀内盛）：症见腰骶疼痛剧烈，难以俯仰坐立，痛处灼热，或伴下肢关节肿痛，口干，汗多，舌质红，苔黄腻，脉滑数。实验室检查可见细胞反应蛋白阳性，免疫球蛋白多数增高，血沉可增高。治法：清热利

湿解毒，活血通络。处方：黄柏 12g，银花 30g，板蓝根 20g，土茯苓 20g，虎杖 20g，川牛膝 18g，薏苡仁 20g，川断 20g，赤芍 15g，白芍 15g，独活 15g，地鳖虫 9g，生甘草 6g。若下肢关节肿甚，加泽泻、车前草；伴发热加丹皮、生石膏；遇阴雨天加重，加羌活；若畏寒明显等属寒热错杂者，加桂枝、细辛；痛甚加川椒。

(3) 稳定期（肝肾亏虚，痰瘀阻络）：症见腰骶及颈项僵硬，晨起尤甚，痛势隐隐，胸闷心悸，头晕眼花，膝软无力，或伴发热，大便干，舌红少苔，脉沉细数。实验室检查多无异常。治法：滋补肝肾，化痰逐瘀。处方：狗脊 20g，生地 20g，川断 15g，骨碎补 12g，蜂房 9g，鹿衔草 15g，乌梢蛇 10g，水蛭 6g，皂角刺 15g，苏木 10g，泽泻 10g。若见畏寒肢冷，便溏溲清者，加川乌、桂枝；少气乏力，自汗明显者，加黄芪；筋脉拘挛不伸，加白芍；腰部僵硬感明显，加白芥子、穿山甲；低热者，加丹皮、地骨皮。

尹氏认为该病以肾精亏虚为本。患者多为青少年男性，肾精未充，阳强妄动，多属于阴虚阳亢之体。或遇后天失养，房劳所伤，均可使肾精更亏。肾与膀胱相表里，肾精亏虚，表阳不固，易招致风寒湿热诸邪首犯太阳，出现隐匿期的太阳经证，此时当以散邪为主；邪气久郁不解，或遇阴虚阳盛之体，从阳化热，均可化生热毒，痹阻经脉，阻滞气血，形成湿热毒瘀互结的活动期证候。患者多以此期就诊，宜选用甘寒之品清热解毒利湿而顾护阴液；至于稳定期，则以肝肾亏虚、骨节失养为主，形成正虚邪恋的证候特征，宜滋补肝肾为主，佐以虫类动物药搜剔痰瘀而建功。同时注意活血化瘀，当贯穿始终，随症轻重选择用药。^[7]

8. 胡仁俊等诊治经验

胡氏重用川乌、草乌治疗本病有较好效果。具体方法是：组方1（制川乌10~30g，制草乌10~30g，甘草10~30g，干姜6~10g，桂枝6~10g，淫羊藿10~30g，延胡索10~20g，云茯苓10~20g，乌梢蛇10~45g，当归10~20g，桑寄生10~20g，葛根10~20g）服3剂后，改服组方2（组方1去制川乌、制草乌，加泽泻10~30g，木通10~20g，玉米须10~30g），然后组方1和组方2交替服用。煎药时应将制川乌、制草乌、甘草先煎3小时。

川乌、草乌在《本草经》、《药典》中皆谓有大毒，经作者多年临床体会，只要配伍、煎服法合宜，虽量大，但效果显著、迅速而不中毒，用之不当即使小量也会中毒。重用川草乌，配伍以等量生甘草先煎，时间不小于3小时，则其毒解效存。如上方服用3剂疼痛缓解，此时可停用川草乌，加泽泻10~30g，木通10~20g，玉米须10~30g，以甘淡渗泄使其身内之药毒渗泄，防止逐渐蓄积为害，以上方交替使用，可达到治疗效果。^[8]

9. 盛远航诊治经验

盛氏对强直性脊柱炎的治疗，主要着眼于以下四点：

（1）清热解毒：多数患者起病隐匿，早期可有腰、背、臀或髋部间歇性隐痛、僵硬感及坐骨神经痛等表现，但因症状较轻，易被患者忽视。待症状明显时，病邪已郁久化热、日积成毒。患者可表现为腰、背、髋部疼痛剧烈，俯仰坐立困难，局部有明显灼热感，上下肢关节肿痛明显，并伴发热口干，舌红、苔黄腻，脉滑数等症。故治疗应以清热解毒为主，适当选用忍冬藤、金银花、蒲公英、土茯

芩、白花蛇舌草、车前草等药。此类药物以甘寒为主，无苦寒药伤阴败胃之虞。

(2) 化痰通络：由于病邪痹阻经络，气血津液受阻，可导致痰瘀内生；日久湿热毒邪胶结，阴液更伤，痰瘀更甚，导致病变部位刺痛明显，僵硬如板，活动受限，部分患者尚可出现关节肿胀，积液停聚，X线摄片可见病变关节有明显的增生和钙化。治疗应以化痰逐瘀、散结通络为主，可适当选用半夏、贝母、南星、山甲片、僵蚕、蜈蚣、全蝎等药。此外，对关节积液不易清除者，还可加泽兰、泽泻两药。其中泽兰以活血祛瘀见长，泽泻以利水渗湿功胜。两药合用，能使血脉通畅，积液消除。

(3) 祛风养血：由于风寒之邪凝聚经络，可致气血受阻不畅，营卫失和。表现为腰骶、胸椎疼痛，痛连颈项，或背凉恶寒，肢节游走性疼痛，或晨起腰骶、项背僵痛，活动受限，得温痛减。治疗应以祛风化湿，养血通络为主，可选用制附片、桂枝、羌活、独活、红花、生黄芪、桃仁、川芎、细辛、苡仁等药。

(4) 补益肝肾：可适当选用牛膝、川断、金狗脊、当归、生地、黄芪等药物，待病情及体质稍有改善后，再酌加龟甲、鳖甲、紫河车、鹿角胶等以增强滋补力度。

每例患者可另加雷公藤 8~25g。服法有两种：一种是连续服用一段时间，待患者病情明显改善后，再逐步减停其量；另一种是加用较大剂量雷公藤数日，待疼痛稍减后，即停用此药，余药续服。并配合应用绿豆、生甘草煎服，以渗泻其毒。数日后仍在原方中加入雷公藤续服，如此循环反复。雷公藤有通瘀阻、清络热、除络毒之功，是治疗本病不可多得良药，但因其毒性甚大，故而使用时应严格做到去皮入药，并先煎 1~2 小时以减小其毒性。^[9]

10. 张恩霖诊治经验

治疗方法：①全部病例均给予雷公藤煎剂 12~15g/d，部分病人用至 20g/d；14 岁以下病人按 1 岁 1g 的剂量给予，一般最大量在 12g/d。仍按传统的文火久煎法，分 2 次服用。同时配合中药补肾通痹汤：独活、寄生、杜仲、牛膝、枸杞、补骨脂、黄芪、鸡血藤、生地、赤芍、丹参。每日 1 剂，药味及剂量随症加减。②停用其它有关治疗风湿病的中西药。对治疗期间出现的上呼吸道感染适当给予抗生素治疗。③全部病例均以半个月为 1 个疗程，均治疗 1~4 个疗程。1 个疗程后症状、体征无变化者判为无效。

此法标本兼顾（补肾通痹方补肾壮腰、祛风除湿、活血通络；雷公藤祛风除湿散寒，活血通络止痛），前者可防后者峻猛燥烈，损伤气血，故而治疗中副反应较单用雷公藤减少。^[10]

11. 周时高等诊治经验

治疗方法：内服益肾温督，化痰活血通络方（自拟方）：仙灵脾 30g，巴戟天 20g，鹿角胶 12g，狗脊 12g，桑寄生 12g，熟地黄 12g，生黄芪 30g，红花 6g，白芥子 30g，金雀根 30g，当归 9g，杜仲 12g，淮牛膝 9g，生南星 12g，制川乌 6~9g，赤芍 12g。上方每日 1 帖，水煎服。加减：疼痛剧烈者，加露蜂房 20g，细辛 12g，川芎 30g，蜈蚣 2 条；关节僵直明显者，加炮山甲片 12g，威灵仙 12g；风寒湿盛者，加青风藤 30g，防风 12g，猪苓 30g，茯苓 30g，制草乌 6g。治疗期间，若合并外感则兼治外感，或先治外感，待外感之邪去后续予本方治疗。同时予白芥子 500g，面粉 250g，水调，或黄酒调成糊状，做成薄饼（大小根据

病变关节范围而定), 纱布隔层, 敷于病变处, 外照射以红外线、频谱或微波等, 每日1次, 每次40分钟, 30天为1个疗程, 部分病例根据病情可重复2~3个疗程。

作者认为脊痹乃由于先天肾阳气虚, 督脉失于温养, 致寒邪凝滞, 日久凝痰成瘀, 致脊柱骨痛、僵硬、强直、变形。故提出益肾温督、化痰活血通络为本病的基本治则。自拟基本方中, 重用仙灵脾、鹿角胶、巴戟天以温肾; 狗脊、桑寄生、杜仲、牛膝补肝肾、祛风湿; 当归、赤芍、红花活血通络; 制乌头、金雀根逐寒祛风湿; 重用白芥子、生南星以搜痰剔络。同时, 予白芥子研末外敷, 既可温散痰结, 亦可促进机体自身免疫调节作用。统计学表明, 该法可有效地改善患者的关节疼痛、晨僵、关节活动度及血清免疫球蛋白水平。^[11]

12. 赵金华诊治经验

内服方: 露蜂房 10g, 白芥子 7g, 巴戟天 15g, 淫羊藿 15g, 昆布 10g, 枸杞子 30g, 穿山甲 7g, 川芎 9g, 生黄芪 60g, 当归 12g, 独活 9g, 葛根 12g, 桂枝 6g, 五加皮 12g, 甘草 6g, 南蛇藤 30g。每日1剂, 水煎内服, 早晚温服。30剂为1疗程。

中药外洗方: 花椒 30g, 羌活 15g, 独活 15g, 制川乌 10g, 制草乌 10g, 老鹳草 20g, 木瓜 15g, 鸡血藤 30g, 胆南星 10g, 伸筋草 30g, 桂枝 15g, 制马钱子 10g。上药水煎30分钟, 将药液倒入盆中, 待药液温和后擦洗患部, 每日擦洗1次, 每次30分钟, 30次为1疗程。每剂中药可重复使用2~3次。

功能锻炼: 嘱患者每日作脊柱的伸、屈、旋转运动练习。晚上仰卧, 或俯卧硬板床, 以防脊柱后凸畸形。^[12]

13. 王爱成诊治经验

王氏采用督灸方法治疗强直性脊柱炎，别具一格。取穴：督脉上大椎穴至腰俞穴（脊柱部位）。令患者裸背俯卧于床上，在施灸部位常规消毒后涂上姜汁，洒上督灸中药粉，呈线条状于脊柱上，之后敷贴桑皮纸，桑皮纸上再铺姜泥呈梯形，最后在姜泥条上铺放艾炷如同乌梢蛇背脊三角锥形，以线香点燃艾炷的头、身、尾三点，任其自燃自灭，1壮灸完后，更换第2壮，依次灸完3壮。治疗结束后，移去衬隔物，用湿热毛巾轻轻揩干净。经灸后皮肤红润，或有少许水疱。无需做特殊处理。^[13]

14. 帖秦等诊治经验

作者采用健脾益气法治疗本病取得较好效果。具体治疗方法：口服刺五加片，每次6~8片，每日3次，连服3个月。汤剂以健脾益气为主，辅以祛风通络，药用黄芪、桂枝、白芍、茯苓、白术、制川乌、细辛、狗脊、防风等。湿热型去桂枝，加黄柏、知母；血瘀型加丹参、红花；血虚型加枸杞、熟地。每日1剂，水煎服，连服2~3个月。同时配合腰椎功能锻炼。

作者认为强直性脊柱炎多由正气虚弱，卫外不固，风寒湿邪侵袭所致。本病病程长，痛苦大，多数患者需长时间服用止痛药物。但该类药物多有发汗和刺激作用，易伤卫气和肠胃，导致脾胃虚弱，运化无力，使病情加重，或缠绵难愈。脾胃为后天之本，扶正应以健脾益气为先，使正气复，邪气退。故选用刺五加、黄芪、白术、茯苓健脾益气固表为主药；制川乌、细辛、防风祛风通络止痛为辅药；狗脊祛风强腰，白芍缓急止痛为佐使药。诸药合用标

本兼治。现代医学认为强直性脊柱炎是一种慢性全身性自身免疫性椎关节病。研究表明,健脾益气药物,大多有免疫调节作用,有助于清除免疫复合物,达到控制脊柱炎症,消除症状之治疗目的。^[14]

【按语】

综合以上诸位医家的经验,主要反映在以下几个方面:

1. 病因病机方面

多数医家认为本病之发生取决于正邪两个方面。如朱良春认为肾督亏虚为本,寒湿痰瘀阻于经络为标,两者相兼而发病。娄多峰认为本病的关键为肝肾亏虚,复受风寒湿邪侵犯,致经脉(主要是督脉)受阻而发病。同时还强调七情、劳逸等因素在该病治疗过程中的关键作用。高根德提出痰浊亦为本病的致病因素,为治疗方法开辟了新的思路。朱晓明强调了风邪在致病中的作用并相应采取祛风之法。“风为百病之长”,其它邪气为病多易与之兼夹,在辨证论治基础上添加祛风剂,或对于久治无明显作用之病例适当加用搜风之品当为可取之道。么远等着重讨论儿童强直性脊柱炎的特点:小儿脏腑娇嫩,形气未充,卫外不固,更易受风寒湿邪侵袭。临床症状主要以下肢关节炎为主,多表现髋、膝、踝关节肿胀疼痛、活动受限,腰背症状表现轻微,很少发生僵硬强直,故属强直性脊柱炎早期阶段。治疗既要祛风散寒,除湿通络,又要补肾壮骨,强壮腰脊。帖泰等认为本病多由正气虚弱,卫外不固,风寒湿邪侵袭所致,强调脾气虚弱在发病中的作用。

2. 治疗方面

朱良春认为宜标本同治，在益肾壮督、荣筋强骨的基础上，蠲痹通督，泄浊祛瘀。只有在大力扶正的基础攻逐痰浊瘀血，方可奏效，且疗程愈长，疗效愈佳。他把该病划分为肾督阳虚、寒湿瘀阻证和肾督阴虚、湿热瘀滞证两大证型，分别运用温肾壮督、散寒通络和滋养肝肾、清化湿热瘀滞的方法，同时配合了外洗法和功能锻炼。

娄多峰认为治疗当以滋补肝肾、疏督壮骨、通络祛邪为主，早期偏重祛邪，中、晚期偏重扶正。并将该病分为早、中、晚三期辨证治疗。

高根德、赵金华均从内治、外治、功能锻炼三方面论治，高氏针对“痰”这一病因，着重扶正化痰，选方用药多为软坚散结之品。外治方在祛痰软坚的基础上加入温通祛风之药，可获较好的效果。周时高等亦从内外合治立论，外治方中采用白芥子外敷，既可温散痰结，又可促进机体自身免疫调节作用。

朱晓鸣提出的五种治法基本概括了强直性脊柱炎的治疗法，具有较好的临床指导意义。

陆肇中将本病分为六型辨证施治（阳虚型、肝肾阴虚型、寒湿型、风胜型、痰瘀痹阻型、寒热错杂型）。

尹玉茹认为根据临床实际本病分隐匿期（风寒湿邪侵袭）、活动期（湿热毒瘀内盛）、稳定期（肝肾亏虚、痰瘀阻络）三期辨证论治更为适宜。

胡仁俊、胡为斌重用川乌、草乌（10~30g）治疗本病有较好效果。川、草乌在《本经》、《药典》中皆谓有大毒，一般不宜用如此大量。但作者体会，只要配伍、煎服法合宜，虽量大，而效果显著、迅速而不中毒，用之不当即使

小量也会中毒。重用川、草乌，配伍以等量生甘草先煎，时间不小于3小时，同时配用泽泻、木通、玉米须等药淡渗排毒，则其毒解效存。但川、草乌毒性甚大，临证应用此法还须谨慎。

盛远航、张恩霖均在辨证论治方中加用大剂量雷公藤。雷公藤治疗各种风湿性疾病均有成功报道，但关键是久服易致毒副作用。盛氏采用去皮入药，并先煎1~2小时以减其毒性，并配合应用绿豆、生甘草煎服，以渗泄其毒。张氏则采用传统的文火久煎法。这些均可参考。

王爱成采用督灸法治疗本病，别具一格。这也和诸医家强调的肾督亏虚的发病机理相一致。

帖泰等强调健脾益气法的作用，现代医学认为强直性脊柱炎是一种慢性全身性自身免疫性椎关节病。研究表明，健脾益气药物，大多有免疫调节作用，有助于清除免疫复合物，达到控制脊柱炎症，消除症状之治疗目的。

(陶晓华 刘夕明)

参 考 文 献

- [1] 朱建华，朱婉华. 强直性脊柱炎的中医证治. 江苏中医, 1992, (11): 21
- [2] 娄高峰，娄玉铃. 中国名老中医药专家学术经验集·立虚邪瘀说的治痹名家娄多峰. 贵阳：贵州科技出版社，1995. (2): 398
- [3] 高根德，程春葵. 扶正化痰法为主治疗强直性脊柱炎. 上海中医药杂志, 1991, (9): 15~16
- [4] 夏俊杰，朱晓鸣治疗强直性脊柱炎的经验. 湖北中医杂志, 1997, 19 (6): 10~11
- [5] 么远，马松春，卢燕，等. 中医辨证治疗儿童强直性脊柱炎 34 例. 北京中医, 1997, 16 (1): 29~30
- [6] 陆肇中. 强直性脊柱炎的辨证论治. 天津中医, 1996, 13 (3):

19~22

- [7] 姜萍, 尹玉茹诊治强直性脊柱炎经验. 江苏中医, 1997, 18 (4): 6~8
- [8] 胡仁俊, 胡为斌. 重用川乌、草乌治疗强直性脊柱炎 80 例. 上海中医药杂志, 1998, (1): 30
- [9] 盛远航. 强直性脊椎炎辨治体会. 浙江中医杂志, 1998, 33 (5): 214
- [10] 张恩霖. 雷公藤配合中药治疗强直性脊柱炎 68 例. 福建中医药, 1996, 27 (2): 12
- [11] 周时高, 陈湘君, 苏励. 中药内外合治强直性脊柱炎 20 例. 南京中医学院学报, 1999, 15 (3): 181
- [12] 赵金华. 中药内服外洗配合功能锻炼治疗强直性脊柱炎 36 例. 广西中医药, 1999, 22 (2): 21
- [13] 王爱成. 督灸治疗强直性脊柱炎. 中国中西医结合风湿病杂志, 1998, 7 (3): 17
- [14] 帖泰, 宋晓光. 健脾益气法治强直性脊柱炎临床观察. 中医正骨, 1998, 10 (6): 42

痛 风

【概述】

痛风是一组由于嘌呤代谢紊乱所致的疾病。其临床特点为高尿酸血症，及由此而引起的痛风性急性关节炎反复发作，痛风石沉积，痛风石性慢性关节炎和关节畸形。常累及肾脏引起慢性间质性肾炎和尿酸肾结石形成。本病病程漫长，后期常并发肾功能衰竭、动脉硬化、冠心病、脑血管意外等。

据血中尿酸增高原因本病可分为原发性和继发性两大类。原发性痛风的病因，除少数由于先天性嘌呤代谢紊乱所致属遗传性疾病外，大多数原因尚未阐明。继发性痛风的病因，可由肾脏病、白血病、药物等多种原因引起。本病好发于男性和绝经期妇女，男性多于女性，男女之比约为 20 : 1。

根据本病以关节红、肿、热、痛反复发作，关节活动不灵活为主要临床表现，属于中医学“痹证”范畴。《医学准绳六要·痛风》云：“痛风，即《内经》痛痹。”《血证论》云：“痛风，身体不仁，四肢疼痛，今名痛风，古曰痹证。”中医认为本病的主要病因乃是暴食膏粱厚味，以致湿热内蕴，兼见外感风邪，侵袭经络，气血津液运行受阻，年老体虚，精气渐衰，脏腑功能失调。其病机关键是风湿痰瘀，痹阻经络。

【名医诊治经验】

1. 朱良春诊治经验

朱氏根据长期临床观察，结合痛风的以下重要表现，如患病率随年龄而渐增，多有阳性家族史；其人每形体丰腴，平素嗜酒，善食肥甘厚味；关节发病夜半居多，主要位于下肢末端，日久可见痛风结节，或溃流脂浊，或伴“石淋”腰痛尿血，甚而“关格”尿闭等，指出痛风的病因病机乃浊毒瘀滞使然，其名为风而实非风，症似风而本非风。他说：痛风浊毒滞留血中，不得泄利，初始未甚，可不发病，然积渐日久，愈滞愈甚，或偶逢外邪相合，终必瘀结为害，或闭阻经络突发骨节剧痛，或兼夹凝痰变生痛风结节，久之，痰浊瘀腐则见溃流脂浊，痰瘀胶固以致僵肿畸形。由于郁闭之邪最易化热，其证又多见热象，如湿浊蕴热，煎熬尿液，可见石淋尿血；浊毒久稽，损伤脾肾，寒热错杂，壅塞三焦，而有“关格”险恶之证。凡此种种，皆浊毒瘀滞为殃，非风邪作祟之征。

朱氏进一步指出，此浊毒之邪非受自于外，而主生于内。盖痛风患者，多有先天禀赋不足，或年迈脏气日衰，若加不节饮食，沉湎醇酒，恣啖膏粱肥甘厚味，长此以往，即会引起脏腑功能失调，其中脾肾之脏清浊代谢的紊乱尤为突出，脾失健运，升清降浊无权，肾乏气化，分清别浊失司，于是不归正化，浊毒随之而生，滞留血中，终则瘀结为患。

朱氏主张，痛风诊断一经明确，治疗便应恪守泄化浊瘀这一大法。临床上常用土茯苓、萆薢、生苡仁、泽兰、泽泻、全当归、桃仁、红花等药为基础方，取降泄浊毒与

化痰活血药物为主进行配伍，如此可促进浊毒之泄化，解除瘀结之机转，推陈致新，增强疗效。方中常参入祛风通络之品，如稀莪草、徐长卿、威灵仙、老鹳草、鸡血藤、乌梢蛇、广地龙等，盖风药可胜湿浊，通络能利瘀化，况痛风每有骨节痹痛也。其加减为：湿浊重者，加苍术、蚕沙、车前；血瘀甚者，加赤芍、地鳖虫、丹参；湿浊蕴热者，配以三妙丸、汉防己、秦艽；痹甚痛剧者，配以全蝎、蜈蚣、炒玄胡、六轴子。若兼夹凝痰，见关节漫肿，结节质软，则加僵蚕、白芥子、陈胆南星等化痰之品。并认为：适当配合化痰药，有助迅速消除关节肿痛，且对降低血尿酸浓度亦有一定作用。若痰瘀交阻，深入骨骱，见关节僵肿畸形，结节质硬，则加炮山甲、蜣螂虫、僵蚕、蜂房等破结开瘀，消痰软坚，或辅以骨碎补、大熟地、补骨脂、肉苁蓉等补肾健骨、填益精髓，一般对痛风慢性期或间歇期维持治疗，可以奏效。倘遇痛风急性发作，可增大土茯苓、萆薢剂量，并加入大队虫蚁搜剔、蠲痹定痛之品，然后根据证候的属热属寒，另选配寒水石、大生地、知母、虎杖、忍冬藤、水牛角、萹草等以清热通络，或选配制川乌、草乌、制附子、川桂枝、细辛、仙灵脾、大熟地等以温经散寒，可收较强的消炎止痛、控制发作之效用。至于痛风伴尿路结石或痛风性肾病的治疗，则泄化瘀浊之法非但不废，尚要加强，前者参用通淋化石法，后者兼以益气补肾法。

朱氏对降泄浊毒药的选择，特别推崇土茯苓、萆薢二味，每方必用。土茯苓一般每日用30~120g，萆薢用15~45g。土茯苓甘淡性平，主入脾胃两经，可助升清降浊；萆薢苦甘性平，主入肾、膀胱二经，有利分清泌浊。两药皆有除湿、解毒、利关节之功。而痛风一病既缘浊毒瘀滞为

患，用之一以降泄浊毒，一以利关节，不但能降低血尿酸水平，又可解除骨节肿痛。^[1]

2. 钟洪诊治经验

钟氏从辨证与辨病相结合的角度探索，认为：①本病多为脾虚。患者随着年龄的增长，发病率渐高，而且形体多肥胖。此为素体脾虚，加之饮食不节嗜食肥甘厚味，损伤脾胃，不仅运化功能失调，反酿湿浊，外注皮肉关节，内流脏腑，故而发病。正如李东垣所说：“内伤脾胃，百病由生”。在其诊治的 54 例痛风患者中，从症状分布来看，纳差、乏力、形体肥胖、脉细等脾虚证候，分别为 41 例、37 例、37 例、29 例，均超过半数，说明其病位虽表现在关节，但其本在脾。②多湿浊。湿性重浊腻滞，流滞脏腑经络，最易阻遏气机，导致气机升降失调，经络阻滞不畅。湿邪流滞，又影响脾运，形成恶性循环，故临床中的痛风患者初始未甚，可不疼痛，然渐积日久，愈滞愈甚，形成高血尿酸、高脂血症，终必突发骨关节肿痛，变生痛风结节沉于皮下，久之可见溃流脂浊。若沉于尿路可见尿酸结石。湿浊内蕴，苔见浊腻。由此可见，原发性痛风病为素体脾虚，加之后天饮食失调，导致脾胃更虚，湿浊内生而发病，故临床上不可单按痹证辨治。

钟氏治疗原发性痛风病，根据病因病机，以健脾祛湿，泄浊通络为治疗大法。急性发作期以祛湿泄浊通络为主，慢性缓解期当以健脾为主。健脾以促运化，湿浊之邪难以生成；祛湿泄浊者，消除致病产物，邪去则正安；通络者，经脉流畅，湿浊之邪不能流滞为害。基本方以党参、苍术、黄柏、泽泻、苡米、云苓健运脾胃，祛湿泄浊，选当归、威灵仙、独活、桂枝通利经络，从现代药理来看，黄柏、泽泻、

苡米、云苓能增强肾血流量而促进血尿酸排泄，当归、苍术、独活、威灵仙、桂枝可消除局部炎症反应，从而缓解关节肿痛等症状。诸药合用，既注重整体宏观调治，又重视局部微观治疗，具有辨证与辨病，局部与整体相结合的特点。^[2]

3. 奚九一诊治经验

(1) 痛风的病因病机，奚氏提出了“内湿致痹”的观点：即本病是由于先天禀赋不足，后天膏粱厚味，伤脾生湿，或年老脾肾气血生化不足，内湿稽留，积而成痹。湿邪流于营血可为高尿酸血症，湿邪注于关节、组织，便成痛风之症，湿凝肌腠即为结石之顽证。

(2) 奚氏根据患者不同发作频率、程度、累及关节，有无并发症，拟订了能反应个体差异的新分型分期法。

①分型方法：发作频率为四级。初发：关节炎症第一次发作者；再发：关节炎症第2次发作者；多发：关节炎症复发3~4次/年；频发：关节炎症2月左右复发1次或每月1~2次甚至持续发作者。受累关节：分单足、双足、单下肢、双下肢、四肢多关节。并发症：有结石（皮下组织）、痛风性肾病、尿酸性结石。

②分期辨证（含病症缓急动态与辨证属性）

急性发作期：指征：局部急性红肿热痛、血尿酸高于正常值。以上两项内容均为阳性。辨证：湿痹化热证。

迁延活动期：指征：慢性关节痛可伴局部肿胀，血尿酸高于正常值。以上两项或一项阳性。辨证：湿痹稽留证。

奚氏认为本病系代谢性疾患，多是终身疾病。故疗效标准应含近期疗效及远期疗效，在疗效分析时，不适宜用“痊愈”，故适用优、良、好转、无效。优相当于“临床痊愈”，良相当于“临床显效”，好转相当于“临床改善”。^[3]

4. 何天祥诊治经验

何氏认为，本病有内因与外因之分，内因多为脾胃虚损，影响运化机能，又因虚而腠理疏松，风寒湿外邪乘虚而入，郁而为病；外因多为损伤，或风寒湿外邪流注四肢百骸，随着外邪的偏盛及内损的情况不同而产生不同的症状。临证时须辨证分明，是外邪为患；是脾肾虚损，外邪客于筋骨关节，积久发病；是治不及时，既而影响脾肾，外邪易犯，正虚邪郁而反复发作。对本病的治疗，除内治外，只要能早期诊断，及时有效的外治，亦能有效地控制高尿酸血症，可以预防和消除急性炎症反应，使痛风结节缩小或消失，减少骨组织的破坏及急性发生，保护肢体的功能，并自创“痛风灵”湿敷剂用于治疗痛风，临床上取得了较为满意的疗效。^[4]

5. 张天等诊治经验

痛风患者都有面黄肌瘦、头目昏晕、腰酸纳差等肝、脾、肾病证，故治疗宜在病情缓解时给予补益肝脾肾。鉴于病程中正邪之争变化无穷，当急性发作时以清热化湿浊为主。因风寒湿邪夹杂，郁久化热者，又宜在治疗中寒热并图。本病多有风邪，常用祛风药及理气活血药。脾虚生湿，湿久郁成痰浊，故见痛风结节，因此又宜用软坚化痰药。痛风证与代谢有关，故除治疗外，尚应注意起居饮食，忌酒肉湿面，避免房事劳伤；尤其忌吃含嘌呤高的动物内脏，以免引起嘌呤代谢紊乱所致尿酸过高而使病情加重。^[5]

6. 张惠臣等诊治经验

痛风病的病因，据临床观察，以正虚寒湿之邪痹阻

为多见。部分可因寒湿久蕴化热而发为湿热痹，即《类证治裁·痛风》中所谓：“寒湿风郁痹阴分，久则化热攻痛”。故临床可分为寒湿和湿热两型，分别选用加味二妙散及乌头汤、薏苡仁汤或躄痹汤等方加减。另本病常可导致并发肾病及肾功能不全、尿毒症等，故晚期常表现为脾肾阳虚、浊阴毒邪内蕴症状。治疗时配合真武汤等加减以温阳利水，用中药保留灌肠消除尿毒，可收到一定疗效。

本病日久不愈，痛风结石沉积，常可出现关节肿大变形，顽固疼痛等，系久病入络，气血失畅，瘀血凝滞所致，即《丹溪心法·痛风》：“肢节疼痛，脉涩数者，此是瘀血。”故治疗须配以活血化瘀方药。若关节肿胀溃瘍，有尿酸结晶析出者，则适当配以化痰药，不仅迅速消除关节肿痛，且对降低血尿酸浓度亦有一定的作用。^[6]

7. 黄久一等诊治经验

黄氏等根据清·汪昂提出的治疗痛风宜遵循顺气、清痰、搜风、散湿、养血、去瘀大法，在此基础上，提出自己的见解和经验。

一曰顺气：所谓气不顺，就是气的失常、越轨和不称职。汪氏所指顺气，决非一般的行气和降气，关键在一“调”字。若因虚而不顺者，补之使顺；因实而气不顺者，泻之使顺；因陷而气不顺者，升之使顺；因上逆而气不顺者，降之使顺；因阻滞而气不通者，通之使顺。医者必须于复杂的病证中，探求气不顺的病机而“调”之。

二曰清痰：痰为百病之母，亦为致病之根；且痹又可助增痰之势，痰痹相合，势同狼狈。故欲解痹、杜痹，均须重视清痰。痰滞气，消耗气血，阻碍脏腑功能，又夹风

寒湿热。而痛风患者，气血受阻，未有不更生痰者，痰湿既成，机能益乱，气血更耗，终成恶性循环。所以，不清痰则顺气之效难收，脏腑机能难复，气血难充，以致痛风之根不能推撼而斩断之。

三曰搜风：痛痹必治风，但常苦不能速效。汪昂下一“搜”字，就是透风、散寒、渗湿，三法并举，则风势孤立，无所依附，而易于消散。

搜散外风，须分表里、轻重。前人谓“风非大汗不除”，此言伤寒中风之属。阳邪之在阳分者，无须待搜。若是痛风，入于阳分之邪，大汗其汗，浑身淋漓，则与寒湿为一体之风不可除，湿亦不能去。痛痹只宜微发其汗，使其汗出渍渍，才可透风于寒湿之外，即寓搜汗于汗法。还须辨其轻重，轻者治以散风、祛寒、除湿即可；若患病年深日久，重感蕴结，邪入筋骨血络，则非乌头、细辛、没药、山甲之属，深入病所以搜之，而不能奏效。若视其病所，察其相关的脏腑，内应外合以搜之，则更得心应手。

痛痹兼风者亦不少，如痛痹日久，气血亏损，筋脉失养，肝风内动，因而痰湿瘀血更为滞塞，虚实夹杂，此为寓搜于补，重在顺气、养血、清痰、化瘀，调补气血，俾其正气强，真阴复、虚风熄而邪风亦灭也。

四曰散湿：散湿当辨寒热：张景岳很扼要地说：“辨治之法，其要惟二：一曰湿热，一曰寒湿。”吴鞠通说：“其性氤氲粘腻，聚则生寒，郁则生热。”上焦化热之时而下焦仍为寒湿者有之，且时令不同，新久有别，寒热转化无常，故辨寒热，须明部位，别时令，分久暂，察转化，方能审证的确。

散湿当明汗法：发汗亦散湿法之一，其法不与常法同。

若用麻黄汤，必加白术或苡仁以去湿；亦可用桂枝汤或附子，以温其经。因痛痹始于阳虚，湿未热化，恐有亡阳之变。张仲景指出：“风湿相搏，一身尽疼，遂当汗出而解，但汗大出，则风去湿留，须使之微微似欲汗者，风湿俱去矣。”故治痛痹之湿，断不可大发其汗。

散湿酌用补法：卫气不固，则外湿内侵；脾阳不健，则内湿亦重。所以，补阳通阳为散湿之本。如果阴虚，亦宜壮水。张景岳谓“真水既行，则邪湿无所容矣。”且宣通之机在于肺，渗利之机在于肾，运化之机在于脾，散湿之时，当重视脾肺肾三者之调护。

散湿宜用宣通经络，分利清解。痛痹既久，气血皆伤，湿邪、凝痰与败瘀混处经络，惟汗、利所能动。一则应调护阴阳，壮真气以散走之；二则当搜剔经络，分利清解，才不致诛罚无过。如能善用宣通之药，在下之湿亦能升散从肺而解，上焦之湿亦可渗利从肾而出。

五曰养血：痛痹初起，即气血俱伤。况痛痹难治，久服祛风、去湿、散寒之药，则散而耗气，伤津而涸阴血。可见痛痹既久，少有不气血俱虚的。

大多认为“气滞不通则痛”，而忽视“血虚不荣”亦痛。养血之法，不能纯作补血看，纯补易致凝滞，用一“养”字还有化瘀生新，补而不滞之意。

六曰去瘀：历考医典，风寒湿热诸因都能使人血瘀。《素问·五脏生成篇》曰：“卧出而风吹之，血凝于肤者为痹，凝于脉者为泣。”《灵枢·痼疽篇》曰：“寒邪客于经络之中，则血泣不通。”痛痹证之所以剧烈疼痛，这也是其重要的原因。清代王清任《医林改错》云：“血受寒则凝结成块，血受热则煎熬成块。”仲景曰：“热之所过，血为之凝滞。”由此观之，热亦可以使血瘀，不必拘于寒。^[7]

【按语】

现代医学对于痛风的治疗，目前尚无理想的方法。虽然近年来问世的秋水仙碱等药物可以较好地控制其急性症状，但因其副作用大，难以坚持用药，而且不能根治。中医药在这方面有较大的优势。上述几位专家诊治痛风经验各有特点：朱良春认为痛风的病因乃浊毒瘀滞使然，其名为风而实非风，症似风而本非风。主张痛风诊断一经明确，治疗便应恪守泄化浊瘀这一大法，以土茯苓、萆薢、生苡仁、泽兰、泽泻、全当归、桃仁、红花等药物为基础方，其中特别推崇土茯苓、萆薢两味，每方必用，是其经验独特之处。奚久一在病因方面提出内湿致痹，注重患者内在体质因素的发病机理，根据患者不同发作频率、程度，累及关节，有无并发症，拟订了能反映个体差异的新分型分期法，旨在可以较确切地判断患者自身的病情类型，有利于指导治疗、分析疗效和估计预后。钟洪等认为本病在病机上多脾虚、多湿浊，主张临床不可单按痹证辨治，治法上针对病机以健脾祛湿，泄浊通络为治疗大法。急性发作期以祛湿泄浊通络为主，慢性缓解期当以健脾为主。何天祥认为本病有内因外因，而又各有主次与偏盛。治疗上侧重外治，不伤阴败胃，避免了因过服寒凉克伐之品导致脾肾阴虚或阳虚而埋下易受湿热侵扰复发的潜在因素。张天等认为当急性发作时以清热化湿浊为主，缓解时给予补益肝脾肾，从而标本兼顾。张惠臣等着重提到本病日久不愈，痛风结石沉积时，治疗须配以活血化瘀方药。若关节肿胀溃瘍，有尿酸结晶析出者，则适当配以化痰药，不仅迅速消除关节肿痛，且对降低尿酸浓度有一定作用。黄久一等根据清·汪昂提出的治疗痛风宜遵循顺气、清痰、搜风、散湿、养血、去瘀大

法。在此基础上,提出自己的见解和经验,此六法对痛风的治疗可以说是执简驭繁,对临床很有指导意义。

(张银柱)

参 考 文 献

- [1] 姚祖培,陈建新.朱良春治疗痛风的经验.中医杂志,1989,(3):16~17
- [2] 钟洪,等.原发性痛风证治规律探讨.湖北中医杂志,1992,14(6):5~6
- [3] 赵兆琳.痛风灵治疗痛风性关节炎临床研究.上海中医药杂志,1996,(1):6~9
- [4] 何浚治.痛风风湿敷贴治疗痛风性关节炎168例.四川中医,1997,(12):43~44
- [5] 张天,扬如哲.中医药治疗痛风验案二则.中医杂志,1984,(7):17
- [6] 张惠臣,刘国善.痛风辨治.浙江中医杂志,1985,20(8):377
- [7] 黄久一,张海燕.痛风治疗六法.上海中医药杂志,1986,(3):36

系统性红斑狼疮

【概述】

红斑性狼疮分系统性红斑狼疮（SLE）和盘状红斑狼疮（DLE）两类。系统性红斑狼疮为一全身性的自体免疫性疾病，病变部位在全身结缔组织。患者以免疫功能失调，细胞免疫降低，体液免疫增强，免疫复合物增多所引起的血管炎为其病理基础。能累及皮肤、粘膜、浆膜、血管、关节、心、肾、肝、脾、肺、脑、胃肠、血液、淋巴等全身组织和器官。病情复杂而严重。

本病因迄今未明，与以下诱发因素有关。感染：某些病毒感染和链球菌、结核菌感染；药物：普鲁卡因酰胺、胍苯达嗪、口服避孕药、苯妥英钠、灰黄霉素、磺胺等；紫外线、日光、寒冷、强烈电闪；内分泌失调；精神因素和创伤也可诱发。本病有家族性，并有缓解和发作交替的倾向。

盘状红斑狼疮，仅损及皮肤，病情局限。以皮肤损害为主，并出现发热、心包炎、血免疫学检查异常，为亚急性皮肤型红斑狼疮（SeLE）。此外，约有5% DLE可转发为SLE，部分病例与干燥综合征重叠。

红斑狼疮在中医学文献中无相似的病名，但对其临床表现有类似描述。对盘状红斑狼疮有人从该病毁坏面容的特征出发，称之为鬼脸疮。系统性红斑狼疮因伴有较多的

脏腑证候，很难明确地划属于某一病证。如有人根据其全身证候认为本病“近似于中医所称的温毒发斑之类”；有人从皮疹特征出发称之为“红蝴蝶”、“蝴蝶丹”、“阴阳毒”等；有人认为本病可累及周身，故称为“周痹”，而多关节疼痛属于“痹证”；有肾炎、肾功能损害属“水肿”；有肝脏损害属“黄疸”、“胁痛”；有急性心内膜炎、心肌损伤者属“心悸”；有胸水者属“悬饮”等等。

【名医诊治经验】

1. 张志礼诊治经验

张氏认为，先天禀赋不足、后天七情内伤使人体阴阳气血失衡，气血瘀滞，经络阻隔，毒邪犯脏，是这类疾病的根本病因。临床表现虽然复杂，但“虚”是本病之本，即其病机是因虚致病，复因病成劳，久治不愈又使虚劳加重。即使急性期矛盾突出表现为毒热标象，本质上还是虚中夹实，标实本虚。因此始终注重扶正重于祛邪的指导思想。即使对急症“急则治其标”，用清热解毒凉血药，也要同时护阴；病情缓和后均以扶正固本为主。病机核心是脾肾不足，阴阳失调。^[1]

2. 吴圣农诊治经验

吴氏根据多年临床经验，倾向于红斑狼疮的病因病机为肝肾阴虚，邪毒亢盛。而火邪热毒有内生、外感之别，红斑狼疮患者，除部分的发病与暴晒日光有关，可提供日晒而诱发的病史，能用外来热毒入里，致伤阴液解释外，大部分患者并无明显的感受外来热毒的病史，虽然与《金

匱》所载的阳毒证“面赤斑斑如锦纹”的表现相似，但绝不是阳毒一样外来的温毒火邪所致，而是由于先天肝肾阴虚，阴虚不能制火，以致邪火内生。而邪毒又与肝肾不足，互为因果，即先天性的阴亏导致了后天性的阳亢，阳亢又进一步灼伤了阴津，如此恶性循环，于是热毒日盛，阴液益虚，由气入血致使气血逆乱，阴阳失调，气滞血瘀，经脉瘀阻，外则肌肉毛发，内则五脏津血，皆受其害，由此而产生种种症状。所以对本病的治疗，吴氏始终紧扣肝肾阴虚为病本，邪毒亢盛为病标的机理，采用滋养先天，补调肝肾为主，清营凉血以泻邪毒为辅的原则。根据本病的症状吴氏大致将其分为三型：

(1) 热毒炽盛型（即急性型或暴发型）：主要表现为突发高烧或高热持续不退，面、胸、腹等处红斑累累，关节肌肉酸痛剧烈，有如《金匱》“身痛如被杖，面赤斑斑如锦纹”的现象，目赤，溲红，大便干结，口苦神烦，气急喘息，头晕脑胀，甚则昏迷谵妄，四肢不时抽搐，吐血、衄血、便血、尿血，舌质红绛，或紫暗，或光泽少津，苔黄腻，脉细弦数，此乃邪毒入营，迫血妄行，元神被扰，气窒无权，急宜养阴清热解毒，昏迷者配针刺。基本方：玄参、赤芍各 15g，紫草 20g，丹皮、山梔各 10g，蚤休、生地、鲜芦根各 30g，鲜菖蒲 12g，水牛角 30g（代广犀角），青黛 0.3g，合成牛黄 1.5g（分吞）。若神志昏迷者加神犀丹或紫雪丹，大便秘者加鲜首乌，或鲜川军。

(2) 痹痛型（即亚急性以关节酸痛为主）：主要表现为发热时起时伏，热势昼升夜降，有时怕冷，自汗，四肢关节酸楚，定着不移，有时红肿，局部有热感，屈伸不利，常伴有头痛，腰酸背痛，神疲乏力，心烦不宁，指甲鲜红光亮，脉象滑数，舌紫淡，或红绛，此乃肝肾不足，邪热

内生，血瘀络阻，形似热痹而实非热痹，治宜养阴清热，凉营通络。基本方：生地、鸡血藤、蚤休各 30g，玄参、当归各 12g，赤芍、紫草根各 15g，知母、黄柏各 10g，牛膝、地龙、防风、防己各 9g，合成牛黄 1.5g（分吞）。

（3）肝肾不足型（即慢性缓解期）：主要表现为精神不振，或不耐烦劳，稍微活动即疲乏不堪，腰酸腿软，头晕耳鸣，或低热，或关节酸痛，苔薄，舌质红，或嫩红，质胖。此乃邪势虽敛而肝肾阴亏不复，以滋养肝肾为主，清热解毒为辅。基本方：生熟地、白芍、黄芪各 15g，当归、牛膝各 10g，枸杞、首乌、茯苓各 12g，丹皮、山栀各 9g，青黛 0.3g，雄黄 0.5g。

以上三型并非一成不变，根据病情病程的不同，可以互相转化，因此治疗方案亦须随之而改变。因患病的热毒为内生之毒，所以非银翘之类能解，故吴氏选用雄黄、青黛、合成牛黄、草河车等药来解毒活血。雄黄性温有毒，过去常用其解毒杀虫之功而治疗疥癣疽疔等外科疾患。但《本草纲目》认为雄黄能“入肝经气分，故肝风、肝气、惊痛、痰涎、头痛、眩晕、暑证、泄痢、积聚诸病，用之有殊功”，且配伍滋阴清热的药物能监制温热之性而发挥其解毒之功。而青黛味咸性寒，有清热解毒、活血消瘀的功用，对于因肝火郁毒的病证适宜。其它如牛黄有清心开窍，豁痰定惊，清热解毒之功。山栀能泻火，有清热利胆，泻火除烦，凉血止血，散瘀止痛的作用。蚤休常用于各种热毒症，有清肝经郁热，活血解毒的作用。^[2]

3. 周仲瑛诊治经验

红斑狼疮无相应中医名称，究其成因，则肝肾亏虚，气血失调为主。本病多发于妙龄少女、青春少妇。“女子以

肝为先天”，“乙癸同源”，患者先天禀赋不足，肝肾本虚；加之情怀久郁，肝郁化火，耗伤肝肾阴精；或热病之后，阴伤未复；或接触某些化学毒物，损伤气血，致使脏腑气机紊乱，气血失调，此乃发病之基础。风毒痹阻，络热血瘀为标。气血失调，郁热内起，化生风毒，毒热固结，郁于血分；遇有日晒，情怀不畅，或外感扰动，则外见皮肤红斑，疹点隐隐，肌肤瘙痒，关节肿痛；内见络损血瘀，脏腑受戕，而成低热绵绵，久久不退，或高热鸱张，反复难已，甚或热盛神昏，腰酸胁痛，心悸气喘，尿多脂沫，种种变证均由风毒瘀热而来。辨证分为四型：

(1) 风热痹阻，络热血瘀证：肌肤瘙痒，周身关节肿痛，两膝为甚，或痛处游走不定，可伴局部关节红肿热痛，屈伸不利；低热绵绵，口干而渴，心烦易躁；红斑隐隐，尿赤便结，舌质暗，或有紫色，舌尖偏红，苔薄白，或薄黄，脉来弦数，或弦滑。手心灼热，腰肋疼痛。本证多见于红斑狼疮内脏、关节损害型。治宜祛风解毒，凉血化瘀，秦艽丸加减。药用：秦艽 10g，功劳叶 10g，漏芦 10g，白薇 12g，大生地 12g，广地龙 10g，乌梢蛇 10g，青风藤 15g，鬼箭羽 12g，凌霄花 10g，商陆根 9g。

(2) 血分毒热，气阴耗伤证：忽起壮热，留连难平，或寒热往来，或定时发热，并无恶寒，届时自平，反复数月，甚或数年不已，面部红，手臂胸腹红疹隐隐，肌肤灼热，关节酸痛，头痛目赤，口干咽痛，溲赤便干，神疲乏力，精神不振，食纳无味，苔薄少津，舌质红，或暗红，脉来弦滑数，重按无力。本证多见于狼疮急性期、发作期。治宜清透血热，益气养阴，选清骨散加减。药用：青蒿 15~30g（后下），白薇 15g，银柴胡 10g，炙鳖甲 15g（先煎），鲜草薢 30g，知母 10g，丹皮 10g，大生地 15g，炒常

山 6g, 雷公藤 10g, 太子参 15g, 白芍 12g。

(3) 肝肾阴虚, 内毒留恋证: 低热绵绵, 或低热时起时平, 稍事劳动即热度渐升, 精神不振, 食纳无味, 不耐疲劳。面颧升火, 皮疹色暗, 活动后或情绪激动时疹色增红, 关节酸楚, 头昏耳鸣, 腰膝酸痛, 头发稀疏或枯焦, 月经不调, 或经闭不行, 小溲短少, 大便偏干, 苔薄少, 舌质红少津或有裂纹, 脉细, 或细数。本证多见于狼疮稳定型、缓解期。治宜培补肝肾, 祛风解毒。方用自拟狼疮肝肾方。药用: 功劳叶 10~15g, 大生地 12~15g, 制黄精 10g, 制首乌 10g, 枸杞子 10g, 川石斛 12g, 秦艽 10g, 漏芦 10g, 紫草 6g, 乌梢蛇 10g, 炙僵蚕 10g, 白薇 10g, 凌霄花 10g。

(4) 脾肾两虚, 血瘀水停: 面色㿔白无华, 目胞及下肢浮肿, 面颧红斑色暗, 或见色素沉着; 心悸气短, 胸腹胀满, 胁下结块, 精神萎靡, 周身乏力, 足跟疼痛, 形寒怕冷, 肢清不温, 小便不利, 大便或见溏薄。苔薄或腻, 舌质紫暗, 色淡, 舌体胖, 或边有齿痕, 脉细弱。本证多见于狼疮晚期, 或合并狼疮性肾炎。治宜补肾健脾, 活血行水。方选自拟狼疮脾肾方。药用: 太子参 15g, 生黄芪 20g, 仙灵脾 10g, 附子 5g, 大生地 12g, 制黄精 10g, 木防己 10g, 天仙藤 12g, 泽兰、泽泻各 10g, 雷公藤 15g, 商陆 9g, 露蜂房 10g。^[3]

4. 丁济南诊治经验

丁氏认为该病的病因病机乃风寒湿三邪入侵机体, 该病属“痹证”范畴。人体感受风寒湿邪后, 经脉气血不畅, 累及皮、肌、筋、脉、骨, 而致皮肤红斑, 肢体、关节、肌肉酸麻肿胀疼痛, 因肝合筋、心合脉、脾合肌、肺合皮、

肾合骨，故痹证迁延日久不已，内舍于五脏，发展成五脏痹。故临床上可分为风痹损及肌肤、脉络以及心、肝、脾、肾、肺等六种类型。

治疗中强调用辛温药，必须采用祛风温阳、散寒除湿、调补阴阳之法。基本方用桂枝、乌头、荆芥、防风、威灵仙、伸筋草等性味均属辛温，辛能发散，祛逐风湿，温能驱散寒湿之邪，达到既能祛风解表，又能入骨肉搜风通络，外则除表寒，里则温下元，祛邪又扶正。因此，临床上遇见伴有身热、烦躁、口渴、尿赤、便干等热象，或舌红少苔，口干咽燥，低热颧红等阴虚内热之证，仍宜用乌头、桂枝，仅对不同兼证加用清热解毒，或养阴生津之品，为防止辛温药耗伤阴津之弊，故用苦寒的玄参监制，为防止川草乌的毒性，用甘平的甘草解毒，调和诸药。^[1]

5. 沈丕安诊治经验

(1) 沈氏认为本病系起于先天禀赋不足，肝肾阴亏，精血不足，加之情志内伤，劳倦过度，六淫侵袭，阳光暴晒，瘀血阻络，血脉不通，皮肤受损，渐及关节、筋骨、脏腑。该病基本病机是素体虚弱，真阴不足，热瘀内盛，痹阻脉络，内侵脏腑。病位在经络血脉，以三焦为主，与心脾肾密切相关。而该病的性质是本虚标实，虚实夹杂，以心、脾、肾阴虚、血虚为本，瘀热、火旺、瘀滞、积饮为标。该病初在表，四肢脉络痹阻，先表后里，由四肢脉络入内而损及脏腑脉络；在内先侵上焦，由上而下，渐及中焦，再及下焦，由轻渐重，由浅渐深；若表里上下多脏同病，当为重证，如再由下而上弥漫三焦，五脏六腑俱损，上入巅顶最为危重。

(2) 沈氏认为系统性红斑狼疮属真阴不足，阴虚血虚

为本，故治疗应以养阴固本贯穿始终。养阴包括补阴、清热、生津、润燥等四个方面。在养阴同时，依据临床不同证情，配合清热、活血、祛风、益气、补肾、养血、利水、安神诸法，灵活运用。

沈氏把系统性红斑狼疮分为 10 个证型。

①阴虚内热证：见于系统性红斑狼疮早期，轻证，慢性活动期以及服用糖皮质激素后，病情未完全控制，属红斑狼疮的基本型。治宜养阴清热，活血通络。方药红斑汤。组成：生地黄、生石膏、玄参、黄芩、生薏苡仁、知母、忍冬藤、羊蹄根、川牛膝、绿豆衣、生甘草、陈皮、大枣。

②气营热盛证：本证多见于系统性红斑狼疮急性发作期，或撤减激素不当引起的反跳。治宜清气凉营。方用三石退热汤。药物组成：生石膏、寒水石、滑石、生地黄、玄参、金银花、黄芩、知母、生薏苡仁、牡丹皮、赤芍、人中黄、羚羊角粉或紫雪散。

③瘀热痹阻证：本证多见于以关节炎、血细胞轻度减少为主的慢性活动期病人，或用激素后或雷公藤减量后轻度反跳。治宜祛瘀退热，宣痹止痛。方用忍冬藤汤合红斑汤加减。组成：生地、忍冬藤、岗稔根、虎杖根、生薏苡仁、生石膏、黄芩、川芎、羊蹄根、海风藤、川牛膝、生甘草、陈皮、大枣。

④血热瘀滞证：本证以手足栓塞性微血管炎为主，或并发肢端溃疡。治宜养阴清热，活血祛瘀。方用紫斑汤合红斑汤加减。组成：生地、玄参、生石膏、黄芩、忍冬藤、鬼箭羽、槐花、生藕节、水牛角、川牛膝、生甘草。

⑤热郁积饮证：本证相当于系统性红斑狼疮引起的浆膜炎、心包积液、胸腔积液，少量积液时无症状，但在超声、B超等检查中发现，部分病人同时伴有心肌损害。治

宜养阴清热，利水蠲饮。方用蠲饮汤合红斑汤加减。组成：生地、生石膏、知母、黄芩、玉竹、葶苈子、白芥子、生薏苡仁、桑白皮、猪苓、茯苓、郁金、五加皮、枳壳、甘草、大枣。

⑥瘀热血虚证：本证多见于系统性红斑狼疮以血小板减少为主。治宜养阴清热，凉血生血。方用紫斑汤。组成：生地、生石膏、知母、黄芩、羊蹄根、虎杖、生藕节、旱莲草、水牛角、炙龟甲、槐花、陈皮、生甘草。

⑦气阴两虚证：本证见于系统性红斑狼疮以红、白细胞减少为主，即是抗红白细胞抗体引起的自身溶血，也可能是其它因素引起的血小板减少。治宜益气养阴，健脾生血。方用生血汤。组成：生地、山茱萸、女贞子、枸杞子、制何首乌、黄芪、白术、猪苓、茯苓、知母、黄芩、白及、佛手、陈皮、甘草、大枣。

⑧瘀热损肾证：本证相当于系统性红斑狼疮中的狼疮性肾炎。治宜补肾养阴，活血利水。方用清肾汤合红斑汤加减。组成：生地、炙龟甲、知母、生石膏、黄芩、落得打、接骨木、六月雪、猪苓、茯苓、泽泻、杜仲、续断、黑大豆、赤小豆、甘草、大枣。

⑨脾肾两虚证：本证见于系统性红斑狼疮中慢性狼疮性肾炎、轻度氮质血症、肾性高血压。治宜健脾滋肾，利水蠲饮。方用清肾汤合蠲饮汤加减。组成：黄芪、白术、生地、炙龟甲、杜仲、续断、菟丝子、葶苈子、猪苓、茯苓、桑白皮、泽泻、落得打、接骨木、川牛膝、甘草、陈皮、大枣、黑大豆、赤小豆。

⑩瘀热入脑证：本证见于系统性红斑狼疮中狼疮脑损害之轻证，在临床出现中枢神经病理表现，且变化缓慢，方适合中医治疗，如出现重症脑损害，宜中西医结合抢救。

治宜养阴清热，平肝活血。方用清脑汤合红斑汤加减。组成：生地、黄芪、枸杞子、天麻、蒺藜、川芎、蔓荆子、炙穿山甲、生石膏、黄芩、全蝎、僵蚕、半夏、陈皮、甘草。^[5]

6. 陈湘君诊治经验

陈氏将系统性红斑狼疮分三期三型治疗：

(1) 热毒炽盛型（相当于急性期），症见高热 $39^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 以上，面部红斑鲜艳，或有紫癜瘀点，出血斑，全身肌肉关节酸痛，严重者神昏谵语，舌红绛，苔黄燥，脉弦滑数。乃热毒入于营血，治宜滋阴凉血，清热解毒。方用（清热）犀角地黄汤加味。

(2) 阴虚火旺型（相当于缓解期），症见低热，面部红斑转暗，神疲乏力，五心烦热，夜寐不安，自汗盗汗，月经不调，舌红，苔花剥，脉细数。乃高热过后，火邪伤阴，阴虚火旺，治宜补肾养阴，生津降火，用六味地黄汤加减。

(3) 脾肾阳虚型（相当于肾病综合征）。症见面色㿖白，神疲倦息，形寒肢冷，全身肿胀，或伴胸水腹水，纳差恶心，尿少等，舌淡，苔薄白或腻，脉沉细。此系脾肾阳虚，水湿泛滥，治宜健脾补肾，温阳利水为主。若口渴舌红者，加生地、沙参、麦冬；胸水腹水者，加三子养亲汤合葶苈大枣泻肺汤；恶心纳差者加苏叶、半夏、川连等。

临床发现，每型病例都有阴虚火毒临床表现，故养阴解毒需贯彻始终。常用生地、玄参、紫草、大青叶、知母、黄柏、蒲公英、虎杖等。生地甘苦而寒，入心肝肾经，能养阴生津，配水牛角（代犀角）凉血清热解毒，治疗壮热神昏，热盛出血诸证；紫草甘寒解毒消斑，凉血活血，有明显的抗垂体促性腺激素及抗绒毛膜促性腺激素的作用；

大青叶苦寒解毒，知母苦甘寒，泻火润燥滋阴，能使激素抑制的血浆皮质醇浓度升高；黄柏苦寒燥湿，清虚热；蒲公英清热解毒。^[6]

7. 艾儒棣诊治经验

初治宜早，重在治标，因肾为要：系统性红斑狼疮早期症状往往以关节疼痛、发热（多为低热，少数为高热）、咽痛、尿频、面部蝶形红斑等主要症状出现，邪气侵犯之初期表现症状虽轻，但肝肾之阴阳已失调，或已波及肾阴，但标邪尚盛，正气尚可，此时症状虽重，治疗时却重在祛邪，兼以固肾而牢根基，以系统性红斑狼疮暴发病例常见为热毒炽盛证。治则：清热解毒，凉血化瘀。方药：加减小瘟败毒饮（《疫疹一得》）化裁：水牛角粉（代犀角）15~30g，石膏、玄参、牛蒡子各20g，知母、连翘各12g，生地、牡丹皮、黄芩、野菊花各15g，栀子、木通各10g，甘草3g。关节红肿者加银花藤、灵仙、秦艽。

中期阴虚内热，重养肝肾，佐以祛邪：中期以阴虚内热症状常见，在初起急性发作之后，病情缓解时，最易见到本证。我们将多数系统性红斑狼疮的急性缓解期归入这一证（阴虚内热证）。治则：滋阴清热，和营养血。方药：首乌地黄汤：制首乌、夏枯草各30g，刺蒺藜、熟地、山药、茯苓、丹参、地骨皮、秦艽、白鲜皮、炒枣仁、钩藤、豨莶草各15g，山茱萸12g，牡丹皮、泽泻、紫草各10g。关节酸痛者加石楠藤、五加皮。

后期脾肾两伤，大补气血，调补阴阳：系统性红斑狼疮一病日久则导致气血两虚，阴阳两竭，邪毒可侵犯五脏六腑，但以脾肾两伤为主，故其症状多见脾肾受损之表现。治则：温肾壮阳，健脾利水。方药：肾气丸、真武汤加减：

肉桂 3~6g, 熟附片 15~30g (先煎), 淮山药 30g, 生姜 6g, 茯苓、白芍各 20g, 生黄芪 40g, 大腹皮 12g, 泽泻、山茱萸、白术、木通、淫羊藿、水红花子各 15g, 临床随证加减。^[7]

8. 钱文燕等诊治经验

(1) 病因病机

①肾虚：主要是肾阴虚，阴虚生内热，阴虚阳亢，阴阳失调是本病的发病基础，也是本病早期表现，继则伤气，见气阴两虚症状，久则伤及肾阳，形成阴阳两虚证候。

②瘀血阻络：长久的阴阳不平衡，气血失调或热毒入里，都易影响气血运行的畅达，从而产生瘀血内停。瘀可变化而生百病，由于瘀血而产生一系列病理变化，从而引起复杂的临床证候。

③热毒侵袭：在六淫中，与系统性红斑狼疮有关的是阳邪，阳热亢进，消灼阴液，日久可酿成毒热，毒热之邪侵袭机体而发病。

(2) 治则：一是益气养阴补肾，二是活血化瘀，三是凉血解毒清热。

(3) 标本虚实：阴虚、气虚、阳虚为本，血热、毒热、瘀血为标。在急性发作阶段，应“急则治标”，投以清热凉血解毒之剂，攻伐毒热为主，然攻伐之中要注意保护阴液，亚急性缓解期，大邪已去，气阴已伤，在清其余热的同时，必须加强增补真阴，增益气血，标本兼顾，攻补兼施，是本病辨治规律的一个重要方面。^[8]

9. 汪履秋诊治经验

(1) 病机：汪氏治疗该病始终抓住肝肾阴虚，风热侵

裘蓓分的基本病机，以养肝肾、清营热为基本治则，再随证加减。活动期则加重疏风解毒之品，如炒荆芥、连翘、土茯苓、地肤子、白鲜皮等，以期营热透气而解；缓解期则重在滋肾。此外汪氏还喜用首乌，认为首乌乃养肝肾、护肌肤之妙品，几乎每例病人必用。红斑性狼疮病程长久，故守方候效十分重要，切不可性急而频频更方。

(2) 治疗：在治疗方面汪氏还注意如下三点：

①祛风清营解毒，急则治标：汪氏认为本病主要是由于外感风湿热毒所致，风热毒邪内燔营血，则见面部红斑；风湿热邪痹阻肌肉关节，气血运行不畅，故关节肌肉疼痛。因而治疗每以祛风清营解毒为主，前者重在祛风清热、凉营解毒，方用消风散加减，药如当归、生地、蝉衣、荆芥、防风、牛蒡子、丹皮、赤芍、紫草等；后者则以祛风宣湿、清热和络为主，选白虎桂枝汤、桂枝芍药知母汤为主方，常用药有石膏、知母、桂枝、防己、忍冬藤、秦艽、虎杖、薏苡仁、桑枝等。部分急性暴发型红斑狼疮患者，除了面部红斑外，往往还伴有高热、烦躁、舌苔黄燥、舌质红绛等气营两燔的表现，甚则出现神昏谵语、四肢抽搐等症，又当投予清瘟败毒饮以清营解毒，常用银花、连翘、石膏、知母、黄连、生地、丹皮、赤芍、水牛角、玄参、竹叶等品，特别是高热持续不退者，运用此法多能收效。热陷心包、神昏谵语者还可合入神犀丹、安宫牛黄丸；热盛动风、四肢抽搐者加入紫雪之类。

②养肝肾补气血，缓顾其本：红斑狼疮的病理变化除了风湿热毒等标实的一面外，还有肝肾亏虚等本虚的一面，标实与本虚往往互相错杂。因为风湿热毒极易耗伤人体的阴血，导致肝肾亏虚，而肝肾亏虚又容易导致风湿热毒等标邪的侵入或稽留不去，再则本病患者由于长期使用皮质

激素、雷公藤等药物，也易形成阴虚火旺的病理改变。证之临床，我们发现本病在病变过程中每见头晕目眩，毛发脱落，面部暗黑，身体低热，或手足心热，舌红少苔等肝肾阴血受损的征象，特别是在病变稳定或缓解期尤为突出，此时治疗则应以养肝益肾为主，方用左归饮加减，常用何首乌、枸杞子、生熟地、女贞子、旱莲草、玄参、山药、山萸肉等。汪氏认为养肝益肾非朝夕可图，须久久服用，方可收功。通过养肝益肾，可以防止营热的再起或邪毒的侵入，若低热不净则每喜用青蒿鳖甲汤加减以养阴清热。另外，部分患者还可兼有面色㿠白，神疲气短等气血亏虚之象，又当投以黄芪建中汤、当归补血汤等补益气血。通过扶正顾本，可调整机体的免疫机能，提高机体的抗病能力，从而达到治疗的目的。

③病证变化多端，随机化裁：红斑狼疮，特别是系统性红斑狼疮往往是多脏器的损害，尤以肾、肝、肺、心等脏器的损害为多见。汪氏在治疗时总是根据各受损脏器的病变特点分别采用相应的治法。狼疮性肾炎主要表现是面目、四肢浮肿，且浮肿程度往往较甚，尿中蛋白持续不消，治疗多以健脾益肾为主，稍佐化气行水、活血化瘀之品，常用党参、黄芪、白术、山药、菟丝子、仙灵脾、补骨脂、茯苓、泽泻、车前子、桃仁、红花、泽兰叶等。同时注意用药不可过分温燥，也不可妄予分利，以免耗伤阴血。若浮肿不消而纳差、便溏等脾虚症状较为突出时，则重用黄芪、白术、山药，加薏苡仁、防己、玉米须、川椒目、冬瓜仁等。对于尿蛋白量多而持久难消者，常用芦根、白茅根、芡实、金樱子、仙灵脾、仙茅等以补肾固涩。若水邪凌心犯肺致咳嗽喘不能平卧者，麻黄、杏仁、葶苈子、桑白皮等宣肺行水之品也每常选用。后期肾功能衰竭引起尿闭

不通，则加用肉桂、知母、黄柏等以滋肾通关。狼疮性肝炎，初期主要表现为胁胀纳差等肝脾不和的征象，由于肝肾阴伤是致病之本，故治疗应以养肝运脾为主，稍佐理气疏肝之品。气郁较甚，胁痛明显时酌加川楝子、郁金、延胡索；腹胀较著，从实用川朴、鸡内金理气消胀，从虚用党参、山药健脾助运。肝功能明显损害时，加用黑料豆、枸杞子、楮实子、泽兰叶等。若腹水形成，则改投春泽汤加味以健脾利水，熟地、石斛等滋腻之品则不相宜。狼疮性肺炎多见咳嗽、气喘、胸闷等，波及胸膜还可形成狼疮性胸膜炎、胸腔积液，以致咳嗽加重。前者治疗重在清热宣肺，常用麻杏石甘汤或泻白散加减；后者则以下气行水为主，常用葶苈子、白芥子、苏子、茯苓、桑白皮、冬瓜子、半夏、薏苡仁、杏仁等，胸胁疼痛较著者还当合入香附旋覆花汤以理气和络。少部分患者还可见狼疮性心肌炎，表现为心悸、少寐、胸闷、气短、脉至数不匀，治疗每以益气养阴、宁心安神为主，常用炙甘草、太子参、麦冬、五味子、紫丹参、生地、茯神、柏子仁、玉竹、酸枣仁等。总之，系统性红斑狼疮病情变化莫测，证候错综复杂，临证时要仔细辨别，抓住主要矛盾，灵活多变地随机施治。^{[9][10]}

10. 章永红等诊治经验

根据辨证分为两组治疗。一组采用养阴解毒法，共 16 例。基本方药：生黄芪 20g，桑寄生 20g，怀牛膝 15g，女贞子 15g，墨旱莲 15g，何首乌 15g，车前子 20g（包），全蝎 3g，雷公藤 15g（先煎 50 分钟），土茯苓 30g，益母草 15g，鸡血藤 15g，生甘草 5g。

另一组采用养阴通络法，共 12 例。基本方药：何首乌

15g, 生熟地各 12g, 元参 20g, 丹皮 10g, 丹参 15g, 女贞子 15g, 墨旱莲 15g, 川芎 6g, 红花 3g, 赤芍 10g, 芥菜花 30g, 秦艽 15g, 虎杖 10g。

疗程 2 个月至 1 年余。对于经上述中医药治疗 2 个月无效者 (本组 8 例), 则加用小剂量激素治疗 (强的松 30mg/日)。^[11]

【按语】

系统性红斑狼疮属免疫系统性疾病, 中医无相应病名。发病多见于青春少女、少妇。病机是因虚致病, 以虚为本, 标实本虚, 虚中夹实。相关脏腑有肝、肾、脾、三焦、心等。患者多为先天禀赋不足, 肝肾本虚, 或者情怀久郁, 肝郁化火, 耗伤肝肾阴精, 或热病之后, 阴伤未复, 或接触某些化学毒物, 损伤气血, 致使脏腑气机紊乱, 气血营运失调, 复感风毒外邪, 络热血瘀。

张志礼提出本病的病机是因虚致病, 复因病成劳, 久治不愈又使虚劳加重, 注重扶正祛邪。吴圣农提出本病病机为肝肾阴虚, 邪毒亢盛。完善了脏腑定位, 注重滋养先天, 调补肝肾, 辅以清营凉血。并将其分为热毒炽盛、痹痛、肝肾不足等三型, 分别采用养阴清热解毒、养阴清热凉营通络、滋养肝肾清热解毒三法治疗, 临床尚需随症加减。周仲瑛也提出病位在肝肾, 分析各种产生阴虚的原因, 大致为先天禀赋不足、肝郁化火耗伤阴津、热病阴伤未复、接触化学毒物, 损伤气血, 再加上风毒外侵, 络热血瘀而发病。临床分为四型辨证治疗。丁济南认为该病病机为风寒湿三邪入侵机体, 属痹证范畴; 方中强调用辛温药, 祛风温阳, 散风除湿, 调补阴阳。考虑到阴虚为本, 辛温药

易伤阴津，此法似不可一概而论。沈丕安提出病位在三焦经络血脉，与心脾肾密切相关。心、脾、肾阴虚、血虚为本，瘀热、火旺、瘀滞、积饮为标。治疗重在养阴固本，又分为补阴、清热、生津、润燥四个方面。依据临床，配以清热、活血、祛风、益气、补肾、养血、利水、安神诸法，灵活运用。沈氏将本病分为十型，分别对应现代医学系统性红斑狼疮各阶段，见解独到，对临床很有指导意义。陈湘君将本病分为三型，强调养阴解毒需贯彻始终。艾儒棣提出本病初期治疗宜早，重在治标，以肾为要，治宜清热解毒，凉血化瘀，方用清瘟败毒饮加减；中期阴虚内热，重养肝肾，佐以祛邪，治宜滋阴清热，和营凉血，方用首乌地黄汤。后期脾肾两伤，大补气血，调补阴阳，治宜温肾壮阳，健脾利水，方用肾气丸、真武汤加减。钱文燕、郑占文认为本病病因病机为：肾虚、瘀血阻络、热毒侵袭，提出宜区分标本虚实。汪履秋对多种风湿疾病有着丰富的治疗经验，对本病始终抓住肝肾阴虚，风热侵袭营分的基本病机，以养肝肾、清营热为基本治则，再随证加减。活动期则加重疏风解毒之品，缓解期则重在滋肾，尤其喜用首乌一药，体现了这一特点。

(陶晓华 贾鹰珏 张 林)

参 考 文 献

- [1] 安家丰. 张志礼治疗重症红斑狼疮及皮肤炎的经验. 中医杂志, 1993, (6): 339~340
- [2] 陈湘君. 吴圣农老中医治疗系统性红斑狼疮的经验. 陕西中医, 1986, (6): 157~158
- [3] 樊莹. 周仲瑛治疗系统性红斑狼疮的经验. 中医杂志, 1997, 38 (11): 658~659
- [4] 罗仁夏. 应用丁济南老中医经验治疗系统性红斑狼疮 52 例疗效

- 观察. 贵阳中医学院学报, 1997, 30 (8): 10~11
- [5] 苏晓, 沈丕安. 沈丕安教授治疗系统性红斑狼疮的经验. 新中医, 1998, 30 (8): 10~11
- [6] 戴安伟. 陈湘君教授治疗风湿病经验拾萃. 南京中医药大学学报, 1997, 13 (2): 100~101
- [7] 艾儒棣. 谨守病机, 分期辨证治疗红斑狼疮的体会. 四川中医, 1994, 12 (9): 4~6
- [8] 钱文燕, 郑占才. 系统性红斑狼疮辨治规律的探讨. 天津中医, 1991, (5): 21~22
- [9] 范小珍. 汪履秋教授治疗胶原病经验拾萃. 杏苑中医文献杂志, 1994, (1): 30
- [10] 汪悦, 郭海英. 汪履秋诊治红斑狼疮的经验. 吉林中医药, 1991, (5): 7
- [11] 章永红, 余承惠, 郭惠芳, 等. 中医药为主治疗狼疮性肾炎 28 例. 吉林中医药, 1990, (5): 7

系统性硬皮病

【概述】

系统性硬皮病是一种原因不明，以血管炎为病理基础，以局限性弥漫性皮肤及内脏器官结缔组织纤维化或硬化，最后发生萎缩为特点的疾病。以双上肢皮肤增厚、变硬，多关节疼痛为主要症状，可累及多个脏器。发病率仅次于系统性红斑狼疮。女性多于男性。以 20~50 岁居多。临床分局限性和进行性系统性两大类，本章讨论后者。

系统性硬皮病的病因迄今不明，据检测的多种血清学改变和细胞免疫反应提示，免疫机制在致病方面起主要作用。本病美国的发病率为 2.7/100 万，女性较男性多见，约为 3~11:1。任何年龄皆可发病，但 20~50 岁为多。关于我国本病发病率，未见系统报道。

中医学无硬皮病之名，但古人有“痹者，闭而不通”之谓。邪阻肌表分肉之间，影响营卫的正常运行，致使病在经脉而有“皮痹”之名。当含现代医学之硬皮病。中医对本病早有认识，如《素问·痹论》篇说：“夫痹之为病，不痛何也……痹在于骨则重，在于脉则血凝而不流，在于筋则屈不伸，在于肉则不仁，在于皮则寒，故此五者则不痛也。”隋·巢元方《诸病源候论》云：“风湿痹病之状，或皮肤顽厚，或肌肉酸痛。”与本病的临床特征有很多相似之处。

【名医诊治经验】

1. 姜树荆诊治经验

硬皮病系素体脾肾阳虚，腠理不密，卫外不固，若寒邪乘虚侵袭，凝结于腠理，进而经络痹阻，气血不通，导致营卫不和，腠理失养而发生。又因病程迁延，邪可循经入脏，造成脏腑功能失调，更加重其皮肤损害。由此可见，病机的要点在于寒凝腠理、经络痹阻和脏腑失调三方面。这是病程由轻到重的三个过程。它们之间互相联系，互相影响，又互相转化，不能截然分开。正气不足为本，皮肤硬化萎缩为标。前者属虚，后者属实，故本病为一本虚标实之证。根据扶正祛邪的原则，应采用温经解肌、活血通络、益气养血之法进行治疗。

根据本病的临床症状和病机转化，将其归纳为以下两期四型进行辨证论治。

(1) 缓慢进展期

①寒凝腠理，脾肾阳虚型：全身症状为畏寒肢冷，关节疼痛，腰部酸痛，性欲减退，齿摇发落，食纳减退，口不渴，大便稀，局部表现为眼睑、面部及手背发紧肿胀，握拳不紧，局部坚硬，皮肤多呈粉红色，或黑白相间，舌体胀大或胖嫩，质淡暗，苔灰滞无泽，脉沉细濡。治以温肾散寒，健脾利湿，活血化瘀。方用阳和汤加味（熟地 30g，鹿角霜 15g，炒白芥子 12g，肉桂、炮姜炭、炙麻黄各 10g，苡仁、鹿衔草各 30g，红花 15g，炙甘草 10g）或回阳通脉汤Ⅰ号（附子片（开水先煎 1 小时）、肉桂、干姜、黄芪、苍术、甘草各 30g，党参、白芍、桂枝各 15g，穿心莲 30g，当归 15g）。

②寒侵络脉，肺卫不宣型：全身症状为低热恶寒，身痛肌痛，或有咳嗽，稀痰，口不渴，大便软。局部表现为皮肤局限性或弥漫性发硬，具蜡样光泽，甚至萎缩紧贴于深层组织之上。关节活动障碍，张口困难，皮色暗褐，毛发脱落，无汗或多汗，舌淡红，苔薄白，脉沉细数。治宜解肌散寒，宣肺利湿，通络化瘀。方用荆防败毒散加味：荆芥、防风、前胡、柴胡、羌活、独活、茯苓、枳壳、甘草、桔梗、川芎、生姜各 10g，薄荷 6g，黄芪 15g，当归、乌梢蛇各 10g，地龙、土元各 15g，全虫 3g，蝉衣 10g。虚甚者酌加党参、熟地、白芍各 15g；有热象者加银花、连翘、公英、地丁各 15g；瘙痒者加白鲜皮 15g，白蒺藜 10g。

③寒热错杂，肝郁血瘀型：全身症状为情绪易于激动，女性患者多有月经不调，或恶心呕吐，齿龈出血，便溏，完谷不化，或时稀时干。局部表现为除同上二型外尚有局部发白、发紫、发凉、灼热、瘙痒及雷诺现象，舌质暗红、苔薄白，脉弦。治宜疏肝解郁，健脾和胃，通络化瘀。方用丹栀逍遥散加味：丹皮、栀子、柴胡、当归各 10g，白芍 15g，茯苓 10g，白术 15g，甘草、生姜各 10g，薄荷、木香各 6g，荆芥 10g，地骨皮、红花各 15g，苡仁 30g。

④气血双虚，脉络闭阻型：全身症状为疲乏无力，食纳减退，体重减轻，肌肉疼痛，心慌气短，头昏，肢体麻凉。局部症状为皮损或轻或重，颜色瘀暗，四末发冷，舌质淡暗，苔薄，脉细弱。治宜气血双补，通络化瘀。方用逐痛汤加味：黄芪 60g，当归 30g，花粉 15g，肉桂 6g，玄胡 15g，车前子 30g，牛膝 15g，秦艽 30g，落得打 30g。

(2) 急期发作期：在四型中均可能有急性发作。常因累及内脏出现咳嗽气短、心慌心跳、黄疸、眩晕等症；也

可因寒邪郁久化热或经络闭阻，气血俱闭而发生指、趾端湿性或干性坏死、低热、齿龈出血、舌红脉数等证。治宜滋阴降火，清热解毒，疏肝理气。方用Ⅰ号苏脉饮（当归、元参各 15g，银花 30g，甘草 15g，郁金、泽兰、紫草、夏枯草各 30g，赤芍 60g）。

本文中医分型与西医的分类及系统性硬皮病的分期（浮肿期、硬化期、萎缩期）既有联系又不完全一致。中医分型既适应于系统性，也适应于局限性。只是局限性患者全身症状较少或没有。至于分期，似乎第一型多见于浮肿期及硬化的早期；第二型多见于明显的皮肤硬化萎缩期，且病情进展较快者；第三型多见于硬化萎缩期兼有肝失条达、寒热错杂等一系列见证者；第四型多见于硬化萎缩期兼气血双虚等证者。总之，四型的确立应以全身症状为主。^[1]

2. 李广瑞等诊疗经验

在大量观察硬皮病患者，学习刘辅仁教授治疗经验基础上，将硬皮病内治法归纳为“三期十法”。

（1）三期论治

①浮肿期：临床常见皮肤肥厚、紧张，呈实质性浮肿，正常皱纹消失，呈淡黄色，或黄褐色，或伴有发热、关节酸痛等急性发作的症状。治宜清热解毒，活血化瘀。方用自拟硬皮病Ⅰ方：当归 15g，玄参 24g，忍冬藤 30g，甘草 6g，白花蛇舌草 15g，赤芍 12g，丹参 15g，威灵仙 12g。

②硬化期：临床常见皮肤变硬，有蜡样光泽，皮肤不易被手捏起，压之无皱纹，可伴色素加深，或夹杂色素减退斑，知觉减退，毛发渐脱，或伴面色㿗白、形寒肢冷、大便溏稀、小便清长。治宜清肺健脾，散寒通络，活血软

坚。方用自拟硬皮病Ⅱ方：麻黄 6g，制附子 24g（先煎 1 小时），当归 12g，鸡血藤 15g，干姜 9g，白术 9g，吴茱萸 6g，丝瓜络 9g，醋鳖甲 24g，海藻 15g。

③萎缩期：临床常见皮肤萎缩变薄，僵如皮革，紧贴于骨，形成木板样硬化。治宜补益肝肾，益气养血。方用自拟硬皮病Ⅲ方：独活 12g，桑寄生 12g，当归 12g，白芍 12g，熟地 18g，川芎 12g，党参 18g，茯苓 12g，枸杞子 12g，龟甲胶 15g（烊化），鹿角胶 9g（烊化）。

（2）十法

①活血化瘀法：可用于局限性、系统性硬皮病的各个阶段，尤宜于系统性硬皮病的硬化期和局限性硬皮病无明显萎缩者。代表方为活络效灵丹、血府逐瘀汤。常用药物：丹参、赤芍、鸡血藤、刘寄奴、苏木、川芎、三棱、莪术、红花、益母草等。

②温肾健脾法：主要用于系统性硬皮病伴脾肾阳虚证候者，亦常用于局限性硬皮病的各阶段。此法常与温经通络、活血化瘀等法合用。代表方为右归丸、二仙汤、附子理中汤。常用药物有：附子、肉桂、干姜、鹿角胶、仙茅、淫羊藿、吴茱萸、肉豆蔻等。

③温经通络法：用于系统性硬皮病硬化期与局限性硬皮病以硬化为主要表现者。本法与活血化瘀法合用，有助于活血化瘀法发挥效应。代表方为阳和汤、大活络丹、小活络丹。常用药物有：桂枝、麻黄、丝瓜络、伸筋草、乌梢蛇、地龙、全蝎、蜈蚣等。

④软坚散结法：包括咸寒软坚、化痰软坚、散瘀软坚等法。此法有软化皮肤的作用，故常用于硬皮病的硬化期。代表方为海藻玉壶汤。常用药物有：海藻、昆布、牡蛎、白芥子、贝母、僵蚕、穿山甲、皂刺、鳖甲等。

⑤益气养血法：多用于系统性硬皮病萎缩期与局限性硬皮病有萎缩现象者，根据中医“气为血之帅”之理论，益气有助于活血，故在活血化瘀时当选加一、二味益气药，以提高活血化瘀法的疗效。代表方为八珍汤。常用药物有黄芪、党参、白术、当归、白芍、熟地、阿胶等。

⑥滋补肝肾法：用于系统性硬皮病萎缩期与局限性硬皮病见萎缩症状者，常与益气养血法合用。代表方为独活寄生汤、虎潜丸。常用药物有：桑寄生、龟甲胶、何首乌、枸杞子、女贞子等。

⑦祛风除湿法：祛风除湿法常用于治疗硬皮病，特别是系统性硬皮病的急性发作期，选加少量祛风除湿止痹痛的药物，有利于关节疼痛等症状的控制。代表方为《百一选方》蠲痹汤。常用药物有秦艽、防己、威灵仙、独活等。

⑧理气疏肝法：用于硬皮病伴情志异常，月经失调等症者，中医认为“气为血之帅”，“气行则血行”。故理气法也常与活血化瘀法合用，从而增强活血化瘀法的作用。代表方为逍遥散，常用药物有柴胡、香附、木香、枳壳等。

⑨清热解毒法：硬皮病急性发作时，常伴有发热、关节疼痛等症状。故常与活血化瘀法合用，以控制本病的急性发作。一旦症状控制，就应减量，或改用它法，以防寒之太过。代表方为四妙勇安汤。常用药物有：金银花、玄参、白花蛇舌草、紫背天葵等。

⑩利尿消肿法：系统性硬皮病急性发作时，若浮肿症状较甚，适当加一两味利尿消肿药，往往有助于浮肿症状的消退。代表方为《金匱要略》防己茯苓汤，常用药物有：茯苓、薏苡仁、车前子、白茅根等。^[2]

3. 张国伦诊治经验

硬皮病是发病率仅次于红斑狼疮的一种结缔组织疾病。分局限性和系统性两型。前者主要为局限性皮肤硬化，后者除皮损外，并可累及内脏器官，伴以相应的症状。本病因不明，多数可能是遗传因素再加反复持久的急慢性感染而造成的一种自身免疫机制失调性疾病。由于其病因尚不清楚，目前尚无特效疗法，预后大多不良，实属难治病证。本病在中医中类属皮痹，如侵及内脏类属癥瘕积聚。作者认真总结历代医家对本病的治疗经验，结合现代医学知识，采取静脉滴注参附注射液和丹参注射液，配合煎服三地二甲汤，取得满意效果。

中医对本病的认识源远流长，历代医书都有详细论述。《素问·痹论》说：“寒客于皮，则腠理开，开则邪入，客于络脉，络脉满，则注与经脉，经脉满则舍于脏腑也。”这里指出了痹之于皮，由邪搏于皮肤，痹阻不通，营卫行涩，血凝为患。因此，寒邪凝结于腠理是硬皮病的主要病机。风寒湿邪阻于表而为病；病久肾阳衰微，阴寒之邪内生，凝聚于全身肌表腠理，使全身皮肤顽硬，甚至危及生命。治疗本病，应以温通为基本原则。温阳与通络并施，扶正与祛邪兼顾，方能切合本病虚实夹杂，本虚标实的病机。如病情延久，皮肤变硬，宜加重祛风通络之品；肤色变深，甚则肌肤甲错、粗糙，应加强活血化瘀之力；肌肤顽硬如板状，乃痰凝胶着，应痰瘀同治，化痰软坚。参附注射液以人参、附子峻补元阳，丹参注射液以丹参活血化瘀通络。古人有“丹参一味，功同四物”之说，《本草纲目》有丹参治“恶疮”的记载，说明丹参有治疗各种顽固性皮肤病的作用。参附注射液加丹参注射液静脉滴注，体现了温阳通

络这一基本治则。三地二甲汤温阳散寒，搜风通络，活血化瘀，化痰软坚，乃使阳气复、营卫充、气血通，邪去正安，达到治疗目的。^[3]

4. 刘世金诊治经验

脾主运化升清，为人身气血生化之源。生成气的基本物质主要来源于脾胃中的水谷精微。而脾的这种运化功能，又能将水谷精微输送至全身肌肉中去，熏肤、充身、泽毛，故《内经》中说：“脾主身之肌肉。”脾气虚弱不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，气日以衰，则会出现临床上一系列症状。治疗以补气健脾为其治疗关键，首选四君子汤。针对其阳虚气弱病理，理当温阳益气以选桂附为佳，然为何不用肉桂、乌附之类，而用桂枝、茯苓等呢？盖因为脉细，久病血虚无疑，桂附大热，虽为温阳散寒之猛将，但能灼血，故而不用。再者，硬皮病患者胃肠粘膜脆弱，易于出血，故苦寒之品、大热之品不宜用。^[4]

【按语】

硬皮病属疑难诊治类皮肤病，尤其是系统性硬皮病牵涉多个脏腑病变，现代医学暂无良好的治疗方法，运用中医学治疗本病颇有疗效。本病主要表现为破坏性皮损，面部四肢皮肤紧张，不能捏起，色素沉着，皱纹消失，表情淡漠，呈假面具面容，皮肤知觉消退，急性发作时皮肤肥厚肿胀。其病因主要为寒、虚、瘀，主要病机为阳虚寒凝，气滞血瘀，肌肤失养。其治疗原则为温阳散寒，活血化瘀，行气通络。姜树荆根据多年临床，将本病归纳为两期四型辨证论治，分为缓慢进展期和急性发作期，以便临床处理。

四型为寒凝腠理，脾肾阳虚型；寒侵络脉，肺卫不宣型；寒热错杂，肝郁血瘀型；气血双虚，脉络痹阻型。李广瑞等则将本病内治法分为“三期十法”，根据病证分为浮肿期、硬化期、萎缩期，并自拟硬皮病Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ方。十法为活血化瘀法、温肾健脾法、温经通络法、软坚散结法、益气养血法、滋补肝肾法、祛风除湿法、理气疏肝法、清热解毒法、利水消肿法。张国伦提出对本病的治疗应以温通为基本原则，并采用静脉滴注参附注射液和丹参注射液，配合煎服其自拟之三地二甲汤，取得满意效果。刘世金则抓住本病肌肤失养病机，而脾主运化为后天之本之功能，从脾论治本病。各位医家对本病的认识、治疗，为临床诊治本病提供了经验，应为临床所借鉴。

(陶晓华 邬洪波)

参 考 文 献

- [1] 姜树荆. 硬皮病辨证分型及其治疗. 陕西中医, 1982, (3): 9~11
- [2] 李广瑞, 李晓燕. 硬皮病三期十法论治. 山东中医杂志, 1993, (6): 5~6
- [3] 张国伦. 系统性硬皮病辨治一得. 中医杂志, 1998, (5): 275~276
- [4] 刘世金. 辨证治愈系统性硬皮病3例. 四川中医, 1987, (5): 39

血栓闭塞性脉管炎

【概述】

血栓闭塞性脉管炎（简称 TAO），又称 Buerger 病。这是一种慢性、周期性加剧的全身小动、静脉闭塞性疾病。我国各地均有发病，北方比南方多见。患者绝大多数为青壮年男子，几乎占到 95%。病变主要累及下肢，脑、心、胃、肠等血管发生病变的罕见。病变呈血管炎、血栓形成、管腔闭塞，最后可导致肢端坏死。

本病的病因尚未明确，与以下诱发因素有关。吸烟：综合国内资料，患本病有吸烟史者占 60%~90%；寒冷和潮湿；外伤、感染；性激素、肾上腺皮质功能和神经调节功能紊乱。此外，自身免疫功能紊乱与本病的发生亦有关。本病有家族性。

本病属于中医学“脱疽”范畴。古籍中又有“脱痈”（《灵枢·痈疽篇》）、“脱骨疽”（《外科全生集》）、“脱骨疔”（《治疗汇要》）之称。俗称“十指零落”。

【名医诊治经验】

1. 王贵之诊治经验

王氏将血栓闭塞性脉管炎（中医脱疽）分为三型：

(1) 热毒型：患者多有慢性肢体缺血史，而因治疗护理不当引起急性缺血坏死合并严重感染。本型病例来势急剧，疼痛剧烈，患者常抱足而坐，彻夜呻吟。全身伴有发烧，重者神志模糊昏迷，多数病人创面颜色不鲜，皮肤呈紫灰色，界线不清。趾（指）及足背、手背全部或大部分呈坏死性紫癜。白细胞计数普遍升高，脉数大而有力，舌苔黄燥。由于热毒过盛，病变迅速，此型应以清热解毒为主，佐以活血消肿。方用四妙活血汤加味：金银花 60g，元参 60g，当归 30g，甘草 30g，公英 30g，丹参 20g，大黄 12g，牛膝 15g，乳香 10g。

(2) 湿热型：此型为热毒型的兼症，除全身有热毒病象外，局部肿胀较重，局部伤口分泌物多，皮肤糜烂，疼痛而有湿痒，创面灰暗，肉芽生长不鲜，脉浮数，苔白腻或黄腻，宜清热利湿，通络消肿，方用祛湿化瘀汤：萆薢 30g，泽兰 20g，茜草 20g，赤芍 20g，苡仁 30g，金银花 30g，大黄 12g，土茯苓 30g，防己 20g，甘草 10g。

(3) 阴虚型：病情发展缓慢，就诊时病情已稳定，疼痛多已不甚剧烈，但面容黄白或青黄，脉细数，舌质红苔白，伤面周围肿胀不明显，分泌物少，坏死界限清楚，宜补血养阴，佐以理气化瘀，方用顾步汤加减：黄芪 30g，金银花 20g，党参 20g，当归 20g，石斛 30g，丹参 30g，赤芍 30g，山药 30g，白术 20g，甘草 10g。

创面内溃水不净，肉芽组织不新鲜，表面不平者，可予外用药以去腐生新：白降丹 0.5g，红升丹 1g，炉甘石 20g，枯矾 20g，生石膏 30g，冰片 10g，丹石 20g，共为细末外用，每日或隔日一次。^[1]

2. 奚九一诊治经验

奚氏认为血栓闭塞性脉管炎应属中医学血瘀之证。其

“瘀”是由致病因子“邪”引起血管炎变而导致，在治疗上若见瘀治瘀，则致瘀之邪祛，新瘀还会不断发生，此非治本之道。他提出了“因邪致瘀”的发病观点，在治疗上确定以“祛邪为先”的原则。根据疾病的不同阶段辨证论治：①急性期——邪盛易致新瘀，所以缺血呈急性状态，其邪气为“湿热”或“热毒”，并常表现为里热外寒的假象。治疗宜清热解毒利湿为主，药用清脉 791-1 冲剂（药物组成：土三七、生甘草等）。此期禁用活血之品，因为在急性活动期，活血药可激惹血管炎症的发展。②缓解期——正虚瘀留，即其邪已去，但气阴两伤，瘀血停滞未化，治宜益气养阴，活血通脉，方用益气活血冲剂（药物组成：生黄芪、川石斛、鸡血藤等）。但也不必大队活血重剂，徒伤脾胃。③稳定期——正复邪去，陈瘀已伏。治疗宜补肾固本，益气活血，方用六味地黄丸合益气通脉片（药物组成：党参、黄芪、当归等），以防复发。

在本病的外治方面，奚氏认为①缺血性坏疽宜干，干性疮面有利感染的预防、坏疽的分界。②清疮、截骨时机的选择，强调要在坏疽与正常组织有明显分界，近端组织肿胀消退，皮肤温度改善，提示血管炎变稳定，侧支代偿已良好建立的情况下方可进行。③足部的湿性溃疡一般多伴有真菌及厌氧菌等混合感染，奚氏善用祛腐杀菌的一枝黄花等药水煎洗。^[2]

3. 王志平等诊治经验

血栓闭塞性脉管炎临床Ⅰ期（功能障碍或局部缺血）多属中医“脉痹”，Ⅱ期（营养障碍期）多属中医“足青紫症”、“手足青紫症”（瘀血），Ⅲ期（坏死期）属中医“脱疽”范畴。发作期失治预后不佳，因此保存肢体生命为首

要，不可贻误病机，应充分利用现代检测方法早期诊断、早期治疗，中医药治疗本病具有一定的特色与优势，体会到治疗宜分期辨证与辨病相结合。

(1) I期(功能障碍或局部缺血期)：临床表现：足或手凉，麻木，抽痛，跛行。足背、胫后、桡、尺动脉摸之细弱或不清，足趾凉，压之回血慢，舌淡，苔薄白，脉沉缓，或沉迟。证属寒凝血瘀，脉络瘀阻。治宜温经散寒，活血通络，方用桂附汤加味：炙附子、肉桂、牛膝、地龙、当归、熟地。体弱气虚者加黄芪；偏血瘀者加红花、丹参、赤芍。所用附子量大，配合肉桂、牛膝、地龙使阳和一转，经络通达，佐以丹参、红花使血活瘀化，再配伍黄芪佐以扶正使气血通畅，而诸证解。本期多属虚寒证，清热解毒之品须禁忌。

(2) II期(营养障碍期)：临床表现：足或手凉、麻木，足趾青紫或苍白、潮红，天冷加重，足趾、手指压之回血慢。足背或胫后、桡、尺动脉摸不清或细弱，舌暗有瘀斑、苔白稍厚，脉沉涩。证属血脉瘀滞，经络瘀阻。治当补血化瘀，通经达络。当归活血汤加味：当归、红花、丹参、赤芍、桃仁、牛膝、地龙。小腿抽痛者加白芍、牡蛎、全蝎、蜈蚣；气虚加黄芪；便秘加白术。本期症状及其病机主要反映在瘀血阻滞，使血脉不能通达，经络气血不能顺接。故重用丹参、当归、赤芍、红花，效果较好。经腹动脉造影和彩色血流图证实，本方能使血管扩张，侧支循环建立。对心血管有增加血流的作用，对周围血管有扩张和改善末梢循环的作用，从而使症状改善，血管痉挛缓解，相对疗程缩短。

(3) III期(坏死期)：临床表现：足(趾)或手(指)，溃破或干黑坏死明显，周围红肿疼痛，抱膝而坐，彻夜不

眠，足或手动脉摸不清，胫后动脉细弱或消失，舌红、苔黄或厚腻，脉洪数或沉数。证属血热瘀滞，毒聚不散。治宜清热凉血，活血解毒。药用四妙勇安汤加味：金银花、玄参、赤芍、当归、全蝎、蜈蚣、黄柏、甘草。若溃久体虚者加黄芪；疼痛重者加白芍、牡蛎；若溃处及周围有浮肿者加黄柏、苍术；若感染重者加强清热解毒或配合抗生素治疗。本期由于趾（指）溃烂或干黑坏死，往往不能在短时间内恢复，应用大剂量中药促使热毒清解，血活络通，防止截肢至关重要。故重用四妙勇安汤之金银花、玄参、当归，佐以解瘀通络攻毒之全蝎、蜈蚣。若溃久体虚，加大量扶正固脱、生肌长肉之黄芪，使气通血活，瘀化毒解，而不伤正，取长补短，相得益彰。

以上三期尚可配合局部处理：干性坏死一般无菌换药；湿性坏疽溃烂外敷一效膏（经验方：滑石粉 250g，煅炉甘石粉 10g，朱砂、冰片各 0.1g，淀粉 10g。上药共为末，香油调。）每日 1 次。若有死骨外露者，可在炎症消失后给予切除。^[3]

4. 郑长松诊治经验

（1）郑氏将血栓闭塞性脉管炎病因病机分为以下几类

①寒邪侵袭，血为寒凝：寒为阴邪，其性凝滞，久居寒冷之地，或骤受暴寒，血为寒凝，阻滞脉络，致成脱疽。临床上本型最为多见。患者每有寒邪侵袭病史，治疗投用温养经脉，益气通络之剂。

②湿浊蕴结，阻遏脉络：湿邪重浊粘腻，最易损伤阳气。湿浊蕴结，阻遏气机，气机不利则血运不畅，瘀阻脉络。本型亦是脱疽较为常见类型。此类患者多伴有头身沉困，脘闷纳呆，肢面虚浮，带下淋漓等证。治疗以醒脾化

湿，活血通络为主，随症伍入它药。

③热毒瘀阻，跖趾溃疡：热毒瘀阻血脉，多由寒邪郁久化生，亦有夙罹热邪蕴郁者。热毒结于局部，阻滞气血运行，腐肉败血，形成疮疡。此类患者多见于脱疽中、后期。是时治之得宜，毒解热平，瘀阻得通，则可免致趾指零落之苦。施治必重用清解化瘀之剂，否则剂量过轻，药不胜病。

④气血俱虚，脉络瘀阻：气血运行全身，贵在流通舒畅。“气为血之帅”，“血为气之宅”。气虚运血无能，血虚气无所生，气血俱虚则易致血运不畅，脉络瘀阻。本型多见于脱疽迁延日久之患者。治疗宜补气养血与活血通脉并重，随症增损。

（2）郑氏治疗脱疽要点

①截肢非为治本：血栓闭塞性脉管炎，特别是有坏死病变者，现代医学多采用截肢治疗。郑氏认为，本病的形成绝非单一的局部病变，发病与否由内在因素所决定，它所表现出来的症状是全身性疾病的局部反映。在治疗上，内源性因素不去，或不加以控制，纯恃截肢手术这不是治本之法，还必须从中医的整体观念出发，进行辨证论治，俾脉络流畅，血灌四末，方为治本。

②疏通贯穿始终：本病的突出表现是患指（趾）剧烈疼痛，肤色改变，温度变异，走路跛行，脉搏减弱或消失等，是气血不能灌注周流，循行失度的结果。溃疡坏疽是气血长久瘀阻，指（趾）失营养的必然。总之，气血瘀滞是脱疽的症结所在，所以在临床上要将疏通脉络贯穿于治疗始终。

③注重顾护胃气：顾护胃气是治疗一切疾病的先决条件。因为本病的病变实质是气虚瘀滞，所以必须将活血祛

瘀，疏通脉络贯穿治疗始终，而不少活血祛瘀药具有损伤胃气之弊。郑氏选药多选丹参、当归、鸡血藤、赤芍等活血祛瘀而不伐胃气之品，较少投入乳香、没药等败伐胃气之类。凡遇脾胃素弱者也多于方中加入白术、陈皮等以健脾和胃。

④补益不宜过剂：在临床上屡有据“气为血帅，血随气行”之理，凡治脱疽每投大剂黄芪冀期气旺则血行顺畅。郑氏认为，脱疽是有其气虚的一面，但绝不可孟浪倡补，痛势愈是剧烈，愈不能补益无度，过剂则反气壅血滞。即是气血俱虚之证，亦要以“通”为主，寓补益于疏通之中，方不致补益反而助邪，不可不慎。^[4]

5. 魏汉民等诊治经验

血栓闭塞性脉管炎分三型：

(1) 阴寒型：症见患肢发凉，喜暖怕冷，遇寒则甚，得热则缓，皮肤苍白，干燥无泽，沉重麻木，疲劳，易成间歇跛行，脚趾有针刺样疼痛感，小腿酸胀，趺阳脉搏动减弱，头晕倦怠，心悸自汗或盗汗，苔白腻，脉沉迟，或弦紧。治当扶正温阳，散寒通脉。药用：当归 15g，鹿角胶 10g，麻黄、干姜、白芥子、肉桂各 9g，乌药 12g。若脚趾冰冷加黄芪 20g，附子、苍术各 10g；肤色暗淡加坤草 20g，鸡血藤、地龙各 10g。

(2) 血瘀型：症见形体消瘦，肌肤枯燥，面色晦滞，肢趾端紫红，或暗红，下垂更加明显，抬腿则变苍白，疼痛呈持续性而难以忍受，夜间加重，患者往往抱膝而坐，趾头有如煮熟之红枣，溃疡初破，足背毳毛脱落，趾甲变厚，趺阳脉搏动消失或微弱，苔薄白、质暗红，或有瘀斑，脉沉细而涩，或弦细。治当活血化瘀，

通络止痛，药用：当归、玄参各 30g，牛膝、坤草各 15g，薏苡仁 30g，乌药 12g，丹参 15g，木通 12g，穿山甲、红花、蜣螂各 10g，两面针根 20g。若寒湿下注，脚趾肿胀加赤芍、泽泻、黄柏各 10g；滞胀不通加槟榔、丝瓜络各 10g。

(3) 热毒伤阴型：症见跖趾如煮熟之红枣，或干枯焦黑，溃破腐烂，肉色不解，渐变为紫黑色，呈浸润性蔓延，脓水稀薄，气味剧臭，疼痛剧烈，如汤泼火烧，甚则肉枯筋萎，色黑而干，昼轻夜重，屈胸抱足按摩而坐，常伴有发热口干，烦躁不安，口渴便秘，尿黄赤，趺阳脉消失，苔黄燥，或黄腻，舌质红，脉细数，或红数。治当养阴活血，解毒镇痛。药用当归、玄参、金银花、公英、地丁各 30g，黄芪 15g，延胡索 12g，生地 20g，乳香、没药各 9g，牛膝、赤芍各 10g，红花 12g，知母 10g。若久未敛口加川贝、白蔹各 10g。

外治法：溃面见脓物稍多，溃口较鲜，气味恶臭，银黄纱条放患处，再用纱布敷料涂上生肌玉红膏，包裹之；见脓物少，溃口紫暗，气味较轻，久不敛口，归银纱条放患处，再用纱布敷料涂上生肌玉红膏，包裹之，每 1~2 日换药 1 次即可。

讨论：阴寒型发病轻，多由禀赋不足，或阳虚之体复感外寒；或阳虚寒化，寒自内生；阴寒为阴霾之邪，最易伤人阳气，趾（指）为人体之四末，易为寒邪所伤，阳气不足，不能畅达四末，则四肢不温，血行不畅，经络气血下聚，筋肉失却温煦濡养，治疗时要时时顾护阳气，扶正不忘祛邪。血瘀型是阴寒型的进一步恶化，是在阴寒证基础上的发展。由于阴寒证的失治误治，延误病机；或脉络受病邪的直接侵袭，未经阴寒型而直接发为血瘀型。患者

正气已衰，脏腑受损，血瘀气结，气结则津液不行，不行则血脉凝滞，血得温则行，遇寒则凝，寒凝则瘀，经络阻塞不通，不通则痛，患肢则见紫红和暗红，疼痛等明显血瘀症状。故治疗着重活血化瘀的同时，不忘理络通经。热毒伤阴型是上二型的进一步恶化，病情较重，因寒邪凝结，气滞血瘀日趋加重，郁久化热，热毒炽盛，热盛肉腐，则形成溃疡——“脱疽”。故治疗一则清热解毒，养阴通脉；二则气血双补以托阴毒，互为兼施而奏效。^[5]

6. 黎镜诊治经验

中医认为脉管炎的主要临床表现是热毒和血瘀为患，故热毒和血瘀存在于脉管炎各型各期之中。作者根据本病的临床症状及体征结合中医四诊，分为虚寒、瘀滞、湿热、热毒四型，每型按中医辨证分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。临床实践证明，脉炎汤（忍冬藤 60~120g，当归 40~60g，玄参 60~90g，党参 30g，蜈蚣 10~15 条，川牛膝 30g，鸡血藤 30~60g，紫丹参 30~90g，石斛 30g，白术 30g，桃仁 15g，红花 15g，甘草 30g，鹿角霜 30~60g，水煎 3 次，取药液混合；制松香末 3.5g，全蝎末 2.4g，水蛭末 3g，金线白花蛇 1 条（研末），上药混匀，装在“0”号胶囊内，分成 3 份，用汤药分早、中、晚送服）方中的药根据病情酌情增减，但不要轻易削减方中药味，要始终坚持“清”与“通”的治疗法则，清其热毒，通其瘀滞，热毒清除，瘀滞疏通，气血运行复常，肢体得气血濡养，溃疡自愈。脉管炎发展到Ⅲ期，久病体弱明显，热毒血瘀交阻于脉络，常剂甚难获效，故用药时要注意重大剂量。一般每味药均宜在 30g 以上。实践证明，在辨证准确选药对症的基础上下重剂，对于迅速控制病势发展，促进闭塞的血管复通，缩短

治疗时间和提高疗效有着十分重要的临床意义。

Ⅲ期脉管炎均有较严重的溃疡坏死，采用标本并治，内外兼施的方案，在内服药的同时，创面的处理也很重要。松桐膏（松香研为极细末，加入适量生桐油调为糊状，瓶装备用。敷药前先用10%食盐水将溃疡面洗净，小心去除腐肉死骨，然后将松桐膏敷满溃疡面，纱布包扎，每日换药1次。）具有消炎杀菌、去腐生肌、活血止痛的良好作用。本组病例从始至终都外敷松桐膏，直至创面完全愈合为止。^[6]

7. 王景春诊治经验

王氏将血栓闭塞性脉管炎分为四型（3个月为1疗程，多者2个疗程。）：

（1）虚寒凝滞型：症见足凉麻木、抽痛、跛行，足趾压之回血缓慢，足背动脉摸之细弱，或不清，气虚无力，面色㿔白，舌质淡白，苔白薄，脉沉缓或迟。治用补气温经，散寒通络之法。药用：黄芪50g，当归30g，红花、丹参、牛膝、地龙、肉桂各20g，附子10g。

（2）血脉瘀滞型：症见足或手凉麻木、青紫或苍白、掣痛，压之回血缓慢，皮肤粗糙，毫毛稀少，趾甲增厚，或变形，足背动脉不清，踝动脉细弱，或消失，面色微红，舌质暗红有瘀斑，或有瘀点，苔白薄，脉沉涩。治以活血化瘀，通经达络之法。药用：当归、赤芍各50g，红花、丹参、牛膝、鸡血藤各30g，地龙、甘草、桃仁各10g。

（3）热毒型：症见足或手指溃烂或干枯，晚间疼甚，抱膝而坐，彻夜不眠，足趾溃烂有腐肉不脱，足或手色紫暗，皮肤粗糙，趾甲增厚，或变形，足背动脉摸不到，踝动脉摸不清，并伴发烧，口干渴，面红，便干，小便黄，

舌质红，苔黄腻，或厚腻，脉洪数。治以清热解毒，化瘀止痛之法。药用：金银花 100g，玄参 50g，当归、赤芍各 40g，全蝎 5g，蜈蚣 3 条，甘草 10g。

(4) 气血虚型：症见足凉麻木或青紫苍白，或溃久不愈，夜间痛甚，趺阳、太溪脉不清，皮肤粗糙，足色紫暗，趾甲增厚，溃口淡白，脓腐不脱，疼痛难忍，或有臭味，重者肌肉萎缩。气虚无力，面容憔悴微白，胃纳不佳，心悸气短，畏寒自汗，舌质淡白，苔白薄，脉沉缓。治用大补气血，化瘀解毒之法。药用：黄芪 50g，当归 40g，党参、红花、丹参、金银花各 30g，熟地、白术、甘草各 20g。^[7]

8. 马同长诊治经验

(1) 病人自身护理

①防止热疗损伤皮肤：由于患者局部血流减少，末梢神经感觉障碍，严重时呈麻痹状态，对外界温度的升降不敏感，易损伤皮肤，又因形成溃疡和坏疽，严重时不得不截肢，故应严格掌握和控制热疗的温度和时间。热伤一旦形成后，要立即采取治疗措施，改善热伤部位血流，有效控制感染，保护肢体。

②避免吸烟使伤口恶化：临床大量伤口感染与恶化，均与吸烟有一定关系，不吸烟的患者，伤口比较稳定，肉芽生长较好，愈合快。据统计，吸烟患者伤口的愈合要比不吸烟患者延迟 1~2 个月。

③患者运动的掌握：早期应作适量运动，可促进局部血流，改善微循环，减慢肌肉萎缩；晚期病人则应严格卧床休息，因此期病人病情恶化，组织缺氧腐败，活动则会加速坏死。卧床时应作脉管炎病人床上体操（平卧，将下

肢抬高 45cm, 3 分钟后放平伸直, 继则下垂 3 分钟, 每次 3 回, 一日 2~3 次。)。伤口愈合期应作功能锻炼。

④发病期间绝对禁止性生活。

(2) 诊断与处理

①可并发脑血栓形成。

②局部封闭, 处理要适当。

③截肢时选择适当的麻醉方法。

④营养障碍不宜过早做趾(指)切除。

⑤药物剂量变化对治疗的影响: 在治疗末期药物剂量要加大。

⑥辨证治疗的观察: 从发病到病理演变, 应认真分期, 分虚实, 分寒热, 分类型, 综合分析, 对症用药, 适量加减。

⑦病愈后要坚持治疗 1~3 个月。

(3) 特殊药物的剂量

①壁虎: 用于第三期有溃口患者疗效最佳, 剂量 1 天常用量 6~8 条为宜。

②蜈蚣: 最大剂量加到每日 10 条, 研末分 3 次服, 服后感觉疼痛减轻, 肿胀消退, 局部红肿黑紫消失。未发现副作用。壁虎和蜈蚣各等分研末, 外撒于溃口有发痒感觉, 一般 1~3 小时便消失, 此后即感局部有搔抓感, 分泌物逐渐减少, 伤口生长见好。

③皂刺: 功用攻坚散结, 活血消肿, 透脓化疽, 疗效可靠。但此药穿透作用较强, 服后有走窜性疼痛, 为药物反应, 不必停药, 可加大剂量, 一般以 50g 为宜, 服后坏死组织脱落较快, 新鲜组织生长较为迅速。

④川芎: 剂量用至 150g, 服药后可见血管扩张, 伤口渗血, 微循环改善, 局部温度上升, 既而伤口见肉芽生长。

无不良反应。

⑤马齿苋和胡萝卜：对于静脉炎及局部组织红肿热痛、溃疡者，除内服中药外，还可配合马齿苋煎汤外洗或外敷，每日1次，可见局部肿胀消退，溃口逐渐愈合，马齿苋具有清热解毒，消肿消炎的作用。胡萝卜内主含维生素A，具有维持上皮细胞正常功能的作用，两者配伍，既经济，效果又好。

⑥珍珠散和消炎粉：用于溃口可促进腐肉脱落，新生组织再生。^[8]

9. 孙旗立等诊治经验

孙氏等认为血栓闭塞性脉管炎的病因与自身免疫有关。通过用益气活血法（基本方：黄芪、党参、甘草、当归、丹参、川芎、鸡血藤；局部凉重者加肉桂；痛甚者加乳香、没药、延胡索；局部感染者加金银花。每日煎服1剂，煎至200ml，早晚分服。另外对局部溃破者加用氦-氖激光照射，以促进其愈合）治疗，表明此病的免疫功能确有变化，具有免疫调节作用，并且临床疗效亦佳。据现代药理研究分析，黄芪、党参有增强人体免疫功能的作用，甘草有类皮质激素的作用，两者配合有免疫调节功能。加之诸活血药的活血通经作用，故收到较好的治疗效果。^[9]

10. 程德华诊治经验

程氏认为本病主要原因是久病气虚致瘀、久病痰浊凝滞致瘀、久病阳虚致瘀，因此在临证时必须考虑到“久病必瘀”，治疗时必须补气活血，行气活血，化痰祛瘀等。程氏选用桃红四物汤加味：桃仁、白芍、当归各12g，红花10g，熟地20g，川芎9g，水蛭、廬虫各6g，丹参、炙黄芪

各 30g，炙甘草 9g。加减：畏冷怕热，局部红肿，昼夜剧痛，烦躁不安，大便干结，小便短赤加玄参、生大黄、蒲公英；患肢不温，夜间痛重加桂枝、炮附子、制乳没；肢体沉重、麻木，嗜睡加土茯苓、苡米，去上方生地；溃疡久不收口加生大黄、黄柏（煎水外洗患处，并加用红霉素软膏）。30 剂为 1 疗程，每日 1 剂。

方中桃红四物汤养血活血。水蛭、虻虫攻逐瘀血，水蛭味咸专入血分，破瘀血而不伤新血。水蛭、虻虫善于走窜入络，通经破瘀之力较强，这与叶天士主张的“通络之法，每取虫蚁迅速飞走诸灵”其义相合。桃仁与虻虫相伍，破血行瘀，能治瘀血凝滞，并有止痛之功；丹参活血祛瘀，专走血分，能祛瘀生新，凡因气血瘀滞所致的多种疾病，均可选用；熟地凉血清热和滋阴补肾，常用血虚诸证。临床上气和血关系较为密切，气为血帅，在活血化瘀中佐入行气理气之品，以期“气行则血行”；选用炙黄芪，重在走里，能补气升阳，散表邪，托疮毒，敛疮收口。据近代研究，黄芪可加强毛细血管抵抗力，扩张血管，改善血行，使久坏之肌细胞恢复活力，可治慢性溃疡痼疽；炙甘草一药，一方面补中益气，调和药性，能使各药互相和谐而无相争之弊。纵观全方，以补气活血而获效。^[10]

11. 霍爱民诊治经验

霍氏认为本病主要是由于情志内伤，肝肾不足，寒湿外受，凝聚经络，闭塞不通，气血运行不畅，日久郁而化热，出现湿热下注而发本病，故用清热通络之法，采用内服二妙五神汤（苍术、黄柏、银花、牛膝、车前子、地丁），外敷桑槐膏（金银花、连翘、当归、大黄、黄连、栀子、香油、槐枝若干，炼制软膏，隔 1 日换药 1 次。）。二

妙五神汤中银花、黄柏、地丁以清热解毒；茯苓、车前子、苍术以利湿；牛膝以活血行血引水下行。然治湿不利小便，非其治也，故方中重用車前子分利水湿，茯苓化浊渗利，二药合用，使湿邪从小便排出。桑槐膏中银花、连翘以清热解毒，当归、大黄以活血，黄连、栀子清热燥湿。炼制软膏，外敷患处，可直达病所，清热燥湿，生肌收口。^[11]

12. 刘亚娴诊治经验

对血栓闭塞性脉管炎之属于寒凝血闭者，刘氏认为用细辛应量大重用。曾治崔荣，男，65岁，因右足麻木发凉年余，足第2趾变青紫色，伴剧烈冷痛、难以行走近2月。现代医学诊为血栓闭塞性脉管炎（Ⅲ期）。诊得脉沉细，舌淡红苔白，乃寒凝血闭，脉络不通，遂以阳和汤、桂枝附子汤、麻黄附子细辛汤化裁治之。处方：熟地25g，细辛20g，炮附子、当归、赤芍各15g，鹿角霜、干姜、肉桂、麻黄、白芥子、桂枝、生甘草各10g。服15剂后足趾冷痛减轻，已可短距离步行，服药无任何不适。遂增附子、细辛之量以加强温通之力，增熟地之量，防细辛燥热伤阴。又服月余，足麻木发凉大减，足第2趾青紫减轻，再将熟地、炮附子、细辛用量分别增至40g、30g、40g。该方服至1991年4月，诸症若失，足第2趾变红润，上方每隔2~3日服1剂巩固之。至1992年情况良好，右足麻木冷痛消失，足趾颜色复常，行动一如常人。该例用细辛达40g，远远超过习惯用量，并未发现不良反应。^[12]

【按语】

综合以上诸位医家的经验，主要反映在以下几个方面：

(1) 病因病机：奚九一、程德华均认为血栓闭塞性脉管炎应属中医学血瘀之证。其“瘀”是由致病因子“邪”引起血管炎症变化而导致，在治疗上若见瘀治瘀，则致瘀之邪祛，新瘀还会不断发生，此非治本之道。他们提出了“因邪致瘀”的发病观点，在治疗上确定以“祛瘀为先”的原则。郑长松提出该病与寒、湿、热毒及气血俱虚有关，强调邪正两方面的致病因素。黎镜则认为热毒和血瘀存在于脉管炎各型各期之中，诊治时需要予以重视。孙旗立认为病因与自身免疫有关，采用益气活血法来增强机体免疫力。霍爱民提到患病与情志有关。

(2) 辨证论治：王贵之将本病分为三型（热毒型、湿热型、阴虚型）。王景春等将之分为三期（功能障碍或局部缺血期、营养障碍期、坏死期）。魏汉民等将之分为三类（阴寒型、血瘀型、热毒伤阴型），并配合外治法治疗。黎镜分为四型（虚寒、瘀滞、湿热、热毒），每型按中医辨证分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。王景春分为四型（虚寒凝滞、血脉瘀滞、热毒、气血虚弱）。这些辨证论治方法，简明扼要，对于掌握该病的特点，很有意义。马同长从病人自身护理、诊断与处理、特殊药物的剂量等方面论述了证治。刘亚娴通过重用细辛（20g）来治疗属于寒凝血闭者获得很好的疗效，经验独到，值得临床探讨、借鉴。

（陶晓华 张 林 贾鹰珏）

参 考 文 献

- [1] 王贵之. 中草药治疗血栓闭塞性脉管炎. 新疆中医药, 1994, (3): 53
- [2] 张啸刚. 奚九一诊治周围血管病的独到经验. 上海中医药, 1993, (6): 8~10

- [3] 王景春, 王志平, 崔国伟, 等. 427 例血栓闭塞性脉管炎分期辨治报告. 新中医, 1993, (9): 24
- [4] 郑其国. 郑长松老中医治疗血栓闭塞性脉管炎的经验. 天津中医, 1987, (1): 9~10
- [5] 魏汉民, 李月英, 李盈昌. 辨证论治血栓闭塞性脉管炎 112 例. 辽宁中医杂志, 1992, (9): 37
- [6] 黎镜. 分型论治Ⅲ期血栓闭塞性脉管炎 115 例体会. 中西医结合杂志, 1991, 11 (11): 677
- [7] 王景春. 血栓闭塞性脉管炎 180 例的中医辨治. 辽宁中医杂志, 1991, (11): 20
- [8] 马同长. 血栓闭塞性脉管炎临床治疗体会. 上海中医药杂志, 1990, (4): 8~9; 1990, (6): 11~13
- [9] 孙旗立, 王怀山, 陈治水, 等. 益气活血法治疗血栓闭塞性脉管炎及其免疫指标观察. 辽宁中医杂志, 1988, (11): 16
- [10] 程德华. 活血化痰法治疗血栓闭塞性脉管炎 21 例. 陕西中医, 1996, 17 (2): 67
- [11] 霍爱民. 清热利湿通络法治疗血栓闭塞性脉管炎. 实用中西医结合杂志, 1995, 8 (10): 587
- [12] 刘亚娟. 细辛通血闭、开结气. 中医杂志, 1993, 34 (6): 326

腰椎间盘突出症

【概述】

腰椎间盘突出症又名腰椎髓核突出症。是腰椎间盘发生退行性变以后，因某种原因（损伤、过劳等），致纤维环部分或全部破裂，连同髓核一并向外膨出，压迫神经根或脊髓、马尾神经的一种疾病。主要表现为腰痛及下肢疼痛，增加腹压及劳累后加重，休息后减轻。小腿外侧及足背皮肤感觉减退，拇背伸肌力减弱。膝腱、跟腱反射减弱，或消失，脊柱侧弯，生理前突变平；椎旁压痛并向下肢放射，沿坐骨神经走行方向压痛。是青壮年的多发病，也是引起腰腿痛的主要原因。临床发病男性多于女性，25~45岁发病最多，体力劳动者尤为多见。

中医学对“腰椎间盘突出”很早就有叙述。《素问·脉要精微论》曰：“腰者，肾之府，转摇不能，肾将惫矣。”《素问·刺腰痛论》中说：“衡络之脉令人腰痛，不可以俯仰，仰则恐仆，得之举重伤腰。”又云：“内里之脉，令人腰痛，不可以咳，咳则筋缩急。”《医学心悟》也说：“腰痛拘急，牵引腿足。”这与腰椎间盘突出的症状基本相似，本病应属于“腰痛”、“痹痛”、“肾亏”的范畴。临床文献中还有“肾亏腰痛”、“气滞腰痛”、“寒湿腰痛”以及“闪腰”、“岔气”、“虚劳”等不同的病名。其病因病机，中医认为主要是强力举重或感受风寒湿邪导致经络阻塞，气血凝滞不通

以及年迈肾虚、腰府失养所致。

【名医诊治经验】

1. 石幼山诊治经验

(1) 辨证论治分虚实：石幼山将腰椎间盘突出症分为两大类，第一类偏实证为主，临床上有明显的神经根症状，如直腿抬高试验阳性，加强试验阴性，有不同程度的肌力减退和感觉异常，椎旁有压痛和放射痛，属于急性发作期，治疗以活血祛风为治则。第二类，从辨证来讲属于虚实夹杂或偏虚为主，从临床症状来看，这类病人大都经过治疗，症状有不同程度的减轻，属于缓解期，治疗以活血益气为主。

(2) 活血祛风缓疼痛：急性期以疼痛为主要症状。石氏认为这类病因病机为血脉不通，气血不活，在此基础上风寒湿邪乘虚而侵犯人体的经筋络脉，使疼痛加剧，故以活血祛风法治疗。活血药中石氏首选当归，当归既可以活血补血，又可温经止痛，是治疗本病的一味主药。其次选用红花、泽兰、丹参等药。祛风药中，根据疼痛的轻重而选用不同的药物。疼痛较甚者，选用温经止痛的川草乌配以地龙。疼痛较轻时，选用祛风通络威灵仙、独活之类药物，还可选用络石藤、寻骨风、秦艽等药。

(3) 活血益气通痹阻：缓解期的治疗以活血益气为主，根据疼痛症状的残留与消失，分别佐以祛风通络和补益肝肾。活血益气、祛风通络治疗腰腿痛急性发作期已过，但疼痛减轻而未消失，石氏治疗中常在活血祛风的同时加以黄芪、党参为主的益气药，这是因为这些病人病程较长，“久病则虚”，另一方面这些病人因疼痛缓解，既而出现腰

腿无力、酸软为主的症状。活血益气补益肝肾是针对腰腿痛基本消失，而以无力、酸痛、麻木为主症状的治法。

(4) 健腰益肾贯始终：“腰为肾之府”，石氏在分析腰椎间盘突出症的病因时指出：正气虚、肾精不足是基本因素，加上感受风寒，或因过于劳累，或跌仆闪挫。正如沈金鳌在《沈氏尊生书》中所说“精气虚而邪客病也”。因此石氏在治疗本症时不论是早期还是晚期，总在活血祛风或活血益气治则下配以狗脊、牛膝、川断、杜仲等健腰补肾之品。其中牛膝、狗脊是石氏推崇的药物。

(5) 症证结合，重视兼邪：石氏在治疗这类病人时常常症证结合，既考虑腰椎间盘突出症这一疾病所出现的症状，又结合四诊进行辨证。在治疗上除了用上述方法外，还注意和兼顾这一疾病以外的症状，有时常常舍证从病，或舍病从证，这体现了石氏所追随的薛己“十三科一理贯之”的学术思想。

(6) 综合治疗，提高疗效：石氏在理伤过程中常采用中药内服外敷、针灸、手法等，还应用牵引、卧床且保暖等方法，这样可以缩短疗程，提高疗效^[1]。

2. 丁得诊治经验

(1) 抓住诊断要点，准确诊断：对于本病的诊断，丁氏强调要抓住以下要点：①下腰疼痛，伴下肢放射痛、麻，时轻时重，反复发作。②腰椎生理弧度变浅，或脊柱侧弯，腰部活动受限。③腰4、5，骶、棘突旁有深部压痛，伴同侧下肢放射痛、麻木不适。④下腰棘突偏歪，棘突距不等宽，棘上韧带剥离、钝厚、压痛。⑤脊柱过伸侧弯试验、直腿抬高试验、直腿抬高加强试验、曲颈试验、挺腹试验、弓弦试验可能阳性。⑥患侧小腿前或后侧，或后外侧感觉

减退，拇趾背伸肌力减弱，或膝或跟腱反射减弱。⑦脊髓腔造影对本病诊断和定位有重要价值；CT扫描可显示椎管影像及神经根受压情况。

(2) 辨证施术，不拘一法一方

①急性发作期：应以绝对卧硬板床休息，加骨盆牵引为主，配合轻柔的手法推拿按摩腰臀部及患侧下肢，以缓解局部的肌肉紧张痉挛。在配合局部外敷消瘀散结药物以化瘀止痛，同时内服活血化瘀、利湿通络的中药，如苍术、黄柏、川牛膝、广地龙、土鳖虫、泽兰、木通、茅根、车前子、桂枝、制乳香、制没药、枳壳、赤芍；病久体虚者，加杜仲、山萸肉、五加皮、熟地黄。

②缓解期：应作大牵引，再配合推拿按摩手法进行复位。大牵引（病员取俯卧，俯卧牵引可减轻椎间盘所受压力）使腰部椎间隙增宽，间隙内负压增加，后纵韧带拉紧。通过后总韧带借助纤维环外纤维的张力和椎间隙内负压的吸力，造成突出髓核回纳和改变位置。推拿按摩主要以腰部后伸扳法的手法为主；病员取俯卧位，医者一手以掌根按压腰椎间盘突出的部位，一手扳病员患侧下肢，由轻渐重地扳，每次5~8分钟，而后继以两手握病员患侧踝部，持续牵抖每次5~8分钟。

③脊柱侧弯明显者，采用旋转复位：病员取坐位，医者一手以拇指抵住偏斜的棘突推向对侧，一手从病员的同侧腋窝下，自胸前伸至对侧肩颈背部，挟按颈根部用力旋转脊柱（由轻度前屈旋转至对侧并伸直），两手协同用力。

④病员下腰部及臀部疼痛明显者，消瘀散结药物外敷，适当内服中西药物，配合推拿按摩（Guan法为主）。如痛点局限，通过以上治疗仍未消失者即以普鲁卡因加强的松龙压痛点局部封闭。

⑤如巨大椎间盘突出或伴椎管狭窄，症状体征重，病程长经保守治疗效果不明显者，即予手术治疗。

(3) 动静结合，防治并重：“静”是指丁氏对本病急性期的治疗，强调病员绝对卧硬板床休息，一则便于紧张痉挛的肌肉缓解；二则可使破裂的纤维环和突出的髓核压迫而引起的局部水肿、炎症消退，以减少对神经根的刺激；三则便于使部分膨出髓核回纳。“动”是丁氏治疗本病后期采用的以锻炼腰背肌为主的练功活动。练功方法：病员每早、晚各一次俯卧于硬板床上作“飞燕点水”，或“仰卧架桥”，或腰背肌收缩锻炼，一次不少于20下，坚持3~6个月。目的使腰肌坚强，稳定腰椎，防止复发扭伤。练功初期，练功间歇时佩带腰围固定。但腰围不宜久戴，一般3~6个月即可不用。此外，在本病恢复期的日常活动中，一般要端正姿势，避免在不正确的姿势下久坐、久立及腰部用力不当等，造成腰椎失衡及受累，可能引起本病复发。^[2]

3. 古庆诊治经验

古氏辨证分型治疗此病，基础方用独活、杜仲、牛膝、茯苓各15g，桑寄生24g，秦艽、全虫各10g，防风、桂枝、当归、川芎各9g，细辛6g，生地18g，白芍30g，蜈蚣3条。气血瘀滞型加姜黄、泽兰、枳壳各10g，玄胡15g，槟榔12g；风寒湿痹型加附片30g；肾虚型加肉苁蓉10g，菟丝子、狗脊各15g，附片30g；术后瘀阻型加泽兰、玄参各10g，丹参15g。^[3]

【按语】

本病诊断不难，西医早期可保守治疗，经严格保守治

疗无效,反复发作,症状严重及神经受压症状明显者,可行髓核摘除术,但由于手术后瘢痕组织粘连,血肿机化,压迫神经,导致医源性腰椎管狭窄,症状不能改善,使患者对手术具有恐惧感。而中医中药无论是对早期、晚期及术后血肿的吸收、水肿的消退都具有较明显的作用。石幼山认为辨证论治应分虚实,偏实证以活血祛风为治则,偏虚者以活血养血为主,根据疼痛症状的残留与消失,分别佐以祛风通络和补益肝肾,并且健腰益肾贯彻始终。治疗上除了用上述方法外,还配合针灸、手法牵引等综合治疗,以期提高疗效。丁锬诊治本病注重抓住诊断要点,准确诊断,辨证施术,不拘一法一方;动静结合,防治并重。古氏则在基本方的基础上辨证加减,方便临床运用。

(张银柱)

参 考 文 献

- [1] 石关桐. 石幼山用中药治疗腰椎间盘突出症的经验. 中国中医骨伤科杂志, 1998, 6 (1): 59~60
- [2] 周恒. 丁锬老师诊治腰椎间盘突出症的经验. 安徽中医学院学报, 1993, 12 (1): 16~17
- [3] 古庆. 中医辨证治疗腰椎间盘突出症. 云南中医杂志, 1992, (5): 19

坐骨神经痛

【概述】

坐骨神经痛是指沿坐骨神经通路及其分布区域发生的疼痛，即臀部、大腿后侧、小腿后外侧和足外侧的疼痛。起病多为急性或亚急性。其可以是单独的一个病，即坐骨神经炎，而绝大多数情况下是继发于其他疾病的一个综合征。

坐骨神经痛的病因可分为原发性和继发性（症状性）两大类。原发性坐骨神经痛即坐骨神经炎，临床上少见，主要是坐骨神经的间质炎，多由牙齿、副鼻窦、扁桃体等病灶感染，经血液而侵及神经外衣引起，多和肌炎和肌纤维组织炎伴同发生，寒冷、潮湿常为诱发因素。继发性坐骨神经痛临床上较常见，主要在坐骨神经通路中遭受邻近组织病变刺激、压迫，或因全身性疾病（如糖尿病、痛风等）所引起。常见的病因有：①脊柱疾患：如腰椎间盘突出（脱）出、骶部先天畸形，此外还有腰椎结核、脊柱炎等；②椎管内疾患：如脊髓和马尾的炎症、肿瘤、外伤、血管畸形、蛛网膜粘连等；③骨盆疾患：如坐骨神经盆腔出口狭窄、梨状肌病变、髋关节炎、髋关节结核、髋关节半脱位、髋关节炎等；④盆腔疾患：如慢性盆腔炎、附件炎、肿瘤、淋巴结转移癌等；⑤臀部药物注射的位置不当，外伤性血肿所致的坐骨神经包绕症；⑥中毒代谢障

碍，如糖尿病等。

发病机理：周围神经的机械性压迫不会引起疼痛，而只会产生感觉异常。实验证明，一旦有神经根炎性肿胀引起受压后才会产生痛觉。所以，疼痛与神经根周围的炎性反应有关。Crook 发现坐骨神经痛是因神经根受压后，引起静脉丛瘀血、缺氧及水肿等一系列改变，所以其痛觉实质上是神经的缺血性疼痛。

坐骨神经痛属于中医学“痹证”、“腰腿痛”的范畴。

【名医诊治经验】

1. 李述文诊疗经验

李氏多年来用自拟驱痹汤（细辛 12～15g，制川乌 12g，制草乌 12g，麻黄 12g，牛膝 20g，木瓜 20g，乳香 10g，没药 10g）治疗坐骨神经痛已逾百例，均获良效。服用本方第二剂时，患肢常有微汗，痛势顿挫，亦有个别病例痛势反剧，继服之痛即可减，当嘱患者勿虑。应当注意的是，本方必须水煎服，而且煎煮的时间不能少于 1 小时，同时，服药期间不能饮酒，以免发生不良反应。经验证明，治疗本病细辛用量不能少于 12g，否则疗效不佳。作者常用量多为 12～15g。

作者经验，细辛散剂用量宜小，汤剂用量可大，头痛、咳喘用量不宜过大，腰肢痹痛用量不能过小。究竟用量以多大为宜，还要根据病情和体质而定。作者习惯用量，通常是头面部痛为 5～10g，腰腿痛为 12～15g，咳喘为 5～8g。应用以上剂量，经多年观察，未发现一例不良反应或毒副作用，特别是对用量较大、用药时间较长的病

人，亦未发现肝肾功能损害。另考《伤寒杂病论》中应用细辛的全部方剂，细辛的相对用量均较大，通常为2两或3两，如麻黄附子细辛汤中，细辛与麻黄同为2两，而小青龙汤和苓甘五味姜辛汤等则为3两。据吴承洛《中国度量衡史》考证，后汉1两相当于现代13.92g，后汉药称1两是当时普遍用称的二分之一（据《新修本草》苏恭说），所以书中的1两约合现代的6.96g，那么，仲景方中细辛用量，少则为13.92g，多则为22.88g。可见，畏细辛如蛇蝎是没有根据的。现代药理研究认为，细辛过量可抑制呼吸中枢，甚至引起呼吸麻痹而死亡，说明细辛有一定毒性。但这种毒性和剂型有直接关系，一般水煎剂的毒性要明显小于浸出剂和散剂。因此，本品入药以水煎剂为宜，煎药时间不应小于1小时，以减少毒性。但应指出，并非凡方中有细辛者都要久煎，而应根据其用量和治疗目的来决定煎煮时间的长短。凡用量大，并以温经散寒或化饮止痛为目的者，煎煮时间应稍长；而以解表通窍为目的，且用量小者，煎煮时间则不必过长。^[1]

2. 曾令衍诊治经验

风寒湿邪流注经脉，凝滞经脉，使气血失荣，筋脉挛急，或闪仆损伤，气血瘀滞，使经脉痹阻，气血不通是本病的主要病机。而痛如针刺，痛有定处又是瘀血的特有症状，现代医学也认为血行障碍是神经系统疾病的病因之一。因此，治疗的关键在于使滞者行，瘀者散，痹者通。正如《医林改错》指出：“总滋阴，外受之邪，归于何处？总逐风寒，去湿热，已凝之血，更不能活，如水遇风寒，凝结成冰，冰成风寒已散。明此义，治痹何难？”倡议活血化瘀

法为治疗痹证的重要方法之一。^[2]

3. 应励诊治经验

《素问·痹论》：“筋痹不已，复感于邪，内舍于肝。”《济生方·痹》篇曰：“皆因体虚，腠理空疏，受风寒湿气而成痹也。”均说明痹证是由体虚而感受外邪所致，因肝虚不能疏泄，相火即不能助气血流行于周身，复感外邪，致气血凝滞，经络阻塞，下肢发热疼痛，不可伸屈。应氏运用清末名医张锡纯所创之曲直汤治疗。曲直汤中萸肉补肝，知母泻热，当归、丹参、生乳香、生没药疏通经络，流通气血，使热愈痛止。若下肢伴发凉加制附片、肉桂，去知母；痉挛抽痛者，加全蝎、蜈蚣或杭芍、甘草；阴雨、寒冷症状加剧者，加独活、威灵仙；气虚者加黄芪，腰痛者加炒杜仲、桑寄生。^[3]

4. 赵琼诊治经验

坐骨神经痛，中医学属痹证范畴中的筋痹。《素问·痹论》说：“风寒湿三气杂至合而为痹也”。赵氏认为治疗方法虽多，但痹痛日久，用刚药往往收效甚微。究其原因，痹痛虽为筋骨间病，但与肝肾关系极为密切。肝主筋，肾主骨，痹痛久而伤及真阴，阴伤亦可导致血脉涩而不利，筋脉日益涸结。故赵氏认为此类痹痛症宜采用温肾阳，滋肝阴，“刚柔并举”调和营卫，则能起到事半功倍之效。采用基本方：补骨脂、川断肉、老鹳草、芍药、透骨草、鸡血藤、金雀根、虎杖根、开金锁等具有补气、活血、助阳、散瘀、消肿、止痛之效的药物，再根据患者伴随症状来加减。畏寒者加嫩桂枝；气虚加黄芪；肾阳虚加鬼箭羽；而对于腰椎间盘突出者可加川

芎、蕲蛇等。^[4]

5. 袁波诊治经验

袁氏认为痹证如《素问·痹论》篇曰：“所谓痹者，各以其时重感于风寒湿之气也。”故治疗上多从祛风、散寒、除湿着手。然而，正虚，尤其是阳气不足、卫外不固才是发生痹证的内在因素。《济生方·痹》则有明确论述：“此病皆由体虚，腠理空疏，受风寒湿气而成痹也。”正是由于阳气不足，不能达邪于外，风寒湿邪才能得以深入经络，留着关节，造成疾病之缠绵反复，难以治愈。袁氏临证以扶正为主，拟大剂生黄芪为君药，随症增减，验之临床，确有其效。

黄芪性温微甘，补气，《本草求真》称其为“补气诸药之最”，《本经》中载有“主大风”，而《医学衷中参西录》中则作了进一步阐述，认为“黄芪有透表之力”。何也？盖其能入表实卫气，而起温分肉、实腠理、司开合之功，外邪自解也。历代以黄芪为主药治疗痹证之方剂颇多，如黄芪桂枝五物汤、蠲痹汤等。袁氏取《辨证录》之蒸膝汤为基础方，变通使用，其中以重剂生黄芪为君（原方用八两），伍以利湿通阳益髓之薏苡仁、肉桂、石斛。其意如书中云：“此方补气未免太峻，然气不旺不能周遍全身，虽用利湿健膝之药，终不能透入邪所犯之处，而祛出之也。第大补其气，而不加肉桂之辛热，则寒湿裹于膝中，亦不能斩关直入于骨髓而大发其汗也……”。

经屡次验证，体会到黄芪确系治痹良药，用大剂量黄芪之功，不仅是补气，更重要的是借其“透表”之力，以温分肉，司开合，达外邪。此时剂量宜大，一般都在 60g 以上，量轻力薄则仅起调中补气之效。使用该

法最好的是生黄芪。对此张锡纯有中肯之见解：“生用则透表之力益大”，炙过以后，要影响其透表之力。在服药后多见汗出，或遍身大汗如洗，或是周身津津微汗。这也进一步证实：黄芪“无汗能发”，“性善透表”之功。汗出后，风寒湿亦随之而解。复因其能入表实卫，虽汗出而津气不损，不至于脉络空虚，故不易复感三邪而形成反复发作，缠绵难愈之证。具体运用时，要注意细审风寒湿邪之偏重，并根据患者之体质差异，灵活加减。总的来讲，仅适宜于虚证、阴寒为重者。湿热为甚，或阴虚阳亢之体者忌之。^[5]

6. 刘傲霜诊治经验

坐骨神经痛属于中医痹证范畴，中医谓“风寒湿杂至合而为痹”，故治之当以祛风除湿，温经通络为先。刘氏自拟越痹汤：川牛膝 60~100g，细辛 15g，川断 15g，寄生 30g，伸筋草 15g，木瓜 15g，海风藤 15g，秦艽 15g，丹参 30g，赤芍 15g，桃仁 15g，红花 10g，全虫 6g，制乳没各 10g。每日 1 剂，水煎分 2 次温服，痛甚且患肢温度低者加制川乌 10g 先煎半小时。刘氏组方时重用川牛膝 60~100g，一则取其重降，引药下行，再则用其温肾活血除湿之功；又突破“细辛不过钱”之说，重用达 15g。乃因细辛之险险在挥发油，入药久煎后挥发油多挥发而其温经通络之力不减，用之良久未见不良反应。然痹之为痛因于经络瘀阻，故需佐以活血化瘀之品。现代药理研究表明，活血化瘀中药能改善血液流变学状况，降低毛细血管的通透性，减少炎性渗出，而且通过改善局部组织供血供氧达到镇痛作用，正是古代所谓“治风先治血，血行风自灭”。^[6]

7. 李志强诊治经验

李氏运用较大剂量马钱子自制散药来治疗坐骨神经痛，临床取得一定疗效。制马钱子 4500g，广地龙、乳香、没药、肉桂、全蝎、细辛各 3000g，研细成粉，过 60 目筛，搅拌均匀，胶囊分装，每粒 0.4g，每次 3 粒，早、中、晚各一次，若无反应，逐日加量至 6 粒/次。服药期间，出现一过性肌肉僵凝感及肌肉轻度颤动者，稍减量，可服些蜂蜜以解毒。

马钱子是一味极毒中药，用之得当，能起沉痾，用之失法，乃至中毒。据现代毒理研究马钱子主要含有番木鳖碱（土的宁）。李氏认为，应用该药，关键在炮制，老了无效，嫩了易中毒。用砂炒法，以深黄色鼓起为度。传统法该药宜去毛，但去毛较难。带毛马钱子做成丸散，经临床运用也未见中毒现象。应用时剂量要准确，一般从小剂量开始，常用量为 0.3~0.6g，最大剂量 1g，但各人的耐受性不同，个别病例超过 1g 也未中毒，若出现肌肉僵凝感，不能再增药。古人曰：“若药不瞑眩，厥疾弗瘳。”李氏体会会有轻度反应者效果好。应用本方治疗该病虽起效较慢，但疗效明确而稳定，很少复发。服药期间忌吸烟及生冷刺激食物，宜心情舒畅，同时加强锻炼，相得益彰。^[7]

8. 陆胜平诊治经验

坐骨神经痛属于中医“痹症”范畴，陆氏认为坐骨神经痛的部位与足少阳经的循行路线相吻合。《灵枢·经脉》载“足少阳之脉，起于目锐眦……其直者，从缺盆下腋，循胸，过季肋，下合髀厌中，以下循髀阳，出膝外廉，下外辅骨之前，直下抵绝骨之端，下出外踝之前，循足跗上，

入小指次指之间，……是主骨所生病者……胸、胁、肋、髀、膝外至胫、绝骨、外踝前及诸节皆痛，小指次指不用。”少阳经既不在表，又不在里，居于半表半里之间。在治疗方面用一般治疗痹痛之法效果往往不佳，故应辨明经络，宗少阳经之治疗原则用小柴胡汤和解少阳，加以温经通阳之品（如桂枝等），养血活血之品（如当归、川芎等），佐以祛瘀攻实之品（如桃仁、大黄等），使少阳经气通利，经络畅通无阻而疼痛自止。^[8]

9. 彭登慧诊治经验

彭氏认为坐骨神经痛虽属中医痹证，但又与痹证不完全相同。其主要病机为气血虚弱、肝肾亏损、风寒湿热之邪外侵，影响气机，阻滞经脉。其痛是气血虚弱，肝肾亏损，经脉失养，“不荣则痛”；风寒湿热等外邪乘虚而入，阻滞经脉，“不通则痛”。其一：疼痛范围固定在坐骨神经分布区内，常以一侧痛为多见，亦可累及双侧。在病变范围内有游走性，但不累及全身其他部位，其病变部位较痹证病变范围小，较固定。其二：疼痛有烧灼感患者，局部可不红肿发热，甚至切诊患肢反凉，是阴虚于内，阳浮于外的虚热。其三：病多发于40岁以上的病人，有夜间痛甚的特点，部分有慢性病史。年过40，其阴阳渐衰，肾府失于温养濡润而腰部疼痛，昼日阳气胜，夜间阳气衰，肾之阴阳衰弱均能引起夜间疼痛加重。其四：坐骨神经痛以拘急疼痛、屈伸不利、用力伸时痛甚为特点。《素问·长刺节论》云：“病在筋，筋挛节痛，不可以行，名曰筋痹。”说明坐骨神经痛同筋脉直接联系。一般的痹痛是多处肌肉关节疼痛、麻木、重着、关节肿大，两者有别。临床无论是气血虚弱，或是肝肾亏损，都导致筋脉肌肉关节不得温养

而呈拘急疼痛。寒性收引，易伤阳气且呈凝滞之性，常使筋脉收缩而疼痛，气血运行不畅而疼痛。其五：腰椎骨质增生、椎间盘突出等腰椎部病变，局部外伤，是坐骨神经痛的主要原因之一，而腰椎骨质增生和椎间盘突出多呈骨质退行性改变，是机体功能低下、衰老的表现。肾主骨，腰为肾之府，腰部病变同肾功能虚弱密切相关。其六：坐骨神经痛的部位同足太阳膀胱经的循行路线相近，肾与膀胱相表里，经气相通，坐骨神经受肾和膀胱经气的灌注。肾精不足，肾的气化功能不足，筋脉肌肉失于温养濡润则疼痛，日久肌肉张力减退，甚至萎缩。同时，有外邪循经而入，使气机不能畅达也同样发生疼痛。

《医学心悟·痹》说：“治行痹者，散风为主，而以除寒祛湿治之，大抵参以补血之剂，所谓治风先治血，血行风自灭也。治痛痹者，散寒为主，而以疏风燥湿佐之，大抵参以补火之剂，所谓热则流通，寒则凝塞，通则不痛，痛则不通也。治着痹者，燥湿为主，而以祛风散寒佐之，大抵参以补脾之剂，盖土旺则能胜湿，而气足自无顽麻也。”程氏指出治痹大法，应分清轻重主次，而后决定君臣佐使，祛邪的同时不忘“补血”、“补火”、“补脾”等扶正措施。彭氏在此宗旨下，扶正祛邪同施，临床上把坐骨神经痛分为：肾阳虚弱型、肝肾阴虚型、风寒湿滞型、瘀血停滞型、湿热壅盛型，分别采用温阳益气、活血止痛；滋阴补肾、解挛止痛；温阳益气补血、祛风散寒除湿；活血化瘀、温阳补气等方法治疗。

肾阳虚弱型：主要表现为患肢疼痛，夜间痛甚，下肢不温，遇寒加重，得热痛减，日久肌肉萎缩，腰部冷痛，僵直，压痛，起病缓慢，面色萎黄或黧黑，尿颜色清便溏，舌淡苔薄白，脉沉迟。彭氏采取温阳益气，活血止痛法，

拟方活血止痛汤：附子、黄芪、当归、白芍、熟地、巴戟天、淫羊藿、杜仲、鸡血藤、木瓜、秦艽、细辛等。

肝肾阴虚型：主要表现为拘急疼痛、屈伸不利，步行艰难无力，抖颤麻木，局部可有热感而切诊无热证，肌张力减弱，腰膝酸软，腰痛，身体瘦弱，肌肤干涩，头昏眼花，咽干盗汗，五心烦热，舌红少苔，脉细弱。彭氏自拟滋阴补肾，解挛止痛法，方用育阴解挛汤：龟甲胶、熟地、当归、白芍、枸杞子、鹿角胶、丹参、木瓜、稀莖草、秦艽、地骨皮、甘草等。

风寒湿滞型：主要表现为疼痛剧烈，有电掣感，游走性，时甚时缓，或肌肉胀痛，重着麻木，可因风寒湿邪外侵而诱发。阴虚阳虚症状不明显，舌淡苔白，脉弦等。此因气血虚弱，风寒湿邪乘虚而入侵筋脉，影响气机，使气血运行不畅，不通则痛，不荣则痛。治当温阳益气补血，祛风散寒除湿，方以独活寄生汤加减。

瘀血停留型：有腰椎骨质增生，椎间盘突出等腰椎病变，有腰或患肢损伤史，常有慢性腰痛，腰痛固定不移，僵直，起卧时疼甚，患肢有电掣感、麻木感，舌紫或瘀斑，脉沉细涩。腰椎间盘突出等腰椎病及外伤，使肌肉筋脉经络气血瘀滞，直接伤及坐骨神经。气滞血瘀，气血运行不畅，肌肉失于濡养。而此型多因身体衰弱，肝肾功能低下，故可佐以调理肝肾之法。治以活血化瘀，温阳补气，方以身痛逐瘀汤加减。

湿热壅盛型：多因患侧外伤感染、化脓、炎性包块压迫所致，发病急，疼痛剧烈，患肢发热肿胀，得热痛甚，遇凉痛减，舌红苔黄腻，脉滑数。彭氏认为此为湿热毒邪外侵，或寒湿郁而化热，阻滞于内，气血逆乱。治以清热解毒，清热利湿。处方：四妙散加五味消毒饮加减。另

用三虫散：全蝎 10g，蜈蚣 10g，僵蚕 20g，制马钱子 3g，共研末而成。每次 3g，每日 2 次，但不宜长久使用，以免耗损气血。孕妇忌用。^[9]

10. 王贵森诊治经验

对于坐骨神经痛的治疗，王氏总结出十法：

①温经通络法；②除湿通络法；③清热通络法；④化瘀通络法；⑤益气通络法；⑥养血通络法；⑦祛寒通络法；⑧峻利通络法；⑨虫类通络法；⑩熏蒸通络法。^[10]

【按语】

坐骨神经痛属中医学“痹证”、“腰腿痛”范畴。其多因外邪侵袭或正气虚弱，外邪乘虚而入，邪气阻于经脉，气血不通，不通则痛。治疗当疏通经络，调和气血为原则。以上 10 位医家辨证论治之经验丰富，各有独到灼见：李述文应用大剂量细辛治疗本病可谓别具一格。古有“细辛不过钱”之说，故历代医家畏细辛为蛇蝎。而李氏认为细辛中有毒成分主要为挥发油，只要久煎，使其挥发油挥发，则可大大降低其毒性，且用药量大小要根据治疗部位的不同有所差异。曾令衍认为本病病因为风寒湿邪外侵，病机为经脉闭阻、气血不通，同时他认为瘀血为本病的主要致病因素之一，故活血化瘀当贯穿治疗过程始终。应励认为本病病机为体虚而感受外邪，而正虚当中他强调了肝虚。肝主疏泄，肝虚不能疏泄，相火不能助气血流行于全身，邪气乘虚而入，发而为痹。肝主筋，肝虚则筋脉失于濡养，故又可表现出肢体屈伸不利等征象。赵琼强调治疗本病当温肝肾、滋肝阴之“刚柔并举”之法。肝主筋，肾主骨，

今肢体疼痛，活动不利，当考虑及肝肾。且本病病程多较长，初可表现出各种实邪侵袭的征象，久则耗伤真阴。可见从肝肾论治确为可行之举。袁波认为本病病机为正虚，重感于风寒湿之气。而正虚主要是阳气不足，卫外不固。针对此特点，在治疗时运用大剂量黄芪，大剂量黄芪（60g以上）可温分肉，司开合，达外邪。而其中又以生者为佳，因其“透表之力益大”。刘傲霜强调了活血化瘀药的功效。他认为痹之为痛因为经络瘀阻，故当以活血化瘀之品，现代研究活血化瘀药可改善血液流变学状况，降低毛细血管通透性，减少炎性渗出。正如古语云“治风先治血，血行风自灭”。可见在治疗过程中，无论何种类型，少佐活血化瘀药可事半功倍。李志强运用大剂量的马钱子散剂治疗坐骨神经痛。马钱子有毒，但其确有起沉痾、止痛等功效。李氏认为关键在炮制，采用砂炒法，减其毒性。从小剂量开始，一有反应则不可再增药。而其中以有轻度反应者为最好，同时临床还应慎用。陆胜平认为坐骨神经痛病位在少阳经，治当以小柴胡汤和解少阳，佐以其它药物，此为六经辨证方法在治疗该病中的运用，可谓别具一格。彭登慧较全面地论述了坐骨神经痛的病因、病机及辨证论治、治疗大法，其中根据患者不同的表现概括出的病机相当精炼。王贵森概括出坐骨神经痛通络十法，对于医者执简驭繁地掌握该病的治疗方法很有裨益。

（陶晓华 刘夕明）

参 考 文 献

- [1] 李述文. 细辛治疗坐骨神经痛. 中医杂志, 1993, 34 (7): 391
- [2] 曾令衍. 身痛逐瘀汤加减治疗坐骨神经痛. 四川中医, 1985, 3 (11): 50

- [3] 应励. 曲直汤治疗坐骨神经痛. 四川中医, 1986, 4 (9): 44
- [4] 赵琼. 温肾柔肝法治疗坐骨神经痛 32 例. 浙江中医学院学报, 1991, (3): 26
- [5] 袁波. 重用黄芪治痹证. 新中医, 1997, 29 (4): 49~50
- [6] 刘傲霜. 越痹汤治疗坐骨神经痛临床观察. 河南中医, 1997, 17 (1): 41
- [7] 李志强. 坐骨神经痛治验. 实用中医内科杂志, 1996, 10 (1): 34
- [8] 陆胜平. 加味小柴胡汤治疗坐骨神经痛 25 例. 上海中医药杂志, 1995, (3): 28
- [9] 彭登慧. 坐骨神经痛的中医证治. 云南中医学院学报, 1997, 20 (1): 35~38
- [10] 王贵森. 坐骨神经痛通络十法. 安徽中医学院学报, 1986, 5 (3): 54

白 塞 病

【概述】

白塞病又称白塞综合征，系一原因不明的全身性自体免疫性疾病。本病累及部位广泛，主要表现为复发性口腔溃疡、外阴部溃疡和眼色素膜炎的三联症，也可见到皮肤、粘膜、关节、消化道、心血管、中枢神经系统等多器官损害的症状表现。

本病病因尚不清楚，国外有些学者认为与病毒感染有关；也有学者提出本病的病原可能与链球菌感染有关；国内有些学者发现，本病的发生与结核病有密切关系。这三种论点皆在深入研究中，尚待作出肯定结论。但不排除本病是一异质性疾病，由多种病因引起。

本病所累及组织、器官的基本病变是血管炎改变，大多为渗出性，少数为增生性，有时二者同时存在。受累血管可为动脉，也可静脉，病变部位可发生充血、水肿、栓塞、狭窄、纤维素渗出和脓疡形成等改变。

白塞病的症状表现和中医学狐惑病相类似，故对本病的治疗，可参考狐惑病的内容论治。

【名医诊治经验】

1. 张志真诊治经验

张氏按病变过程由轻及重分为以下三个层次：第一当

属肝郁蕴热，脾虚湿阻，湿郁化热，湿热蕴毒，热毒伤络的进行性的病理过程；第二是在此发病过程中，湿热毒邪内侵脏腑，并影响脏腑之间的协调关系，以肝脾为主，进而影响与之有母子关系的心、肾二脏，致使气血阴阳失调和邪正盛衰的变化。因湿滞伤气，热毒烁阴，故气阴两虚的比例较大。第三是在病情发展过程中，亦有因湿阻、热郁或阴虚而造成血瘀证病理变化。湿热毒邪烁伤津液，耗伤气阴，血行不畅而为瘀滞；或久病入络，邪阻血瘀，如此必然累及脏腑气机的生化机能，使脏腑难于正常协调促进气化，其中尤以肝、脾、心、肾及三焦等脏腑功能失调为主。

在辨证立法方面，谨守主要病机，予以标本主次治疗：即清除湿热毒邪在于清肝热、除脾湿，以杜绝肝热脾湿，湿热毒邪之源；益气养阴扶正在于健脾气、养肝阴，以促利中焦转枢，使肝脾之气协调；调整脏腑失调在于清除心火以平逆肝热之气，通利三焦以祛除湿热之患，益气养阴以促使气阴转复，从而达到虚热清，湿浊化，肝脾之气调畅，五脏六腑安和之目的。所以治法当先以苦辛开泄，引邪外出；清热同时泄利湿浊以疏导气机；再以助元阳，引火归源，除虚热，健脾益肾，促进气化而达到和阴血的目的。在此基础上，养血活血化瘀亦是立法的关键。

在辨证用药方面，在清热化湿解毒的同时，尤其在后两阶段的辨证治疗时，可适时选用大剂量的黄芪及白术、甘草益气扶正，健运脾气，肉桂、桂枝、细辛、沉香等温通血脉，引火归源，并用鸡血藤、生地、赤芍养阴和血，活血通脉，使得气血调和，祛除化湿生瘀之源，从而使清热解毒祛湿化瘀之品能更好地发挥作用，也是使病情稳定并转入恢复巩固期的重要一环。^[1]

2. 沈继泽诊治经验

沈氏从狐惑病与白塞综合征的主证进行分析对比,认为狐惑病不是白塞综合征。但因它们有时临床个别的主症相似,因此只能说有时白塞综合征的某型或病程中的某一阶段相似而已。并从仲景内服甘草泻心汤、赤小豆当归散,外用苦参汤洗之、雄黄熏之来治疗推之狐惑病的病机当为中虚有寒,湿热内蕴。沈氏综合分析了国内外文献对狐惑病的病机:或是热毒蕴结,或是气血凝滞,或是肝肾阴亏,或是脾胃两虚,有的提出有急、慢性之分等等。认为上述病机的提出多是在治愈白塞综合征的基础上分析归纳总结出来的,显然这是误将白塞综合征与狐惑病等同的结果。在其治疗的39例白塞综合征者中,8例是以内服甘草泻心汤为主,另外以苦参加蛇床子煎水取汁外洗阴部而愈。其余分别是用龙胆泻肝汤、黄连解毒汤、三妙丸、下瘀血汤、导赤散、沙参麦冬汤、六味地黄汤、知柏地黄汤、金匱肾气丸等方化裁为主治愈。^[2]

3. 姜坤等诊治经验

本病的病因病机为饮食不节,或病程日久,致肝脾失调,肝肾阴虚,湿热内生而致病;或脾肾阳虚,阳虚生内寒,致寒凝血瘀所致。病变的脏器在肝肾,故治疗着重在肝肾二经。将本病分为三型:

(1) 热毒湿浊型:表现为口腔、外阴溃疡疼痛,两眼眶作痛,口干苦,烦热头昏,心慌心悸,关节酸痛,小便色黄或赤痛,苔黄腻,或厚黄腻而糙,脉细数。治以清热解毒,利湿化浊,药用二黄散加减:生地10g,黄芩、大黄各6g,黄柏、赤芍、丹皮、白术、茯苓、泽泻各10g,

生苡仁、金银花各 15g，黄连、龙胆草各 6g。

(2) 肝肾阴虚型：表现为口、咽、前阴、肛门溃烂，疮面暗红，久不愈合，头昏目眩，腰膝酸软，午后潮热，时有烘热汗出，手足心热，心烦不眠，舌红少苔，脉细数。治以滋肾养肝，育阴清热，药用一贯煎加二至丸化裁：沙参、麦冬、生地、当归、川楝子、旱莲草各 10g，枸杞子、女贞子、白芍各 12g，知母、黄柏各 6g，仙灵脾 10g。

(3) 肾虚血瘀型：表现为口腔、外阴溃疡疼痛，两目眶胀痛，面色苍白，形寒肢冷，头昏腰酸，关节酸楚，舌质暗，或有瘀斑，脉沉细涩。治以温肾散寒，活血化瘀，药用甘草泻心汤加减：生甘草 15g，生地、半夏各 10g，党参 15g，黄芩 9g，干姜 3g，黄连 6g，大枣 7 枚，三棱、莪术、当归、赤芍各 10g。^[3]

4. 陆德铭诊治经验

陆氏认为疾病反复发作，病久不愈，易耗伤正气，阴液亏损，肾阴不足，水不制火，则虚火愈炽。故在治疗中以益气养阴为主，常用药物为生黄芪、党参、白术、茯苓、南沙参、枸杞子、女贞子、天花粉、生地、玄参、麦冬等。加知母、白花蛇舌草、蛇莓、金雀根、徐长卿等清热药物。^[4]

5. 蔡铁勇等诊治经验

对本病的论治以甘草附子汤、桂枝加附子汤、桂枝二越婢一加大汤、四逆汤等温补之剂为优。如合用大剂量生黄芪（30g 以上），疗效更满意。

治疗本病应以温补法为主，适当配合活血解毒方剂。因为从现代医学的观点看，本病属自身免疫病，用激素、

免疫抑制剂，疗效可疑。现偏向于应用免疫增强剂治疗。免疫增强剂可调节抑制性 T 细胞的功能，从而阻抑自身抗体的生成，达到治疗的目的；免疫抑制剂可同时抑制 T 细胞的功能，从长期观点来看，可能会造成更大的损害。中药活血解毒之剂一般具有免疫抑制剂的作用，而温补方剂则大都具有免疫增强作用。根据上述机理，治疗本病应以温补法为主。

在应用温补方剂的同时可合用左旋咪唑，疗效有增强趋势，可能因为两者之免疫增强作用得到了协同。

根据临床经验和日本有关报道，认为柴胡剂对白塞病确有不良影响，应尽量避免使用。^[5]

6. 路志正诊治经验

狐惑病以湿热为主，化燥伤阴不明显者，溃烂部位渗出物多，甚则有膜状物附于溃疡之上，常兼见口苦而粘，不欲饮水，便溏溺赤，舌苔腻，脉濡数，治疗宜清热解毒燥湿为主，内外治法兼施。内服药以调理脏腑功能，祛除病邪，用甘草泻心汤化裁，常加用苦参、黄柏、败酱草、土茯苓、地肤子、炒槐花、密蒙花、草决明等药。甘草泻心汤以甘草为君药，取其性味甘凉，清热泻火解毒；配黄芩、黄连之苦寒，以清热泻火燥湿；干姜、半夏之辛温，以开通散结而除闭郁之湿热；大枣、人参性温味甘，虑其助热留湿，多弃而不用，苦辛合用，寒热并投，共奏苦辛通降，清热解毒燥湿之功。加苦参、黄柏、败酱草、土茯苓之属以增强其清热泻火、祛湿解毒之力，前阴溃疡加地肤子，肛门溃疡加用炒槐角，眼部损害明显者加密蒙花、草决明等药。苦参味极苦而性寒，具有清热燥湿杀虫的作用，其清热解毒的功效与芩、连、龙胆草相近，而其苦愈

甚，其燥益烈，其力可直达诸窍。一般医家畏其味苦难服，亦嫌其峻烈，多外用而很少入煎剂。但毒疮恶癰，非此莫除，如认证准确，其效甚捷，诚为治疗狐惑病之要药，不单外用，内服亦佳。先以苦参汤加黄连、白矾、马鞭草、桃仁、甘草之属水煎熏洗阴部，再用冰蛤散撒于患处，以清热燥湿，止痛敛疮。口腔溃疡可外用冰硼散，或锡类散。

若病变经久不愈，湿热化燥，损伤肝肾之阴，治疗宜有所变化，应以养肝血、益肾阴为主，稍佐清利，可酌选一贯煎、杞菊地黄丸加味；若病至后期，阴损及阳，脾肾阳衰者，亦应首先顾及阳气，法随机转，可选用理中汤、肾气丸等方，切勿专事清利，而贻害于人。

狐惑病多迁延日久，病程逾年，反复发作，病人备受其苦，而根治确属不易，宜早认证，早治疗，以减少病人的痛苦。治疗本病不但要有方，且贵在有守。临证常见用药多时而见效轻微，但坚持用药则病有转机，终获痊愈。故守方是治愈本病必不可少的条件之一。医者亦须向病人讲明病情，增强其信心，勿轻试则止，反复更医。本病后期，治疗应注意勿致苦寒过用，化燥伤阴。症状消失后，不宜立即停药，仍应嘱其服药一个阶段，以资巩固，防止复发。^[6]

7. 威海龙诊治经验

由于本病的主要发病部位均在肝经循行和络属之上，故可以认为本病属于肝脏系统疾患。另外，经络又是疾病传变的途径，当经络所主的部位发生病变时，其所主脏器也必然会受到影响。肝主疏泄，调节情志，由于肝脏与本病的发病部位有经络循行和络属关系，故本病临床上常伴有神志不安，恍惚迷乱，或精神抑郁，多疑善虑等症状。

(1) 肝脾同治

①肝郁脾虚证治：肝主疏泄，脾主运化，主肌肉。肝郁不疏，脾失健运则清阳不布，营养不足，故肌肤不得以充，肝经亦失其养。故症见情绪变化不定，倦怠无力，饮食减少，两胁及脘腹胀满，口咽、眼、外阴溃疡久不敛口，创面较浅，颜色淡白，舌淡红，苔薄白，脉沉弦缓。治宜疏肝解郁，健脾生肌。方选逍遥散加生黄芪、细辛等。

②肝脾湿热证治：肝郁不疏，脾虚湿停，积久而为湿热蕴毒，弥漫于中焦则气机不畅，流注于肝经则发为痈疡。此类患者症见口咽、眼、外阴发为灼热性溃疡，且溃疡面较大，四周色赤，眼部血管充血并有炎性改变，发热，头晕沉重，默默欲眠或卧起不安，口苦纳呆，胁肋胀满，呕恶腹胀，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治宜疏肝清热，祛湿解毒。方用龙胆泻肝汤合三仁汤加减。

(2) 肝心同治：肝主藏血，心主血脉。热邪稽留，灼伤脉络，扰乱神明，上犯肝窍，循肝经而发，故临床可见烦躁、失眠、高热，面部及全身皮肤出现皮疹、红斑，双目球结膜充血，口咽、外阴溃烂腐臭，溃破处颜色鲜红或深红，四周红肿灼热疼痛，舌红，苔黄厚，脉洪数，或弦数。治宜清热解毒，凉血化斑。方选当归芦荟丸合化斑汤加减。

(3) 肝肾同治：肝藏血，肾藏精，肝肾同源，精血互生。肝热不解，积久则耗伤阴血，阴血一伤，肾精亦亏，阴虚则生内热，虚火上浮则扰乱神明。故临床可见：午后低热，手足心热，烦躁不安，头晕失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便短赤，双目红肿畏光，口咽、外阴溃疡，其患处暗红灼痛，舌质红，苔干黄，或光红无苔，脉弦细数，重按无力。治宜滋阴益肾，清热育阴。方用一贯煎加

地骨皮、黄柏、知母、玄参、野菊花、赤小豆等。^[7]

8. 雷新民诊治经验

治疗方药：红参 6g，黄芪 30g，甘草 10g 为主方，湿热重者可酌情加车前子、茯苓、黄芩、黄柏、虎杖内服，兼用药渣局部热敷。

雷氏认为本病患者多为气虚，因此对这类患者扶正补气是治疗的关键。补气即扶正，正复则祛邪，以红参、黄芪、甘草补中益气，健运脾胃，化生气血，气血充足则脾胃虚弱得以纠正，运化功能增强，从而收到益气固本之效。现代医学研究扶正类药能够增强机体免疫功能。有人认为正气包括免疫功能，实验证明人参具有激发造血机能和提高血中红细胞数及血红蛋白的功能，参、芪并能作用于网状内皮系统，提高网状内皮系统吞噬功能，黄芪还能提高淋巴母细胞转化率，促进炎性物质排除，均能增强机体免疫功能，甘草含甘草酸和甘草甜素等成分，有解毒作用，并有类固醇的抗炎抗过敏作用。本病急性期患者见湿热浸淫证候者，可酌加车前子、茯苓、黄芩、黄柏、虎杖以利湿、清热、解毒。^[8]

9. 薛盟诊治经验

本证的诊断特点，应注意它具有系列症状而非局部炎性疾患，上有口腔，或目内、外眦糜烂点，下有阴部溃瘍面，因此不能单纯从三焦湿毒、心脾积热诊治。要抓住口舌干燥，盗汗乏力，低热，饥不欲食，干嗽等一派阴虚内热和中气不足之象，诊治当遵“实火当泻，虚火当补”之旨，采用甘温益气、甘寒养阴的治则，选黄芪、怀山药、玄参、天麦冬、生白芍、马鞭草、人中白、炒知母、丹皮、

石斛、车前草等为主方，口糜舌疳合导赤散；口干潮热合黄连阿胶汤；腰酸头晕者合杞菊地黄汤；目赤干燥较甚加服石斛夜光丸。若兼热毒湿邪炽盛者，可加银花、土茯苓、白花蛇舌草、苦参、赤小豆等。外用药：口腔溃疡选用锡类散、琼黄散、冰硼散涂擦；阴部溃疡用蛇床子、黄柏、侧柏叶熏洗亦效。^[9]

10. 姚念宏诊治经验

姚氏用甘草泻心汤合重剂板蓝根治疗本病 31 例。具体方法：

(1) 急性发作期：①100%板蓝根注射液 4ml 肌肉注射，每日 2 次，5~10 天为 1 疗程；或口服板蓝根冲剂 10~20g，每日 2 次，5~10 天为 1 疗程。②甘草泻心汤（用生甘草）随症化裁：有皮肤、粘膜糜烂、溃疡者，加薏苡仁、苦参；有口苦、口干、欲冷饮之热象者，加栀子、柴胡；关节疼痛者，加牛膝、苍术；阴液不足者，加麦冬、生地；脏腑燥实者，加生大黄、芒硝；大便秘结者加炙大黄。③外用药：若有肌肤糜烂、溃疡者，可先用板蓝根 30~100g 煎液冲洗患处，再撒溃疡粉（黄芩、黄连、黄柏各 10g，硼砂、冰片各 3g，外阴糜烂加苦参 10g，共研为细粉）敷患处。

(2) 缓解期：视治疗前发作的规律，即缓解期的长短，每间隔 10~20 天或出现急性发作征兆时口服板蓝根冲剂 10~20g，每日 2 次，3~5 天为 1 疗程；或用生药板蓝根 30~60g 代茶饮。同时兼服补中益气丸或金匱肾气丸，每日 2 次，每次 2 丸，3~5 天为 1 疗程。

本病为肝胃火盛，心脾伏火，阴分不足，湿热毒邪所致，治宜清热解毒祛湿法，仲景用甘草泻心汤治之。方中

黄芩、黄连苦寒，清热解毒，半夏、干姜辛燥化湿，人参、甘草、大枣和胃扶正。姚氏通过临床实践，发现单用西药或仅用甘草泻心汤，虽能解除急性发作之症，达到临床治愈之目的，但不能防止复发。鉴于单味板蓝根具有抗菌、抗病毒作用，对复发性口疮、多种眼部疾患、外阴糜烂溃疡有较好的疗效，姚氏将其加重用量，用于治疗本病。临床证明在急性发作期有助于迅速缓解临床症状，缩短病程，延长缓解静止期，减少复发，在急性期后经常服用板蓝根并配服补中益气丸，或金匱肾气丸，有防止复发的作用。

现代医学认为，白塞综合征的病因与病毒、免疫机制紊乱有关。甘草泻心汤中的黄芩、黄连、泽泻、白术具有降低血液粘稠度的作用；人参、黄芪有增强白细胞及肝脏网状内皮的吞噬能力，增加机体的免疫力，黄芪还能促进机体产生干扰素；甘草抑制抗体的产生，板蓝根能清除已潜伏于机体的细菌、病毒的滋生、繁殖。所以甘草泻心汤合重剂板蓝根是治疗狐惑病比较理想的方剂。^[10]

【按语】

白塞综合征是一种至今原因不明的疾病，病程漫长，反复发作，多系统损害是炎症疾病，治疗棘手，即使采用多样化治疗也很难痊愈，有的终生反复发作。许多医家对此进行了不懈的努力，取得了较好的疗效。张志真按病变过程由轻至重分为三个层次，在病机上重点抓住正虚与邪实的比重，治疗中要切实掌握病机，在清热化湿解毒的同时，不忘扶正，可使病情较快缓解，减少了复发的可能。沈继泽理论造诣较深，对狐惑病与白塞病的关系进行了探讨：认为狐惑病不是白塞病，只是临床个别的主症相似，

白塞病的某型或病程中某一阶段所出现的症状与《金匱》狐惑病相似。治疗上反对墨守成方，主张根据病情变化进行辨证治疗。姜坤等认为病变的脏器在肝肾，故治疗重在肝肾二经。临床分热毒湿浊、肝肾阴虚、肾虚血瘀三型论治，条理清晰。陆德铭强调应以益气养阴为主，同时加用清热药物。蔡铁勇等认为采用温补之剂（如甘草附子汤、桂枝加附子汤）合大剂量生黄芪（30g 以上）具有免疫抑制和免疫增强剂的作用，这为使用中药治疗类似免疫性疾病提供了思路。路志正治疗本病注重内外兼治，后期则以养肝血、益肾阴为主，稍佐清利。同时强调治疗本病不但要有方，而且贵在有守，这对取得预期的疗效极为重要。威海龙认为本病的主要发病部位均在肝经循行和络属之上，故属于肝脏系统疾患，临床症状和治疗方面也突出了这一特点。雷新民则以红参、黄芪、甘草作为主方药突出扶正即祛邪这一治法，薛盟也强调甘温益气，两者目的一致。姚念宏采用甘草泻心汤合重剂板蓝根治疗本病获得较好疗效。单味板蓝根具有抗菌、抗病毒作用，对复发性口疮、多种眼部疾患、外阴糜烂溃疡有较好的疗效，姚氏将其加重用量，用于治疗本病，临床证明在急性发作期有助于迅速缓解临床症状，缩短病程，延长缓解静止期，减少复发；在急性期后经常服用板蓝根并配服补中益气丸或金匱肾气丸，有防止复发的作用。从而认为甘草泻心汤合重剂板蓝根是治疗狐惑病比较理想的方剂。

（张银柱）

参 考 文 献

- [1] 刘薇. 从“肝热脾湿”辨治白塞氏综合征 50 例探讨. 北京中医, 1995, (6): 28~30

- [2] 沈继泽. 谈谈有关《金匱》狐惑病的几个问题. 南京中医药大学学报, 1995, 11 (3): 4~6
- [3] 姜坤, 王卉, 王蓉, 等. 中医药治疗白塞氏综合征 11 例临床观察. 光明中医, 1999, 14 (4): 53~54
- [4] 万华. 陆德铭外科运用益气养阴法的经验. 中医文献杂志, 1998, (2): 24~25
- [5] 蔡铁勇, 葛冠英. 白塞氏病辨证论治刍议. 上海中医药杂志, 1981, (8): 14
- [6] 高荣林, 王鹏宇. 路志正老师谈狐惑病的辨治经验. 河南中医, 1982, (4): 16~18
- [7] 戚海龙. 试论白塞氏病从肝辨治. 新中医, 1992, (4): 10~11
- [8] 雷新民. 中药治疗白塞氏病 34 例. 陕西中医, 1992, 13 (2): 56
- [9] 薛盟. 怎样认识白塞氏综合征? 临床如何掌握辨证用药的要领? 中医杂志, 1989, (11): 55
- [10] 姚念宏. 甘草泻心汤合重剂板蓝根治疗狐惑病远期疗效的观察. 山东中医杂志, 1989, (6): 17

大动脉炎

【概述】

大动脉炎，病变的部位在主动脉及其分支，呈慢性、进行性、闭塞性全层动脉炎症。体内各部位的大动脉皆可产生病变，并易累及数处血管，造成血管腔狭窄或闭塞，形成血栓。亦有少数呈囊状动脉瘤。若肾动脉炎导致肾动脉狭窄或闭塞，甚者肾萎缩，则可导致肾功能衰竭。

本病或发于一侧，或发于两侧。由于主动脉的狭窄或闭塞，使血液运行障碍，致患侧缺血而肌肉、筋脉失养，出现肢体酸胀、麻木、疲倦无力等症。病情进展时伴有发热和肌肉、关节疼痛，或出现结节性红斑。

头臂动脉炎，可见头晕头痛，记忆力减退，视力下降，两眼发黑，上肢发冷，麻木疼痛，颈动脉或寸口脉搏动减弱，或消失。上肢血压低，或难测出，严重时双目失明、昏厥。腹腔或股动脉炎，则血压升高，心脏扩大，可发生心衰、肾衰、脑卒中等并发症。

大动脉炎的致病原因，至今尚不明确。当前认为本病是一种自身免疫性疾患。其发病与遗传基因、风湿病、链球菌感染、结核病传染等有关。

大动脉炎是西医病名，中医学历代医籍中未见有此病名的记载。然对其病状文献中有不少描述，甚至有“无脉证”的记载。本病属中医“脉痹”的范畴。

【名医诊治经验】

1. 孙祥诊治经验

多发性大动脉炎，也称缩窄性大动脉炎，或无脉症，系一种病因不明的主动脉及其分支的慢性、进行性、且多为闭塞性的血管炎症。类似中医学之“心痹”、“脉痹”。本病以头和臂部动脉受累引起的上肢无脉症为多见，其次是降主动脉、腹主动脉受累引起的下肢无脉症和肾动脉受累引起的肾动脉狭窄性高血压。总之，由于受累动脉的部位不同，临床上就会出现不同的症状表现。孙氏根据多年的诊治经验，将多发性大动脉炎分为早、中、晚三期进行论治。

(1) 早期：症见低热，关节游走性疼痛，头晕乏力，肢体麻木，舌质红，苔薄黄，脉沉伏。听诊颈与腹部，出现粗糙的血管杂音。上肢单侧或双侧血压降低。此乃感受风寒湿邪，郁久化热，脉道痹阻所致。治宜清热化湿，活血通络。方用自拟清脉饮（银花藤、蒲公英、苡仁、丹参各 30g，野菊花、玄参、苍术、路路通各 10g，生地、当归各 15g，甘草 5g）。

(2) 中期：症见肢体麻木刺痛，四末发凉，头晕且痛，胸闷烦热，心悸失眠，舌质暗红，有紫斑，脉无。身体大动脉处可闻及较响的血管杂音。上肢一侧或两侧血压测不出。此由瘀血内停，脉道不畅或不通所致。治宜活血化瘀，通脉剔络。方用自拟通脉饮（桃仁、红花、赤芍、当归、苏木、莪术、炮山甲各 10g，丹参、黄芪、地龙、生地各 30g，川芎、地鳖虫各 5g）。

(3) 晚期：症见面色苍白，精神萎顿，畏寒喜暖，胸

闷心悸，四末麻木冷痛，腰背酸痛，食少便溏，舌质胖淡，脉无。上肢血压测不出。此乃脾肾阳虚，寒凝脉络，痹阻不通所致。治以健脾补肾，温阳散寒，通脉和络。方用自拟温脉饮（熟地、鹿角胶、肉桂、干姜、骨碎补、当归、白芥子各 10g，黄芪、地龙、丹参各 30g，水蛭 2g，甘草 5g）。

加减：上肢无脉加桂枝；下肢无脉加牛膝；胸闷苔厚加全瓜蒌、草果；气虚甚者加红参；阳虚甚者加附子、炮姜；阴虚甚者加制首乌、枸杞子；心虚寐差者加酸枣仁、五味子；肾虚肝旺者加桑寄生、天麻；血瘀甚者加三七；纳呆加焦山楂。

又：活血化瘀药物是各期的必用之品，本病早期可适当配合应用激素及抗风湿西药，对缓解症状有益。但属中、晚期者则不宜应用，据临床观察，其副作用较大。^[1]

2. 陈敏等诊治经验

多发性大动脉炎是一种以侵犯大动脉为主的自身免疫性疾病，多发于年轻女性。本病起病缓慢，病程长，重者可危及生命，根据其发病规律和临床表现归属于中医的痹证范畴。

分为四个证候论治。

（1）湿毒阻络证：症见身热，倦怠乏力，肌肉关节酸痛，患侧肢体发凉、麻木，无脉，舌质红，苔黄腻。西医诊断为多发性大动脉炎活动期。方用新加四妙四物汤加减：银花 30g，连翘 30g，黄柏 20g，苍术 20g，牛膝 30g，薏苡仁 30g，桃仁 15g，红花 15g，川芎 30g，赤芍 25g，丹参 50g，鸡血藤 50g。

（2）心脾两虚瘀血阻络证：症见心悸气短，动则尤甚，

食少纳呆，头晕目眩，患侧肢体乏力，发凉，麻木，面色少华，脉细弱或无脉，舌淡苔白。此类证候多见于较晚期合并心肾改变者。治以补气养心，活血通络。方用黄芪桂枝五物汤加减：黄芪 50g，桂枝 50g，赤芍 30g，川芎 15g，百合 30g，丹参 50g，鸡血藤 50g，党参 30g，大枣 10 枚。

(3) 脾肾阳虚寒凝血瘀证：症见形寒肢冷，腰膝酸软，头晕，食少纳呆，倦怠乏力，肢体麻木，患侧脉弱，或无脉，舌淡苔白。方用桂附八味合阳和汤加减：山萸肉 15g，熟地 15g，山药 25g，川断 15g，桑寄生 15g，鹿角霜 25g，黄芪 25g，党参 15g，白芍 25g，杜仲 15g，首乌 15g，肉桂 15g，桃仁 15g，红花 15g，鸡血藤 25g，白术 15g，白芥子 15g。

(4) 肝肾阴虚风痰阻络证：症见腰酸膝软，头晕，目眩，耳鸣，面赤，心烦易怒，舌红，脉弦数。方用天麻钩藤饮加减：天麻 15g，钩藤 15g，川芎 15g，石决明 25g，菊花 15g，夏枯草 15g，丹参 15g，赤芍 25g，桃仁 15g，红花 15g，川楝子 15g，木香 15g，郁金 15g，鸡血藤 25g。^[2]

3. 王进勇诊治经验

因大多数大动脉炎患者血清中可查出抗主动脉抗体，故认为本病系一自身免疫性疾病。根据临床表现，属于中医“脉痹”、“虚损”的范畴，气虚血瘀为该病的主要病理特征。

治疗方面，依照气虚血瘀的病理特点和“治病求本”的治疗原则，采用益气活血法，其特点是以补为主，重在补气，佐以温阳通络，旨在鼓舞气血，行血消瘀，修复病损，恢复功能。因本病疗程长，宜坚持守方，才能取得较好疗效。治疗方药：生黄芪 60g，党参、丹参各 30g，桂枝

15~20g, 牛膝 20g, 银杏叶 9g, 仙灵脾、麦冬各 24g。气虚甚者党参易红参; 血瘀重者加苏木、刘寄奴; 肾阳亏损者加附子、肉苁蓉、鹿角胶; 气滞加陈皮、佛手等。并服大黄廑虫丸 3g, 每日 2 次。对一些病情较重, 病变广泛的患者, 还配用川芎嗪 100~150mg, 加于 5% 葡萄糖液 500ml 中静滴, 每日 1 次, 20 次为 1 个疗程, 疗程间隔 5 天, 用 1~3 个疗程。

用药方面, 按“多用则破, 少用则活”的用药经验, 在益气活血复方中, 重用桂枝, 以通阳复脉; 鉴于久病阳虚, 责之于肾, 又选用了仙灵脾、肉苁蓉、鹿角胶等, 以补精化气, 温肾而不伤阴; 银杏叶可通经活络, 对血脉瘀阻所致的头昏健忘, 肢体困麻确有疗效, 但胃脘胀痛或上逆者, 用量酌减。伍麦冬以监制桂附辛温太过。全方通补兼施, 辅佐得得, 故久服无弊。^[3]

4. 孔海云等诊治经验

本病多见于青年, 女性多于男性, 死亡率极高。病变呈慢性, 进行性加剧, 故禀赋不足, 正气内亏为其本; 患者有广泛的持续性的器官或肢体缺血, 缺血则致瘀血, 故瘀血内阻为其标; 瘀血内阻造成局部器官代谢与功能障碍, 继之发生器质性改变, 如脑梗死、心绞痛、肾性高血压等, 此皆为标中之标。基于上述病机特点, 结合中医脏腑理论, 临床上可分为五型:

(1) 心气亏虚, 血脉瘀阻: 患者常有上肢麻木冷痛, 寸口脉一侧或双侧减弱, 或消失, 上肢血压降低, 或双侧不对称, 锁骨下动脉处可有血管杂音; 头晕头痛, 视力障碍, 面部麻木冷痛, 颈动脉处可有血管杂音, 部分患者可突发脑梗死。“心主血脉, 主神志”, 心气虚则脉搏鼓动无

力，神无所主；瘀血内阻，络脉不通，则致气血更亏，故治疗当以温阳益气，活血通窍为原则，可用黄芪桂枝五物汤合通窍活血汤加减治疗。

(2) 肝脾两虚，血脉瘀阻：患者可有下肢麻木冷痛，间歇性跛行，足背动脉搏动减弱，或消失，下肢血压降低，或两侧不对称；或血压持续居高不下，头晕失眠，尿内有蛋白；或间歇性腹痛，腹泻，呕吐或吐血，便血等。“脾主运化，为气血生化之源，主肌肉四肢；肝主藏血，主濡养筋脉”，故治疗当以健脾养肝，活血通络为原则，可用十全大补丸健脾养肝以治本，并根据症状表现及瘀阻不同部位而加用活血通络药。以肾性高血压为主加用丹参、赤芍、桃仁、红花、益母草等活血化瘀；以下肢冷痛为主者加用海风藤、鸡血藤、安痛藤、地龙、乌梢蛇等祛风活血通络；以腹痛、呕吐为主者加用少腹逐瘀汤。

(3) 肾气亏虚，瘀血内阻：患者既有上肢头面的瘀血阻络，也有胸腹及下肢的血瘀为患，故除有心肝脾三脏正气内亏外，主要为肾气内亏。“肾为先天之本”，为全身阳气之根。肾气内亏，它脏失养，故温补肾气为治本之法。可用金匮肾气丸，再加用其他活血通络方剂。重、缓、急选择通窍活血汤、桃红四物汤、少腹逐瘀汤、身痛逐瘀汤等。

(4) 肺肾亏虚，痰瘀互结：患者除有上述三型表现之外，可有轻重不等的咳嗽、气喘、咯痰、咯血、尿少、下肢或全身浮肿、形寒肢冷等，病情严重者常不能平卧，喘息不止，甚至大咯血。“肺主气，主通调水道；肾主水，主纳气”，肺肾亏虚，水充斥于肺则为痰，为饮而喘咳，水泛溢于肌肤则全身或下肢浮肿，肺内不化之水与瘀相搏，致痰瘀互结，气机格拒，故喘息不能卧；水饮瘀血凌心耗气，

致形寒肢冷，甚至形成闭脱之证。故本型病机复杂，病势急迫，治疗当谨察病机，因势利导。喘急浮肿，尿少肢厥者，当回阳救逆，平喘利尿，可用参附汤合苏子降气汤，必要时要配合西药以加强利尿、活血、强心之力。俟病情缓和，可用温肾纳气、补肺祛痰加活血化瘀药，如济生肾气丸或八味都气丸合血府逐瘀汤加减。

(5) 五脏亏耗，阴阳衰竭：本病的任何一种病理类型，均可由于炎症的反复发作与进行性加剧，抗原抗体复合物的堆积及受累血管的瘢痕收缩使相应供血器官因之衰竭，如心肌梗死、脑梗死、肾功能衰竭、心力衰竭等，而致病人死亡。在此之前的中医药治疗，以补气、调五脏与活血化瘀为主，除了缓解临床症状、控制炎症反应外，其重要目的之一即通过活血化瘀而改善器官的微循环，同时帮助侧支循环的建立和疏通，从而延缓病程进展，延长生存期并提高生存质量。一旦患者进入此期，则需结合西医治疗，用综合疗法以提高疗效。故本期的治疗原则应补气活血以改善器官的微循环，而不是解决血管病变，因为此时的血管改变一般需外科手术重建，已非药力所及。^[4]

5. 初秋结等诊治经验

既然本病慢性炎症期和再发活动期的病理改变是受累大动脉壁的抗原抗体反应性炎症不断进行，导致血管壁增厚乃至闭塞；实验室检查有血小板凝聚力亢进，血栓素(TXA₂)增多，抗主动脉抗体阳性，血沉快，CRP阳性，白细胞高、γ-球蛋白增多；临床表现有不同程度发热、周身不适、关节痛，无脉侧肢体无力、发凉、发麻，头昏、头痛、昏厥等毒热证和血瘀证，所以认为毒热与血瘀之病机始终贯穿于本病的全过程。如能有效的控制毒热证，即

自身免疫反应性炎症和血瘀证，即由炎症引起的血管狭窄、血运障碍、组织器官缺血、血液高凝状态等，将会阻止病变进展，防止血管壁瘢痕化及狭窄或闭塞，对改善预后非常重要。以此立论，采用解毒活血法，筛选出以丹参、白花蛇舌草为主药的 6 味中药，制成“脉炎消”注射液，本剂经动物实验和临床观察无毒性，无副作用。脉炎消组未用激素治疗，与用激素治疗的丹参组比，总有效率并无差异，而且脉炎消组的临床治愈率和显效率优于丹参组 ($p < 0.01$)。其它指标如低血压的恢复、无脉到有脉、全身中毒症状发烧和关节痛、周身不适等方面，脉炎消组优于丹参组 ($p < 0.05$)，表明脉炎消的活血化瘀和清热解毒作用优于丹参注射液。脉炎消的疗效与其自身对照也显示其疗效显著。又如在减轻头昏头痛、胸闷背痛、肢体凉麻无力等缺血症状方面起效迅速，一般于用药后 4~13 天出现明显改善，静点中病人感到周身变暖、微汗，无脉肢体可触到脉搏，肢体冷痛麻木感消失，除个别人有头昏、头痛、微热外，余无副作用。^[5]

6. 严复圭等诊治经验

中医诊断本病属“脉痹”范畴，临床主证：精神萎靡，面色无华，头晕头痛，耳聋眼花，倦怠懒言，畏寒喜温，胸闷心悸，上肢或四末麻木冷痛，腰脊酸痛，寸口脉或跌阳脉单侧或双侧无脉，或脉伏，舌淡，苔薄白；气虚甚者兼见气短乏力，易于外感；血虚甚者面色苍白，头晕眼花，失眠；阳虚甚者畏寒肢冷，腰脊酸软，食少便溏；阴虚甚者，口燥咽干，耳鸣少寐，舌红少苔。证属阳虚寒凝，气虚血瘀，脉络痹阻。治拟益气活血，温阳通脉。方药以温阳通脉汤加减：附子、当归各 10g，麻黄、川芎、桂枝、

细辛、炙甘草各 6g，黄芪 20g，丹参 15g。每日 1 剂，水煎服，10 剂为 1 疗程。气虚甚重用黄芪；血虚甚重用当归加鸡血藤；阳虚甚重用附子，最大剂量可达 20g 以上；阴虚甚者加用麦冬、玄参。若伴阳亢者同时加牛膝 15g、菊花 9g，并酌减附子用量。肢麻冷痛者重用丹参、桂枝；药后热象明显时麻黄、附子、细辛酌情减量。

参附注射液静脉点滴，每日 10~20ml，加入 10% 葡萄糖液 500ml 内，10 次为 1 疗程（参附液为院内制剂，每毫升相当于人参 0.1g、附子 0.16g、丹参 0.16g）。

本病属中医“脉痹”范畴。其病五脏皆可受累，与心肾关系更为密切。青壮年女子由于经期及妊娠耗伤阴血，致使体虚而易感受外邪诱发本病，故女性较男性多见。本病标为血脉痹阻，本为里虚寒证，辨证为阳虚寒凝，脉络痹阻。治疗上采取标本同治，以温阳散寒、培补元气为主，益气养血为辅，佐以活血祛瘀通络。方中附子为辛热之品，温经散寒，入心、肾二经，上助心阳以通血脉，下补肾阳以益命火；麻黄、细辛与附子相配，辛温发散，蠲痹通滞，出里走表，达卫散寒；人参大补元气，参附相配益气生血；黄芪为补气之长，振奋元气，促进血行；炙甘草甘缓和中并可降低附子、细辛的毒性；川芎、丹参、当归既活血化瘀，又加强营血生化。本方共奏温阳散寒、益气养血、化瘀通脉之功，为温、补、通兼施之法。^[6]

7. 邹庆雨等诊治经验

多发性大动脉炎在国内外尚没有满意的治疗方法。目前，国内多以中西医结合治疗为主，有一定疗效。一般急性期或再发活动期，伴有发热和血沉快者，中医辨证多为阴虚内热，治以养阴清热，活血通络，同时应用激素治疗，

可迅速控制症状。慢性期以缺血症状为主，中医辨证分为脾肾阳虚和气血两虚，治以温肾健脾、活血通络和补气养血。个别病例肢体缺血症状严重，继发坏疽感染并伴有高热等全身症状者，中医辨证多为热毒炽盛，治以清热解毒，化瘀通络。在上述治疗过程中应用复方丹参注射液静脉滴注，对加速改善患肢的血液循环疗效可靠。由于本病的临床症状多表现为中医学的“虚、瘀、毒、热”的特点，而血瘀又贯穿于各个病证之始终，故在辨证施治之中，均采用活血化瘀法。^[7]

【按语】

大动脉炎是慢性复发性疾病，发展缓慢，呈进行性加重。早期因无明显缺血表现而易误诊。本病的转归和预后取决于早期明确诊断与正确合理的治疗，以及病变类型、病变轻重和重要内脏器官组织损害程度。孙祥认为，由风寒湿邪致发的本病应分早、中、晚三期。早期为风寒湿痹阻脉道，宜清热化湿，活血通络；中期瘀血内停，脉道不畅，应活血化瘀，通脉剔络；晚期寒凝脉络，痹阻不通，应健脾补肾，温阳散寒。邹庆雨等也强调本病的“虚、瘀、毒、热”的病理特点，他们均认为活血化瘀法应贯彻于该病治疗的始终。陈敏等将之分为湿毒阻络、心脾两虚瘀血阻络、脾肾阳虚寒凝血瘀、肝肾阴虚风痰阻络等四型辨证论治。王进勇根据从患者血清中可查出抗主动脉抗体这一事实，认为该病是一自身免疫性疾病，为从免疫方面治疗该病找到了依据。并重视气虚血瘀的病理及益气活血的治法。孔海云等探讨了本病的临床病变分型与中医辨证论治的关系，中医辨证分为心气亏虚、血脉瘀阻，肝脾两虚、

血脉瘀阻、肾气亏虚、瘀血内阻、肺肾亏虚、痰瘀互结和五脏亏耗、阴阳衰竭等五型进行治疗。初秋结采用解毒活血法，筛选出以丹参、白花蛇舌草为主药的六味中药，制成“脉炎消”注射液。经临床验证，其在活血化瘀和清热解毒作用方面优于丹参注射液。严复圭认为本病标为血脉痹阻，本为里虚寒证，辨证为阳虚寒凝，脉络痹阻。治疗上采取标本同治，以温阳散寒、培补元气为主，益气养血为辅，佐以活血祛瘀通络，以温阳通脉汤为主方。

综合有关文献统计资料，临床总有效率为80%~96%。在大动脉炎的临床治疗研究中，既注意了辨证论治规律的探讨，同时也注重病史过程中各期的病理学特点，辨证与辨病相结合。急性活动期以清热解毒、养阴活血为主要治则，能够消除血管炎症，控制病情进展；迁延期则以益气养血、活血化瘀为主要治则，可以提高抗病能力，促进病情稳定，改善组织缺血状态；稳定期则以活血化瘀、软坚散结为主要治则，能够改善血液流变性质，扩张血管，促进侧支循环建立，增加组织血液供应，改善临床症状和体征。在此基础上也注意到因病变类型不同而导致内脏器官受累后所引起的临床特点，针对这些临床特征进行辨证论治，可以明显提高疗效。

(陶晓华 张 林 贾鹰珏)

参 考 文 献

- [1] 杨林. 孙祥老中医治疗多发性大动脉炎的经验. 江苏中医, 1989, 10 (12): 531~532
- [2] 陈敏, 朱淑荣, 金友, 等. 多发性大动脉炎 63 例的辨证论治. 中医杂志, 1988, 29 (8): 43~44
- [3] 王进勇. 益气活血汤治疗多发性大动脉炎 70 例. 陕西中医,

1992, 13 (10): 433~434

- [4] 孔海云, 陈利平, 谢天忠. 多发性大动脉炎的临床分型与中医辨证论治的关系. 上海中医药杂志, 1994, (1): 4~6
- [5] 初秋结, 韩丽, 王晓东, 等. 解毒活血法治疗多发性大动脉炎的临床研究. 中医药学报, 1992, (4): 25~28
- [6] 严复圭, 赵培阜, 张素清, 等. 中西医结合治疗多发性大动脉炎疗效分析. 中西医结合杂志, 1987, 7 (8): 488
- [7] 邹庆雨, 邹德力. 中西医结合治疗多发性大动脉炎 50 例. 实用中医药杂志, 1998, 14 (9): 19

干燥综合征

【概述】

干燥综合征 (sjogren's syndroem, 简称 SS) 又称口、眼干燥和关节炎综合征, 是一种以侵犯唾液腺、泪腺、腮腺为主的慢性系统性自身免疫性疾病。本病的病因可能与遗传、免疫、激素、内分泌和病毒感染等因素有关。其病理改变主要为腺组织受淋巴细胞和浆细胞浸润而有进行性破坏, 导致唾液和泪液分泌减少, 出现口、眼干燥症状。病变主要侵犯大小唾液腺和泪腺等外分泌腺。早期口眼干燥不易被人重视, 其病程长、易误诊, 临床表现多种多样, 比较复杂。除唾液腺及泪腺最易受累外, 其它内脏也可受累。单纯的口眼干燥症状称为原发性, 伴有类风湿关节炎或其它结缔组织疾病者 (如系统性红斑狼疮、硬皮病、皮肌炎、结节性或胆汁性肝硬化、结节性动脉炎等) 为继发性。本病也常合并淋巴瘤。临床上本病 90% 以上为女性, 大多数 30~40 岁发病。

本病在中医文献中无相似的病名记载, 但其复杂的临床表现许多古典医籍中有类似描述。无论原发或继发者, 因其往往伴发许多脏腑病变, 因此很难明确其属于某一病证。有人认为本病宜归属“燥证”范畴; 有人认为因其可累及周身故称为“周痹”; 关节疼痛属于“痹证”; 有脏腑损害者如肾、肝等受损, 称之为“脏腑痹”; 近年全国

中医痹病专业委员会所著《痹病论治学》称本病为“燥痹”。

【名医诊治经验】

1. 蔡抗四诊治经验

中医认为干燥综合征，从累及部位来看，主要是燥邪伤及肝脾肾的真阴。肾主骨，伤肾则关节疼痛；脾开窍于口，伤脾则口角糜烂，经久不愈，口腔干燥；肝开窍于目，伤肝则目为之病。所以在选方用药上，选用山药、蜂蜜治疗该病，效果较好。因为山药可以健脾、补肺、固肾益精、润皮毛、长肌肉，久服耳目聪明。章炳麟亦谓：“薯蓣一味，开血痹特有神效。”故与是证甚合。配以蜂蜜，润燥解毒止痛，且蜂蜜含有丰富蛋白质，多种氨基酸，尤益于人，两者相得益彰，故病可除。^[1]

2. 王鸿慧诊治经验

本病病程长，进展慢，主要表现为阴液亏损，阴虚则津液枯涸，脏腑不荣，燥由此生。肝肾阴虚，津液不能上济，故见目干涩无泪，耳聋耳鸣等；肺阴不足，鼻窍、声道失其滋润，故见口鼻干燥、声音嘶哑；津液不能充养肌肤，故见形瘦肤干；胃喜润恶燥，胃阴不足，燥由内生，故见口干舌燥，吞咽困难，纳差，或知饥不食等。所以在治疗上以养阴生津为总的治疗原则。“保得一分阴液，留得一分生机”。但久病阴损及阳，出现气阴两虚，阴阳两虚，或阴亏气损，气血运行受阻，筋脉不通而致瘀阻、痰凝、湿聚，或阴虚火旺，迫血妄行而致咳血、衄血、呕血等。

因此，临床上应根据出现的不同情况，分别佐以益气温阳、活血化瘀、除湿化痰、通经活络、凉血止血等辅助治疗。王氏将本病分为肝肾阴虚型、肺胃阴虚型、阴虚夹痹型辨证施治。^[2]

3. 马永楨诊治经验

对燥证的认识，早在《素问》即有“燥邪异于寒湿，同于火热”，“诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属于燥”，“燥胜则干”等记载，对其分类多从外燥、内燥着手。而本病尤重于内燥，往往在阴血亏虚的基础上，突发高热、吐泻、出汗、出血等因素，致使阴血更加亏耗，燥热渐进而生。外燥常为诱发因素，或使病情加重的外因之一。从临床观察，本病治疗不离滋阴润燥之原则。但因病情波及脏腑有别，病情浅深不一，其治法大致归纳为以下几点：

(1) 甘寒滋润法：本法适用于肺胃津伤，燥热稽留者，多见于干燥综合征的早期或轻型。临床表现以口干少津、口舌经常破溃，素易感冒，或咽干作燥，咳而少痰，苔薄质干红，脉细数，方药常选沙参麦冬汤合竹叶石膏汤化裁。

(2) 养血润燥法：本法适用于心脾两亏，血虚燥热者，多见于中年女性或更年期妇女。可见面黄少华，贫血貌，头昏目涩，口干鼻干，极易疲乏，素易焦虑烦躁，失眠多梦，肌肤毛发枯燥，舌嫩红少津，苔少脉细。方药可选地梅四物汤合黄连阿胶汤。

(3) 育阴润燥法：本法适用于肝肾阴虚，燥热内行者，多见于干燥综合征中症状比较典型者。症状表现为两目干涩，口干，唾液极少，形体消瘦，五心烦热，精神萎靡，少寐多梦，腰膝酸软，舌光龟裂，脉细数。方药以明目地黄丸合大补阴丸。

(4) 清营凉血法：本法适用于阴虚燥热偏盛者，为干燥综合征严重的证型。表现为目干，口干，鼻燥，面部烘热，唇红，易于破溃，舌干无津，无苔，舌质殷红，脉细小而数。方药可选清热（犀角）地黄汤加味。

(5) 益阴蠲痹法：本法适用于肝肾阴虚，湿瘀阻络者，常见于干燥综合征合并类风湿性关节炎的病人中，又可称之为重叠综合征者。症状除口目干涩外，且形瘦骨节疼痛，甚或强直畸形，舌红苔光，质有裂纹，脉细涩。方药以滋血汤合舒筋汤化裁。

(6) 滋阴通痹法：本法适用于阴虚络痹，营运滞涩者，以干燥综合征病程长久，或合并硬皮病者。症状表现除口目干燥外，还可伴毛发焦枯，指节肿痛发僵，皮肤光亮、弹性减弱，甚则增厚发硬，女性舌光无苔，舌质暗红有瘀斑，脉细涩。方药可选归芍地黄汤合大黄廑虫丸、莪术散化裁。^[3]

4. 邱建荣诊治经验

本证之治疗，以“燥者濡之”为原则，但与一般燥证有所不同。本证不能单以养阴生津应事。积多年研究和临床体会，邱氏认为此病治疗应注意以下三点：首先，应重视祛除燥热邪气，邪去则正安。燥热邪气不除，阴津难复。且本证之邪已深入入里，非一般祛表邪法可效。其次，本证多见于中老年女性，常伴耳鸣、腰酸、乏力、健忘等肾虚症状。肾虚则阴液不能上承，亦见口舌干燥，双目干涩等症状。肾虚为本，口眼干燥为标，与一般口渴津亏证治有异，应重视补肾。其三，本证往往迁延不愈，耗伤阴血正气而致气虚血涩，经脉运行不畅，痰瘀内生，而见腮腺肿大、疼痛，肌肤甲错等症状，尤其是兼痹证者。故治疗

须兼祛瘀化痰通络之法。三甲散是明代吴又可《温疫论》方，原方由鳖甲、龟甲、穿山甲、蝉蜕、僵蚕、牡蛎、土鳖虫、当归、白芍、甘草组成，用治正虚邪陷，主客交混，邪恋不去的多种疾病。邱氏用治干燥综合征获较好的效果。^[4]

5. 谭晨诊治经验

干燥综合征属燥证范围。遵《内经》：“燥者润之濡之”的法则，干燥综合征多用甘润之品以缓其燥，但奏效不彰。经反复查阅文献和长时间临床验证，逐步认识到干燥综合征是一累及多系统的全身性疾病，不同于一般燥证，不能简单以肝肾阴虚来概括所有证型。单纯治以滋阴补液难以收效。初步摸索出一套辨证分型规律，并归纳出八种相应治法介绍如下：

(1) 养胃生津润燥法：为治疗口干燥的主要方法，也是各类燥证的基本治法。由于病变侵犯唾液腺，唾液分泌减少，口干唇红起皱，舌红干裂，或溃疡，咽干音哑，齿松碎落，苔少脉细。缘“口为脾窍”，胃阴受损，津液枯竭，口咽失润，故出现上述燥证，治以养胃生津法，常用沙参麦冬汤、增液汤等加味。

(2) 滋肝明目润燥法：为眼干燥症的主法。邪犯泪腺，泪腺分泌减少，甚至无泪，两眼干涩，有异物感或灼热感，痒痛畏光，角膜混浊、糜烂、溃疡等。缘“目为肝窍”，肝肾阴虚，目失濡养而发为燥。治以滋阴明目润燥，主方杞菊地黄丸等。

(3) 补肾填精润燥法：适用于各种燥证。因干燥综合征为全身性疾病，多系统损害，非局部治疗所能解决。且其与遗传因素有关，肾主先天，中医学从整体观念出发，

依据脏腑相关、精血互化理论，补阴必补肾阴。缘“肾为先天之本”，各脏腑之阴均赖其滋养。若肾精亏损，则诸脏腑之阴乏源，故补肾阴以期精充液足，燥邪得除。若为疾病后期，穷必及肾，则补肾尤为重要。治如养胃阴同时加用补肾阴方药，补肝阴则必肝肾同补，后期阴损及阳则阴阳并补。方用六味地黄丸、左归饮加减。

(4) 益气养血润燥法：为燥证兼气血虚的治法。干燥综合征常见纳差乏味，神疲乏力，形体干瘦等气虚表现，缘“脾主运化”，是谓气能生津；“脾为胃行其津液”，是谓气能行津。若气虚则津液化生不足，流动缺少动力，亦发为燥，治当益气生津。“津血同源”，失血亦失津，津伤血亦虚，故补阴养血应相辅相成。

(5) 活血化瘀润燥法：适用于各种燥证。干燥综合征多伴高粘综合征表现，而活血化瘀药是降低血粘度的主要药物。临床表现为面色晦暗，肌肤甲错，脉涩等血瘀征象。缘阴血既虚，不足以载血运行则滞涩为瘀，反之，瘀血内阻，津不上承，五官九窍失养，燥亦难解。故润燥化瘀当配合运用。常用验方如活血生津润燥汤、大黄廬虫丸等。

(6) 清热凉血润燥法：用于干燥证兼有热象者。现代研究认为干燥综合征与病毒感染有关。又常并发细菌、病毒、真菌感染，症见身热、口干渴饮、尿黄便秘、舌红苔黄脉数等热证表现，治则清热养阴并施。缘热为阳邪，极易伤阴化燥，若因燥证复感外邪，或五志化火，阳亢化热，气郁血瘀，痰浊蕴热等，则气分营血热炽，阴血日涸，燥势难缓，宜清热解毒活血并养阴润燥。可用黄连解毒汤合沙参麦冬汤，或用清营汤加减。

(7) 化痰软坚润燥法：适用于燥证兼癭瘤结块者。干燥综合征可并发腮腺、颌下腺肿大、局部或全身淋巴结肿

大、甲状腺或肝脾肿大等，按之可触及有形之包块，缘津液亏乏，滞涩不行则凝聚为痰，结而成形。治非软化化痰不能消其结。方如加味消瘰丸等合用滋阴剂。

(8) 蠲痹通络润燥法：适用于燥证兼痹证者。干燥综合征常并发风湿性关节炎、局灶性肌炎，或其它结缔组织病有关节炎症状者，缘血燥生风淫于肢节，或阴虚血稠，流行瘀滞，络脉不通则发为痹。治宜蠲痹通络润燥。于滋阴润燥方中加入祛风活血通络之品，用药力避辛烈燥热以免耗津灼液。早期用沙参麦冬汤或杞菊地黄丸加秦艽、威灵仙、丹参、鸡血藤、木瓜、桑寄生等。中晚期可合用益肾蠲痹丸。均可同服雷公藤制剂。临床由于病情较复杂，治疗常数法兼施，如阴血同补，痰瘀同化等。^[5]

6. 刘国正诊治经验

根据本病的临床表现，归属中医“内燥”范畴。此病皆由内生，系津液亏耗、敷布失司所致。所以，任何影响机体阴津正常敷布之因素，均可相因为果，而在本病的发生发展过程中起到重要作用。诸如阴虚内热，则可销铄津液，津伤不行，乃可致燥。脾虚气弱，脾不健运，则水津不能四布，难以润泽五脏，从而起到其应有之作用；湿热郁阻，则可直接影响气机之通畅，使津不上承而致燥。其它如各种原因所致之瘀血阻络，脏腑虚损等，都可使津液不能正常敷布代谢，或源泉枯涸，而发为燥证。对于治疗则应辨证论治。燥毒型者，需清解润燥，药用清热（犀角）地黄汤，或立润燥生津法，药用天花粉、葛根、芦根、玉竹、石斛、乌梅、宣木瓜等甘凉微苦辛酸之品，或以润燥解毒法，药用山药、蜂蜜等。如属阴伤者，需养阴生津，具体视其何脏阴伤而分别治之。肝肾阴虚者，药用一贯煎、

六味地黄丸、左归饮、增液汤等方加减；脾胃阴虚者，药用益胃汤、石斛清胃汤、玉女煎、五汁饮等方加减；肺阴不足者，则用养阴清肺汤、麦门冬汤、杏苏饮等加减；如属气虚者则当温阳补气，使“气旺而津生”，可选四君子汤、七味白术散、参苓白术散、补中益气汤等加减运用；其他如滞涩、虚损者，俱随其变而施其治。虽然如此，但根据本病以口眼干燥为主要表现的特点，病变脏腑似与肺脾胃关系密切，近年来即有学者对“脾阴”作了深入研究，以滋养脾阴法治疗本病而获良效。^[6]

7. 孟澍江诊治经验

孟氏认为本病病位在于肺、肝、脾胃、肠、肾，尤与肝、胃密切相关。究其治疗，首先要除燥热之根。肝郁者，柴胡、青皮、枳壳、桑叶疏之；化火者，用丹皮、山梔、连翘凉之；肺热者，芦根、玄参、黄芩清之；胃热者，石膏、知母泻之；肠实者，麻仁、首乌、大黄通之。其次是恰当配合大剂量滋润濡养药物，肺胃阴伤者，选加玉竹、麦冬、天花粉、知母；肝肾阴亏者，宜用玄参、生熟地、乌梅、白芍；脾胃阴虚者，当投山药、太子参、北沙参、川石斛；肠液枯涸者，非细生地、玄参、麦冬、蜂蜜莫属。此外，尚应注意稍佐桂心温通，一助阳气化生阴津，二制寒凉滋腻以防损阳伤中，当伴随口舌生疮时用之。

针对本病燥热为患的特点，孟氏常投以自拟制干润燥方，药用：北沙参 15g，细生地 12g，乌梅 12g，寒水石 15～20g，玄参 12g，大麦冬 15g，何首乌 15g，川黄连 3g，天花粉 15g，醋柴胡 9g，桂心 2g，炒知母 15g，芦根 15～30g。

用法：每日 1 剂，水煎服。尚须配合丸、散、茶剂等简易成药。特别是汤药与成药间隔服，对巩固疗效大有裨

益。①茶剂有玄麦茶：玄参 7g，麦冬 6g，每日 1 剂，开水泡茶频饮，脾肾肺胃燥热者尤适。②散剂如桑麻粉：取黑芝麻、桑叶各等量炒黄后研细粉混匀，每次 5~10g，日服 3~4 次，对肾亏便秘、目暗、发枯稀者甚宜。③丸剂如润燥丸：乌梅 100g，川黄连 5g，玄参 90g，白芍 50g，研成细末，加蜜及姜汁适量制成小丸如梧桐子大，每于口中噙化，能清热润燥，安神除烦，主治心肝肺胃阴伤，烦躁，口渴，舌红诸证。方中于大队滋阴清热药中加入敛阴之乌梅，行气之醋柴胡，以达补而少泄，津得敷布得以濡养全身，燥证自除。^[7]

8. 刘国英诊治经验

病因燥与气，辨证求因：燥何以致干？其一，内在禀赋，阴虚燥盛；其二，热毒蕴袭，煎灼津液。二者均干扰人体津液的生成、转化和敷布。对于津液的生化，气机的调畅起着重要作用。在人体中五脏皆有气，各司其职，但肝气主疏泄，调节控制人体气机的枢转。肝的疏泄正常，则肝气调达，气血平和，脏腑协调。反之，则疏泄无权，气机失调，病由此生。故有“百病皆生于气”之说。干燥综合征，虽以一派干燥症状为其主要特征，但通过临床观察，无论是郁、虚、瘀、痹所致之燥，均是通过气郁痰结，或兼感温热之邪等因素，影响了气机的调畅和津液代谢，才使其阴阳偏颇所致。

治法疏肝养肝，从气调治：本证表现为一派粘膜干燥之象，又可见燥热伤阴之征，治以养阴润燥方可顺理。但刘氏认为，其燥因不同于一般的内燥，又非实火亢炽之证。运用中医学的辨证求因理论，其之燥，乃是由于气机失畅，郁而化热，气津敷布受障、阴阳偏颇所致。故非单纯滋阴

补液所能复。去伪存真，顺其病因，以疏肝养肝，兼以降逆化痰，活血化瘀，顾护脾胃之法，从气调治，使肝气调达，气血平和，以达三焦气通，水液运行，气津得宜，津必上承，燥证自除。

治疗方药以《伤寒论》四逆散疏肝为主，酌加郁金、苏梗。如兼有痰浊内阻，宜加竹茹、茯苓、陈皮、砂仁等降逆化痰；如兼有血虚络阻，宜加丹参、当归、丝瓜络等和血通络。同时，再加以怡情养性，多可获效。^[8]

9. 王燕青等诊治经验

干燥综合征除阴虚燥热外，瘀血贯穿始终，并且是疾病发展和缠绵不愈的重要原因。瘀血的成因主要有以下几方面：其一，该病起病隐袭，早期不易发现，就诊时往往已有数年、甚至数十年病史。按《内经》“病久入深，营卫之行涩”，以及叶天士“初病在气，久病在血，以经脉主气，络脉主血……凡气既久阻，循行之脉自痹”等理论推论，出现症状时，往往已至“久病人络”、“久病必瘀”阶段。其二，本病以阴虚燥热为本，日久耗气伤津。《内经》曰“营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血”、“津血同源”，津亏液少，血液浓浊，加之气虚无以运血，则瘀血内生。正如《直指方》所言“气为血帅也，气行则血行，气滞则血滞，气有一息之不运，则血有一息之不行”。其三，临床观察，本病患者发病前，常有精神紧张或抑郁史，发病后，又因病情缠绵而心情不畅。肝主疏泄，能调畅气机，运行气血。情志所伤，肝气郁结，肝失疏泄，气机不畅，则血行瘀滞。因此，整个病程中，瘀血贯穿始终。对于瘀血致燥机理，古代医家早有认识。如石芾南曰：“气结则血亦结，血结则营运不周，而成内燥。”《金匱要略》曰：“病

人胸满，唇青，口燥，但欲漱水不欲咽。”描述了瘀血口燥的特点。《血证论》在阐述瘀血致燥的机理时，曰：“有瘀血，则气为血阻，不得上升，水津因不得随气上升。”明确指出瘀血内停，气机受阻，水津不能输布是瘀血致燥的病机所在。干燥综合征患者除干燥症状外，部分患者尚有皮肤发斑或紫暗、腮腺漫肿、假性淋巴瘤及肝脏肿大等。实验室检查往往有血液流变学、微循环及免疫功能的异常，病理检查外分泌腺导管可有增生、狭窄等，这些均与中医瘀血的概念相符，为从瘀论治奠定了基础。

治疗方面，不能单纯强调滋阴生津，活血化瘀亦至关重要。活血化瘀可使瘀去血活，气机调畅，津液畅达，得以敷布，濡养全身，从而燥证自除。《血证论》曰“瘀去则不渴”，意在其中。活血化瘀尚利于体内瘀积的消散。药理研究也表明活血化瘀药在改善微循环、血液流变学、调整免疫等方面较之其他疗法有明显的优势，因此是治疗该病不可或缺的环节。常用的活血化瘀药有当归、桃仁、红花、丹参、鸡血藤等。另外，该病以阴虚内燥为本，滋阴生津必不可少，常用药有生熟地、天麦冬、石斛、花粉、玉竹、女贞子、龟甲等。该病病情复杂，症状表现个体差异性很大，临证时需灵活变通。气虚明显者可加太子参、黄芪、白术、山药等。其中黄芪用量不宜大，一般用15g，因其具生阳之性，易化燥伤津；热毒炽盛，灼伤营阴者加紫草、丹皮、水牛角（代犀角）等；伴瘀积痞块时加三棱、莪术、牡蛎、贝母等；关节症状明显者加威灵仙、稀莪草等。后期津回燥润之际，加重补肾养阴药的应用。^[9]

10. 傅宗翰诊治经验

（1）本证虽属燥证，但却不同于一般内燥，又非实火

亢炽，治疗不易速效。且本证在其病程中虽多阴虚之象，亦非滋阴补液所易复，又与一般阴虚证不同。故本病之燥是既不同于内燥又有异于外燥的一种燥毒。

(2) 燥毒害人，肝肾首当其冲。征之临床，阴虚液燥又是本征的主要病理基础。按肾恶燥而肝苦急，肾得液养而源充，肝得水涵则潜静，故滋养肝肾，亦治此等症之要旨也。

(3) 本证之因，既然因燥成毒（或因毒致燥），因此解毒一法，实是本证治疗中不容忽视的治则。按本证之毒源于燥，毒随燥入，燥由毒生，变由毒起；毒不去，则燥不除，变症丛生。因此，解毒清燥治则当贯穿于整个治程之中。傅氏在临床实践中，几经探索，试用了土茯苓、蚤休、生甘草、绿豆、大黑豆、磁石、紫草、紫竹根等，掺于辨证法则之中，尚有小效。

(4) 古人谓燥字既有属温属凉之异，更有在气在血之别，因此注意调整气血，乃治疗之又一关键。按燥之所成，系于津液之变动，而津液之变动，既赖于气，又及于血。在血者，津质伤也，滋之清之是属常法；在气者，津不流也，推之散之可也，助气载血通经运津，乃辟治燥之又一途径。

(5) 临床资料说明，本证患者多为女性，推究其因，从禀赋素质而论，阴虚液燥者女性常多于男性，且女子有经乳孕育之特殊生理，尤易耗气伤阴。而“女子以肝为先天”，阴血既耗，肝木失涵，其用越难自稳，其抑者不疏津道，其亢者下汲肾阴。故本证之治除养肝肾之阴外，还宜怡情养性，病者医工均当共识。

(6) 对本证病程中常出现的几个证候的处理：口、咽、唇、舌溃疡或干痛突出者，可选甜柿蒂、青盐、玄参、青

蕤、挂金灯、淡秋石、乌梅、安南子、生石膏、人中黄、枫斗、洋参、银耳、白残花、白蜜、猪肤等。腿足萎弱者，可选知母、黄柏、龟甲、牛膝、菟丝子、二至丸、玉竹。低热，可选银柴胡、鳖甲、白薇、葶草、功劳叶。便秘可选火麻仁、瓜蒌仁、生地、无花果、生紫菀。痰核瘰癧可选玄参、牡蛎、鳖甲、山慈姑、黄药子、青木香、蒲公英。小关节肿痛，可选威灵仙、土茯苓、鹿衔草、木瓜、虎杖。肢端苍白紫暗可选当归尾、紫草、赤芍、桃仁、红花、生山楂肉、桑枝尖、水蛭、廔虫等。对于某些局部干燥灼痛浅表溃疡症状，还可配合珍珠杏仁霜、玉红膏、蛋黄油、胡桃仁油等外用，以达内滋外润之效。^[10]

11. 杨香生等诊治经验

本证的病因与“病气”有关，如“春初温升”，“夏日炎炎”及“秋深初凉，秋风萧杀”，或“久晴无雨，秋阳以暴”等异常外燥气候均可劫灼津液而引发本病。此外，临床误治或失治，如误用汗、吐、下，或过服辛温升散药物伤津耗液而导致本病的也不少见。还有因久病而致精血内夺，津液耗损，官窍失于濡养，导致阳气不足，阴液亏损，气津不布，或年高癸竭，更易感受燥热邪气，内耗阴津，使上窍失濡而引发本病。

杨氏等除在病因上提出本证与“病气”有关外，在临床上常将本证分为5个证型，分述如下：

(1) “病气”犯肺型：可见于单纯干燥综合征患者，病多发于春、夏及秋初，症状较轻，为风热燥邪侵犯人体，上受于肺，津液耗损而致。临床可见于上呼吸道感染、干燥性鼻炎、咽喉炎、支气管粘膜干燥症。症见：口、眼、鼻轻度干燥，关节疼痛，或发热，干咳，痰少，舌质红，

苔薄黄，脉浮或细浮。常以疏散风热，宣肺布津为治，以桑杏汤加减。

(2) 阴虚内热型：为临床常见证型，多为病久或年高而致津液内耗，阴液不足引发一派阴虚内热症状。临床可见于干性结膜炎、鼻炎、咽炎、鼻腔、牙龈出血症，胃液、胃酸减少等症。偏重肺胃阴虚的，症见口、鼻干燥，干咳，鼻、齿衄血，胃中嘈杂灼热，大便燥结，舌红少津。治以百合地黄汤合玉女煎加减。偏重于肺肾阴虚的，症见口、鼻干燥，干咳痰少，皮肤干燥，或低热、自汗、盗汗。治以百合固金汤加减。偏重于肝肾阴虚的，症见目干涩，口、鼻干燥，筋骨涩痛，或见五心烦热、胁胀、乏力等症，治以杞菊地黄汤合一贯煎加减。偏重脾肾阴虚的，症见鼻、咽干燥，口干饮少，进食干噎，或见形体消瘦，乏力困倦，失眠梦多，治以益胃汤合六味地黄汤加减。

(3) 脾肾阳虚型：是临床上少见的证型，由于多种原因，如禀赋阳虚气弱素质的患者，或病程时间较长，疗效缓慢，迁延反复，均可导致阴损及阳，阳虚不能化水，津液不能正常输布而发。临床检查多见于女性内分泌失调及贫血、白细胞减少、骨髓有受抑制表现者。其病症表现为口、眼干燥，但不思饮水，面色苍白无华，口唇淡白，肌肉关节酸痛，畏寒肢冷，纳少便溏，小便清长，舌体胖大或有齿印，苔白，脉迟缓无力。临床应基于“善补阴者，必于阳中求阴”之理。可以考虑用补中益气汤或丁蔻附桂理中丸加减治疗。

(4) 气血瘀阻型：由于病久不愈，燥气羁留，伤津耗气，由气及血，气伤则血脉鼓动无力，以致瘀血内留，血行不畅，从而导致气血瘀阻而引发本病。若停留于某一部位，则出现某局部瘀血为主的征象。症见四肢关节疼痛，

或关节畸形、屈伸不利，腮腺肿大，皮肤粗糙，或见黑斑，腰酸痛，口燥咽干，眼干涩，舌质紫暗，脉细涩。治宜活血化瘀通络，以血府逐瘀汤加减。

(5) 气阴大伤型：一般见于干燥综合征重症期。实验室检查：血沉可明显增快，西蒙试验及泪腺破碎时间试验可明显降低。多由病久缠绵，脾胃衰败，阴液干涸，肺不布津，气阴两伤所致。临床表现口眼干燥征，皮肤色素沉着、粗糙、硬化，脱发，指甲变干、粗糙，或伴有其它自身免疫性疾病。症状可见口、眼干涩，唇干舌燥，口角皸裂，纳呆气短，进食干噎，常咽虚水，关节酸痛，颜面虚浮，神疲乏力。根据中医阴阳互根，气旺津生，求液于气的理论，临床宜益气养阴生津，增液润燥，治以生脉散合清骨散加减。^[11]

12. 潘文奎诊治经验

近年来，通过临床观察，结合各家运用中医药对该病治疗的报道，对此病辨证论治方法略有心得：

(1) 内燥之象，治宜润燥护津：口眼干燥综合征以口干眼干为其临床主要表现。刘河间曰：“干，不滋润也。”故临床是以燥象为其特有征象。当归属中医“燥证”之范畴。究其因，并非外燥六淫之邪所致，乃系内燥之由，液枯津涸是其基因。内燥之证既不同于实热，也有别于阴虚。其一，燥者干而涩也，具有粗糙之感，其舌干可见芒刺，皮肤扪之碍手；阴虚失润者，鲜有粗糙起刺。其二，燥者热之渐也。肤热面红，有烘热之感，而非实热面红目赤、里热郁蒸之象也，非阴虚潮热两颧樱红之貌。其三，燥者枯而裂也。其舌有裂纹，唇肤皸裂；诚如刘完素曰：“皮肤乃干裂，手足有如斧伤。”舌裂也“裂如直槽”，宛如

刀割、剪碎之状，而非阴虚者皮肤干瘪而起皱褶，舌裂纹如网“冰片之状”。其四，燥者涩而痛也。其舌碎、肤裂均有痛感，目涩则有砂砾摩擦之感，均痛楚不适，实热阴虚均无此裂痛或涩痛之感，临床当可辨别。治之可宗《内经》“燥者濡之”、“燥者润之”、“以甘缓之”、“佐以苦辛，以苦下之”之旨，藉甘凉濡润以清燥，甘辛流湿以润燥，苦下平热以护津。清燥可取清热（犀角）地黄汤，护津可选滋燥养容汤、天门冬膏。润燥贵在流湿，若徐之才曰“湿可去枯”，刘河间云“荣卫涸流，必湿剂以润之”。流湿则当保其津液之道畅达，若刘河间曰“开道路”。

（3）阴伤之质，治当滋阴生津：燥证仅是口眼干燥证之表象，而阴虚津亏是其本质。其因有三：一是患者以女性居多，且多发于更年期妇女，经云：“女子，六七，三阳脉衰于上，七七，经脉虚，太冲脉衰少。”张隐庵注曰：“女子，从阳而衰于阴。”可见此为阴虚之损伤期。二是症状，本病侵犯泪腺、唾液腺等外分泌腺的疾病，以干燥性角膜炎及口腔干燥为主症，是一派液涸津亏之象。三是舌象，本病以舌质红绛、舌面干燥、苔少舌裂为主要表现，《辨舌指南》曰：“舌色灼红无苔而焦干者，阴虚水涸也。”当属阴虚津亏无疑。本病阴伤之脏腑，主要涉及脾胃肝肾，间或涉及肺。盖口为脾之窍，涎为脾之液，今口干涎少，当为脾阴不足之兆，今脾与胃相为表里，脾为胃行其津液，而胃恶燥，故脾阴不足与胃燥津涸互有关联。经云“脾虚则四肢不用”，可见与脾脏有关。其责之肝阴不足者，因肝开窍于目，今肝泪少，视物模糊，是为肝阴不足之象。陈士铎曰：“内燥之病，不平肝木则胃气难生，不易生津液。”也说明阴伤与肝有关。肾阴不足则表现为全身干瘦、腰膝酸软、牙齿松动等，均为肾之损害。至于肺之病变是

基于肺司通调水道之职，但口眼干燥综合征见肺部病损者较少。阴伤津亏当以滋阴生津为其大法，但本病见有燥象，燥证须防滋腻，故宜用甘淡化阴，或酸甘养阴之法，且随其不同病损之脏腑分别择用。其脾胃阴伤者，可用益胃汤、玉女煎、石斛清胃汤、五汁饮化裁；其肝肾阴虚者，可以一贯煎、六味地黄丸、左归饮或增液汤加减；兼有肺阴不足者，可以养阴清肺汤、麦门冬汤滋阴，取杏苏饮润燥治之。

(3) 阴虚之由，治拟益气生津：在口眼干燥综合征中，部分患者虽见口眼干燥之燥象，但尚无阴虚之兆，究其成因乃脾虚失运，津不上奉，盖津液之敷布依赖阳气之推运，气运则津流，气足则津充，气虚失运则津失敷布，故东垣曰：“气少作燥，甚则口中无涎。泪液也系津液，赖气之升提敷布，始能达其所，溢其窍，今气虚津不供奉，则泪液也少，口眼干燥之症作矣”。故此虽见燥象，虽为津少，但实由阳虚津失敷布所致，责在气虚，而非阴涸。然口与眼皆在头面，居于高位，津失供奉，当系脾不升津，脾主升清之职失司。阴虚之枢机，治当宗“气旺津生”之旨，基于“善补阴者，必阳中求阴”之理，故拟益气升提布津之法，可以四君子汤、七味白术散、参苓白术散、补中益气汤等。然而本病症见燥象，责系津亏，故益气升提布津之法当慎温燥耗散。升提主用升麻而慎柴胡，药选甘平或甘辛，而不采苦温，以取其“甘守津反”“辛以润之”之意，防其苦温耗津。总之，口眼干燥综合征是以燥证为其特征，而阴虚乃其本质，在病变枢机中却寓有阳虚之因素，故临床主分内燥及阴伤二型，兼有阳虚证候，治以润燥为法，可从滋阴生津、益气布津着手，兼以清燥护津为用，然临床诸症有错杂，故当辨其主次、审其病机、综合施治，不

能拘泥于一方一药，才不悖中医辨证论治的原则。^{〔12〕}

13. 孟如诊治经验

(1) 润燥当须益气：由于本病具燥象丛生的特点，归属中医之“燥证”范围，遵《内经》燥者润之、濡之的法，治疗多用甘润之品以缓其燥。然而，因本病又可累及多系统的损害，出现脏腑气血亏虚的表现，故又归属“虚劳”范围。孟氏认为，本病多为阴虚之体内伤积劳，神气内耗，渐至精气虚少，诸脏腑失濡，气阴虚亏；亦有热邪内蕴，日久阴津亏损，化生内燥，进而至阴伤气耗；此外气虚运血无力则可致血瘀。故临床中本病除有燥象外，尚可有气虚、血瘀之见证。并认为治疗本病若仅以润燥难以获效，只有气阴兼补，方可使燥证得缓而获满意疗效。宜以养阴益气、生津润燥为主要治疗原则，选用增液汤合黄芪生脉饮组成基本方随症加减，灵活变通；气阴虚兼有血瘀者，基本方中加四物汤或丹参养血活血。

(2) 治燥尚须兼顾脾肾：由于本病系一慢性可累及多系统的病证，可致诸脏腑气血阴津亏虚，以肺、肝、脾（胃）、肾之气阴亏虚为主，而脾（胃）、肾之气阴亏虚为其根本。脾气虚，脾失健运可见腹胀、便溏、纳食不化等症，体液不足可见口舌干燥、舌红少苔等症；脾阴不足则胃阴亦易虚，胃失脾助，和降失职，其气上逆，又可见干呕、呃逆之症。故对本病的治疗，除用甘润之品治燥外，调补脾（胃）肾之阴亦较为重要。临证中孟氏以滋阴润燥、益气生津为治，兼顾脾（胃）肾，选用基本方增液汤合芪淮生脉饮加天花粉、玉竹、乌梅等药治之，既补脾肾之气，又益脾、胃、肾之阴，兼补肺、肝之气阴，而达生津润燥之目的。依此治之既使诸燥之象得缓，又可使诸如大便秘

溏、腹胀、纳食不化等症状得以改善，病情好转。

(3) 润燥兼治继发病：本证常继发一种或几种自身免疫性疾病，造成多系统的损害，临床中多见系统性红斑狼疮（或狼疮性肾炎）、类风湿性关节炎、硬皮病、桥本氏甲状腺炎。孟氏认为，尽管本病可伴发各种病证，但燥证之表现均始终不同程度地存在着，故应以润燥为其本，在给予养阴益气、生津润燥的同时，辨病和辨证结合治疗继发病证。如继发系统性红斑狼疮属肝肾阴虚者，在润燥的基本治则下加滋补肝肾之二至丸、六味地黄丸加减治之；继发狼疮性肾炎致慢性肾衰者，加滋补肝肾之二至丸和清热、泄浊、祛痰之川连、生大黄、丹参等药治之，且川连、生大黄均有降低尿素氮的作用；继发类风湿性关节炎属风湿热痹阻者，加羌活、豨薟草、忍冬藤、威灵仙、桑枝、苡仁、伸筋草、秦艽等以疏风、清热、利湿、通络；伴类风湿性关节炎之关节变形痛甚者，加骨碎补、淫羊藿、桑寄生、鸡血藤膏、鹿衔草、木瓜、丹参、制乳没等以补肾壮骨，活血通络；继发硬皮病属肝郁血瘀证者，加当归芍药散，或丹栀逍遥散以调肝健脾；属肝肾阴虚证者，加杞菊地黄丸滋肝养肾明目。

孟氏在润燥治燥的同时较注重肺脾肾之气，补脾胃肾之阴，从而使先后天之气阴得补，津液得充，诸燥得缓，以增液汤合芪淮生脉饮为基本方剂配合；其中，增液汤既滋肾水，又益胃阴，生脉饮气阴双补，黄芪补脾肺之气，淮山药既补脾肾之气，又益脾阴，诸药合用共奏养阴益气、生津润燥之效。^[13]

【按语】

干燥综合征主要表现为口眼干燥，枯涩，无涎无泪，

或皮肤干燥等燥热阴虚之象，西医无较好治疗方法，而中医中药对此却颇有疗效。其病因主要为燥、虚、瘀、湿；主要病机为阴虚为本，失于濡养，而以燥热为标。治疗以养阴润燥为基本治则。各位医家由于对本病认识的角度不同而在辨证论治方面有所差异。

蔡抗四认为该病主要是燥邪伤及肝脾肾的真阴，善用山药、蜂蜜来治疗。

王鸿慧在养阴生津的同时，分别佐以益气温阳、活血化痰、除湿化痰、通经活络、凉血止血等辅助治疗。

马永桢认为本病治疗不离滋阴润燥之原则，但因病情波及脏腑有别，病情浅深不一，因而归纳出相对应的六法：甘寒滋润法、养血润燥法、育阴润燥法、清营凉血法、益阴蠲痹法、滋阴通瘀法。而谭晨则归纳出八种润燥法，即：养胃生津润燥法、滋肝明目润燥法、补肾填精润燥法、益气活血润燥法、活血化痰润燥法、清热凉血润燥法、化痰软坚润燥法、蠲痹通络润燥法。

邱建荣认识到本病有三点值得注意：重视祛除燥热邪气，邪去则正安；本证多见于中老年女性，且多有肾阴虚之表现；本证迁延不愈，耗伤阴血正气而致气虚血滞，经脉运行不畅，痰瘀内生，故治疗须兼祛瘀化痰通络之法，善用明·吴又可《瘟疫论》之三甲散。

刘国正则从本病与阴液的产生、敷布、濡养脏器的线路关系辨证论治，燥毒型需清解润燥或润燥解毒，阴伤型需养阴生津，滞涩型需行气通滞，“随其变而施其治”。

孟澍江为温病名家，对于干燥综合症的诊治有自己独特的经验。其自拟制干润燥方，配合丸、散、茶等简易成药，可广泛用于本证，疗效可靠。

刘国英强调肝气郁结在发病中的重要作用，认为无论

是郁、虚、瘀、痹所致之燥，乃是通过气郁痰结，影响了气机的调畅和津液代谢所致。故治以疏肝养肝，从气调治，代表方如四逆散加郁金、苏梗。

王燕青等从本病与瘀血关系密切，瘀血贯穿始终，认识到本病瘀血的产生原因，致病机理——阻碍水津输布，从而提出“治疗以活血化瘀为关键”。

傅宗翰、潘文奎、孟如均从病因病机、辨证论治方面对本证进行了阐发，内容多有发挥。

杨香生等从本病的发病机理及其发展着手，抓住几个阶段的主要病机、特点和临床表现，将之分为五型辨证论治。

(陶晓华 邬洪波)

参 考 文 献

- [1] 蔡抗四. 干燥综合征从燥论治经验. 江西中医药, 1997, (4): 20
- [2] 王鸿慧. 辨证治疗老年干燥综合征 23 例. 湖南中医杂志, 1997, (3): 47
- [3] 马永桢. 干燥综合征辨证论治六法. 南京中医学院学报, 1994, (5): 29~30
- [4] 邱建荣. 浅谈干燥综合征的治疗. 浙江中医学院学报, 1996, (6): 6
- [5] 谭晨. 干燥综合征辨治八法. 四川中医, 1998, (2): 10~11
- [6] 刘国正. 中医药治疗干燥综合征临床研究进展. 中国中医药信息杂志, 1995, (4): 25~27
- [7] 吴成. 孟澍江治疗杂病经验. 中医杂志, 1993, (7): 402~403
- [8] 刘国英. 疏肝法治疗干燥综合征体会. 中医杂志, 1997, 38 (3): 147
- [9] 王燕青, 刘学法, 李达祥. 从瘀论治干燥综合征探微. 中医函授通讯, 1998, (4): 16~17

- [10] 傅宗翰. 干燥综合征初探. 中医杂志, 1983, (8): 4~6
- [11] 杨香生, 陈高材. 干燥综合征的中医分型论治探讨. 江西中医药, 1989, (5): 26~28
- [12] 潘文奎. 口眼干燥综合征的辨证论治. 辽宁中医, 1988 (10): 14
- [13] 林丽, 曹惠芬. 孟如教授治疗干燥综合征经验. 云南中医中药杂志, 1999, 20 (1): 10~11

骨 坏 死

【概述】

骨坏死是指骨的活成分（骨细胞、骨髓造血细胞和脂肪细胞）死亡所引起的病理过程。它与许多疾病、某些药物和创伤有关。几乎可以发生于所有长管骨的骨端、骨突以及短骨的原发或二次骨化中心，但以股骨头、月骨、跗舟骨及跖骨处较多见。在风湿性疾病中，尤其以股骨头坏死的发病率最高，病损最严重，后遗症多，也是最为难治的一种骨坏死。

骨坏死不是一个单独的疾病，而是许多不同致病因素所导致的一种共同的病理现象。其病因，除创伤造成的骨坏死缘于血运被完整阻断比较明确外，其他的病因尚不十分清楚。一般认为，与血流动力学改变、应力因素、解剖学等有关。骨坏死的病理改变开始于骨质的缺血，引起骨组织的各种细胞迅速坏死、溶解、固缩；肾上腺皮质激素引起的骨坏死，还可见到骨髓内脂肪细胞增多，脂肪细胞增大。随后，引起周围正常骨组织的反应性改变，表现为由毛细血管、成纤维细胞和巨噬细胞组成的肉芽组织向坏死骨区长入，取代坏死骨，使坏死骨吸收。在血液循环得以恢复，坏死骨吸收的同时，有新生骨沉积，开始了再生、修复和重建过程，最后新骨形成，骨小梁结构和骨外形逐步恢复，当骨密度均匀一致并普遍出现正常骨小梁时，即

为本病愈合的主要标志。与此同时，滑膜细胞增生，形成血管翳样结构，将活的关节软骨表面吸收，造成关节软骨的破坏。上述骨质的坏死、再生、修复现象，常由于某种原因而重复出现，最后多形成不可恢复，发生退行性骨关节病。

骨坏死由于发生的部位不同，症状各异，但具有某些共同的临床特点。坏死早期一般没有症状，或有症状而无阳性体征。症状表现为局部疼痛，可伴有局部肿胀，关节骨的坏死可引起关节功能障碍。

骨坏死属于中医“骨痹”、“骨蚀”、“骨痿”、“血痹”、“阴疽”等范畴，中医学认为本病的发生多由肾精亏虚，长期过劳负重而致。因肾主骨而生骨髓，骨髓又是造血器官，肾精充足，骨髓充盛，造血有源，血运丰富而滋养骨骼。肾虚而髓减，造血无源，骨失滋养，使骨枯而缺血坏死。

【名医诊治经验】

1. 施维智诊治经验

施氏认为，本病的起因皆与肝肾、气血的盛衰有关。肝主筋，肾主骨，肾水能充髓益精，滋养筋骨，使筋骨强劲，筋脉和顺。若肾水不足，骨髓失充，则筋骨衰弱，生长无力。气主煦之，血主濡之。《灵枢》曰：“血和则筋脉流行，营复阴阳，筋骨劲强，关节清利矣。”气血有滋养和运行敷布精微之功能，气血充盈则运行有力，气血不足则运行无力，敷布失司。股骨头部位属髀枢，为气血罕至之处，一旦损伤，调治尤为困难。所以肝肾亏损，气血不足，损伤的骨端失去滋养，是造成本病的主要原因。在治疗原

则方面，首先考虑的应该是怎样充分利用原来部分坏死的股骨头继续作支架，这样，既可避免异物反应，又可免受手术之苦。因此如何延迟股骨头的坏死进度，甚至不使其进一步恶化，则是治疗本病的关键。

施氏认为，要延长或不使股骨头继续坏死恶化，除辨证用药外，还要注意治疗期间尽量减少股骨头的负重。股骨头支撑着上半身的重量，坏死后的股骨头已经失去了肝肾精血的滋养，处于“人不敷出”的状态，如此时再继续负重，加剧残留精气耗散，股骨头就会变形，加速坏死进程。所以，病员必须卧床休息并扶拐杖行走，以尽量减少股骨头的负重，是治疗本病的原则之一。

辨证用药方面，施氏强调审因论治。根据引起本病的主要原因，其治则应以温补肝肾，益气养血为主。少数病员因兼感风邪，髋部出现持续性疼痛，可酌加桂枝、防风、独活、秦艽、威灵仙等疏风通络药物，使疼痛缓解。然而大部分的髋部疼痛，皆由真元不足，支撑无力而引起的，属于功能性疼痛，而非风邪所致，此时宜补养为主。施氏常用的基本方是党参、黄芪补中益气；熟地、当归、白芍滋阴养血，填精生髓；川断、杜仲、枸杞子益肝肾，壮筋骨；鹿角片、苁蓉、补骨脂温肾阳，益精血；千年健祛风湿强筋骨；鸡血藤补血行血，通经活络；淮牛膝引药下行；川芎辛香走散，旁达四肢，使诸药补而能通，不致有呆滞之弊；陈皮、木香健脾和胃畅中，一般通过数周，乃至1年的连续服用，病员患肢行走有力，疼痛消失。^[1]

2. 罗元方等诊治经验

罗氏认为本病的病机初期多为肾虚血瘀，其次为瘀血化热，中后期则为肾虚寒凝，气虚血滞。所诊治的14个病

例中, 体质虚弱兼有外伤史 12 例, 2 例原因不明。由于先天不足, 后天失养, 肝肾亏虚, 气血虚弱, 髓海不足, 导致骨质疏松, 痿软无力是其内因。又因儿童生性好动的特点, 往往过度跳跃或负重, 易造成髋关节损伤, 伤后气血不能贯通, 经脉失去周流, 即股内滋养动脉、旋股内外动脉血运障碍, 缺乏营养, 使修复和再生能力减退而发生骨痹。治疗上分两期四型辨证施治。

(1) 早期

①外伤劳损型: 有过度活动或明确外伤史。患肢疼痛、肿胀, 明显压痛, 轻度跛行, 可兼有头晕目眩, 面色苍白, 身倦乏力, 腰膝酸冷, 舌质淡, 苔薄白, 脉弦紧或细弱等肝肾不足症。治以补气养血, 活络通痹。方以八珍汤加味, 药用党参 15g, 茯苓 12g, 白术 12g, 当归 10g, 黄芪 20g, 川芎 6g, 白芍 12g, 熟地 12g, 枸杞子 12g, 川断 12g, 骨碎补 12g, 木瓜 12g, 砂仁 6g, 三七 3g, 甘草 3g。

②瘀血化热型: 有外伤史, 初发时患髋灼热疼痛, 行走跛行, 活动受限, 压痛拒按, 皮温略有升高, 体温 37.5℃左右, 血象偶有偏高, 以后体温、血象正常, 出现头晕目眩, 面色苍白, 腰膝酸软, 舌质淡, 或有瘀斑, 苔微黄, 脉弦微数。治以补肾活血, 解毒止痛。方用补肾活血解毒汤, 药用当归 6g, 川芎 10g, 生地 15g, 川断 20g, 枸杞 12g, 丹参 12g, 乳香 6g, 没药 6g, 红花 6g, 银花 12g, 连翘 12g, 蒲公英 30g, 骨碎补 12g, 甘草 3g。

(2) 中后期

①气虚血瘀型: 髋部酸痛, 或刺痛, 明显跛行, 身倦乏力, 头晕目眩, 少气自汗, 性情急躁, 面色苍白, 舌苔薄白, 舌质紫暗, 或有瘀斑, 脉细, 或涩。治以益气活血, 健脾补肾。方以补阳还五汤加味, 药用黄芪 30g, 桃仁 6g,

红花 6g, 当归 10g, 川芎 10g, 地龙 10g, 丹参 12g, 白芍 12g, 白术 12g, 砂仁 6g, 熟地 15g, 川断 12g, 骨碎补 12g, 枸杞 12g, 甘草 3g。

②肾虚寒凝型：患部酸痛，畏风惧寒，常因气候原因而加剧，活动受限，腰膝酸软，四肢无力，夜尿频多，或有遗尿，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力，或弦紧。治以补肾活血，散寒除湿。方用补肾活血通痹汤，药用熟地 15g, 枸杞子 12g, 川断 20g, 破故纸 12g, 菟丝子 12g, 当归 10g, 没药 6g, 山萸肉 12g, 独活 12g, 威灵仙 12g, 红花 4g, 黄芪 30g, 丹参 12g, 白术 12g, 秦艽 12g, 鸡血藤 12g, 甘草 3g。^[2]

3. 诸福度等诊治经验

诸氏根据病程长短和临床症状，将股骨头坏死分为二期和八种类型。二期为初期和后期，病变初期属实证，当泻之，化其瘀痹；病后期属虚证，当补之，补肾长骨。八型是瘀湿夹热型、瘀血气滞型、瘀结寒凝型、瘀湿夹热型，瘀湿气滞型、瘀湿寒凝型、肾阳虚型、肾阴虚型。并创立了内治八法和外治八法。

内治八法

①清湿化瘀长骨法：适用于瘀湿夹热型，多有创伤史，伤处瘀痛颇剧，瘀湿交阻，郁而化热呈发作状，口苦口干，舌苔黄腻，脉弦滑带数。清湿化瘀长骨汤（黄柏、苍术、牛膝、桃仁、王不留行、延胡、骨碎补、自然铜、接骨木等）治之。

②理气化瘀长骨法：适用于瘀血气滞型，上证热退瘀化后，伤处隐痛者，用理气化瘀长骨汤（枳壳、香附、青皮、陈皮、当归、赤芍、乳香、没药、骨碎补、自然铜、

土鳖虫等)治之。

③温经化瘀长骨法:适用于瘀结寒凝型,病久缠身,瘀结寒凝,畏寒掣痛者,用温经化瘀长骨汤(炙麻黄、桂枝、白芷、细辛、桃红花、白茯苓、仙茅、仙灵脾、补骨脂、鹿角片等)治之。

④清湿化痰长骨法:适用于痰湿夹热型,体肥胖,苔厚腻,脉弦滑,或濡细带数,用清湿化痰长骨汤(黄柏、苍术、白芥子、莱菔子、车前子、青礞石、生大黄、芒硝、骨碎补、自然铜、薏苡仁)治之。

⑤理气祛痰长骨法:适用于痰湿气滞型,继上证后髋部隐痛不舒者,用理气祛痰长骨汤(仙半夏、橘皮、枳壳、乌药、胆南星、茯苓、生大黄、芒硝、自然铜等)治之。

⑥温经祛痰长骨法:适用于痰湿寒凝型,患髋畏寒的病者,用温经祛痰长骨汤(麻黄、桂枝、熟地、白芥子、莱菔子、胆南星、炮姜、鹿角片、千年健等)治之。

⑦养元复骨法:适用于肾阳虚型,病至后期,面色皤白,神萎乏力,阳痿滑泄,形寒便溏者,用养元复骨汤(熟地、山萸肉、苁蓉、补骨脂、仙灵脾、当归、黄芪、鹿角胶、猴骨等)治之。

⑧滋阴复骨汤:适用于肾阴虚,肝肾亏损,阴虚内热,面红口干,时欲升火,便坚瘦赤,梦遗滑泄,苔光质红,脉细数。用滋阴复骨汤(生地、元参、麦冬、知母、黄柏、丹皮、丹参、牛膝、鹿角胶、猴骨等)治之。

(2) 外治八法

①按摩法:在髋周进行按摩、推拿、滚擦等手法。在手法操作过程中,要重视内收肌的揉拨,解除痉挛,减轻疼痛,在股骨粗隆部要加用按摩乳至局部温热舒适为度。

②针罐法:在髋周取穴,以5~7枚针刺入,针后加艾

温灸，并拔罐。

③敷贴法：初期以三色敷药加活血长骨散，中后期以石氏伤膏加活血长骨膏散。

④熏洗法：以外用熏洗方（桂枝、麻黄、细辛、川草乌、半夏、三棱、莪术、桃仁、红花、丁香）加水，以电路自动控温 $<70^{\circ}\text{C}$ 。

⑤牵引法：以定制的下肢海绵牵引带进行持续牵引3~4小时，悬重5~6kg，对髌关节间隙狭窄，患肢缩短者有舒筋解痉，通利脉络的功效。

⑥肢体血循环促进法：以气压式四肢血液循环促进装置为佳，利用电动气压对患肢末端至躯干中心反复地压迫和松弛，促使静脉血回流，加速坏死修复。

⑦床上导引法：采用屈髋、旋转、绕圈等动作，在运动过程中动作要缓慢，配合吐纳呼吸，并要意守脐中。脐为元气之根，生命之源，意守脐中有增补元气的功效。

⑧避重法：扶拐行走，温水游泳，坐着工作，肥胖减肥等。上述疗法，每3个月为1疗程。

内治八法中，因创伤性和激素性骨坏死的发病机理不同，由此其治疗方法亦异，前者以化瘀血为治标手段，后者以祛痰湿为治标方向，但最终皆以补肾复骨而收功。外治八法中的熏洗、按摩、温针火罐，能促进局部血液循环，使骨内静脉瘀滞得以畅通，有降低骨内压效应，加快坏死的修复。^[3]

4. 孙捷等诊治经验

孙氏认为本病发生的原因是先天禀赋不足，创伤劳损与外邪袭人。先天不足为本病发生的内因，先天不足则人体必虚，卫外不固，极易受各种外因的作用而发病。后者

则是外因，如创伤使血行失度或损及内脏，内脏受损而导致气血运行不畅而致瘀；创伤还可以直接引起股骨头血供的不足而致本病的发生。引起本病发生的外邪主要为寒、湿与热邪。寒为阴邪，寒邪伤人，必犯阳气，阳气受损则气滞血瘀而致瘀痹；湿邪亦可伤人之阳气而致气血运行不畅；热邪（主要为糖皮质激素等热性药物所致）则伤劫阴血，导致筋脉骨肉失养而枯萎。并根据病因确立了疾病的分型：①瘀阻型，多为外伤所致；②寒湿型，多为感受寒湿之邪所致；③内损型，多为热邪所致；④劳损型，多为慢性劳损所致；⑤肝肾亏虚型，病久而致肝肾亏虚。

在治则方面，根据病因病机确立活血化瘀与补肝肾的基本治则。因疾病分型不同，治疗原则各有侧重：①外伤引起者多伤气血瘀阻于头而病，应针对瘀阻未散这一病理机制，补肝肾祛瘀健骨；②寒湿而致者，偏寒者患侧多刺痛，冷凉为主，应温散寒邪；偏湿者患肢以重着持续疼痛为主，应除湿健骨；③内损型属火热劫阴，气耗凝血，骨失血供，治则宜补益肝肾，平衡阴阳；④劳损型，久劳必伤肝肾，应补肝肾益气血。^[4]

5. 开翔诊治经验

开氏认为本病的病因病机，多为肾气亏虚，瘀血内阻，风寒湿邪侵袭所致。治疗上应以补肝肾、祛寒湿、益气血、活血化瘀为治则。临床分为四型。

（1）创伤型：因伤气血，恶血流内，瘀痹于髓骨而发病。治疗在补肝肾的基础上，针对瘀阻未散这一病理机制，配以补血活血，佐以理气止痛。主方选用三痹汤化裁，药用独活 15g，秦艽 15g，防风 12g，细辛 3g，川芎 15g，当归 30g，生地 15g，赤芍 10g，茯苓 15g，党参 30g，肉桂

6g, 杜仲 15g, 牛膝 15g, 生黄芪 30g, 续断 10g, 香附 12g, 川楝子 15g, 甘草 6g。

(2) 寒湿型: 多因寒湿浸润而致病。偏寒者以刺痛、凉痛为著, 治疗可在补肝肾的基础上酌加祛瘀散寒, 温经之品; 偏湿者以重着、持续疼痛为主, 可在补肝肾的基础上加行气、活血、利湿之品。主方独活寄生汤化裁, 药用独活 15g, 桑寄生 30g, 秦艽 15g, 防风 12g, 当归 30g, 赤芍 12g, 川芎 15g, 茯苓 12g, 桂枝 10g, 细辛 3g, 牛膝 15g, 木香 10g, 丹参 30g, 草薢 12g, 甘草 6g。

(3) 内损型: 多因滥用激素及经常饮酒而致, 中医辨证多属火热劫血, 伤气凝血, 此乃“热甚客于肾部, 干于足厥阴之经”, 遏蕴郁结极甚而气血不能宣通则痿痹, 治宜在补肝肾的基础上, 加补中益气活血之品。选方以二仙汤加味, 药用仙茅 15g, 仙灵脾 15g, 巴戟天 15g, 生黄芪 30g, 当归 15g, 川芎 10g, 鸡血藤 30g, 牛膝 15g, 黄柏 10g, 木瓜 12g, 白术 15g, 路路通 10g, 甘草 6g。

(4) 肝肾两虚: 为股骨头坏死之重症, 多为老年患者, 股骨头严重变形坏死, 治疗重补肝肾, 用培元固肾药物以壮骨。以滋阴复骨汤加减, 药用生地黄 15g, 玄参 30g, 麦冬 15g, 知母 12g, 盐炒黄柏 10g, 牡丹皮 15g, 丹参 30g, 牛膝 15g, 龟甲胶 15g, 猴骨 10g, 枸杞子 15g, 甘草 6g。服药每日 1 剂, 8 周为 1 疗程。^[5]

6. 阎贵旺诊治经验

阎氏认为本病与创伤、关节负重等因素有关, 如关节扭伤、摔伤、股骨颈骨折、跳高、跳远、重力挤压等使局部气滞血瘀, 股骨头失养, 而致缺血坏死。因为股骨头是人体全身负重最大关节之一, 它的解剖特点以骨松质而构

成血运丰富，当关节受外力创伤可致骨质中造血系统功能紊乱，造血功能障碍，供血不足而诱发本病的发生。病机多由肾精亏虚，长期过劳负重而致。因肾主骨而生骨髓，骨髓又是造血器官，肾精充足，骨髓充盛，造血有源，血运丰富而滋养骨骼。肾虚而髓减，造血无源，骨失滋养，使骨枯而缺血坏死。治则上针对病因病机，以补肾、活络化瘀止痛为主，自创“活络骨化丸”为主治疗股骨头无菌性坏死，经临床验证取得了较好的疗效。其药物组成为：莪术 6g，木瓜、制穿山甲、鹿衔草、续断各 9g，制川、草乌各 3g，桂枝 10g，威灵仙、乌梢蛇各 12g，红花、地龙、牛膝各 10g，鹿角胶 9g，甘草 6g。诸药为末炼蜜为丸，每丸 9g，1 次 1 丸，日服 3 次，白温水送下。同时可外敷“骨康膏”，药物组成及用法：活公鸡 1 只，乳香、没药各 15g，血竭 4g，骨碎补 12g，五加皮 20g。将鸡拧死（勿见铁器），去羽毛及腹腔脏器，剥下整个鸡皮备用，用石臼将肉血捣烂如泥，将上述后五种药共研细末混匀于鸡肉泥一起摊于鸡皮上，直接敷于患侧股骨头部位，用绷带包扎 24 小时后去除药物，隔 5 天敷 1 次。据报道：总有效率为 92.5%。^[6]

7. 黄俊卿诊治经验

黄氏认为本病的形成有因外来暴力作用于髋部致髋关节脱位，股骨颈骨折或髋关节周围软组织严重损伤，或反复使用粗糙手法整复，进一步加重损伤。骨内外血脉破裂，股骨头失去正常濡养，或离经之血不能消散形成瘀血，阻塞经络，压迫脉道，股骨头缺血而成；或因风寒湿邪乘虚侵袭，滞留髋部关节致血气凝滞不通，失其温煦，骨节失养而成髋骨痹；或因过食肥甘厚味，或长期酗酒，损伤脾

胃，运化失职，湿热痰饮内生，阻塞经脉，碍血运行，血行不畅，骨失其养而发病；或因年老体弱，肾气已虚，精髓亏乏，水不涵木，肝肾精血双亏，股骨头得不到濡养而坏死；或因长期大量服用糖皮质激素或甾体类消炎镇痛药物，致血液凝固性和粘度增加，微循环灌注量下降，股骨头血流量减少，骨细胞因缺氧发生变性而坏死。在辨证施治方面，将本病分为初中晚三期、七个证型。

(1) 初期：有明显外伤史，或长期使用激素类药物，或过度运动史。髌部疼痛，轻度跛行，活动后加重，休息后缓解，X线检查骨质普遍性疏松，股骨头无变形，关节间隙不窄，但骨密度不均匀，有局限性密度增高区，范围不等，多在负重面骨密度增高区的边缘可见新月状、带状或斑片状密度减低区，或小囊状影，骨质碎裂。

①损伤瘀滞型：有外伤史，或过度活动史，髌部疼痛由轻而重，有时呈刺痛，拒按，向膝部放射，轻度跛行，舌紫暗或有瘀点，苔薄白，脉弦涩。治以活血祛瘀，桃红四物汤加减。

②气滞血瘀型：无外伤史，服用激素类或消炎镇痛类药物后发病，髌部刺痛，痛有定处，时轻时重，夜间加重，跛行，舌质紫暗，或有瘀斑，脉细涩，或沉弦。治以活血祛瘀，散瘀止痛，正骨紫金丹加减。

③寒湿阻滞型：髌部持续性重着疼痛，患肢冰凉，得热痛减，畏寒怕冷，舌淡胖，苔白腻，脉沉缓，或沉细。治以温阳散寒，利水渗湿，麻桂温经汤加泽兰、木通、茵陈、泽泻、山楂等。

(2) 中期：髌部疼痛加重，跛行明显，髌关节轻度屈曲，内收畸形，外展内旋活动受限，负重后疼痛明显加剧，休息后减轻。X线表现股骨头关节面塌陷，正常的弧形曲

线部分消失，出现“台阶征”，变扁，骨密度不均，出现囊样破坏区，周围可有新骨增生，关节间歇增宽或变窄。

①寒邪入络型：髌部疼痛向膝部放射，患肢麻木，肌肤不仁，筋脉拘急，舌质淡红，略有瘀点，苔薄白，脉弦紧。治以舒筋活络，健步虎潜丸合黄芪桂枝五物汤加减。

②肝肾亏虚型：髌部疼痛，下肢乏力，腰膝酸软，头晕耳鸣，精神萎靡不振，关节屈伸不利，舌淡红苔薄或少苔，脉沉细无力。治以补肝肾，强筋骨，独活寄生汤加减。

(3)晚期：髌部疼痛较甚，下肢短缩，跛行明显，大腿及臀部肌肉萎缩，各项活动均受限。X线表现股骨头压缩塌陷，明显变形，骨质增生硬化，或间有囊状破坏，关节间隙变窄，关节面不整齐，周围有骨质增生可形成骨赘，股骨颈粗短，髌臼有相应的骨增生，常伴有半脱位，或病理骨折。

①气血两虚型：髌部疼痛，面色萎黄，倦怠乏力，纳差，气短懒言，舌淡白，苔薄，脉虚细无力，治以益气养血通脉，生血补髓汤加减。

②筋骨萎弱型：髌部酸楚疼痛，下肢萎软无力，跛行，舌淡苔薄白，脉沉弦无力，治以填精益髓，补肾壮骨，自拟方加减（熟地、淫羊藿、巴戟天、何首乌、骨碎补、狗脊、菟丝子、肉苁蓉、牛膝、续断、鹿角胶、山萸肉、陈皮等）。

除按上述7个证型辨证施治给予内服药物外，黄氏还结合牵引、中药离子导入、手法、中药外治来治疗本病。如牵引：患者侧卧位，行持续皮肤牵引，或用下肢牵引套牵引，牵引重量4~6kg。

中药离子导入：中药处方：当归30g，威灵仙30g，川椒25g，生南星12g，制马钱子5g，透骨草30g，土鳖虫12g，红花10g，制乳没各10g，紫荆皮15g，大黄10g，冰

片 6g, 丁香 6g, 川牛膝 12g, 苏木 12g, 细辛 6g, 无名异 15g, 莪术 10g。用法: 将上述中药煎煮 30 分钟, 去渣取药液加入冰片, 装瓶中备用。使用时将纱布浸透药液置于离子导入机正极, 放在患侧腹股沟中点, 每次治疗 20~30 分钟, 每日 1 次。

手法治疗: ①循经点穴: 点按足阳明胃、足少阳胆、足太阳膀胱经分布在患髋及下肢的穴位。

②松解软组织: 依次使用按、摩、提、拿、搓、滚法, 松解患髋关节周围肌肉。

③弹拨内收肌群: 患者侧卧, 髋关节外旋外展, 术者用拇指指腹弹拨内收肌群。

④推揉髋胫束: 患者侧卧, 患肢在上, 术者用掌根部推揉髋胫束。

中药外治: 遵循温通、活血、消肿止痛的治则, 方用刘寄奴 15g, 当归 30g, 赤芍 15g, 无名异 15g, 透骨草 30g, 伸筋草 30g, 鸡血藤 30g, 五加皮 30g, 乳没各 10g, 细辛 10g, 三棱 10g, 防风 15g, 秦艽 15g, 川草乌各 10g, 桂枝 10g。上药布包, 煎煮 30 分钟, 热敷髋部, 也可水煎熏洗, 每日 1 次。^[7]

【按语】

股骨头缺血性坏死又称股骨头骨髓炎。现代医学一般采用手术治疗, 患者多不易接受。中药治疗有确切的疗效, 可逆转或延缓病情, 对青壮年股骨头无菌性坏死病例尤其有利。上述 7 位医家对本病的病因认识基本相同, 即先天禀赋不足, 创伤劳损与外伤。施维智认为本病的起因, 皆与肝肾、气血的盛衰有关, 治则应以温补肝肾, 益气养血

为主，其着眼点在于“补”，在补养的基础上，酌加祛邪的药物。罗氏在病因上注意到肾虚是本病之本，也注意到瘀血对本病的作用，其着眼点“虚”、“浊”并重，治则补肾活血并重，临床上分为两期四型，便于掌握。诸氏创立了内治八法、外治八法。其病因病机理论依据是痰湿夹热、瘀血气滞、瘀结寒凝、痰湿夹热、痰湿气滞、痰湿寒凝、肾阳虚、肾阴虚而分别采用清湿化痰长骨汤、理气化痰长骨汤、温经化痰长骨汤、清湿化痰长骨汤、清湿化痰长骨汤、理气祛痰长骨汤、温经祛痰湿长骨汤、养元复骨汤、滋阴复骨汤八个方剂。前六型是股骨头坏死初期，病属实证，当用泻法，化其痰瘀，后两型是股骨头坏死中后期，病属虚证，当用补法，补肾长骨，同时根据标本缓急，配以八种外治法，提出了一套较为合理的治疗方案。孙捷等在临床上将本病分为五型，即瘀阻型、寒湿型、内损型、劳损型、肝肾亏虚型，治则上以“活血化瘀与补肝肾”为基本治则，根据本病中晚期症状多显寒象，多辅以“温”法，并随机加入一些接骨续筋、促进新骨生成和止痛功效的中药。开翔采用中医辨证施治治疗 230 例，总有效率 87.8%。在病因病机方面，认为本病多为肾气亏虚、瘀血内阻、风寒湿邪侵袭所致。治疗上以补肝肾、祛寒湿、益气血、活血化瘀为治则，辨证分为四型：即创伤型、寒湿型、内损型、肝肾两虚型，由于是结合病因、病程及症状来分型，便于临床掌握。阎贵旺自拟“活络化骨丸”治疗本病 27 例，方中除活血化瘀补肝肾之药外，制川草乌、桂枝、威灵仙等均为性温之品，有用“温”法之意。同时外敷“骨康膏”，重视对本病的局部治疗，在临床上收到了较好的疗效。黄俊卿根据病因、病程，结合现代科技手段，将本病分为初、中、晚三期和损伤瘀滞型、气滞血瘀型、

寒湿阻滞型、经络痹阻型、肝肾亏虚型、气血两虚型、筋骨萎弱型等分型。使辨证分型有了具体量化指标，并结合中药离子导入、手法治疗、中药外治等综合治疗，进一步提高了治疗效果。

(张银柱)

参 考 文 献

- [1] 吴云定. 施维智治疗股骨头无菌性坏死经验. 天津中医, 1994, 11 (2): 37
- [2] 罗元方, 赵邦友. 中医治疗股骨头软骨炎 14 例疗效分析. 中国骨伤, 1992, 5 (1): 12~14
- [3] 诸福度, 等. 股骨头缺血性坏死的中医药疗法. 中国骨伤, 1994, 7 (6): 46
- [4] 孙捷, 等. 股骨头缺血性坏死的中药治疗. 中国中医骨伤科, 1994, 2 (1): 53~55
- [5] 开翔. 中医辨证综合治疗股骨头坏死 230 例报告. 中医正骨, 1996, 8 (5): 24
- [6] 阎贵旺. 活络骨化丸治疗股骨头无菌性坏死 27 例. 辽宁中医杂志, 1990, (3): 21~22
- [7] 黄俊卿. 股骨头无菌性坏死的中医辨证. 河南中医, 1995, 15 (4): 222~223

过敏性紫癜

【概述】

过敏性紫癜（HSP），又名出血性毛细血管中毒症，是过敏性血管炎症反应，是一种变态反应性疾病，病变主要累及毛细血管壁，使血管壁通透性增强而出现出血症状，以皮肤紫癜为主，尚有不同程度的胃肠道、关节、肾脏方面的症状，而表现出腹痛、便血、关节肿痛、浮肿、尿血等。

发病前常有乙型 A 族溶血性链球菌、支原体、水痘病毒、传染性单核细胞增多症相关病毒、流感病毒、风疹病毒、麻疹病毒等感染之历史。也可由预防注射、接触食物过敏原、某些药物毒素、昆虫叮咬以及寒冷等因素诱发。此外还与受冻、外伤、更年期、精神刺激等有关。由于上述诸因素使某些个体细胞免疫低下，抑制性 T 细胞功能障碍，多克隆 B 细胞活化，抗体形成，发生 I、Ⅲ型变态反应，引起广泛急性无菌性血管炎。主要损害部位是直径 $<0.1\text{mm}$ 的毛细血管和小静脉。电镜检查肾小球血管系膜、皮肤及肠道，发现有免疫复合物沉着。

过敏性紫癜必具特征为皮肤紫癜，其他脏器受累程度依次为肾、关节、消化道、心血管、神经系统等。一般在发病前有类似感冒的前驱症状，个别先有腹痛、关节痛。约 30%~70% 的患者有一过性血尿，部分发生过敏性紫癜

性肾炎。但绝大多数患者为小儿，尤以4岁左右小儿最为常见。成人发生者占总数5%，男女之比约为5:1。

过敏性紫癜属中医学“发斑”和“血证”范畴。关节症状明显者，属中医痹病范畴。

【名医诊治经验】

1. 黄俊玉诊治经验

黄俊玉根据中医学理论和现代医学知识，并结合多年的临床观察治疗，把过敏性紫癜的病因病机概括为外感风热之邪与内有脾胃湿热邪毒合而为病。因小儿脏腑娇嫩，形气未充，为稚阴稚阳之体，气血不足，卫外不固，易受外邪而发病，传变迅速；又饮食不节，脾胃易被生冷积滞所伤，蕴生湿热，内伏脾胃，内外合邪，则疾病丛生。肺合皮毛，脾主肌肉、四肢，故邪易伤肺、脾胃，累及肌肉、腹、四肢。纵观临床患儿，又多见有纳呆、舌质红、苔黄腻，或舌红少津、苔薄黄等症状。中焦湿热日久，热盛津伤，又致阴虚内热。故紫癜为外感风热引动内在湿热，热盛动血，肌衄发斑而发病。黄氏根据多年经验总结一方，辨证加减运用，以泻脾胃伏火，清除湿热，兼散风热，凉血止血。基础方为：石膏、栀子、藿香、贯众、紫草、仙鹤草、蝉衣、防风。

(1) 皮肤型：主要症状为皮肤紫斑，多见于双下肢及臀部，两侧对称，色较鲜红，按之不退色，呈多形性斑丘疹样，分批出现，肌肤可肿胀。在婴幼儿可见疱疹样皮疹，并常伴有发热、咽痛、舌质红、苔薄黄、脉浮数等症。辨证：风热外感，脾蕴湿热。治则：疏风清热，除湿凉血。

方用基础方加味：金银花、连翘、牛蒡子、黑荆芥、炒防风、藿香、炒栀子、仙鹤草、石膏、紫草、蝉衣、贯众。纳呆，恶心呕吐，湿热较盛者，配加薏苡仁、竹茹，并重用石膏、藿香；若兼有低热不退，盗汗，手足心热，舌质红少津者，配加生地、知母、麦冬、川牛膝等。

(2) 关节型：主要症状为关节肿痛，可见红肿热痛，伴皮肤紫斑，压之不退色，纳差，下肢痿软，便秘，或大便不爽，小便黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。辨证：湿热阻滞，脉络不畅。治以清热燥湿，凉血通络。方用基础方合三妙散加减：苍术、黄柏、苡仁、川牛膝、石膏、栀子、藿香、伸筋草、槟榔、紫草、防风、仙鹤草。若关节肿痛、低热盗汗，乏力，舌红少津者，酌加生地、知母、麦冬；盗汗多者加牡蛎。

(3) 胃肠型：主要症状见紫癜伴有腹痛，痛在脐周，或下腹部，或有恶心呕吐，胃脘痛，便血，舌质红，苔白黄腻，脉弦，或细数。辨证：热毒蕴结，内迫营血。治以清热凉血，理气止痛。药用：白芍、枳壳、柴胡、生地、石膏、焦栀子、藿香、紫草、当归、赤芍、防风、甘草。腹痛甚者，加木香，玄胡；大便色黑或尿赤者，加三七粉、生大黄、槐花炭、地榆炭；便血多者，见气血不足之征，加人参、黄芪、炒白术、阿胶等。

(4) 肾型：主要症状见紫癜，伴有小便短赤或尿血，或水肿，或皮肤疮毒，或紫癜消退而尿赤，或化验检查有镜下血尿者。舌质暗红，或红，苔黄腻，脉沉数，或细涩。辨证：湿热下注，迫血妄行。治以清热解毒，泻火凉血。方药：石膏、藿香、栀子、防风、紫草、蝉衣、小蓟、生地、木通、滑石、淡竹叶。水肿明显者，加茯苓、泽泻、猪苓、大腹皮；血压高者，加夏枯草、浮萍；尿血严重者，

加生大黄、地榆、白茅根、阿胶；若尿色深红，舌质紫暗，加三七粉、琥珀粉；若尿蛋白高者，加山萸肉、黄精、熟地、女贞子、菟丝子、怀山药；若腰膝酸痛、四肢不温者，加桂枝、附子等。^[1]

2. 李少川诊治经验

(1) 清热凉血，勿忘宣气透营：小儿过敏性紫癜，一般为内有伏热，兼感时邪而发，邪热入血，迫血妄行，血不循经，热极伤络为其主要发病基础。阳络伤则吐血，阴络伤则溢血，上出则为吐衄，下出则为便血；瘀而不行则为蓄血；溢于皮肤则为发斑。治斑之法，古有清热（犀角）地黄汤、化斑汤、消斑青黛饮等，多以清热凉血为法，但遇及爆发型的小儿过敏性紫癜，除四肢紫斑遍发之外，往往多伴有高热吐逆、战慄、谵妄等症。临床经验，单以清热凉血，事多罔效，因此在临床上遇到紫癜病儿，除给予清热凉血之外，还要注意宣气透营，防其苦寒直折，阻遏气机。以清营汤化裁，去方中紫丹参、川黄连，加生石膏、知母、鲜茅根而收效。清营汤长于清营解毒，透热养阴，适于温邪由气入营，热伤营阴，身热神烦，血热妄行，溢于肌肤，发斑发疹。方中水牛角代犀角，清解营分之热毒，因热伤阴液，故辅以玄参、生地、麦冬以清热养阴，配以银花、连翘、竹叶以清气分之热，兼解温热之毒，并可透热于外，使邪热转出气分而解。阳明主肌肉，属多气多血之经，胃热则熏蒸于肌肤而发斑，故多配以生石膏、知母以清其胃热，兼有表证发热寒战者，又常伍以薄荷、豆豉以宣通疏解。

(2) 宣风祛湿，注意凉血润燥：过敏性紫癜另一兼症是关节肿痛，多见于下肢膝关节与踝关节，肿痛难忍，伸

屈不便。此关节痛与一般单纯之风寒湿之邪而致之关节痛不同，李氏遇到此病证，见关节肿痛并伴低烧者，以玉女煎加减，旨在凉血润燥，以顾血证之本。生石膏辛凉解肌，清热凉血而化瘀；生地凉血生津以濡其筋脉；牛膝性善下行，活血通络；知母、麦冬取其质柔性平，以润其燥。常配以秦艽、晚蚕沙、松节、木瓜以宣风祛湿而奏效。待关节肿痛缓解后，加以柔养肝肾之阴而收功。

(3) 久病致虚，宜健运，忌壅补：紫斑迁延不已，病情反复发作，每多导致紫斑暗淡，面色不华，神疲纳呆，腹痛便血，舌质淡红，脉多虚软。传统治则，常以归脾汤为治。李氏认为幼稚之体，质多属阳，虚而不受补者多，况紫癜伴有腹痛之症，乃为瘀血内阻，胃肠功能紊乱所致，过投参、芪甘温香燥之品，势必更伤及络。李氏多以香砂平胃丸和芍药甘草汤相互为用。木香、砂仁和胃醒脾；陈皮理气健脾；厚朴苦能下气，辛能散结，温能燥湿，善除胃中滞气；加芍药以补血敛阴，柔肝止痛；甘草借其甘缓之性以缓急止痛。腹痛、呕吐缓解后，以芎归胶艾汤化裁为用，借阿胶血肉有情之品，补肝血，滋肾阴，润肺燥，以善其后。

(4) 滋阴固肾，兼顾调理脾胃：过敏性紫癜迁延日久，缠绵不愈，有相当一部分病儿，每于皮疹消退之后，发现浮肿、尿少、血尿和蛋白尿，而并发紫癜性肾炎。紫癜性肾炎是由于营血内耗，伤及肾阴，阴不足而阳不能振，阳不振遂致肺脾肾气化功能失调，它与上感咽炎所致肺气闭塞，湿热下注的小儿急性肾小球肾炎不同。因此，传统的治疗手段如银翘散、四苓散、八正散、导赤散一派疏风清热、凉血利湿之剂效果不佳。法宜滋阴固肾，兼顾调理脾胃方为上策。以归芍地黄丸、平胃散相互化裁为用。地黄

丸为补肾阴代表方剂，加当归、芍药者，取其补血敛阴，以顾营血之源，配陈皮、厚朴、甘草者，既可矫地黄之腻，又可调和脾胃升降枢机，以促进生化之源。〔2〕

3. 余菊英诊治经验

中医学认为本病是因感受病邪所致。若受热邪则迫血妄行，溢于肌表，因而可见大面积红色瘀斑，甚至融合成片，有的还可能发生血疱。故以丹皮、赤芍清热凉血，丹参、归尾、鸡血藤、桃仁、五加皮、威灵仙、白鲜皮活血散风；受寒则血凝成斑，因而紫癜呈暗紫色，故以桂枝、干姜、肉桂、附子温经散寒，以归尾、川芎、桃仁、香附、红花活血化瘀，使寒凝之经脉畅通。若紫癜病情较久，反复发作，致使脾虚不能统血，气虚不能摄血，因而血不归经，离经之血外溢肌肤而成紫癜。故以党参、黄芪、茯苓、白术、扁豆健脾益气，以当归、白芍、川芎、香附养血止血。伴关节痛、腹痛，均加桑寄生、五加皮、威灵仙、独活、鸡血藤等品通经活络，以陈皮、川芎、香附、枳壳理气止痛。〔3〕

4. 詹起孙诊治经验

（1）阐发病机，首重湿热：詹氏认为，小儿过敏性紫癜容易反复发作的病机，无不与湿热相结，蕴郁中焦，内伏血分密切相关。小儿本乃脾常不足，又喜贪凉饮冷，湿阻中州，日久湿郁化热，湿热内蕴。加之小儿腠理不密，表卫不固，易感外邪，又因肝常有余，素体阳热，外感之邪每易从阳化热，与内蕴之湿热相搏，伏于血分，灼伤脉络，流于肌肤则皮肤紫癜；湿阻气滞，郁于肠胃则腹痛；湿热流注关节则肿痛；下灼膀胱则为血尿。湿性粘滞，湿

邪为病常缠绵难愈。本病之湿又常与风、热之邪搏结，难解难分，促使病情反复，病程迁延。因此，过敏性紫癜患儿常于临床缓解后，仍有四肢困倦，神疲乏力，胸闷纳呆，口苦尿少等湿热内蕴之象。同时本病常因外感风邪引起急性发作，而兼见发热，咽红疼痛，咳嗽等上呼吸道感染等症状，说明本病的发生与复发除因于热邪外，与内蕴之湿、外感之风无不相关。

(2) 宣畅湿热，兼以清透：湿热胶结是湿遏热伏、热处湿中，热以湿为依附，湿不去则热不清，故治当化湿为先，湿去热孤。由于三焦气化失司是内蕴湿热的病理基础，故治湿热又当以调畅三焦气机为首要环节。詹氏仿叶天士轻淡宣通湿热法，选择杏仁、清水豆卷、桑叶、白菊花、前胡等药，轻开肺气以宣上焦；用藿香、佩兰、石菖蒲芳香化湿及苍术、白术、姜半夏等苦温燥湿以和中焦；用茯苓、苡仁、忍冬藤、灯心草等淡渗利湿以通下焦，并适当佐以枳壳、郁金、陈皮、制香附、大腹皮等行气之品，以增强其通阳化湿之功，使三焦气机宣畅，湿热之邪从上中下分消。同时，不忘清凉透泻血中之伏热，常配以蝉衣、僵蚕两味虫类药。盖蝉衣性微凉，善解风热，僵蚕味咸，辛而性平，具有散风泻热、平肝解毒之功。蝉衣配伍僵蚕，能清透达邪，发散诸热，拔毒外出，从而使湿热胶结、壅遏肌肤、内伏血分之紫癜透而达之，泄而清之。^[4]

5. 钟一棠诊治经验

钟氏认为，本病多系热毒内陷引起，根据热毒侵犯部位，个体反应差异分四型进行辨证论治。

(1) 血热型：主证：起病突然，开始时有发热，微恶风寒等表证，继则出现广泛性的皮肤出血，紫癜如针尖，

或如片状，呈对称分布，多见于臀及下肢，色紫红，舌红，脉数，或正常。有的病人可无其它体征，有的可伴有头痛、皮肤瘙痒、口燥、便秘等症。病机：热毒内陷，损伤血络，使血渗脉外所致。治则：清热解毒，凉血止血。主方：清热（犀角）地黄汤加减（水牛角 30~60g，生地、鹿衔草、仙鹤草各 15~30g，丹皮、赤芍各 9~12g，白茅根 30g，甘草 3g）。

（2）肺热型：主证：前额头痛，鼻塞，流清涕，咽痛，皮肤病变同血热型。舌红，或偏红，脉数，或正常。病机：鼻为肺之窍，咽喉为肺之门户，热毒之邪郁结于肺，故见鼻塞流黄涕，咽痛。舌红、脉数为内有热候，肺合皮毛，热毒郁肺，血络受伤，故见皮肤紫癜。治则：清宣肺热，凉血止血。主方：自拟清肺凉血汤。（桑叶、杭菊、浙贝、苍耳子、丹皮、赤芍各 9~12g，清甘草、薄荷各 3g，辛夷 6~9g，生地榆 15~30g）。

（3）胃肠型：主证：皮肤病变同血热型。常有恶心、纳差、上腹不适，脐周及下腹作痛，大便溏薄，或腹泻，舌质偏红，苔黄腻，脉滑数，或正常。病机：由于热毒郁结肠胃，使脾胃升降失司，运化失调，故见恶心、纳差、腹痛、便溏等症。脾主四肢及肌肉，热毒郁结，损伤血络，故见皮下紫癜等候。治则：清肠泄热，凉血止血。主方：葛根芩连汤加减。（葛根 9~15g，黄芩、丹皮、赤芍各 9~12g，清甘草 3g，生地榆、谷麦芽各 15~30g，滑石 15~20g。）。

（4）肾热型：主证：皮肤病变同血热型。常伴有神疲乏力，腰腿酸软，尿赤或肉眼血尿。舌红脉数。病机：热毒之邪郁结于肾，使肾阴暗耗，血络受损，而致腰腿酸软，尿赤尿血。皮肤紫癜亦是热毒损伤血络所致。治则：清热

滋肾，凉血止血。主方：知柏地黄汤加减。（知母、黄柏、茯苓、丹皮、泽泻各 9~12g，生地、白茅根、荠菜花、鹿衔草各 15~30g，怀山药 12~15g。）。

除上述辨证施治外，可适当加用具有抗过敏的中草药，如蝉衣、紫背浮萍、蚕沙等。除胃肠型外，对迁延日久的病人，嘱每天服用生红枣 20 枚，有一定疗效。^[5]

6. 吴康衡诊治经验

（1）突出脾胃湿热，强调气滞血瘀：吴氏根据多年经验及大多数病例所见舌质红、苔黄厚或黄腻，审证求因提出湿热乃是最主要的病因。湿热搏结，损伤血络则血溢脉外，络伤而血外溢乃发紫癜、鼻衄、齿衄；阴络伤而血内溢则为便血、尿血；阻遏气机则气滞血瘀，滞于肠道乃发腹痛，瘀于关节故为肿痛，屈伸不利。因此，血溢与瘀滞是本病的两个病机环节。定位在脾胃，胃经热炽，或热伤胃阴而阳亢皆可动血而外溢；湿困脾阳，或湿伤脾气皆可失统而不摄；邪阻气滞，脾胃升降不利，瘀滞又由此而生。是故脾胃湿热、血溢瘀滞乃是本病主要病因病机。

（2）依据主次分型，抓住虚实纲领：吴氏认为因本病多系里证、热证为主，唯虚实夹杂难辨，故以虚实辨证为纲领。

实证多见于皮肤型、关节型、胃肠型。其紫癜密集，颜色深红，关节肿胀，酸痛较甚，腹痛如针刺，便血、尿血鲜红，病程较短，多由感邪而发。多数伴有口渴、少饮或不饮，或便溏，舌质红，苔黄厚，或黄腻，脉象滑数，或濡数，因脾胃湿热蕴结，络伤血溢，气滞血瘀所致。少数可见关节灼热，腹痛拒按，面唇红赤，口渴喜饮，大便结燥，舌红苔黄，脉数洪大，乃胃经火热伤络迫血所发。

虚证多见于肾型或混合型，病程较长，紫癜反复发作，尤其血尿、蛋白尿缠绵难尽，或腹痛隐隐，关节酸痛无力，多因素体正虚感邪而发，或邪盛伤正所致。若紫癜暗红，面唇樱红，五心发热，夜间低热，舌红少津少苔，甚至舌光无苔，脉象细数，当属胃或肾阴虚火旺而动血。而紫癜淡红，腹痛喜按，面色㿔白，声低懒言，神疲多睡，舌淡脉弱，则属脾气虚衰而不摄血，亦可见气阴两虚者。

在疾病过程中，并非一成不变。初期出血多呈实证、急证，出血日久气血虚衰，甚至气随血脱，虚实转化或夹杂，对柔弱小儿更为容易，不可拘泥。

(3) 重在祛邪安血，善用理气消瘀：大多数病例表现为脾胃湿热蕴结而伤血络，故吴氏多用泻黄散去甘草（石膏、山栀、藿香、防风）清利脾胃湿热，祛邪以安血。对紫癜较甚、集斑成片之皮肤型者，加知母、薏苡仁、丹皮、赤芍、紫草以除瘀消滞。偏于关节型而关节肿胀痛甚者，若湿重于热者则合四妙丸（苍术、黄柏、薏苡仁、川牛膝），而热重于湿者，则合玉女煎去麦冬，均可加木防己、秦艽等通络除滞。偏于胃肠型腹痛较甚者，若苔厚腻，则合丹参饮；若苔不厚腻，下腹痛为主，则合失笑散；瘀滞甚者加少腹逐瘀汤去干姜、肉桂理气消瘀止痛；便血甚者加血府逐瘀汤去瘀滞而安新血；偏于肾型血尿鲜红，或镜检红细胞及蛋白者，此即所谓继发性肾炎，因多缠绵难愈，故可单独论治；若舌红苔黄厚或黄腻，用半夏泻心汤去干姜、炙甘草、大枣，加藿香、赤芍、丹皮、白茅根、石韦清热利湿，开结消瘀安血；而舌红少津少苔，则用泻心汤（黄连、大黄）合导赤散加玄参、赤芍、白茅根、石韦养阴清热，消瘀安血。水肿明显者加商陆、泽泻、车前子以利水消肿。病情缓解则以消痰软坚，破气化瘀法，方用吴氏

自拟治肾 V 号（三棱、莪术、姜黄、王不留行、白芥子等）随证加减以善后。

虚证属胃阴虚火旺者用化斑汤（玄参、石膏、知母、水牛角）合二至丸滋阴降火、消瘀安血；因出血而致血虚夹瘀者用桃红四物汤加紫草、白茅根养血消瘀。久病及肾阴虚者用杞菊地黄丸加赤芍、紫草、知母、黄柏滋阴降火，消瘀安血。偏于肾型重用知母、黄柏，加龙骨、牡蛎，兼气虚者加党参、黄芪，其余加减同前。脾气虚衰不摄者，一般皆以归脾汤。气虚夹瘀滞用补阳还五汤加党参、怀山药、蒲黄炭益气消瘀除滞；气虚夹湿热者，用四君子汤合革藓分清饮加蒲黄炭、赤芍、知母益气清热除湿。偏于关节型或胃肠型者加减同前。但便血甚而肢冷者改用黄土汤加黄芪、大枣、蒲黄炭温脾益气而摄血，偏于肾型加菟丝子、破故纸、怀山药，病情缓解后以补中益气汤加减善后。^[6]

7. 李明道诊治经验

本病大多数患者体质较差，而气血两亏的症状比较突出，表现面色苍黄不华，头晕乏力，食欲减退，精神不振，不耐劳累，易疲劳，感冒频作等症。往往出现呼吸、循环、消化与吸收、精神与营养诸方面之障碍。由于气血两虚，必然影响到脏腑与全身功能。如脾肺气虚所导致的卫气不固，外邪入侵；血虚肝旺而出现的肝不藏血，血不循经；脾气不足而造成的运化失司，气不摄血；心血亏乏而引起的经脉空虚，邪毒伤络以及肾中经血耗伤，或先天不足致使毒邪内陷，遂产生下肢浮肿与尿液异常等。

实践证明，临床许多疾病的发生都与气血虚衰有关，而李氏从中认识到过敏性紫癜的发生，亦由气血两虚所致，因此认为，本病发生的病理基础是气血两虚；而皮疹、出

血与紫癜则为其病理反应，前者为本，后者为标。由于气血在人体直接维持着正常的生理功能，又为组成充实机体形态与结构的基本物质成分与产生生命活动的源泉动力。气血的盛衰，直接影响着人体的健康与生命活动，因此，补益气血，是防治疾病的一种方法，以益气养血为主，参以凉血解毒，或活血止血之剂以治其标；二者有机结合，相得益彰。^[7]

8. 王庆显等诊治经验

过敏性紫癜临床以四肢皮肤紫癜、鼻衄、呕血、便血、尿血和四肢痛、腹痛等为主证。从血液物理生化特性测定结果，提示本病血液凝集性增高。因湿热毒邪蕴结阻滞血脉，累及四肢、胃肠、肾等则出现全身血瘀综合征。本病表现为血瘀证，故以去瘀为先，方用桃核承气汤加味，破血下瘀，使湿热毒邪由胃肠而解。药理学研究证明活血化瘀方药有抑制体液免疫反应，降低毛细血管通透性和改善毛细血管脆性等作用，可能是本法获效的机理之一。^[8]

9. 张祥福诊治经验

湖南省芷江侗族自治县中医院张祥福临床 30 多年，运用大剂量蝉蜕（15~20g），在辨证的基础上加用其他药物治疗急性肾炎 35 例、过敏性紫癜 30 例，取得满意的疗效，且无不良反应，通过多年的临床实践认为：大剂量蝉蜕治疗此病，不但能迅速消除症状，而且有缩短病程，减少复发的作用。^[9]

10. 郑强诊治经验

郑氏认为本病属于中医“斑”、“疹”、“衄血”等范畴，

以阳证、热证为多，当然也有虚寒之类，但从临床来看，不论何种类型多存在一个共同点，即血瘀。因此在治疗上除清热凉血外，适当运用活血化瘀药能防止血不循经而进一步加重出血。故重用连翘治疗过敏性紫癜，全方组成如下：连翘 30~60g，紫草、生地、乌梅、白芍各 15g，防风、甘草各 12g，陈皮 9g。临床加减：痒甚加蝉衣、白鲜皮各 12g；关节痛加木瓜 15g，桑枝 12g；腹痛加玄胡 12g；腰痛加桑寄生 15g；尿血加小蓟 12g，白茅根 30g；阴虚内热加地骨皮 9g，女贞子 15g；紫斑重者加红花 12g，赤芍 15g；气虚加黄芪、牡蛎各 30g。方中连翘轻清芬芳，其性升浮，郁结火热，因而扬之、越之；结者散之，流通气血，治十二经血凝气聚。重用之既能消血热，又能散血结，从而收退热消斑之功，据实验研究报道，连翘含有丰富的维生素 p，能增强毛细血管的致密性，对毛细血管破裂出血、皮下出血有防治作用。紫草能凉血解毒，透发斑疹；生地凉血止血；乌梅配白芍酸甘化阴以泄热；防风祛风止痒；陈皮理气；甘草善解诸毒并调和诸药。全方共奏清血热、化瘀滞、消紫斑之功。^[10]

11. 丘根祥等诊治经验

丘氏等在临床上收治 18 例紫癜性肾炎患儿，通过研究认为，其临床表现与发病机理，集中体现于“虚”、“毒”、“瘀”三者之中。患儿体质素虚，或血虚（包括肝肾阴虚），或气虚（包括脾肾阳虚），致邪毒从外入侵，或由内而生；邪毒蕴留体内，则致气血瘀滞，气血瘀滞的结果加重了本虚。因而三者互为因果，环环相扣，恶性循环。针对上述病因，丘氏采用补虚解毒化瘀方法，断其环、解其扣。基本方如下：生黄芪、党参、生地、赤芍、当归、黄芪、白

花蛇舌草、大小蓟、丹参、茜草根。若阴虚加女贞子、旱莲草；阳虚加补骨脂、菟丝子；脾虚加苍白术、茯苓；血热重加丹参、白茅根；兼有感冒加防风、忍冬藤。方中黄芪、党参、生地、当归等益气养血，可以提高机体免疫能力，调节免疫状态；黄芩、白花蛇舌草等清热解毒，一则预防感染，消除诱发因素，二则抑制免疫反应，起到免疫抑制剂作用；赤芍、丹参、茜草根、大小蓟等活血、凉血、化瘀，能够改善微循环，对抗血小板凝聚，起到抗凝剂作用。^[11]

12. 章惠陵诊治经验

在辨证用药的基础上，加用大剂量紫草（15~30g）治疗过敏性紫癜、过敏性紫癜肾炎均取得良好疗效。紫草性味苦寒，有清热解毒、凉血止血之功效。据现代医学研究，紫草中的紫草素能抑制毛细血管通透性的亢进，亦能抑制局部水肿，表明紫草对炎症急性渗出期的血管通透性亢进、渗出和水肿及增殖期炎症均有拮抗作用，与紫草凉血止血作用相符。紫草煎剂能增强小肠的紧张性，或使其收缩，此作用可能与紫草滑肠的功效有关。另一方面紫草素可缓解胃肠道平滑肌的痉挛疼痛，因而常用于腹痛、呕吐、便血等消化道症状，在临床上未发现不良反应，且能缩短疗程，降低复发率。^[12]

13. 孔昭遇等诊治经验

（1）对皮肤紫癜的辨治：认为本病除热毒外，还夹有风邪。因此必须在清热凉血方中加入具有抗过敏作用的祛风药，如蝉衣、防风、白蒺藜、白鲜皮、地肤子等，才能提高疗效，缩短病程。

(2) 对关节损害的辨治：过敏性紫癜的关节损害多见于膝、踝等处，亦可累及多关节，局部肿胀疼痛，虽多无红热现象，但结合舌、脉等全身症状，其病机仍属风、热、湿、瘀交阻经络，导致络脉失畅，不通则痛。常于方中加入秦艽、威灵仙、忍冬藤等药，以祛风清热，胜湿通络。本病的关节症状一般较轻，经上法治疗后，大多短期内即可消失。

(3) 对消化道出血的辨治：过敏性紫癜引起的消化道出血，其原因不外有三：火盛迫血妄行，气虚藏统失司，瘀阻之血不循经。因此，亦应遵循塞流、澄源、复旧的三大原则进行治疗。每遇发生消化道出血时，先予 10% 白及胶浆以塞流止血，配合复合汤药澄源治本，佐以小量参三七以活血化瘀。由于本病存在“瘀阻经络”的病理，因此治疗时不能忽视活血化瘀，因为“瘀血不去，血不归经”，可以导致反复出血；“瘀血阻滞，不通则痛”，又可反复发生腹痛、关节疼痛。但在具体配方中，又必须处理好止血与活血之间的辩证关系，要寓行血于止血之中，使血止而瘀祛，既有利于止血，又有助于止痛，不宜单用活血化瘀药，以免加重出血。至于活血化瘀药的选择，当以凉血化瘀药及化瘀止血药为宜。如生地、丹皮、赤芍、参三七等。

(4) 对肾脏损害的辨治：肾脏损害是过敏性紫癜中最难恢复的，它与其他肾炎的不同处，关键仍在于“风、热、瘀”三字，根据不同的证候，临床可分为 4 型：

① 风热夹瘀型：症见皮肤紫癜，斑色鲜红，多如锦纹，略觉瘙痒，肉眼血尿或显微镜血尿，常伴腹痛便血，关节疼痛，舌质红，苔薄黄，脉浮数。治宜祛风凉血，化瘀止血。常用药物如蝉衣、白蒺藜、地肤子、生地、丹皮、赤

芍、连翘、大小蓟、甘草等。腹痛加白芍、延胡索；便血加大黄炭、地榆炭，或另服10%白及胶浆20~30ml，1日3次；关节肿痛加秦艽、威灵仙。

②风湿热夹瘀型：症状同上而舌苔黄腻且厚，脉象滑数。可于风热夹瘀方中加黄芩、黄柏、赤茯苓、泽泻等清利之品。

③肾虚血热型：皮肤紫癜已消，或虽出亦轻如蚊迹，但尿液变化仍明显，有较严重的蛋白尿、肉眼血尿或显微镜血尿，常伴面肢浮肿，高血压，舌质红，苔薄黄，脉细数。治宜补肾凉血。常用药物如生地、丹皮、山茱萸、女贞子、旱莲草、山药、茯苓、地肤子、大小蓟、阿胶、仙鹤草等。若紫癜尚未完全消退，仍需酌加蝉衣、白蒺藜等祛风之品；尿蛋白多而兼有气虚者，加黄芪、党参。④脾肾两虚型：大多病情迁延，紫癜虽消，但面色㿠白，腰酸尿少，全身浮肿，尿常规可见大量蛋白尿、红细胞及管型。常伴有不同程度的肾功能损害、胆固醇增高、血浆蛋白降低、舌淡胖、苔薄白、脉沉细。治宜补肾健脾。常用药物如黄芪、党参、生地、山茱萸、续断、杜仲、仙灵脾、桑寄生、金樱子、阿胶、地肤子、泽泻等。^[13]

【按语】

总结上述医家的经验，主要反应在如下两方面：

(1) 辨证论治：黄俊玉在应用泻脾胃伏火、清除湿热，兼散风热，凉血止血基础方的基础上，分皮肤型、关节型、胃肠型和肾型进行治疗；钟一棠则分血热型、肺热型、胃肠型、肾热型辨证辨治；余菊英、吴康衡、王庆显等均从血瘀证论治小儿过敏性紫癜，王氏主方以桃核承气汤加味，

破血下瘀，使湿热毒邪由胃肠而解。李少川、詹起荪等讨论了治疗该病时应注意的相关问题，如：清热凉血，勿忘宣气透营；宣风祛湿，注意凉血润燥；久病致虚，宜健运，忌壅补；滋阴益肾，兼顾调理脾肺；宣畅湿热，兼以清透等。李明道则强调本病之发生与气血虚衰有关，治疗以益气养血为主，参以凉血解毒或活血止血之剂。邱根祥认为本病的临床表现与发病机理，集中体现于“虚”、“毒”、“瘀”三者之中，因而采用补虚解毒化瘀方法，由生黄芪、党参、生地、赤芍、当归、黄芪、白花蛇舌草、大小蓟、丹参、茜根组成基本方。孔昭遐等对本病发展过程中的几个关键问题进行了探讨，如皮肤紫癜、关节损害、消化道出血、肾脏损害，使治疗更具针对性。

(2) 单味药的应用：在辨证论治基础上，很多医家擅长运用自己长期临床实践摸索出来的单味药，可以大大提高疗效。如张祥福善用大剂量的蝉蜕（15～20g），郑强重用连翘（30～60g），章惠陵加用大剂量的紫草（15～30g），这点对临床颇具启发。

（陶晓华 张 林 贾鹰珏）

参 考 文 献

- [1] 王振海. 黄俊玉从脾肺论治小儿过敏性紫癜的经验. 河南中医, 1994, 14 (5): 284~286
- [2] 李少川. 小儿过敏性紫癜证治体验. 吉林中医药, 1994, (3): 2~3
- [3] 余菊英. 活血化瘀法治疗过敏性紫癜 49 例. 江苏中医, 1993, (7): 7~8
- [4] 盛丽先. 詹起荪治疗复发性过敏性紫癜经验. 四川中医, 1993, (8): 16
- [5] 王明如. 钟一棠老中医对过敏性紫癜的辨证施治. 浙江中医学

- 院学报, 1981, (2): 29~30
- [6] 张新渝. 吴康衡治疗过敏性紫癜的经验. 中医杂志, 1996, 37 (12): 721~722
- [7] 李明道. 补益气血为主治疗 70 例过敏性紫癜. 黑龙江中医药, 1993, (1): 11~12
- [8] 王庆显, 董秋燕, 刘作芳, 等. 从血瘀证治论治小儿过敏性紫癜 100 例. 中医杂志, 1993, (8): 499
- [9] 张祥福. 蝉蜕治疗急性肾炎、过敏性紫癜. 中医杂志, 1994, 35 (7): 389~390
- [10] 郑强. 重用连翘治疗过敏性紫癜 30 例. 陕西中医, 1994, 15 (6): 250
- [11] 丘根祥, 顾明达. 补虚解毒化瘀法治疗小儿紫癜性肾炎 18 例. 上海中医药杂志, 1994, (2): 26~27
- [12] 章惠陵. 紫草治疗过敏性紫癜肾炎. 中医杂志, 1996, 37 (3): 133
- [13] 孔昭遐、田孔伟. 过敏性紫癜 103 例辨治体会. 中医杂志, 1995, 36 (1): 37

肩关节周围炎

【概述】

肩关节周围炎，简称肩周炎，是肩周肌肉、肌腱、滑囊和关节囊等软组织退行性改变所引起的广泛性炎症。本病是以肩关节疼痛、活动受限为主要特征的慢性疾患，好发于40岁以上的中老年人。女性多于男性，左侧较右侧多见，双侧同时发病者少见。早期表现，仅以疼痛为主，或仅有轻微隐痛，或肩关节不适和束缚感；继则疼痛逐渐加重，夜间尤甚，常影响睡眠，肩关节活动也逐渐完全受限，最后形成“冻结状态”。

一般认为本病的发生与下列因素有关：①肩关节周围软组织的慢性磨损或创伤，特别是在已发生肩关节退行性变的情况下；②肩关节的创伤可引起肩关节渗出、出血、疼痛及肌肉痉挛；③肩关节活动减少及过久的不适当的制动等引起的肩关节蜕变；④肩外因素，如颈椎病、冠心病等也能引起肩部发生疼痛和肌肉痉挛，患者因之减少肩部活动，从而引起肩周炎。另外，精神心理因素、肩部受寒、体内有感染灶及内分泌紊乱等，都可诱发病。

本病的主要病位是肩部纤维关节囊。早期，因某种原因导致纤维关节囊的非特异性炎性改变，并引起轻度的退行性变，关节囊挛缩，关节下隐窝闭塞，关节腔容量减少，肱二头肌腱长头与关节囊粘连，并逐渐加重。后期，肩关

节周围软组织大多受累，胶原纤维变硬变粗，结缔组织失去弹性发生纤维化并挛缩，使肱骨头上移，限制了其各向运动，滑囊增厚闭塞，肩关节及周围软组织相互粘连。

本病在中医学属“痹证”范围，又称为五十肩、漏肩风、肩凝症、冻结肩等。

【名医诊治经验】

1. 余泽文诊治经验

肩周炎初期，炎性变是其主要病理表现，其特点是以肩关节疼痛为主，范围较广泛，甚则可向臂部放散，日轻夜重，肩关节周围无肿胀，或稍有肿胀，活动时有关节性疼痛，湿热瘀阻是这期的主要病机，余氏常重用甘寒的白茅根和葛根以清热凉血，活血利湿。《本草纲目》记载：白茅根偏入血分，清热凉血止血，善治血热妄行之证。葛根升阳解表，善除项背强痛。现代药理显示：葛根能缓解肌肉痉挛，扩张血管，降低阻力，增加动脉血流量，对改变肩关节周围血液循环，促进炎症吸收，其效果是较显著的。

病程在2个月以上的患者，肩关节周围组织粘连是主要的病理变化。其特点是肩关节疼痛较局限，肩关节前屈、后伸、外展、抬举等功能都有不同程度受限，这与中医学“痛久入络”相近。遵循“通则不痛”的法则，增加补气活血祛瘀药物如黄芪、当归、桃仁、三七等，以及全蝎、蜈蚣、白花蛇、乌梢蛇等虫蛇类搜风通络走窜之品，对缓解组织粘连和促进瘀血吸收，减少疼痛，恢复肩关节功能活动是极其关键的。

病程超过半年以上的患者，局部组织变性是其主要的

病理变化。主要表现在肩关节僵硬，活动功能严重受限，触痛范围较广泛，且有明显的肌肉萎缩。气血虚弱、肝肾不足、瘀血凝滞是这期的重要病机。补气益血、滋肾养肝、搜风通络之药如黄芪、当归、川杜仲、怀牛膝、何首乌、枸杞子、蜈蚣、全蝎、白花蛇等都是必用之药。除此之外，药物敷洗也是十分重要的措施之一。桂枝、豆豉、羌活、桑枝、大黄、黑老虎、银花藤、桃仁、没药等具有温经散寒、舒筋活络、活血消瘀止痛之功。^[1]

2. 林林等诊治经验

(1) 致病以寒邪为主：肩凝症的突出症状是局部疼痛剧烈，这主要与寒邪的作用有关，经云“寒气盛者为痛痹”，因寒邪其性收引凝滞，易使经络气血凝滞不通，故疼痛剧烈，清·高士宗云：“寒气胜者，阴盛阳虚，故为痛痹。”

(2) 发病以阳气内虚者多见：《素问·痹论》中，曾强调人体的体质因素与发病有着重要的关系，认为素体阳气衰弱，是导致痛痹发生或促使病情加重的重要内在原因。经云“其寒者，阳气少，阴气多，与病相益，故寒也。”日人丹波元简也曾说：“邪入阳经，致手足厥而寒冷，则真阳衰弱可知。”可见肩凝证的发生与素体阳虚有密切关系。素体阳虚是肩凝证的发病基础。另外，从临床实际来看，肩凝证的发生，常发生于中老年人，这同样也是有一定病理生理学根据的。经云女子“六七，三阳脉衰于上，……七七，任脉虚，太冲脉衰少”，男子“六八，阳气衰于上，……七八，肝气衰，筋不能动”，“年四十而阴气自半也”。人到中年之后就会出现一系列的衰老征象，表现出机体生理功能逐渐衰退，阳衰血弱日趋明显。阳气虚衰，则

肌表疏而不固；阴血亏虚，则筋脉失于濡养。这样便给肩凝症的发生提供了可能性，使寒邪易于乘虚侵袭，伏于经络血脉，发于肩凝之症。

(3) 病位与厥阴肝经有关：肩凝症病变部位在筋膜层次，且与厥阴肝经阳气的盛衰至为相关。《内经》认为：“肝主身之筋膜”，肩臂乃筋膜聚集之处，因此寒邪入于厥阴肝经，阴胜则阳病，阳衰不能温其筋膜，故肩臂冷痛，厥寒过于肘膝，阳气不能外达肢末，故四肢厥冷。同时，“肝为藏血之脏”，病入厥阴，久之未有不伤血分者。从整体来看，肝经以阴为体，以阳气为用，亦即肝主筋膜，体阴而用阳，肝经阳衰血少，经膜失养，故牵引掣痛，活动受限。总之，肩凝症的发生，既与年龄有关，更与素体阳虚血弱有联系。寒邪的侵袭是致病因素，素体阳虚血弱是发病基础，而病变所在则以肝经及其所主筋膜为主。

(4) 选方用药：根据肩凝症的病理特点和当归四逆汤的作用机制，结合个人临证体会，确立下列基本方药：当归 10g，桂枝 10g，芍药 10g，细辛 6g，炙甘草 6g，制附片 10g，黄芪 15g，山萸肉 15g，通草 6g，大枣 15 枚。^[2]

3. 张和平诊治经验

中医学认为，本病的发生，由年老体虚，气血不足，肝肾亏损，复感风寒湿邪；或跌打闪挫，瘀血内阻，引起筋脉失养，经络阻滞，气血不和所致。作者经过多年的临床实践体会到本病的主要原因在于脾胃失调。盖脾主肌肉、主四肢，为气血生化之源，阳明主宗筋，宗筋主束骨而利关节者也，脾虚则化源不足，气血亏虚；脾失健运，则水湿内停，聚而生痰，阻滞经络；脾胃虚弱则风寒湿邪乘虚客于阳明、太阴之筋脉，导致筋脉拘急关节不利。治则当调

理脾胃，益气养血，兼以祛风散寒除湿。方用自拟调中解凝酒。组成：黄芪 10g，炒白术 10g，川木瓜 9g，陈皮 9g，青皮 6g，广木香 6g，龙眼肉 15g，丁香 6g，白蔻仁 6g，茯苓 6g，当归 10g，川芎 9g，白芍 6g，秦艽 8g，羌活 5g，川牛膝 9g，白冰糖 180g，白酒 500ml。上药为粗末，浸渍于白酒中，夏天 5 日，冬天 10 日，滤出去渣，取上清液备用。服法：每次 10ml，每日 2 次，饭后温服，15 天为 1 疗程，一般 2~3 个疗程可痊愈。

方中黄芪、白术、茯苓健脾益气；陈皮调中化痰，理气健脾，东垣赞曰：“欲调气健脾者，橘皮之功居其首焉”。青皮散结消痰，广木香行气止痛、温中和胃；川木瓜和胃去湿舒筋，《本草再新》云其有“活血通络”之功；龙眼肉补气血、益脾胃；丁香、白蔻仁温中散寒，《医林纂要》谓丁香有“去中寒，散风湿”之用；当归、白芍、川芎、川牛膝活血补血，通络止痛；秦艽、羌活祛风湿、利关节，《珍珠囊》曰“秦艽，去阳明经风湿痹”；白酒通血脉、厚肠胃、养脾气、行药势、散湿气；冰糖《本草再新》谓其“补中益气，和胃化痰”。全方共奏调补脾胃、活血养血、散寒祛湿化痰之功。药虽平淡无奇，用量甚微，但能切中病机，疗效确切。^[3]

4. 高礼作诊治经验

高氏将肩周炎分为风寒型、虚寒型、外伤型。风寒型用麻黄、桂枝、细辛、白芷、桃仁、红花、赤芍、甘草；虚寒型药用黄芪、白芍、桂枝、香附、五加皮、蔓荆子、当归、党参、川芎、甘草；外伤型药用三棱、莪术、赤芍、海桐皮、羌活、白术、沉香。外用麻黄 12g，归尾、透骨草、羌活、木瓜、独活各 10g，附子、干姜、桂枝各 10g，

红花、防风、白芷各 15g，共为细末，蒸或炒热敷患处。治疗 215 例肩周炎病人，总有效率达 91.6%。^[4]

5. 陈家宽诊治经验

陈氏将肩周炎分为阳虚寒凝、湿热阻络、气血瘀滞三型。对阳虚寒凝者用附片 10g，桂枝 15g，干姜、防风、羌活、姜黄、川芎、当归、白芍各 12g，黄芪 40g，蜈蚣 2 条。湿热阻络者用银花、桑枝、秦艽各 30g，苡仁 24g，防己、地龙、姜黄、苍术、黄芩各 12g，丹参 18g，鸡血藤 15g；气血瘀滞者用归尾、鸡血藤、续断各 15g，川芎、赤芍、红花、没药、乌药、桂枝各 12g，丹参、伸筋草各 30g 等，取得了良好效果。^[5]

【按语】

中医药是目前治疗肩关节周围炎的主要方法。余泽文对该病分初期、病程在 2 个月以上、病程超过半年以上等阶段，通过分析各期的病理特点，制定出相应的治疗方法：初期重在湿热瘀阻，常用白茅根和葛根；中期重在“痛久入络”，常用补气活血祛瘀药物；晚期重在气血虚弱、肝肾不足、瘀血凝滞，常用补气益血、滋肾养肝、搜风通络之法。林林等分析了该病的病因、病机、病位和选方用药。张和平认为本病当以调理脾胃为主，因为脾主肌肉、四肢，为气血生化之源，阳明主宗筋，宗筋主束骨而利关节。脾虚则化源不足，气血亏虚；脾失健运，则水湿内停，聚而生痰，阻滞经络；脾胃虚弱则风寒湿邪乘虚客于阳明太阴之筋脉，导致筋脉拘急关节不利。因而自制调中解凝酒，有较好疗效。高作礼、陈家宽均从辨证论治方面来探讨本

病的治疗, 所分类型对临床有一定参考价值。

(陶晓华 王 琦)

参 考 文 献

- [1] 余泽文. 肩周炎治疗经验点滴. 河南中医, 1998, 18 (3): 144
- [2] 林林, 林夏. 肩凝症中医治疗探讨. 实用中西医结合杂志, 1998, 11 (1): 64~65
- [3] 张和平. 肩周炎当以调理脾胃为治. 河南中医, 1998, 18 (3): 143
- [4] 高礼作. 治疗肩关节周围炎 215 例总结. 国医论坛, 1988, (4): 33
- [5] 陈家宽. 肩周炎同病异治举隅. 北京中医, 1986, (5): 30

颈 椎 病

【概述】

颈椎关节综合征（简称颈椎病），是由于颈椎间盘退行性变性、周围骨质、小关节及软组织发生一系列病理改变，压迫或刺激颈神经根、脊髓、椎动脉等组织而产生的一组临床综合病症。本病大多为多发，同时累及2个以上椎间盘，以颈_{5~6}椎间盘为最多见，颈_{6~7}及颈_{4~5}次之。因受累部位不同，受压迫组织及压迫程度各异，临床表现也不尽相同，常见眩晕、猝倒、颈肩疼痛、上肢麻木、肌肉无力、萎缩、汗出异常、步履蹒跚，甚至四肢瘫痪等，中老年人为多见。

本病的发病机制大多认为与颈部慢性长期反复劳损（如反复落枕、姿势不良等），头、颈部外伤（颈椎或椎间盘损伤），颈椎或颈椎间盘慢性退行性变、炎症（尤其是咽喉部炎症）及畸形等诸多因素有关。

本病起病缓慢。由于病变部位的不同，临床症状及体征变化多端。为便于诊断，一般将其分为颈型（局部型）、神经根型、交感神经型、椎动脉型、脊髓型、混合型等几种类型。

颈椎病一名，中医学无记载，但据其临床表现可归属中医学“眩晕”、“痹证”、“偏瘫”等范畴。以“痹证”为多见，多因外感风寒湿邪伤及经络，或长期劳损，肝肾亏

虚，或痰瘀交阻，气滞血瘀等原因引起。清·沈金鳌《杂病源流犀烛》：“凡颈项强痛，肝肾膀胱病也，三经受风寒湿邪。”

【名医诊治经验】

1. 张贤慈诊治经验

神经根型颈椎病是中老年人的常见病、多发病。其病因主要是由于颈椎间盘突出、颈椎增生、胸椎关节和后关节蜕变及其附近软组织的病变，从而刺激、压迫脊神经根，引起颈部感觉异常，运动功能障碍等综合症的病变。张氏采用中药内服，疏通经络，活血化瘀止痛，（方药：羌活 15g，独活 15g，桑寄生 20g，当归 15g，黄芪 15g，防风 15g，丹参 15g，川芎 15g，桃仁 12g，红花 12g，乳没药各 10g，甘草 10g。颈项强痛加葛根 30g，玄胡索 12g；手指麻木者加秦艽 10g，全蝎末内服。上方日 1 剂，水煎服。）配以牵引及推拿手法，可改善病变部位肌肉、血管的痉挛，扩大椎间隙及椎间孔，缓解受压的神经根，促进颈部血液循环，使病变部位的组织粘连及肿胀消除。加入穴位注射药物，既有经络针刺的效果，又有药物的相互作用，从而增强了中药及手法之功效，促使局部组织修复，物理性炎症吸收。此综合疗法效果佳，病人无痛苦。^[1]

2. 陆晓东诊治经验

生葛根配大川芎，专疗颈椎病眩晕。生葛根甘润偏凉，有升散、退热、生津之功；大川芎辛温走窜，上升巅顶，下行血海，通行十二经脉，具有活血行气、开郁调肝、燥

湿搜风之力。两药一温一凉，一燥一润，相反相成，并力上行，主治颈椎病。椎基底动脉供血不足、脑动脉供血不足等病引起的项背抽掣酸痛、眩晕欲仆、头晕而痛、两上肢麻木疼痛、肩背疼痛且转侧不利，疗效卓著。^[2]

3. 张军等诊治经验

根据本病发病的早、中、晚三期的不同症状可概括为痹阻型、血瘀型和肝肾亏虚型。

(1) 痹阻型：由于感受风寒，劳倦内伤及颈椎退行性变等原因，造成机体抵抗力下降，风寒湿邪可乘虚而入，往往首先侵入太阳，导致营卫失和。此时多为本病的早期，以风寒湿外邪侵犯的表证为主，是治疗的有利时机。本型包括风寒痹阻和寒湿痹阻。风寒痹阻又分为实证和虚证。实证者可见患肢窜痛及麻木，以痛为主，颈部活动受限，僵硬怕风畏寒，喜温喜热，苔薄白，脉多弦紧，治以祛风散寒，通络止痛。方药用葛根汤、桂枝加附子汤、蠲痹汤及阳和汤加减（葛根、桂枝、麻黄、白芍、细辛、干姜、防风、羌活、附子）。虚证者可见上肢麻木、疼痛，以麻为主，怕冷，四肢不温，疲乏无力，舌胖大，苔薄白，脉弦细无力。治以温阳益气通络。方药可用桂枝加葛根汤、加減木瓜汤（木瓜、黄芪、白芍、羌活、独活、桑枝、徐长卿、川断、牛膝、桂枝、五加皮、甘草）。寒湿痹阻者可见上肢沉重无力或疼痛、麻木，手指屈伸不利，伴有头沉、胸闷、纳呆等，舌质暗、舌体胖大有齿痕，脉沉迟或弦滑，治宜散寒祛湿通络。方药可用羌活胜湿汤、地龙汤加减（地龙、羌活、独活、麻黄、桃仁、当归、肉桂、苏木）。从治疗痹阻型的用药可看出，本病早期病邪侵犯营卫，所以用药以祛风散寒，温经通络为主，多应用羌活、独活、

桂枝、姜黄、附子等药。现代药理学证明，羌活中所含有的挥发油具有较明显的抗炎、镇痛作用。桂枝可以促进血液循环，提高大脑感受中枢痛阈，起到镇痛解痉作用。此外，温里散寒药如吴茱萸、附子等均具有明显的镇痛作用。从而说明祛除风寒湿邪在神经根型颈椎病的早期治疗尤为重要。

(2) 血瘀型：主要由于外伤导致脉络破损，血液瘀滞，或由于病程日久，外邪留滞经脉，也可见于久病体虚或脾胃虚弱，气血不足，血行无力，以致气血滞留脉中所酿成。本型与痹阻型的不同之处在于外邪的表现较轻，而气血瘀滞的证候较重。多见于神经根型颈椎病的中期，病人多有典型的阳性体征和 X 线改变。根据临床表现可分为实证和虚证。实证者可见头、颈、肩、背以及上肢疼痛、麻木，其痛多为针刺样痛，痛有定处，拒按，夜间加重，舌质紫暗，或有瘀斑，脉弦有力。治以活血化瘀，理气止痛。方药可用血府逐瘀汤、通窍活血汤、身痛逐瘀汤、桃红四物汤合失笑散、颈椎 2 号（葛根、没药、桃仁、红花、白芍、甘草）、颈复汤（当归、葛根、赤芍、川芎、红花、桃仁、丹参、白芍等）、骨赘冲剂（血竭、三七、威灵仙、白花蛇等）。虚证者可见指端麻木，手部肌肉萎缩，指甲凹陷无光泽，皮肤枯散发痒，头晕眼花，面色不华，惊惕不安，脉弦细，或细涩。治以养血活血，舒筋通络。方药可用补阳还五汤、葛根二藤汤（葛根、钩藤、鸡血藤）。

(3) 肝肾亏虚型：在以上两型病变的基础上，由于病程的迁延，精血的耗伤，可以导致“骨痹不已，复感于邪，内舍于肾；筋痹不已，复感于邪，内舍于肝”的情况。本阶段神经根型颈椎病主要以筋骨为患，肝主筋，肾主骨，因而肝肾受累最著，成了典型的本虚标实证。症状可见患

肢麻木疼痛，腰膝酸软，头晕眼花，耳鸣，失眠多梦，舌体瘦，舌质红绛，少苔或无苔，脉弦细，或细数。治以滋水涵木，调和气血。方药可用二仙汤、芍药甘草汤、颈痛灵（人参、鹿茸、熟地、黑芝麻、黄芪、枸杞子、葛根等）、颈愈汤（黄芪、仙茅、鹿角胶、淫羊藿、白芍等）、填髓丹（熟地、人参、杜仲、鹿角胶、桑寄生、当归等 20 余味中药组成）。培补肝肾是治疗重点。^[3]

4. 江东友诊治经验

颈椎病属中医痹证范畴，其病机主要为气血不足，或肝肾虚损，邪气易趁虚而入，致使外邪痹阻，或痰湿阻络，或气滞血瘀，“不通则痛”。正如《诸病源候论·风痹候》说：“痹者，风寒湿之气杂至而成痹，其状肌肉顽厚，或疼痛，或人体虚，腠理开，故受风邪也。”故对其治含有两个方面：一是扶其正，补其气血、肝肾之虚；二是祛其邪，使气血畅通。具体运用时采用中药或疏邪通痹，或燥湿化痰，或活血化瘀，或补益气血，或调补肝肾等辨证施治，固本祛邪。且这些治法中多以活血化瘀为主，或配有活血化瘀药起到改善血液循环，促进局部炎性水肿的吸收作用。加以针刺主穴夹脊、大椎、肩井、肩髃，均有利气通络，主治肩臂疼痛之功。再经进一步推拿按摩调和气血，能起到解除因疼痛或施行局部治疗所带来的局部肌肉紧张，达到理筋调气的作用。^[4]

5. 王大经诊治经验

颈椎病是由于颈部骨质增生压迫相应神经，引起上肢的麻木、胀痛为主症的病证。麻木是指肌肤知觉减弱或消失，不知痛痒。此类麻木多属气虚血滞，若麻木伴有胀痛，

多为气郁血滞。气为血帅，血为气母，气行则血行，气虚或气郁均可引起血滞，气血郁滞，填塞经络，营阴失养，卫气失温故见上肢麻木、疼痛。王氏认为临床鉴别要分清虚实之证，虚证麻木伴有患肢软弱无力，揉按则舒；实证麻木患肢伴有疼痛郁胀，按之不舒，此为两者辨证要点。治疗上遵循“虚者补之”，“实者泻之”的原则，补法以补气血为主，泻法有祛风、散寒、行滞、活血、化痰等法，至于虚实夹杂证，则当辨别孰轻孰重，权衡缓急，辨证施治。^[5]

6. 周林宽等诊治经验

脊髓型颈椎病因颈椎蜕变或颈椎间盘膨出所致椎管内容积减少，脊髓受压而出现一系列症状。病位在脊髓，脊髓的生理功能与肾、脾两脏有密切关系。脊髓型颈椎病属中医“痉”、“痿”、“痹”等证范畴。临床上或实或虚，或虚实夹杂，实证以痉证为多，表现为肌肉拘挛失用；其病在肝，属瘀血、痰湿所致。虚证以痿证为多，表现为肌肉痿软无力；病在脾、肾，属气虚肾亏所致，外伤则血溢脉外，离经之血阻滞经络；久劳则气虚，“气为血帅”，气行则血行，气虚则血脉失和，筋脉失养，气血不能充达肌肤。脾失健运，水湿不化，湿着于肉则卫气不荣，肌肉顽痹；肾精不足，骨枯髓虚，足不任身。此外，气血失和，筋脉失养，腠理空虚，风寒湿邪乘虚而入，合而为痹。总之，脊髓型颈椎病的病机为“荣气虚，卫气实”之故。

临床常分三型辨证施治：气虚瘀阻以补阳还五汤加减，痰湿阻滞以平胃散加味，肝肾亏虚以六味地黄汤合左归饮加减。并强调以益气、养阴、祛瘀、利湿为治疗大法。常选用生黄芪、太子参等益气；生地、熟地、玉竹、山茱萸、

石斛、桑椹子、龟甲胶等养阴；丹参、当归、川芎、红花、桃仁等祛瘀；苍术、白术、茯苓、薏苡仁等健脾利湿，并依体质或兼证加减。湿热加知母、黄柏、焦栀子等；痰浊加半夏、陈皮、白芥子等；阳虚加桂枝、细辛、巴戟天、鹿角胶、淫羊藿等；血虚加制首乌、鸡血藤、白芍、当归等；项强加葛根；头晕加珍珠母或石决明；腰腿酸软加千年健、怀牛膝、制狗脊、木瓜、杜仲等；麻木甚加地龙、僵蚕、全蝎、蜈蚣、白花蛇或蕲蛇等。^[6]

7. 陈迈群等诊治经验

根据颈椎病的临床表现和病情发展，将颈椎病分为三型：痹证型，以羌活胜湿汤加减；眩晕型，以补中益气汤加减；痿证型，以独活寄生汤加减。并与现代医学临床分型结合起来：早期痹证型，即颈神经根型；中期眩晕型，即椎动脉型；后期痿证型，即脊髓型。

由于痹证型和痿证型的病因病机基本一致，即两者均因外伤、劳损、风寒湿侵袭等外因的影响，导致局部气血运行不畅，经脉阻滞，影响局部的微循环，使局部充血、水肿、粘连，使神经系统受压而发病，临床表现两者均以疼痛为特征，故两者均可以运用祛风散寒、活血通络法治疗。不同之处在于，前者为颈神经根受压，发病多在人体的上部，即在头、颈、肩背及上肢；后者为脊髓受压，兼有气血肝肾亏损，发病多在人体下部，即在腰及下肢。痹证型及痿证型分别运用羌活胜湿汤及独活寄生汤加减，两方均有祛风散寒，活血通络之功效，但前方主治其病在上，后方主治其病在下，并兼补气血，益肝肾，故疗效较为满意。方中羌活、独活、防风、细辛、川乌、附片祛风除湿，温经散寒，能改善微循环，消除炎症；蜈蚣、全蝎、乌梢

蛇、白花蛇等虫类药物搜风解痉，消除疼痛；黄芪、党参、白术、当归、白芍培补气血，能增强人体的免疫功能，促使疾病早日康复。处方配伍精当，能使骨质增生由痛性转化为非痛性，抑制骨质增生进一步生长，从而达到治疗目的。眩晕型因气血亏虚，脑失所养，或聚湿生痰，上蒙清窍，使椎动脉受压，此时，大多病人血压偏低，故临床表现以眩晕、呕吐为特征，治宜益气升阳，和中降逆为法，处方运用蒲辅周治眩晕一方，本方具有上述功效，经多年临床运用，疗效显著。^[7]

8. 王必舜诊治经验

王氏将颈椎病分为四型：

(1) 寒湿痹阻型：主证：颈项僵硬，活动受限，头颈肩背寒痛，痛有定处，得温痛减，两颞及眉棱恶风挛痛，肢体沉重，手指麻木，胸闷纳呆，舌苔白，脉沉迟。本型包括西医诊断神经根型颈椎病，颈肩综合征。

(2) 气滞血瘀型：主证：头颈肩背疼痛，枕部刺痛，痛处固定不移，指端麻木，甲床色紫，指甲凹陷，胸闷心悸，情绪不畅，喜叹息，女子月经不调，经行头痛，项强症状加重，多有外伤劳损病史，舌色暗，或有瘀斑，脉弦细，或涩。本型包括西医交感型、混合型颈椎病。

(3) 痰瘀交阻型：主证：头颈肩肘疼痛麻木，眩晕目昏，耳聋耳鸣，恶心呕吐，甚则头颈不能转侧，转侧昏仆跌倒。颈项部可触及核块、条索，压痛明显，或喉间痰核，咳之不出，吞之不下，舌体胖大，脉象滑数。该型包括西医的颈动脉型、混合型颈椎病。

(4) 肝肾亏虚型：主证：年事偏高，头枕部闷痛，颈项牵强，鱼际肌肉萎缩，舌僵语謇，肢体沉重，步态蹒跚，

二便失禁，卧床不起，舌淡脉细。包括西医诊断脊髓型、交感神经型颈椎病。

治疗原则：颈椎病本虚标实，治疗宜标本兼治，治标以通为主，重在通络止痛，治本防重于治，去除病因，预防劳损，纠正看书、写字、睡觉姿势，预防外感。药物治疗主要通经络、补气血、祛瘀血、除痰湿、益肝肾。

基本方用颈椎方：葛根、鸡血藤、首乌藤、桂枝、片姜黄、川芎、丹参、赤芍、蜈蚣。加减：寒湿痹阻型加细辛、制川乌、白芷、淫羊藿；气滞血瘀型加柴胡、枳壳、当归；痰湿交阻型加半夏、天麻、白术、白芥子；肝肾亏虚型加山药、山茱萸、熟地、菟丝子；痛甚加威灵仙、白芍、甘草、细辛；麻甚加生芪、当归、全蝎；晕甚加石决明、草决明、生龙牡；呕吐加制半夏、生姜、竹茹；头摇手抖加僵藤、僵蚕、地龙；纳呆者加石菖蒲、鸡内金。^[8]

【按语】

颈椎病发病机制不同，临床表现各异，治疗方法多样，中医药是常用的治疗手段之一。张贤慈采用疏通经络，活血化瘀止痛汤药，配以牵引、推拿手法及穴位注射药物，取得了较好的效果，这种综合方法也是多数医家所提倡的，因为单一疗法难以从根本上去除病因。陆晓东用生葛根配大川芎治疗颈椎病眩晕有独特效果。

张军等根据本病发病的早、中、晚三期不同的病因和证候将本病分为痹阻型、血瘀型和肝肾亏虚型，并依据这一特点来处方用药；周林宽等则将本病分为气虚瘀阻型、痰湿阻滞型和肝肾亏虚型；陈迈群等则将中医分型和现代医学临床分型结合起来，即早期痹证型相当于颈神经根型，

中期眩晕型相当于椎动脉型,后期痿证型相当于脊髓型,这为中西医结合治疗本病提供了方便。王必舜分为寒湿痹阻型、气滞血瘀型、痰瘀交阻型和肝肾亏虚型。这些分型方法强调了虚实两个方面的情况,临床应分析病情的标本缓急来辨证施治才能获得较好的疗效。

(陶晓华 张 林 贾鹰珏)

参 考 文 献

- [1] 张贤慈. 综合治疗神经根型颈椎病的疗效观察. 按摩与导引, 1997, (1): 5
- [2] 陆晓东. 巧用药对起沉痾. 浙江中医杂志, 1987, 32 (7): 310
- [3] 张军, 易金根, 孙树椿. 中药治疗神经根型颈椎病概况. 中医杂志, 1997, 38 (7): 435~437
- [4] 江东友. 中医治疗颈椎病 127 例临床观察. 按摩与导引, 1997, (4): 18~19
- [5] 韩洪. 王大经主任医师治疗痹证经验. 中医教育, 1997, (3): 40
- [6] 周林宽, 章明. 脊髓型颈椎病的辨证论治. 浙江中医学院学报, 1997, 21 (2): 13
- [7] 陈迈群, 罗秀福. 辨证分型治疗颈椎病 58 例总结. 湖南中医杂志, 1997, 13 (2): 13
- [8] 时吉萍. 王必舜教授治疗颈椎病的经验. 甘肃中医学院学报, 1998, 15 (4): 3

雷诺综合征

【概述】

雷诺综合征是血管神经功能紊乱所引起的肢端小动脉痉挛性疾病，其致病原因目前尚未完全明确，临床表现特点为阵发性四肢肢端（主要是手指）对称的间歇发白、紫绀和潮红。常为情绪激动或受寒冷所诱发。本病属少见病，多发生于女性，尤其是神经过敏者。男女之比约为 1 : 10。发病年龄多在 20~30 岁之间。在寒冷季节发病较重。少数呈家族性发病。

根据指、趾动脉的病变状况，本病可分为梗阻型和痉挛型两大组。病变初期，指、趾动脉无显著病理变化。后期可见动脉内膜增生、弹力膜断裂和肌层增厚等变化，小动脉管腔狭小，血流减少，少数患者最后可有血栓形成，管腔闭塞，伴有局部组织的营养性改变，严重者可发生指、趾端溃疡，偶有坏死。

本病的病因未完全明确，可能与中枢神经系统功能失调、血循环中肾上腺素和去甲肾上腺素含量增高有关；可能与免疫和结缔组织病，如：系统性红斑狼疮、硬皮病、结节性多动脉炎、皮炎、混合性结缔组织病、乙型肝炎抗原所致的血管炎、药物所致的血管炎等有关；还有可能与影响神经血管机制的因素及内分泌或遗传等有关，因为观察到病情常在月经期加重。

中医学虽无“雷诺综合征”病名，依其临床表现，似属四肢厥冷、脉痹等证的范畴。汉代张仲景《伤寒杂病论》中有相似记载：“手足厥冷，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。”《诸病源候论·虚劳四肢逆冷候》曰：“经脉所行皆起于手足，虚劳则血气衰损，不能温其四肢，故四肢逆冷也。”清代《医宗金鉴》进一步论述：“脉痹，脉中血不和而色变也。”等与本病颇多相似。

【名医诊治经验】

1. 孙金昌等诊治经验

温经散寒、益气活血祛瘀为本病的治疗原则，方以当归四逆汤加味：黄芪、丹参、当归、桂枝、白芍、细辛、炙甘草、通草、大枣、鸡血藤、川芎。寒胜加干姜、附子；湿胜者加防己、苍白术。每日1剂。外治法：艾叶、川椒、红花等水煎趁热熏洗、浸浴，每日2~3次，每次30~40分钟。

方以当归、黄芪补气生血，合芍药补其血虚；桂枝温经散寒，与细辛合用而除内外之寒；寒胜者用姜、附加强温经散寒止痛；用益气健脾之大枣、甘草助当归、黄芪补血，助桂枝通阳；借通草除血脉之湿滞；以丹参、川芎、鸡血藤祛血滞；寒胜者用姜、附加强温经散寒止痛；湿重者用防己、苍术祛湿通络。用艾叶、川椒、红花共煎汤局部熏洗、浸浴，借其温热之力，使热气内注，温煦气血，透达经络以温中、逐冷、除湿、化瘀、通络止痛。外治法通过蒸汽和药液对局部熏洗、浸浴可刺激神经和血管，引起皮肤和患部的血管扩张，促进局部和全身血液和淋巴

循环，能起到增强疏通经络、调和气血、祛风除湿、温经散寒、消肿止痛、祛瘀生新等协同作用。总之，内外并治能使局部营养状况和全身机能得到迅速改善，可明显提高疗效缩短疗程。^[1]

2. 路立然等诊治经验

其辨证论治分为三型。

(1) 阴寒型：肢端发凉，轻则麻木，重则疼痛，喜暖怕凉，遇冷则皮肤苍白、青紫，继而潮红，得暖后症状缓解。舌质淡，舌体胖，边有齿痕，苔薄白，脉沉细迟。治以温经散寒，活血通脉，解痉通络。

方药：细辛 3g，桂枝 15g，葛根 20g，白芍 20g，甘草 15g，当归 30g，丹参 20g，全蝎 10g，蜈蚣 3 条，地龙 15g，乌梢蛇 15g，川芎 20g。每日 1 剂，水煎服。方中细辛、桂枝温经散寒；当归、丹参、川芎活血养血通脉；全蝎、乌梢蛇、蜈蚣、地龙、葛根解痉通络；芍药与甘草能缓急止痛。大凡虚寒之人肌表受寒后多拘急，其中葛根、桂枝、白芍、甘草为桂枝汤加味，可解肌透表，调和营卫，使温经散寒之功更彰。

(2) 血瘀型：遇冷肢端苍白、青紫、潮红、疼痛，情绪激动时症状加重，呈持续性，患部轻度肿胀，舌苔薄白，舌质暗，或有瘀斑，脉弦细而涩。治以疏肝解痉，活血通脉。

方药：柴胡 10g，丹参 30g，当归 30g，川芎 20g，桃仁 15g，红花 15g，葛根 20g，桂枝 15g，白芍 20g，甘草 15g，细辛 3g，蜈蚣 3 条，乌梢蛇 15g，全蝎 10g。日 1 剂，水煎服。方中柴胡疏肝解郁，芍药、甘草和血柔肝、缓急止痛；蜈蚣、乌梢蛇、全蝎入肝经，有祛风通络止痛之效；

当归、丹参、川芎、桃仁、红花活血祛瘀，通脉止痛；葛根、桂枝、细辛温经散寒，共奏疏肝解痉，活血通脉之功。

(3) 血热型：患病日久，发作频繁而持续时间较长，肢端肿胀，皮色常呈青紫，怕凉而患部有热感。溃疡或坏疽，疼痛剧烈。苔黄，或黄腻，舌质偏红，脉数，或滑数。治宜清热养阴，活血化瘀，解痉通络。

方药：银花 30g，玄参 20g，当归 30g，甘草 15g，葛根 20g，地龙 15g，白芍 20g，丹参 30g，赤芍 30g，川芎 30g，全蝎 10g，蜈蚣 3 条，乌梢蛇 15g。日 1 剂，水煎服。^[2]

3. 颜德馨诊治经验

雷诺病为周围血管病的一种，其治疗可参颜氏对周围血管病的治疗。

(1) 活血化瘀法：症见局部肿胀、刺痛，皮肤红斑、结节、紫绀，舌暗，脉涩等。颜氏认为气血乃构成人体的基本物质，气血流通无所不至，故“血脉流通，病不得生”，特别是“脉者，血之府”，故血管病表现为血瘀最为常见。虽然其临床表现不一，且其瘀阻血脉，隧道不通之机理则一，用活血化瘀，异病同治，常用红花、桃仁、赤芍、川芎、当归、丹参、郁金、水蛭、生菖蒲、川牛膝等。

(2) 温经散寒法：用于肢体寒冷发紫，疼痛剧烈，舌淡脉细，或脉搏难以触及之属寒凝型。颜氏认为，仲景用通脉四逆汤治阴证厥逆，脉沉微细欲绝，取其伸发阳气，化凝复脉，可以效法。临床以阳和汤和麻黄附子细辛汤加减，药用麻黄、附子、桂枝、细辛、毛冬青、白芥子、当归、川芎、红花等，本法温经散寒，回阳通脉，扩张血管，具有改善肢体血液循环作用，若与补气养血等法配合，灵

活运用,效果更佳。

(3) 扶正祛邪:用于身体虚弱,肌肉萎缩,或疾病恢复期,正气耗伤型。颜氏认为,凡见此症,因气血方虚,血行不畅,艰涩成瘀,因虚而瘀,因瘀而虚,相为因果,久病难复,故须补益与祛邪并进。如正气虚弱,热毒炽盛,当以补气与清热同用。若病情稳定阶段,多以补益气血与活血化瘀兼顾,以防复发,临床常用黄芪桂枝五物汤、补阳还五汤、桃红四物汤加减。

(4) 软坚散结法:用于患肢结节、硬索状物,肿胀疼痛,或肢体麻木、发冷疼痛属痰瘀交阻型。常用药物如夏枯草、牡蛎、玄参、海藻、昆布等,与化痰药如瓜蒌、贝母、海浮石,或予活血药当归、莪术、红花同用。若病情顽固难愈则用虫类搜剔,如水蛭、虻虫、全蝎、地龙等以加强疗效。^[3]

4. 王吉民等诊治经验

雷诺病与中医学所描述的“血痹”、“手足厥冷”等症相似。原因为体虚腠理不固,心脾肝肾功能失调,复因风寒湿邪侵袭,或情志不遂等致使脉络闭阻,气血运行不畅。《素问·痹论》云:“在于脉则血凝而不流。”成无己说:“手足厥寒者,阳气外虚,不温四末,脉细欲绝者,阴血内弱,脉行不和。”心气虚,心阳不足,推动气血运行的动力缺乏,使本病治疗与康复过程延长。本病治疗以黄芪、当归、党参、丹参、红花、附子、肉桂、蜈蚣为基本方。以附子、肉桂温心阳,散寒通脉,黄芪、党参益气以行血,当归、丹参、红花补血活血祛瘀安神,蜈蚣通络止痛。分型论治:

(1) 气虚型:双手皮色苍白,逐渐变紫红色、变冷,

麻木刺痛，气短乏力，心悸心慌，神疲肢倦，舌质淡，苔薄白，脉细弱。证属心气虚，气血运行不畅，阳气不达四末。治以益气养心，活血通络。基本方加赤芍、大枣、桃仁、柏子仁。心悸气短重者，再加薤白、太子参，重用党参；手指发凉甚者，重用附子，再加干姜，以桂枝易肉桂。

(2) 气血两虚型：手足发凉，皮色青紫，面色苍白，气短，神疲肢倦乏力，心悸怔忡，失眠健忘，多梦，舌质淡，脉细弱无力。证属气血亏虚，经脉失养，心气不足。治以补益气血，养血安神。基本方加白术、茯苓、白芍、川芎、甘草。心悸怔忡重者再加磁石、夜交藤；指端青紫加丹皮、丹参、地龙、鸡血藤。

(3) 血瘀型：手指皮色紫暗，皮温低，疼痛呈针刺样，寒冷刺激后更甚，胸前区隐痛，或刺痛，入夜更甚，心悸，憋闷感，舌质有瘀点，脉弦涩，或结代。证属瘀血阻络，心血闭阻。治以活血化瘀通络。基本方加牛膝、川芎、柴胡、赤芍。疼痛较重者加土鳖虫、三棱、莪术、玄胡；胸前区痛较重者加瓜蒌、薤白、半夏、丹参、降香；脉结代症状明显者加炙甘草、干姜、寸冬、阿胶、枣仁，以温阳复脉，养血安神。

(4) 寒凝血痹型：手足冷，怕冷较重，皮色苍白，或青紫，保暖后缓解，舌质淡，舌苔白，脉迟缓。证属寒凝血瘀阳气不通。气血不畅。治以温经散寒，活血通络。基本方加细辛、赤芍、木通。经脉拘急者加全蝎、地龙；寒甚者加干姜，重用附桂。

(5) 湿热型：病程较久，指端疼痛、肿胀，头晕，心烦、心悸，舌苔薄黄，脉数。证属寒凝血瘀，郁久化热，湿热蕴结。治以清热活血化瘀。基本方去党参、附桂，加玄参、金银花、连翘；有面赤、急躁、头眩、脉弦数等肝

阳上亢症状者加柴胡、钩藤、僵蚕、牡蛎；心悸加朱砂、合欢花、寸冬。

本病也可用外治法：①气温低季节注意保温，并可用温灸器或汗热垫。②熏洗法：用桂枝、红花、吴萸、艾叶、川椒、桃仁，水煎，浸浴双手。③针灸，理疗。^[4]

5. 牛志册诊治经验

近年来研究发现雷诺综合征患者血清有抗原抗体免疫复合体存在，它作用于交感神经终板，引起血管痉挛变化，导致肢端对称性发凉、麻木、肤色改变。本病属中医的“痹症”、“厥证”范围，根据病因及症状特点，临床上总结出两个辨治要点：①因患者平素肝气怯弱，暴受寒冷，阳微阴阻，肢端失去温和，故而手足发凉。寒邪客于脉内，血涩不行，筋爪失养则青紫、麻木、刺痛。其病机为肝虚受寒，阳气痹阻，当以补肝调气，柔肝养血治之。②因七情失调，肝失调达所致。肝主疏泄，调理一身气机，肝气抑郁，阳气阻遏，血行不畅，肢端失去温煦濡养，则厥冷，瘀血久留于脉络则肌肤甲错，手足青紫，其病机为肝郁气滞，瘀血留络，当以疏肝化瘀治之。经云：“肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泄之”，柴胡疏肝散辛酸苦甘并用，临床上如根据不同病证变通单味药的用量，则能起补肝、柔肝、疏肝、活血不同功效。治疗肝虚受寒证则柴胡用量宜少，以引经达病所。川芎、香附辛香性温，用量在20g以上则温通血脉，活血通阳功卓。若症状严重则加黄芪、牛大力、桂枝辛甘补肝通阳，临床每获捷效。治疗气滞血瘀证，大剂量柴胡、川芎、香附内服，则能较快和顺气血，减除血管痉挛。方中加入炒枣仁，配玄胡、夜交藤对稳定情绪，调节自主神经作用较好。瘀血久留，手足青

紫持续不消，病情顽固，属瘀血重证，临证加入地龙、蝉衣、土元，通络化瘀收效佳。方中如大剂量用川芎、香附等辛温之品，白芍用量必须和其相等或更大，使行气不耗血，养血不滞气，则肝血得养，阳气得长，阳通瘀化，其厥自除。在药物治疗的同时，应重视心理治疗，设法解除患者的精神因素，同时还要避免暴触寒冷，注意保暖，以病防变。

所划分的三个证型为：

(1) 肝虚寒痹证：遇冷肢端呈对称性皮肤苍白、青紫、潮红，伴发凉、麻木、刺痛，遇温暖症状消失。患肢沉困乏力，不耐劳，体怠怕冷，疲倦懒动，舌淡暗，体胖，苔白，脉沉细，或沉涩。治则：补肝调营，温经通络。方药：柴胡 6g，白芍 30g，黄芪 60g，牛大力 60g，川芎 30g，醋香附 30g，枳壳 15g，桂枝 20g，甘草 12g，豆豉姜 30g。水煎 3 次，前两次内服，第 3 次浸泡肢端，每日 2 次，每次 30 分钟。

(2) 气滞血瘀证：遇情绪不畅肢端呈对称性皮色改变，伴肢端发凉、麻木、抽疼。胸胁胀痛，或满闷，全身走窜痛，失眠，易怒，善太息，脉沉弦，舌暗红，苔白。治则：疏肝解郁，化瘀通络。方药：内服柴胡 20g，白芍 40g，川芎 30g，醋香附 30g，两头尖 15g，两面针 20g，夜交藤 60g，羌活 15g，炒枣仁 30g，甘草 12g。若患病日久，瘀血久留，肢端呈对称性青紫，持续不退，指甲脆裂，皮肤光薄易破，舌暗，有瘀点，苔白，脉沉弦，或沉细，上方加蝉衣、地龙、土元。

(3) 肝郁化热证：患肢端紫暗胀痛，红肿瘀斑，指端出现小溃疡，舌暗红，苔白黄，脉沉弦而数。治则：清肝活血，解毒通络。内服方药：柴胡 15g，赤芍 25g，白芍 30g，川芎 9g，醋香附 9g，丹皮 12g，忍冬藤 30g，地龙 30g，蝉衣 30g，蒲公英

英 30g, 川楝子 15g, 了哥王 15g, 甘草 10g, 枳壳 15g。^[5]

6. 王瑞凤诊治经验:

本病初期时仅用当归四逆汤连续服用即可奏效, 能明显地缓解血管痉挛, 改变皮肤苍白、四肢厥冷之症状。如出现晚期症状, 且血栓形成, 进而出现阴疽之时, 又当使用当归四逆汤加阳和汤以增强温阳补血, 宣通血脉之力, 犹如离照当空, 化阴凝而使阳和, 则阴疽自愈。如出现下肢厥冷, 剧烈疼痛, 患处色紫赤, 尚未破溃, 脉细涩者又可以当归四逆汤去细辛合芪附汤、四妙勇安汤进行治疗。雷诺病的四肢厥冷多属于寒厥, 但不同于四逆汤的亡阳急证, 而是由于平素血虚, 阳气不足, 又感受外寒以致气血运行不利, 不能温养四末出现的手足厥寒。正如成无己云: “手足厥寒者, 阳气外虚, 不温四末, 脉息欲绝者, 阴血内弱, 脉行不利, 与此汤复阳生阴”。故此时不宜纯用辛热之剂, 而当用温经散寒, 养血通脉之法, 而当归四逆汤正是从此处着眼, 故用于雷诺病收效颇佳。^[6]

7. 李得俭等诊治经验

数年来李氏等采用辨证分型治疗雷诺病共 42 例, 效果显著, 兹小结如下: 患者均表现为与冷水接触、遇寒冷或情绪变动时发作, 手指肤色变白, 继而紫绀, 从指尖开始, 逐渐波及手指, 甚则至手掌。伴有局部冷、麻、针刺样疼痛或其它异常感觉, 脉搏一般正常。本病发作数分钟后症状自行消失, 皮肤转为潮红, 然后转为正常肤色。治疗方法: 根据病因和症状的不同, 本病可分为四型分别论治。

(1) 气滞阳郁型: 症见情绪激动时发作, 手指肤色变白, 继而发紫, 并有冷、麻、胀、痛, 精神紧张或情绪不

安时病情加重，善太息，腕闷胁胀，或月经不畅，少腹胀刺而痛，苔薄白，脉弦。本型乃由肝郁气滞，阳气内郁，血行不畅而致。治拟通阳达郁，理气活血。方选逍遥散加减：当归、白芍、茯苓、白术、薄荷、生姜、甘草、红花、桂枝、制乳香、鸡血藤。若精神紧张，情绪不宁，善太息，腕闷胁胀甚者，加附子、枳实、郁金；行经不畅，少腹胀而刺痛者，加桃仁、延胡索。

(2) 气虚寒凝型：症见每因劳累后发病，两指苍白，继而变紫，伴疼痛、麻木、发冷，倦怠乏力，休息后减轻。此为气虚血弱，血行不畅，肢末失养所致。治拟益气通阳，和营化瘀。方选黄芪桂枝五物汤加味：黄芪、桂枝、赤芍、当归、川芎、鸡血藤、生姜。

(3) 血虚寒凝型：症见手指疼痛、麻木，遇冷加重，得温则减。甚则持续发作，皮肤萎缩或增厚，指甲呈纵向弯曲畸形，指尖溃疡可向指甲下扩展，伴有剧烈疼痛。此为血虚感寒，气血凝滞，四肢失其温养所致。治拟养血散寒，温经化瘀。方选当归四逆汤加味：当归、桂枝、白芍、细辛、甘草、通草、大枣。

(4) 阳虚寒凝型：症见手指冷痛，指趾先变白，后紫黑，虽置于热水中而疼痛不减，痛如针刺，麻木不仁。甚则指端溃烂，持续剧痛。此为阳虚阴盛，阴阳之气不相顺接所致。治拟温阳散寒，通经化瘀。方用温经回阳通瘀汤加减：桂枝、当归、赤芍、白芍、熟地、炮姜、鹿茸、牛膝、党参、附片、红花、细辛、甘草。^[7]

【按语】

雷诺病是一种肢端末梢动脉痉挛性疾病，与中医之

“寒痹”、“血痹”、“四肢厥逆”相似，临床常有报道。在积古今对本病认识的基础上，利用中医药内服或外洗都取得了很好的疗效。其病因主要为寒、虚、瘀、痹，基本病机为：阳虚寒凝，气滞血凝，经脉痹阻，气血不能通达四末、营养经脉四肢。其临床典型症状为受凉或情绪失调，或受寒冷刺激，手指足趾变苍白，继而青紫、紫绀，转暖后变成潮红，伴冷、麻、针刺样疼痛。治疗以温经散寒，益气活血通络为主。孙金昌等根据本病之内因脏腑功能失调，外因寒湿侵袭，采用整体与局部相结合，内服当归四逆汤加减，外用红花、川芎、艾叶等熏洗、浸浴的方法取得良好疗效。另外，王吉民等也提出了这类的内服外用结合的方法。可见此法对本病的治疗确有重要作用，不失为一种临床值得重视的疗法。路立然等则认为本病是由体虚卫外不固，心脾肝肾功能失调，复加寒湿侵袭，或情志不遂等使脉络闭阻，气血运行不畅而诱发，分为阴寒型、血瘀型、血热型论治。颜德馨对该病的治疗贯穿了其治疗周围血管病的经验，即注重活血祛瘀、温经散寒、扶正祛邪和软坚散结等方法，分别适应于该病的各个不同的阶段。牛志册则根据本病的病因及症状特点，平素肝气虚弱，暴受寒冷所致者和因七情失调，肝失调达所致者，并以柴胡疏肝散化裁治疗。王瑞凤认为本病手足厥寒不同于四逆汤之亡阳急症，而是由于平素血虚，阳气不足，又感受外寒以致气血运行不利，不能温养四末而出现四肢厥寒，以当归四逆汤为主治疗颇佳。众医家从各自角度提出了自己对本病的认识，为我们临床治疗本病提供了很好的借鉴和启发作用。

(陶晓华 邬洪波)

参考文献

- [1] 孙金昌, 赵长兰, 邓森, 等. 中药内外并用治疗雷诺氏病. 四川中医, 1989, (2): 28
- [2] 路立然, 周春和, 史凤娥. 治疗雷诺氏病 713 例. 河北中医, 1989, (5): 27
- [3] 吕立言. 颜德馨教授治疗周围血管病经验简介. 新中医, 1994, (7): 12~13
- [4] 王吉民, 顾淑媛. 雷诺氏病合并心血管病变时的辨证施治. 实用中西医结合杂志, 1993, (3): 144~145
- [5] 牛志册. 柴胡疏肝汤治疗雷诺氏综合征 31 例疗效观察. 实用中西医结合杂志, 1993, (7): 421~422
- [6] 王瑞凤. 当归四逆汤治疗雷诺氏病. 云南中医杂志, 1990, (5): 30
- [7] 李得俭, 田友谊, 秦子和, 等. 辨证治疗雷诺氏病 42 例. 浙江中医杂志, 1990, (6): 254

方剂(药)篇

类风湿性关节炎

一、风寒湿邪，侵及经络

1. 类风湿汤（史鸿涛）

组成：黄芪 20g，秦艽 20g，防己 15g，红花 15g，桃仁 15g，青风藤 20g，海风藤 20g，地龙 15g，桂枝 15g，牛膝 15g，山甲珠 15g，白芷 15g，白鲜皮 15g，甘草 15g。

方解：方中秦艽，一药多能。治疗痹证，风寒湿热，皆可应用，并且病发无问新久，病情无问轻重，均可用之，实为治疗痹证的要药。防己善除风寒湿邪，长于消肿。二药相配，迺除风湿肿痛病变。青风藤、海风藤取藤之通络之功，通利经络，为治疗关节不利、麻木拘挛之要药。四药合用，驱风散寒，除湿清热，舒筋活络，解麻止痛，为治疗类风湿之要药。痹者，“闭也”。气血经络，闭阻无疑，故桃仁、红花为必用之品；桂枝辛温，温经通阳；地龙咸寒，又善走窜，四药合用，通痹止痛，化瘀活络。更兼地龙为血肉有情之品，对顽固性痹证尤为适宜。白芷能清热

解毒止痛，白鲜皮能清热燥湿除痒，二药合用，专治热痹之痒痛不适。黄芪补一身之气，卫外而行内；牛膝善通经活血，补肝肾，强筋骨；甲珠破坚通闭，其力甚强；甘草调合诸药而缓急止痛。四药配伍，鼓舞正气，强筋健骨，调达气血，合取纠正关节变形之功。

加减：此方随症加减，以改动方中药物用量为主，或将药物稍事变更。热盛为主，可加漏芦 30g，漏芦清热而不伤阴；以寒为主者，可加制附子 10g，增强散寒止痛之力；顽痹正虚、关节变形者，可加当归 20g，制附子 10g，伸筋草 15g，并改甲珠 30g，加强温补穿透之力。^[1]

2. 痹苦乃停（娄多峰）

组成：制川、草乌各 100g，制乳香、没药各 150g，制马钱子 50g，怀生地 200g，薏苡仁 100g。

功能：祛风除湿，舒筋通络，活血化瘀，消肿定痛（偏于温通化阳）。

主治：类风湿性关节炎。^[2]

3. 痹隆清安（娄多峰）

组成：草薢 200g，怀生地 200g，制马钱子 50g，制乳香、没药各 150g，薏苡仁 100g。

功能：祛风除湿，舒筋通络，活血化瘀，消肿定痛（偏于清利湿热）。

主治：类风湿性关节炎。^[3]

4. 温阳蠲痹汤（梁剑波）

组成：熟地、黄芪、浙贝母各 30g，白芥子、鹿角胶各 12g，肉桂面（冲）0.9g，当归、制川乌各 6g，姜炭、

麻黄、甘草各 3g，乳香、没药各 5g。

用法：每剂水煎 2 次，早晚温服。

主治：类风湿性关节炎（风寒型）。

方解：此方由李东垣的当归补血汤合《外科证治全生集》的阳和汤加川乌、乳香、没药、浙贝母组成。方中熟地、当归大补气血；黄芪、鹿角胶补益阳气，强筋壮骨；姜炭温中散寒，肉桂入营温通血脉；麻黄达卫散寒，协同姜、桂使气血宣通；川乌、乳香、没药活血镇痛，行瘀消肿；浙贝祛痰散结；甘草协和诸药，合而成之。

加减：如局部剧痛，经久不愈，或见关节肿大变形者加姜黄 10g。^[4]

5. 通痹止痛汤（张学文）

组成：制川乌（先煎）、制草乌（先煎）、羌活、独活、制乳香、桂枝各 3g，地龙、木瓜、当归、川芎、台乌药、海藻各 12g，全蝎 3g。

功效：温经通痹，舒筋止痛。

主治：寒湿偏盛之痛痹证。症见肢体关节疼痛甚剧，屈伸不利，痛处固定不移，每遇寒湿则痛重，痛处触之发凉，反复发作难愈者。苔薄白，脉弦紧或沉涩。

方解：方中主用川乌、草乌温经散寒止痛；用羌活、独活祛风除湿；地龙、全蝎、木瓜以舒筋活络，祛风止痛；配桂枝以增强二乌温经散寒之力，佐台乌药以助诸药温经顺气，伍海藻以协助当归、川芎、乳香消散痰瘀。全方共奏温经通痹，舒筋止痛之功。

加减：疼痛剧烈者，加没药 6g，三七粉 3g（冲服），白芷 8g，以增强舒筋活血止痛之效；寒盛肢体发冷者，加制附子（先煎）6g，以温阳通脉；遇风痛重者，加细辛

3g，威灵仙 10g，以加强祛风通痹止痛之功；寒凝血滞，关节冷痛，皮色青紫者，重用当归、川芎、羌活、独活，加白芷 8g，松节、丹参各 15g，姜黄 10g，以增强温经活血通痹之力；证情顽固者，可酌加虫类药，以搜剔脉络之寒湿瘀毒，如乌梢蛇 9~15g，地龙 6~9g，蜈蚣 1~3g。可加适量蜂蜜，一则缓解乌头类毒，二则调和药苦之味，如宿有咳喘或便秘更为适合。^[3]

6. 温痹汤（夏度衡等）

组成：桂枝 6~12g，麻黄 3~6g，附子 6~12g，白芍 10~25g，知母 12g，防风 12g，白术 15g，黄芪 10~30g，熟地 15g，生姜 15g，炙甘草 6~10g。

用法：水煎服，日 1 剂。

分型加减法：

风寒湿型：关节晨僵肿痛，屈伸不利，或轻度变形，疼痛如掣，局部发冷，畏寒喜温，阴天或遇寒肿痛加剧，日轻夜重，舌淡红或有齿痕，苔薄白，或白腻，脉弦紧，或弦缓，治用温痹汤。

寒热夹杂型：关节肿痛，变形僵硬，屈伸不利，或形寒肢冷而部分关节肿痛灼热，或全身低热，口干汗出而部分关节冷痛，遇寒加剧，或部分关节肿痛灼热，得凉则舒，部分关节肿胀冷痛，遇冷加剧，形成寒热交错的状态，舌质稍红，或边夹有红点，苔微黄，或燥，脉弦细，或细数。治宜温痹汤，加重知母用量，加黄柏 10g 以养阴清热。

瘀凝血瘀型：关节畸形肿胀，不能屈伸，疼痛悠缓，或木重不仁，身体羸瘦，四肢不温，肌肉萎缩，腰脊酸痛，月经衍期，或量少色淡，小便清长，舌质淡，或暗淡，或见瘀斑，苔薄白，脉弦涩，或弦细。治以温痹汤，加制南

星6~10g以消痰，当归尾、赤芍各10g活血。

随症加减法：关节冷痛明显，单个关节痛甚，痛处不移者，加制川乌6g；若周身关节痛甚者，去附片、防风，加制草乌6g，鸡血藤30g以搜风散寒止痛；关节疼痛走窜剧烈者，去防风，加羌活10g，威灵仙12g以祛风散寒止痛；痰湿重、关节肿大者，以苍术10g易白术，加苡仁30g，制南星6~10g以健脾化湿，祛痰消肿；气血亏虚明显者，加重熟地、黄芪用量，并加当归、川芎各10g以益气补血；肾虚明显者，重用熟地，加巴戟天10g以补肾壮阳；久服本方口干咽燥者，去乌、附，加淫羊藿10g，石楠藤30g，千年健15g以养阳通痹。^[6]

7. 通络熄风汤（欧阳琦）

组成：桑枝、忍冬藤、白芍、草薢、秦艽、归尾、蚕沙、豨莶草、苡米、甘草。

主治：类风湿性关节炎。

加减：兼恶风寒、无汗身痛者，加苏叶、防风；关节肿大，屈伸不利者，加松节、竹节；小指关节肿大僵硬者，加僵蚕、蜈蚣、白花蛇；手足心热、关节肿胀热痛者，加生地、丹皮；心悸短气、自汗恶风者，加丹参、炙远志、黄芪。^[7]

二、湿热阻络，毒邪炽盛

1. 养阴清热祛湿汤（风湿1号）（王为兰）

组成：半枝莲、草河车、白花蛇舌草、白鲜皮、土茯苓、防己、生甘草等。

用法：上药制成风湿1号浓缩液，每次50ml，日服2

次, 3 个月为 1 疗程。

加减: 湿热型用风湿 1 号; 湿热下注型用风湿 1 号加苍术、黄柏; 湿热兼气虚型用风湿 1 号加太子参、枸杞子、生黄芪。^[8]

2. 清热利湿解毒汤 (宋绍亮)

组成: 金银花 30g, 蒲公英 24g, 紫花地丁 18g, 白花蛇舌草 30g, 土茯苓 30g, 土贝母 12g, 苍术 12g, 黄柏 12g, 薏苡仁 24g, 赤芍 21g, 羌活 9g。

用法: 水煎服, 每日 1 剂, 服药忌茶。

加减: 热毒炽盛, 关节红、肿、热、痛, 伴发热者, 重用金银花、蒲公英、紫花地丁、土贝母; 病情反复发作, 关节肿胀、灼热、晨僵、胶着感明显者, 重用土茯苓、白花蛇舌草、薏苡仁、黄柏; 阴虚低热不退, 舌红少津, 脉细数者, 加生地 30~60g, 牡丹皮 12~18g; 关节肿胀、积液明显者, 加车前草 15~30g。^[9]

3. 三土汤 (李学增)

组成: 土茯苓、土贝母、土三七、金银花、蒲公英、生薏苡仁、赤芍、川芎、王不留行、生地、补骨脂、全蝎、蜈蚣等。

用法: 每日 1 剂, 水煎分 3 次口服。

加减: 关节红、肿、热、痛, 或伴全身发热加紫花地丁; 关节肿痛而无灼热感加川乌、草乌; 关节肿胀明显或有积液加车前草; 关节肿大变形, 或见皮下结节加穿山甲。

临床与实验证实, 三土汤能有效地控制或改善活动性类风湿性关节炎的关节肿痛, 降低血沉, 能显著减轻大鼠非特异性与变态反应性关节炎, 说明三土汤具有可靠的

抗炎效果；三土汤还可使45%左右患者的类风湿因子转阴，并可降低SRBC免疫后小鼠的溶血素反应，也表明三土汤对异常的体液免疫反应有一定的抑制作用。^[10]

三、痰瘀凝滞，筋脉痹阻

1. 加减痛风方（汪履秋）

组成：生麻黄 10g，川桂枝 10g，制苍术 10g，熟附片 10g，防风 10g，防己 10g，威灵仙 10g，制南星 10g，桃仁 10g，红花 10g，鸡血藤 15g，全蝎 5g，露蜂房 15g，雷公藤 15g。

用法：水煎，每日1剂，每剂煎服2次，首次煎煮时间不少于45分钟。

功能：祛风宣湿，化痰消瘀。

主治：风湿顽痹。症见手指、足趾关节肿胀疼痛，甚则强硬变形，张口不利，或伴四肢关节肿痛，舌淡、苔薄微腻，脉象弦细带涩。

方解：风湿顽痹主要属于西医学的“类风湿性关节炎”，古代亦称为“历节风”、“痛风”、“尪痹”。本病的主要病因是外感风寒湿邪，病久邪气痹阻络脉，气血津液运行受阻，或因久痹正虚，推动无力，气血津液迟涩，则可形成痰浊与瘀血。因此，风湿痰瘀痹阻络脉实乃本病之病理关键。针对这一病理特点。治疗则应采取祛风、利湿、化痰、消瘀的方法。朱丹溪“上中下通用痛风方”融此四法为一炉，对本病甚为合拍。汪氏以该方为基础，结合临床经验，自拟加减痛风方。方中麻黄发散风寒，苍术苦温燥湿，附子温经散寒，防风祛风胜湿；桂枝祛在上之风，防己除在下之湿；威灵仙通行十二经脉，祛风通络，南星

化痰燥湿，桃仁、红花活血消瘀，鸡血藤活血又养血，兼制它药温燥太过；全蝎、露蜂房搜风剔络，雷公藤祛风解毒。综观全方，君臣佐使，配合得当，既能散风邪于上，又能渗湿邪于下，还可散寒通络，化痰消瘀。

加减：寒邪偏盛者加用川乌、草乌等大辛大热之品以祛内在之沉寒痼冷；热邪偏盛者加石膏、知母、虎杖等寒凉之味以清络中之热；风盛游走加白芷、羌活；湿盛漫肿加苡仁、大腹皮；肢体肿而且胀者加入枳壳、川朴等理气宣痹；久痹正虚者加归芪或地黄之类以补气血、养肝肾。此外，还应根据病变部位配合引经药，如上肢重用桂枝，加片姜黄；下肢加木瓜、川牛膝、钻地风；周身关节疼痛加千年健、伸筋草、络石藤。^[11]

2. 蠲痹舒络冲剂（朱良春）

组成：炙全蝎 3～6 分（研冲），炙蜈蚣 3～6 分（研冲），炙虻螂虫一钱五分，炙蜂房一钱五分，炙廕虫一钱半，炙蕲蛇一钱半，鹿衔草 3 钱，伸筋草 3 钱，寻骨风 3 钱，炙狗骨 1 两（代虎胫骨 1 钱），钻地风 3 钱。全当归 3 钱，甘草 1 钱半。

用法：上药煎汁内服，每日 1 剂。连服 5 日后，改为丸剂常服，可以除根。（丸剂按上方加十倍量研细，用鸡血藤五两、老鹳草六两、苍耳子六两，煎取浓汁泛丸如梧桐子大，每服三钱，一日二或三次，则效更速。）^[12]

3. 麝香丸（钱远铭）

组成：全蝎、山甲珠、乌梢蛇、蜈蚣、地龙、丹参、川牛膝各 60g，麝香 1g。

用法：上药各研为细末，再和匀，炼蜜为丸如梧子大。

每服 10 粒，日 3 次。

主治：类风湿性关节炎。^[13]

4. 痹七方（张琪）

组成：蕲蛇、当归各 20g，蜈蚣 2 条，全蝎、地鳖虫各 5g，穿山甲 7.5g，仙灵脾 15g，熟地 25g，白芍 25g，秦艽 15g。

主治：类风湿关节炎，关节肿痛，变形僵直，手指足趾关节呈梭形，疼痛如锥刺，严重者功能丧失，几成残疾，肢体消瘦，肌肉萎缩，皮肤干燥等。^[14]

5. 风湿灵片（聂志伟、陈治水、郭黎明、李枫）

组成：雷公藤、黄芪、鹿角胶、秦艽、附子、细辛、蜂房、鸡血藤等。

用法：每次服 4 片，每日 3 次，饭前服用，30 天为 1 疗程，连服 2~3 个疗程，治疗期间停用其它治疗药物。

方解：本方以具有抗炎、镇痛和免疫抑制作用的雷公藤为主，配合用黄芪健脾益气，鹿角胶补血益精、壮骨生髓，增强细胞免疫和免疫调节作用。秦艽祛风除湿、和血舒筋，附子温阳散寒、通痹，细辛祛风止痛，三者合用，配合雷公藤增强抗炎、止痛功能。陈皮、砂仁理气调中，以减少雷公藤的毒副作用。临床治疗结果表明，风湿灵片具有较明显的免疫抑制和免疫调节作用，其非特异性抗炎作用、镇痛作用以及改善受累关节功能等作用均明显优于布洛芬。本品疗效显著，复发率低，毒副作用小，使用安全，具有重要临床意义和推广应用价值。^[15]

6. 漏痹饮（李炯）

组成：制川乌 18g，制附子 12g，麻黄 6g，黄芪 30g，

苍术、细辛各 10g，苡仁、桂枝、仙灵脾、威灵仙、制南星、地鳖虫、虎杖各 15g。

用法：配用雷公藤片，每次 40mg，每日 3 次。

加减：风甚者，加羌独活、防风、秦艽；湿甚者，加防己、萆薢、泽泻、蚕沙；肿甚者，加木通、茯苓、皂角刺；寒甚者，加肉桂、干姜、草乌；化热者，加石膏、知母、寒水石、黄芩、黄柏、忍冬藤、生地、赤芍、丹皮；痰瘀互结者，加半夏、白芥子、山甲片、桃仁、红花、丹参、炙乳香、炙没药；气血不足者，加当归、党参、白芍、炙首乌、白术；肝肾不足者，加生熟地、桑寄生、续断、狗脊、杜仲、骨碎补、牛膝；肾阳虚者，加肉桂、鹿角片、巴戟天。^[16]

7. 加减健步壮骨（虎潜）丸（庞存生等）

组成：黄芪 30g，白术 15g，威灵仙 10g，络石藤 30g，当归 10g，锁阳 10g，伸筋草 18g，老鹳草 10g，蜈蚣 2 条，蜂房 10g，乌梢蛇 15g，鸡血藤 30g，川牛膝 15g，炙龟甲 10g，片姜黄 15g，甘草 6g。

用法：配合西药硫甲丙脯酸，治疗 96 例，总有效率为 95%。^[17]

8. 五藤汤（周林宽等）

组成：青风藤 15g，雷公藤 6~9g（先煎），忍冬藤 15g，海风藤 15g，络石藤 15g，蕲蛇 10g，蜈蚣 3 条，仙灵脾 12g，当归 30g，白芥子 10g，鸡血藤 30g，生黄芪 30g。

用法：以此为基础方辨证加减治疗 101 例，总有效率为 86%。^[18]

9. 三藤饮 (易希园等)

组成: 蕲蛇、炮山甲各 6g, 当归、白芍、黄芪、熟地、丁公藤各 15g, 桂枝、桃仁、灵仙、制川乌、乳香、没药、甘草各 10g, 鸡血藤 20g, 青风藤 30g, 全蝎 4g。

疗效: 治疗 34 例, 总有效率为 88.1%。^[19]

10. 复方蚂蚁丸 (郭来旺)

组成: 蚂蚁 50g, 人参 1g, 黄芪 7.5g, 当归 4g, 鸡血藤 7.5g, 淫羊藿 5g, 巴戟天 5g, 苡仁 20g, 丹参 7.5g, 制川乌 2.5g, 威灵仙 5g, 蜈蚣 2.5g, 牛膝 2.5g。^[20]

10. 麝香丸 (王永信等)

组成: 生川乌、生全蝎、生地龙、生黑豆、麝香。

用法: 此为明·孙一奎方, 改丸剂为胶囊, 经观察其有效率为 96.5%。^[21]

11. 海马威灵汤 (李培洲)

组成: 海马 1 条研细末另冲, 威灵仙 30g, 茯苓皮 30g, 地骨皮 10g, 自然铜 10g, 炙蕲蛇 20g。

用法: 配用干姜 10g, 官桂 10g, 山奈 20g, 薄荷 10g, 雷公藤 10g, 白芥子 20g, 水酒各半煎, 去渣, 纱布浸药水敷盖患处。^[22]

四、肝肾亏虚, 邪气留恋

1. 泽补汤 (汤琢成)

组成: 泽漆、补骨脂、虎杖、威灵仙、雷公藤、白花

蛇舌草各 30g, 秦皮、生地、丹参、当归各 20g, 全蝎 9g, 昆布、海藻各 10g, 蜈蚣 3 条, 细辛 30~35g。

用法: 水煎服, 每日 1 剂。

功效: 补肝肾, 活血、通络、软坚。

主治: 类风湿性关节炎。

方解: 方中泽漆化痰散结, 利水消肿; 补骨脂补骨壮骨, 强肾壮阳, 是为主药。辅之虎杖活血通经止痛, 秦皮清热燥湿, 生地补血滋肾阴; 丹参活血化瘀, 通透血脉, 改善病损处血液循环, 当归补血活血止痛, 威灵仙解毒散结, 舒痉镇痛; 白花蛇舌草解毒清热, 大剂量细辛 (30~35g) 温散止痛, 雷公藤据多处报道对类风湿性关节炎有较好疗效。骨痹症, 其病在筋骨, 久则筋挛骨僵。泽漆汤有补肾、壮骨、补血、活血、通络、祛瘀及软坚之功, 故可使筋舒骨健, 关节肿消及改善伸屈, 方证相符, 因之对类风湿性关节炎有一定疗效。

加减: 兼有发热者, 加青蒿 20g, 银花、地丁各 30g; 游走性痛者, 加徐长卿、磁石各 30g, 双钩藤 12g; 体虚者, 加黄芪 30g, 党参 20g, 鹿角胶 12g (烔服); 久用药觉胃部不适者加蒲公英 30g。^[23]

2. 补肾五要除痹丸 (刘兴远等)

组成: 补骨脂、仙灵脾、蚂蚁、杜仲、枸杞子、鸡血藤、丹参、乌梢蛇、威灵仙、桂枝、细辛、全蝎、制马钱子、制川乌等。

用法: 将上药制成药丸, 开始时每晚睡前服 1 粒, 两天后每日早晚各服 1 粒, 根据患者的年龄、体重、体质情况及病情轻重可以适当加减。3 个月为 1 个疗程。

按: 补肾五要除痹丸的主要成分是补肾药物。补肾药

物是以不同方式作用于下丘脑-垂体-肾上腺轴系统的,有的是作用于下丘脑而提高垂体的代偿功能,有的是对垂体靶腺水平同时提高,使其免疫反馈调节能力得到恢复和改善。补肾药之所以能参与免疫调节作用,这与它们所含微量元素锌、铜等有关。据测定补肾中药蚂蚁、枸杞子等含锌较多,丹参等含铜较多,铜、锌等微量元素对核酸及蛋白质的合成、免疫过程、细胞呼吸、分裂、繁殖和新陈代谢都有直接作用,对结缔组织形成和成熟都有重要意义。补肾五要除痹丸既能抗炎又有免疫抑制作用,在补益肝肾调节免疫基础上佐以活血化瘀之品,能显著减轻炎症过程中的肿胀、改善毛细血管的通透性,促进炎症病灶的消退,并可抑制结缔组织的代谢,促进增生组织的消化和吸收,从而使关节血管的炎症反应和内膜发生增生性改变的类风湿性关节炎得到治疗的效果。经观察补肾五要除痹丸的抗炎作用明显优于阿司匹林、布洛芬、消炎痛等非甾体抗炎药物,其作用亦优于免疫抑制剂与免疫调节中的环磷酰胺、D-青霉胺等药物。本药虽有类固醇样的效应,但不具有类固醇样的副作用。^[24]

(陶晓华 王 琦)

参 考 文 献

- [1] 史鸿涛. 当代名医临证精华·痹证专辑·自拟类风湿汤治疗类风湿. 北京: 中医古籍出版社, 1998. 287
- [2]、[3] 娄多峰, 林平. 治疗顽固痹(类风湿关节炎)的临床研究——附345例治疗结果报告. 河南中医, 1985, (5): 2~6
- [4] 周瑞珍. 梁剑波老中医治疗类风湿性关节炎的经验总结. 新中医, 1992, 24 (11): 16~17
- [5] 张学文. 通痹止痛汤. 陕西中医, 1994, 15 (4): 169
- [6] 夏度衡, 朱章志. 夏度衡治疗类风湿性关节炎经验总结. 湖南

- 中医杂志, 1991, (4): 3~5
- [7] 杨维华, 欧阳剑虹. 欧阳琦研究员治疗痹证的经验. 江苏中医, 1993, (8): 3
- [8] 王为兰, 等. 养阴清热祛湿汤治疗类风湿性关节炎急性发作之研究. 中国医药学报, 1994, (2): 16~18
- [9] 宋绍亮. 清热利湿解毒汤对类风湿性关节炎活动期的临床与实验研究. 山东中医学院学报, 1988, (2): 53~55
- [10] 李学增. 三土汤治疗活动性类风湿性关节炎的临床与实验研究. 中国医药学报, 1992, (2): 7~10
- [11] 汪履秋. 加减痛风方. 实用中西医结合杂志, 1991, 4 (10): 602
- [12] 朱良春. 虫类药对风湿性关节炎 60 例的疗效观察. 江苏中医, 1961, 6: 21
- [13] 李轩锦. 麝香丸治疗类风湿性关节炎. 浙江中医杂志, 1992, 27 (10): 472
- [14] 李国平, 刘香云, 张琪治疗痹证 10 方. 中医杂志, 1992, 33 (10): 18
- [15] 聂志伟, 陈治水, 郭黎明, 等. 风湿灵片治疗类风湿性关节炎 215 例疗效观察. 中医药信息, 1990, (5): 47
- [16] 李炯. 蠲痹饮合雷公藤片治疗类风湿性关节炎 76 例. 辽宁中医杂志, 1991, (3): 13~14
- [17] 庞存生, 等. 加减健步虎潜丸中西医结合治疗类风湿性关节炎 96 例. 实用中西医结合杂志, 1992, (10): 585~586
- [18] 周林宽, 等. 五藤汤治疗类风湿性关节炎 101 例疗效观察. 中医正骨, 1992, (4): 15~16
- [19] 易希园, 等. 三藤饮治疗类风湿性关节炎 34 例. 四川中医, 1993, (6): 28~29
- [20] 郭来旺. 复方蚂蚁丸治疗类风湿性关节炎 354 例临床疗效观察. 中国中西医结合杂志, 1992, (10): 626~628
- [21] 王永信, 等. 麝香丸治疗类风湿性关节炎的临床观察. 实用中医内科杂志, 1992, (4): 32~33

- [22] 李培洲. 海马威灵汤治疗类风湿性关节炎 32 例. 新疆中医药, 1991, (4): 13~15
- [23] 汤琢成. 泽补汤治疗 35 例类风湿性关节炎的体会. 新中医, 1986, (2): 41
- [24] 刘兴远, 等. 补肾五要除痹丸治疗类风湿性关节炎 100 例. 河北中医, 1990, (3): 4~6

风湿性关节炎

一、痛（寒）痹

天麻浸膏丸（陈伯煊等）

组成：天麻、独活、生地、杜仲、附子、当归、草薢、羌活、牛膝、玄参

用法：4~10粒/次，日2~4次口服。每粒相当原生药6~15g。

主治：治疗风湿性关节炎116例，有效率85.3%。以寒湿型疗效最高，风甚型次之，湿甚型更次之，热甚型最差，前三型与热甚型相比均有显著差异（ $p < 0.05$ ）。本方对关节疼痛及功能障碍的疗效尤为突出。^[1]

二、着（湿）痹

1. 慢性风湿性关节炎方（姚庆云）

组成：桂枝、鸡血藤各20g，制川乌、附子各15g，白芍、当归、黄芪各12g，防风9g，炙甘草6g。

主治：慢性风湿性关节炎。

加减：风偏重加秦艽；湿偏重加生苡仁；下肢痛加木瓜；上肢痛加片姜黄；腰痛加续断；久病体虚者，加补气血、滋肝肾和强筋骨之品。适当选用藤类药，如游走性痛

用海风藤；四肢肌肉萎缩用石楠藤；筋骨拘急用宽筋藤等。并酌加露蜂房、白花蛇等以搜风活络。^[2]

2. 补益风湿汤（王为兰）

组成：菟丝子 10~15g，制狗脊 10~15g，炒杜仲 10~15g，生川断 10~15g，大熟地 15~20g，怀牛膝 10~15g，肉桂 5~10g，党参 10~15g，炒白术 10~15g，当归 10~15g，炒白芍 10~15g，制川乌 6~15g，细辛 3~15g，独活 6~12g，防风 6~12g，威灵仙 10~15g。

用法：每日 1 剂，水煎，温服，日两次。

功能：温补肝肾，益气养血，兼以祛风散寒燥湿。

主治：慢性风湿性关节痛、风湿肌肉痛、腰痛、坐骨神经痛。

方解：菟丝子、制狗脊、炒杜仲、生川断、肉桂温补肝肾之阳；大熟地、怀牛膝滋补肝肾之阴；党参、炒白术健脾益气；当归、炒白芍养肝补血；制川乌、细辛温经散寒以止痛；独活、防风、威灵仙祛风湿以止痛，共奏补正祛邪的作用。

加减：气虚加黄芪 15~30g，炙甘草 6~10g，茯苓 10~15g；血虚加川芎 8~12g，炒阿胶 10~15g；风盛加赤芍 15~20g，鸡血藤 20~30g；寒盛加炮附子 10~30g，草乌 10g；湿盛加苍术 10~15g，生薏苡仁 15~25g；上肢痛重去独活加羌活 10g，肉桂改桂枝 10~15g 或桑枝 30g；下肢痛重加木瓜 15~18g，千年健 10~15g；肝血不足加阿胶 10~15g，鹿角胶 10g；大便秘结加肉苁蓉 30g；肾阴虚甚加盐龟甲 15g，山萸肉 10g；大便干燥加玄参 30g。

按语：久病风湿必伤及肝肾，或损耗气血，体质越虚，病邪越不得解，因此有一些久病不愈的风湿病，越用祛风

散寒除湿的药物，燥血伤阴疼痛越重，形成恶性循环。本方由《千金要方》中独活寄生汤化裁而成，若运用得当则左右逢源，恰到好处，疗效显著。

王氏长期以来，治疗一些慢性风湿痛、风湿肌肉痛、老年风湿病、产后风湿病、部分神经痛和一些久治不愈的风湿病患者，即在这个方剂的理论指导下，进行辨证施治每每获得良效。然而，并不是把方剂的药物全部罗列上，以大围攻的方式治疗，而是气不虚不用“四君”，血不虚不用“四物”，无风象不用风药，无湿证不用燥湿药，要依据体质的强弱、病邪的盛衰，有选择性地用药，且要了解每味药的特性，用每味药都应有的放矢，药物的性味、归经、用量、炮炼炙煨或生用，方剂的配伍、煎法、服法、禁忌等相互发挥着协同作用，这与治愈疾病密切相关。因此，组方不在全而在当，用药不在多而在精，药量不在大而在恰。

补益风湿汤是一个既可补肝肾，又能益气血，参以祛风散寒除湿药物，为治疗虚中夹实风湿病的比较有效的方剂。在临床应用中，务要扶正不碍邪，祛邪不伤正，总之要看正虚邪实的偏颇，而定治疗方案。^[3]

3. 除痹方（初振才）

组成：制草乌 7g，穿山龙 50g，红花 25g，桃仁 20g，苍术 25g，白芍 20g，甘草 15g。

功能：搜风祛湿，活血通络。

加减：痛痹加桂枝 40g，麻黄 15g，细辛 10g（后下），蜈蚣 2 条；着痹加薏苡仁 50g，萆薢 40g，蚕沙 20g；行痹加当归 20g，川芎 15g，防风 15g，羌活 20g；热痹加石膏 15g，连翘 20g，黄柏 20g，秦艽 25g，忍冬藤 50g，蒲公英

50g;瘀血加制乳没各25g,鸡血藤50g,黄芪25g;肝肾两虚加熟地25g,牛膝25g,补骨脂30g,蜂房10g,桑寄生35g,杜仲25g,全虫10g,狗脊25g。以上治疗效果不佳者,为经络闭阻甚坚,加用虫类药蜈蚣1条,全虫1.5g,为细末冲服,1日2次。疼痛剧烈,经用前方仍不缓解,甚则拘挛麻木者,属顽痰阻络,加服制马钱子研面,每次0.3g,日2次冲服。

注:制草乌是方中的要药,治痹之功优于川乌与附子,作者一般从7g开始,以每剂3g递增,用量是否继续增加,取决于两点,一是中病即止,二是出现毒性反应也应减量。^[4]

4. 五藤饮 (张从善等)

组成:忍冬藤、络石藤、青风藤、海风藤、鸡血藤各15g,制川乌3g。

用法:先煎川乌30分钟,后纳它药,再煎20分钟,日1剂,晚间顿服。病重者日2剂,早晚各服1剂。^[5]

5. 通痹汤 (马力行)

组成:钻地风30g,防风、当归各12g,熟地、苡仁、鸡血藤各15g,桂枝、全蝎各9g,制乳香、制没药、生甘草各6g。

疗效:治疗60例,痊愈58例,无效2例。^[6]

6. 蛇仙汤 (唐茂清)

组成:乌梢蛇、鸡血藤、老鹳草各30g,灵仙、伸筋草、路路通各15g。

加减:行痹加防风、海风藤、全蝎;痛痹加麻黄、细

辛、附片或制川乌、制草乌；着痹加苍术、苡仁、防风；热痹加黄柏、秦艽、银花藤；上肢痛甚加羌活、粉葛；下肢痛甚加独活、牛膝；关节强直加炮山甲、麝虫、蜈蚣，久病体虚加黄芪、当归。

疗效：治疗 40 例，痊愈 17 例，无效 7 例，总有效率 82.5%。^[7]

四、热痹

1. 热痹饮（刘志明）

组成：当归 12g，黄芩 9g，连翘 12g，忍冬藤 12g，海桐皮 12~15g，生甘草 12~15g，生苡仁 24g，防风 12g，防己 12g。

用法：上药 9 味，水煎，1 剂煎 2 次，上午煎头煎，下午煎二煎，煮开煎半小时，每次煎成一小碗，饭后 1 小时服，1 日 1 剂。

功能：清热利湿，宣痹通络。

主治：湿热为主，风寒为兼，寒热虚实错杂，气血流行不畅的热痹证。

方解：当归辛温，血中气药，养血活血，治一切风、气、血病，善止肌肉、关节、神经痛；黄芩苦能燥湿，寒能胜热，清化湿热，以利经脉，具有消炎、解痉、镇静功效；甘草调和诸药，缓峻急之势，和寒热之性，大量生用更能凉泻火邪，善于消炎镇痛；防风能散风寒湿痹、解热镇痛，治一身尽痛，称风药中润剂；防己苦寒，泄血中湿热，通其滞塞，十二经有湿热壅滞不通，皆可用此通经活络，消炎镇痛，松弛肌肉；海桐皮祛风湿，通经络，消肿止痛，痹痛严重者得此可减；连翘升浮宣散，流通气血，

治十二经血凝气滞，总治诸火，泻诸经络脉之热；薏苡仁除湿而不助燥，清热而不伤阴，益气而不助湿热；忍冬藤清热解毒，通经脉而调气血，对风湿性关节炎有良效。九药合用，湿化热清，结散痹通。

加减：热盛者，加知母 12g，栀子 9g，羌独活各 12g；湿盛者，加苦参 15g，滑石 15g，半夏 9g，秦艽 12g；阴虚者，加生地黄 18g，知母 12g，苦参 12g，半夏 9g，滑石 15g。^[8]

2. 清热宣痹汤（张沛虬）

组成：生石膏 30g，知母 10g，生甘草 5g，桂枝 10g，防己 15g，忍冬藤 30g，天花粉 30g，威灵仙 30g，稀莩草 15g，黄柏 12g。

用法：上药先煎石膏，约半小时后，将其余药物一起兑入，再煎半小时，每剂煎 2 次，日服 1 剂，分 2 次温服。如病情严重，可日服 2 剂，分 4 次服用。

功能：清热通络，宣痹胜湿。

主治：风湿性关节炎急性期（热痹），症见高热，关节肿痛，口渴，苔白腻，或黄腻，血沉增速和抗链“O”升高。

方解：热痹起于感受风、湿、热之邪，或风寒湿邪久郁，因阴虚之体而化热，以关节红、肿、热、痛为其主证，其治疗大法当清热通络，疏风胜湿，宣痹止痛。本方由仲景白虎加桂枝汤化裁而成，方中石膏、知母清泄肌热，忍冬藤、稀莩草、威灵仙、防己、黄柏清热宣痹，舒筋通络。其中忍冬藤、稀莩草、防己性寒，既能清热祛风湿，又有通络止痛的作用。方中更用性味辛温的桂枝一味，在大剂阴寒药中，能增强该方祛风湿通经络的效果。天花粉、生

甘草清热生津，调和诸药，共奏清热通络、宣痹胜湿的作用。^[9]

3. 痹证五圣汤（周炳文）

组成：黄芪 30～60g，金银花 20～30g，石斛、远志、川牛膝各 15g。

用法：水煎服。

功能：益气通痹，清热消肿除痛。

主治：痹证急性发作，四肢大关节肿胀剧痛，双膝、髌关节肿痛为主者疗效尤佳。

方解：痹证包括风寒湿痹与热痹两大类。本方主治疗体虚受邪热痹之证，故重用黄芪鼓舞气血、通经活络、贯百脉、调营卫、密腠理为主，配金银花甘寒清热解毒以除肿痛；石斛味甘益精滋阴，协同黄芪补虚损壮筋骨，助一身元气；远志温经祛风消瘀结、逐痹通闭，助黄芪贯注络脉温润关节；牛膝性滑走十二经络、补髓填精、益阴活血、引药下降直达病所，共奏益气蠲痹，清热除痛之功。

加减：肿痛退后脉仍滑数者，为阴虚内热，加鳖甲、白芍或龟甲益阴除蒸而敛浮阳；若膝关节肿痛不消，膝盖畸形，上下消瘦如鹤膝，为风湿壅滞，则加枸杞、苍术、独活、秦艽、萆薢、蚕沙、白茄根等益肾祛风胜湿，膝肿可消。^[10]

4. 痹八方（张琪）

组成：生石膏、银花各 50g，防己、萆薢各 20g，秦艽 15g，薏苡仁 30g，桂枝、黄柏、苍术、木通各 30g。

主治：本方治疗热痹，适用于急性风湿性关节炎，关节红肿焮热疼痛，小便黄赤，肢体出现红斑，舌赤、苔白

腻，脉浮滑，或滑数者。^[11]

5. 祛痹1号（闻起风等）

组成：黄柏、秦艽、独活、苍术、牛膝各15g，忍冬藤、络石藤、半枝莲各30g，威灵仙20g，细辛3g，桂枝6g。

用法：水煎2次，早晚分服，再将药渣加水2500ml，煎煮20分钟，待温后将受累关节浸泡或湿敷30分钟，每日1次。儿童剂量酌减。

加减：热象偏盛者加生石膏、红藤；湿重者选加玉米仁、萆薢、蚕沙；伤阴者加生地、鳖甲、知母；正气不足、气血亏虚者，加黄芪、党参、当归、鸡血藤；脉络瘀阻，久痹不愈者，选加穿山甲、地龙、桃仁、丝瓜络，或加雷公藤10~15g。

疗效：治疗风湿性关节炎45例，治愈35例，显效10例。祛痹1号对退热、消除红肿热痛，改善关节功能等均有非常显著的作用。（ $p < 0.01$ ）。^[12]

（陶晓华）

参 考 文 献

- [1] 陈伯煊，等。天麻丸治疗风湿性关节疾病的临床疗效分析。中成药研究，1987，（3）：17
- [2] 姚庆云。治疗慢性风湿性关节炎104例小结。浙江中医杂志，1982，17（11/12）：504
- [3] 王为兰。补益风湿汤。实用中西医结合杂志，1993，6（8）：496
- [4] 初振才。痹证证治（专题笔谈）。中医杂志，1989，（4）：9
- [5] 张从善，等。五藤饮治疗痹证135例。四川中医，1987，（2）：43
- [6] 马力行。通痹汤治疗类风湿性关节炎。时珍国药研究，1992，

(2): 86

- [7] 唐茂清. 自拟蛇仙汤治疗痹证. 实用中医内科杂志, 1992, (2): 20
- [8] 刘志明. 热痹饮. 实用中西医结合杂志, 1992, 5 (7): 434
- [9] 张沛虬. 清热宣痹汤. 实用中西医结合杂志, 1992, 5 (11): 700
- [10] 周炳文. 痹证五圣汤. 实用中西医结合杂志, 1994, 7 (2): 91~92
- [11] 李国平, 刘香云. 张琪治疗痹证 10 方. 中医杂志, 1992, 33 (10): 18
- [12] 闻起凤, 等. 祛痹 1 号治疗风湿热痹 200 例临床疗效观察. 实用中西医结合杂志, 1993, (1): 19

强直性脊柱炎

一、风寒湿滞型

1. 强脊宁一号汤（娄多峰）

组成：威灵仙 10g，独活 12g，千年健 10g，钻地风 10g，木瓜 15g，丹参 20g，白芍 20g，生地 20g，薏苡仁 20g，川牛膝 10g，香附 15g，甘草 9g。

用法：水煎服，每日 1 剂，分早晚 2 次服。

功能：祛风除湿，疏督通络，活血止痛。

主治：强直性脊柱炎早期，风寒湿邪痹阻督脉，症见腰脊强硬疼痛，遇寒受风加重，肢体困痛，或游走痛，局部寒热不明显，舌质淡，苔白，脉弦。^[1]

2. 通痹宁（陈纪藩、邱联群）

组成：桂枝、白术、蕲蛇、穿山甲、川续断各 6 份，白芍 8 份，知母、生姜、黄精、防风各 5 份，制马钱子 1 份，制附子、炙甘草、麻黄、制乳香、全蝎、制没药各 2 份。

用法：按上述分量制成片剂，每片 0.25g，每次 6~7 片，每日 3~4 次，饭后温开水送服。30 天为 1 疗程，观察 2~3 个疗程。

功效：祛风除湿，活血化瘀，通络止痛，补益肝肾，

强壮筋骨。

主治：强直性脊椎炎。

注：本方由经方桂枝芍药知母汤加味而成。^[2]

3. 类风湿液（冯云柱、买焕章）

组成：雷公藤 50g，生川、草乌、三七、全蝎、地龙、土鳖、红花、丹参、当归、独活、羌活、党参、黄芪、砂仁各 9g，蜈蚣 8 条。

用法：将雷公藤全根切成 2cm 长，洗净置锅内加水适量，煎 4 小时后出渣，剩药液约 2 000ml，把其余部分药物放入，加水适量，武火沸后文火煎 2 小时，过滤去渣，得液 2 000ml，冷却后加白酒（60°）200ml，搅匀即得类风湿液。每次 15~20ml，每天 3 次，饭后服。^[3]

4. 舒督通痹汤（李现林）

组成：麻黄 10g，桂枝 10g，当归 15g，赤芍 15g，木瓜 15g，伸筋草 15g，独活 10g，青风藤 15g，乌梢蛇 15g，杜仲 15g，五加皮 15g，甘草 10g。

用法：水煎服，每日 1 剂，3 个月为 1 疗程。

功能：散寒除湿，舒筋通络，活血止痛。

方解：麻黄、桂枝、独活、青风藤散寒除湿祛风，为祛风湿止痹痛的要药；木瓜、伸筋草、五加皮、乌梢蛇可舒筋通络，缓解筋脉之挛急；杜仲则可补肝肾，壮腰膝，有温煦督脉，引药力直达病所之功，佐以当归、赤芍活血化瘀止痛，甘草调和诸药。数药合用，可使寒湿祛、关节舒、督脉通而痹痛自止。

加减：如患者寒盛，遇冷痛甚者加制川草乌各 6g；内有热象，苔黄脉数者加连翘 30g，栀子 10g。^[4]

5. 中药药汽浴（段瑛春、曹铁梅、韩宏妮）

组成：豨薟草 30g，防己 20g，鸡血藤 20g，红花 20g，丹参 15g，麦冬 20g，牡丹皮 15g，秦艽 15g，独活 20g，五加皮 20g，露蜂房 10g，青风藤 20g，黄芪 30g。

用法：将上述药物加水浸泡 2 小时，加热煎煮 2 次制成 500ml 原液。病人坐入蒸气房中，先用蒸汽熏蒸 15 分钟，使全身汗毛孔开，然后开始进行药浴。将中药液反复均匀地喷淋在皮肤上，重点在腰骶部位，时间为 20~30 分钟。在熏蒸过程中嘱患者不断活动各关节，以使长期疼痛、僵硬的关节功能得到改善。隔日进行 1 次，15 次为 1 疗程。

主治：强直性脊柱炎。

加减：热象明显，血沉快者，加土茯苓 50g，生石膏 20g；寒象明显，血沉正常者，加麻黄 10g，干姜 10g。

注意事项：药浴过程中，要密切观察病人的神志、呼吸、面容、出汗多少等。随时询问患者的自我感受，如头晕、恶心、乏力等，如有不适要及时终止治疗。药浴结束后嘱病人淋浴净体，出浴房后，协助病人穿上浴衣，严防感冒。有严重心血管疾病、肝炎、活动性肺结核等各类传染性疾病及各种疾病引起体虚者忌用。^[5]

二、湿热内盛型

消痹灵袋泡剂（周翠英、宋绍亮、樊冰、孙素萍）

组成：金银花、土茯苓、黄柏、土贝母、赤芍、蜂房、牡丹皮、细辛等。

用法：每次 1 袋 15g，200ml 沸水浸泡 20 分钟后饮用，浸泡 2 次，每日 2 袋，连续服用 1 个月为 1 个疗程，观察 2

个月。

主治：活动期类风湿性关节炎、强直性脊柱炎。

方解：金银花甘寒，性偏宣散，能泄脏腑中之热毒，清络中之湿热，清热解毒而不伤胃，芳香透达而不恋邪；土茯苓甘淡性平，能利湿毒，祛风湿，强筋骨，舒关节，搜剔湿热之蕴毒，二药共同清热解毒，利湿通络为君药。黄柏泻火除湿痹，入肾经直清下焦之湿热毒邪；土贝母味苦性凉，能散湿毒、消痈肿，二药共同清热利湿为臣药。赤芍清热凉血、行瘀消肿止痛；蜂房甘平，能祛风攻毒、消肿止痛；牡丹皮辛苦性凉，能清热凉血、和血消瘀，三药共同清热凉血、散瘀消肿为佐药。细辛则“善开结气，宣泄邪滞，而能上达巅顶，通利耳目，旁达百骸，无微不至，内则宣络脉而疏通百节，外行孔窍而直透肌肤”为使药。全方既清热利湿、通利关节，又能散瘀肿、祛风寒。^[6]

三、肾虚督寒证

1. 补肾强督治疔汤（焦树德）

组成：熟地 15～20g，淫羊藿 9～12g，金狗脊 30～45g，制附片 9～12g，鹿角胶 10g（烊化），川断 12～20g，骨碎补 15～20g，羌独活各 10g，桂枝 12～20g，赤白芍各 12g，知母 12～15g，地鳖虫 6～9g，防风 12g，麻黄 3～9g，干姜 6～9g，怀牛膝 12～18g，炙山甲 6～9g，炙草乌 5～9g。

主治：强直性脊柱炎。

方解：本方以补肾祛寒治疔汤加减化裁而成。方中以熟地补肾填髓，淫羊藿温壮肾阳，除冷风劳气；金狗脊坚骨益血，强督脉，利俯仰共为主药。制附片补肾助阳，逐

风寒湿，并治脊强拘挛；鹿角胶益肾生精，壮肾强腰；川断补肝肾，强筋骨；骨碎补坚肾壮骨，行血补伤；羌活散风祛湿，治督脉为病，脊强而折；独活搜肾经伏风；桂枝温太阳经而通血脉。赤芍散血滞，白芍和血脉，缓筋急；知母润肾滋阴，以防桂附之燥热，地鳖虫搜剔血积，接骨疗伤；防风祛风胜湿，善治脊痛项强；麻黄散寒祛风，疏通气血；干姜逐寒温经；草乌逐寒搜风，善治腰脚冷痛；怀牛膝引药入肾，治腰膝骨痛；炙山甲散瘀通经，引药直达病所。

加减法：若腰痛显著，则加桑寄生 30g，杜仲 12～15g，并加重川续断及狗脊的用量，且随药嚼服 2 枚炙胡桃肉；若项脊痛明显加葛根 12～18g，并加重羌活的用量；若寒盛痛重者可加重制附片、草乌的用量，七厘散 1/3 管随汤药冲服；若身体拘挛，脊背发僵，则可加片姜黄 9～12g，白僵蚕 9～12g，生薏米 30～40g，苍耳子 6～9g；若腰脊僵硬如石者，可加急性子 3～5g；若舌苔厚腻者可减少熟地，去鹿角胶，加鹿角霜 10g，砂仁 3～5g，苍术 6～9g；若脾虚不运，脘胀纳呆者，可去熟地，加陈皮 10～12g，焦麦芽 10～12g，焦神曲 10～12g，或加千年健 12～15g；若有低热，或药后咽痛口干，便干口渴者，去干姜，减少桂枝、附子用量，加黄柏 12～15g（须黄酒浸 3～4 小时，取朱丹溪“潜行散”之意），生地 15～20g，地骨皮 10～12g，秦艽 12～25g；若骨质受损严重，关节僵化，以成“尻以代踵，脊以代头”之势者，则可加透骨草 20g，寻骨风 15g，自然铜（醋淬，先煎）6～9g，以其代替虎骨以强骨祛风。对于病程缠绵，久而不愈，痰湿重者，可加白芥子 6～9g 以化顽痰、搜风邪，苍耳子 6～9g 辛通窜透以引药入骨；髋关节活动受限，两腿屈伸不利者，加伸筋

草 30g，生薏米 30g，泽兰 12~18g，威灵仙 15g。^[7]

2. 风湿灵蜜丸（冯文岭、周沛、张玉良）

组成：人参（5%），丹参（12%），生地（36%），附子（8%），土元（8%），枸杞子（8%），菟丝子（8%），蜂蜜（15%）等。每丸 3g。

用法：每日 3 次，每次 2~4 丸，饭后服用，3 个月为 1 疗程。

功效：温补肾阳，滋补肝肾，益气补血，通络活血。

主治：强直性脊柱炎。^[8]

3. 强脊汤（曹贻训）

组成：葛根 15g，白芍 15g，当归 15g，黄芪 20g，川芎 9g，桂枝 9g，姜黄 9g，狗脊 15g，川续断 15g，补骨脂 15g，独活 9g，桑寄生 15g，络石藤 15g，千年健 9g，老鹳草 15g，党参 15g，全蝎 9g，地龙 9g，延胡索 9g，威灵仙 15g，甘草 6g。

用法：水煎服，日 1 剂，30 剂为 1 疗程。

功效：培补肝肾，补养气血，通阳行痹，活血止痛。

主治：强直性脊柱炎。

方解：本方重用狗脊、川续断、补骨脂、桑寄生以滋补肝肾，又以生黄芪、党参、当归、白芍等大补气血，令肝肾充实，气旺血行，痹阻诸症自然迎刃而解。方中集独活、桂枝、姜黄、络石藤、千年健、老鹳草等以通阳行痹，祛风散寒，以川芎、全蝎、地龙、延胡索活血定痛；葛根不但为督脉引经之品，而且配以甘草解肌止痛。综观全方具有培补肝肾，补养气血，通阳行痹，活血止痛之功。

加减：偏湿热去桂枝、姜黄，加苍术、黄柏、生地；

脊背僵硬强直、活动受限加鹿角胶、龟甲胶冲服。^[9]

4. 肾痹汤（杨爱国、尹玉茹）

组成：生地 20~90g，赤芍 15g，白芍 15g，红花 10g，王不留行 15g，川断 15g，葛根 20g，黄芪 20g，银花 30g，蒲公英 20g，独活 20g，土茯苓 30g。

用法：水煎服，日 1 剂。疗程 3 个月。

功效：补益肝肾，强壮督脉，益气活血，祛风除湿，清热解暑，软坚散结。

方解：生地养阴补肝肾，助筋骨，长肌肉；川断补肝肾，行血脉，续筋骨，二者合用，补肾填精，强壮筋骨，使肾气旺，精气足，髓生骨健，关节筋骨得以润泽营养，肢体关节逐渐恢复功能；葛根有强壮督脉，舒经活络，解肌之功；黄芪益气壮筋骨；赤白芍活血通络，祛瘀生新，养肝柔筋，能缓解筋肉拘急；红花、王不留行活血散瘀、通络散结，使经络舒通，关节活动正常，银花、蒲公英、土茯苓清热解毒；独活祛风除湿止痛。上药共奏清热解毒祛瘀、补肾活血之功，使外邪除、肾气复、瘀血散、经络通、气血行，则诸关节疼痛消失，活动灵活。^[10]

5. 补肾祛寒活络汤（隋孝忠、于文青）

组成：金狗脊、玄参、白芍各 10 份，熟地 7 份，桂枝、陈皮、羌活、白术、枸杞子、牛膝各 4 份，炙山甲、当归各 3 份。

用法：日 1 剂，水煎空腹内服，共 15~30 剂。服药后如腰腿明显疼痛，嘱其卧床休息 30 分钟，待疼痛缓解后始可下床活动。

功效：补肾祛寒，化湿散风，养肝荣筋，祛瘀通络。

主治：强直性脊柱炎（早期）。

加减：虚寒兼标热者去桂枝、熟地，加生地、金银花、桑枝、地骨皮，俟标热得清后再行祛寒之法；血瘀者，加桃仁、红花以活血祛瘀。^[11]

6. 骨痹汤（刘红丽）

组成：狗脊、杜仲、怀牛膝、骨碎补、独活、陈皮各15g，仙灵脾、威灵仙、生地、枸杞子各15~30g，僵蚕、熟地、当归各12g，桂枝9~15g，蜈蚣2条。

用法：水煎服，每日1剂，30天为1疗程，连用2个疗程。

功效：补肾强骨，散寒祛湿，活血通络。

主治：强直性脊柱炎。

方解：方中狗脊、杜仲、怀牛膝补肝肾、强筋骨、壮腰膝；熟地、枸杞子补肾益精；仙灵脾温补肾阳；骨碎补补肾强骨活血；威灵仙、独活祛风散寒除湿，善治腰膝疼痛；桂枝温阳散寒，活血通脉；当归活血养血通络；蜈蚣、僵蚕活血通络止痛；生地清热滋阴补肾；陈皮行气健脾以助消化。根据现代药理研究：狗脊、仙灵脾、熟地、枸杞子、杜仲能提高机体免疫功能；当归、骨碎补、怀牛膝、僵蚕、蜈蚣具有调节免疫和加速免疫复合物消除的作用；骨碎补并能修复关节软骨的退行性改变；生地有皮质激素样作用；威灵仙、独活有明显的消肿、止痛作用。全方具有较强的免疫调节及抗炎、消肿、止痛等作用。本方经临床验证，疗效显著，无副作用，若能配合腰骶部按摩则症状缓解更为显著。

加减：阳虚明显者，加鹿角胶9g，阴虚明显者，加女贞子15g，寒盛加制附子9g，湿盛加薏苡仁12g，热盛加忍

冬藤 15g。^[12]

7. 清痹灵胶囊（焦柏魁、吕世富、毕平、刘述言）

组成：熟地、肉桂、淫羊藿、续断、牛膝、川乌、地龙、蜈蚣、鸡血藤等。

用法：上药共为细末，装入胶囊，每粒 0.5g，每次服 10 粒，日服 3 次，外贴膏药，3 个月为 1 个疗程。

主治：强直性脊柱炎。

注：清痹灵对早、中期强直性脊柱炎患者的治疗总效率为 86.2%。长期服用，无毒副作用。^[13]

8. 通督散痹汤（章建华）

组成：炮甲片 10g，制附片 10g，狗脊 15g，续断 10g，熟地 20g，生黄芪 30g，当归 10g，羌活 10g，独活 10g。

用法：每日 1 剂，水煎，早晚分 2 次服。30 剂为 1 个疗程，连服 2 个疗程。

主治：强直性脊柱炎。

方解：炮甲片性专行散，功能通督散痹。制附片具补肾助阳、逐风散寒之功。续断补肝肾，强筋骨。熟地补肾填精，且防温补之药过于温热。羌独活则祛风散寒，舒筋通络。久病必虚，虚则补之，黄芪益气补虚，当归养血祛风，辛散温通。

加减：疼痛剧烈者，加全蝎 3g，细辛 3g；关节僵硬活动受限者，加伸筋草 15g，青风藤 30g，威灵仙 10g；关节肿胀者，加茯苓皮 30g，薏苡仁 30g；痰湿盛者，加白芥子 6g，炒牛蒡子 10g，姜半夏 10g；热盛者，加生石膏 15g，黄柏 6g。^[14]

9. 强脊康胶囊（焦柏魁、吕喆、毕平、吕世富）

组成：红参、黄芪、当归、鹿茸、巴戟天、冬虫夏草、山萸肉、伸筋草、汉三七、玄胡、川断、桑寄生、苍术。

用法：上药共为细末，装入胶囊，每粒含生药 0.5g。每次服 6 粒，日服 3 次，饭后温开水送服。

功效：温补肝肾，添精益髓，散寒除湿，舒筋活络，消肿止痛。

主治：幼年型强直性脊柱炎（与风寒湿邪引起的肝肾虚的腰腿痛、腰僵症有相似之处，属本虚标实的寒湿痹证，宜温补肝肾，扶正祛邪）。^[15]

10. 强脊宁二号汤（娄多峰）

组成：淫羊藿 30g，何首乌 30g，桑寄生 30g，川牛膝 30g，当归 20g，丹参 30g，鸡血藤 30g，白芍 30g，独活 30g，木瓜 20g，威灵仙 20g，甘草 10g，黑豆 60g，黄酒 100ml。

用法：水煎服，每日 1 剂，分早晚 2 次服，用量根据患者体质强弱和病情酌情加减。

加减：湿热盛者，加茯苓 30g，知母肉 20g。^[1]

四、肾督阴虚、湿热瘀滞型

肾痹汤（邱玉珍）

组成：生地 30~60g，葛根 20~30g，金银花、土茯苓各 30g，蒲公英 20g，狗脊、赤白芍、王不留行各 15g，红花 10g。

功效：养阴补肾，清热活血。

主治：强直性脊柱炎，早、中期患者，特别是活动期患者。

加减：疼痛剧烈，难以忍受，属热毒炽盛者，加紫花地丁、板蓝根；属寒热错杂者，加川椒、桂枝；兼发热者，加石膏、丹皮；兼下肢浮肿，或关节积液者，加苡仁、车前草并酌减生地用量；兼畏风汗多，或平素易感冒者，加黄芪；对病情较重的病人均加服理气通络散（由香附、川芎、玄胡、黄柏、全蝎组成）。^{〔16〕}

（陶晓华 刘夕明）

参 考 文 献

- [1] 娄高峰，娄玉铃. 中国名老中医药专家学术经验集·立虚邪瘀说的治痹名家娄多峰. 贵阳：贵州科技出版社，1995. 398
- [2] 陈纪藩，邱联群. 通痹宁治疗强直性脊柱炎 32 例疗效观察. 新中医，1994，（7）：2
- [3] 冯云柱，买焕章. 类风湿液治疗强直性脊柱炎 50 例疗效观察. 内蒙古中医药，1997，（3）：10
- [4] 李现林. 舒督通痹汤治疗强直性脊柱炎. 河南中医，1997，17（2）：109
- [5] 段瑛春，曹铁梅，韩宏妮. 中药药汽浴治疗强直性脊柱炎疗效观察. 吉林中医药，1999，（3）：23
- [6] 周翠英，宋绍亮，樊冰，等. 消痹灵袋泡剂的临床研究总结. 山东中医杂志，1997，16（11）：490~492
- [7] 闫小萍. 焦树德治疗强直性脊柱炎的经验. 中医杂志，1994，35（7）：407
- [8] 冯玉岭，周沛，张玉良. 中药风湿灵治疗强直性脊柱炎的实验研究与临床观察. 中国骨伤，1994，7（3）：12~15
- [9] 高飞，王明喜. 强脊汤治疗强直性脊柱炎 30 例. 山东中医药大学学报，1997，21（5）：374~375
- [10] 杨爱国，尹玉茹. 肾痹汤治疗强直性脊柱炎 30 例. 南京中医

药大学学报, 1997, 13 (3): 171~172

- [11] 隋孝忠, 于文青. 补肾祛寒活络汤治疗早期强直性脊柱炎 50 例. 新中医, 1995, 21 (11): 36~37
- [12] 刘红丽. 骨痹汤治疗强直性脊柱炎 47 例. 陕西中医, 1998, 19 (11): 494~495
- [13] 焦柏魁, 吕世富, 毕平, 等. 清痹灵胶囊治疗强直性脊柱炎 189 例. 辽宁中医杂志, 1994, 21 (8): 360
- [14] 章建华. 通督散痹汤治疗强直性脊柱炎 32 例报告. 中医正骨, 1998, 10 (3): 32
- [15] 焦柏魁, 吕喆, 毕平, 等. 强脊康胶囊治疗幼年型强直性脊柱炎 27 例. 中医药学报, 1997, (3): 28
- [16] 邱玉珍. 肾痹汤治疗强直性脊柱炎 30 例. 陕西中医, 1991, (2): 62

痛 風

一、濕熱痹阻

1. 秦蚕汤（吕凤祥、程春葵）

组成：秦皮 10g，蚕沙 12g，黄柏 10g，苍术 10g，牛膝 10g，车前子 30g，徐长卿 15g，连翘 6g，当归 15g，桂枝 6g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：清热除湿，散瘀消肿，温阳通利。

主治：急性痛风性关节炎。根据临床表现，将本病分为三型：①湿毒型：来势迅猛，肿胀颇甚，皮色发红，按之灼手，疼痛难忍，拒按，筋脉拘急，活动艰难，畏寒身热，口干而渴，溲短赤，脉弦数、苔黄。②湿热型：关节疼痛，局部有灼热感，红肿拒按，口渴，烦闷不安，舌苔黄腻，脉滑数。③湿瘀型：患部红肿、刺痛，舌有紫斑或瘀，苔腻，脉涩。

方解：方用秦皮、蚕沙引湿下趋，化浊归清；黄柏、苍术、牛膝清热利湿；徐长卿、连翘解毒消肿；当归、桂枝活血化瘀，温阳化气；车前子利水，使湿邪从小便而出。

加减：湿毒型加白花蛇舌草 30g，蒲公英 15g；湿热型加紫丹参 30g，赤芍 15g；湿瘀型加竹沥 10g，半夏 12g，夏枯草 10g，贝母 12g。^[1]

2. 当归拈痛汤加减方(夏涵、周蓉)

组成:羌活 9g, 防风 9g, 防己 9g, 粉葛根 15g, 宣木瓜 12g, 忍冬藤 30g, 油松节 9g, 全当归 12g, 赤芍 9g, 炒苍术 9g, 绵茵陈 15g, 虎杖根 15g, 生甘草 5g, 猪苓 9g。

用法:每日 1 剂,水煎服。

功效:祛风通络,清热利湿。

主治:痛风。

方解:方中羌活苦辛,透关利节而胜湿;防风甘辛,温散经络留湿;葛根苦辛平,味之薄者,阴中之阳,引而上行,以苦发之也;苍术体轻浮,能去皮肤腠理之湿;血壅而不流则痛,取当归、赤芍温以散之,使气血各有所归;甘草甘温补脾养正气使苦药不伤胃;茵陈以苦泄之,治肢节烦痛;治湿不利小便,非其治也,故取猪苓甘淡平,淡以渗之。方中另加虎杖根味苦辛平,活血通络止痛;忍冬藤味甘性寒能清热通络治风湿痛;油松节其味苦性温以祛风燥湿,活络止痛;宣木瓜味酸性温舒筋活络,皆以助祛风通络、清热利湿之功。

加减:病患上肢者,加桑枝;下肢加川牛膝;病程长关节变形加海风藤、天仙藤、威灵仙。^[2]

3. 痛风饮(樊移山)

组成:Ⅰ号方:水牛角 50g,石膏 100g,知母 15g,生地 30g,银花 20g,蒲公英 15g,车前子 20g,滑石 20g,苡仁 30g,桃仁 15g,红花 10g,乳香 6g,没药 6g,当归 15g,甘草 6g。

Ⅱ号方:石膏 30g,知母 10g,银花 10g,秦艽 15g,威灵仙 15g,石楠藤 30g,车前子 20g,金钱草 30g,当归

15g, 乳香 6g, 没药 6g, 地龙 10g, 甘草 6g。

用法: 水煎服。Ⅰ号方每日 1 剂, 每日 2 次, 服至症状消失, 改用Ⅱ号方, 每周服 3 剂, 连服 2 月。

主治: 痛风。

方解: 方中以水牛角、石膏、知母、银花、蒲公英、生地清热养阴; 滑石、车前子、苡仁清热利湿; 桃仁、红花、乳香、没药、当归活血通络止痛。痛风饮Ⅱ号减少清热、活血之品, 而加用秦艽、威灵仙、石楠藤加强除湿通络之功。据现代药理研究, 车前子、滑石均有显著的利尿排尿酸作用。整体用药与针对性用药相结合而获良效。考虑到痛风病患者尿酸排泄增多, 易患泌尿系结石, 故在Ⅱ号方中加用了金钱草以逐淋排石、防止痛风患者并发泌尿系结石。^[3]

4. 镇痛消风汤 (韦家杰)

组成: 车前子 15g, 秦艽、威灵仙、川牛膝、忍冬藤、地龙各 12g, 黄柏、山慈姑各 10g, 甘草 6g。

用法: 每日 1 剂, 水煎服。

功效: 镇痛祛风。

主治: 痛风。

方解: 痛风与中医学中“热痹”的症状有相似之处。在采用中药治疗时, 作者认为应结合现代医学理论, 把解决血尿酸值增高作为重要的一环。有关医籍记载: 车前子、地龙、山慈姑均有一定的排尿酸作用; 秦艽、威灵仙可解除尿酸性疼痛。如单纯用清热解毒、活血止痛之剂, 虽能缓解局部症状, 但不能把血尿酸值降至正常而往往病程缠绵。

加减: 痛甚加制川乌 9g, 玄胡 12g; 热盛加野菊花

15g, 黄地丁 30g; 活血加丹参 15g; 利尿加滑石 15g; 如红肿较甚者, 局部可用紫金锭调醋外搽。^[4]

5. 消痛饮 (叶伟洪)

组成: 当归 12g, 牛膝 15g, 防风 12g, 防己 15g, 泽泻 18g, 钩藤 15g, 忍冬藤 25g, 赤芍 18g, 木瓜 25g, 老桑枝 30g, 甘草 5g。

用法: 每日 1 剂, 水煎服。

功效: 清热通络, 消肿止痛。

主治: 痛风性关节炎急性发作时, 关节呈现红、肿、热、痛, 同时有口苦或口臭, 小便常见黄赤, 大便或结或不爽, 舌质红而暗, 苔白或黄而腻, 脉多弦滑, 数而有力。

方解: 方中当归、赤芍、牛膝凉血活血止痛; 钩藤、忍冬藤、桑枝清热解毒通络; 防风、防己、泽泻、木瓜祛风利湿消肿。

加减: 关节红肿甚者, 加黄柏、地龙; 大便燥结者, 加大黄; 痛甚加田三七、乳香、没药。同时用下列药物煎汤熏洗: 马钱子 20g, 红花 15g, 生半夏 20g, 王不留行 40g, 大黄 30g, 海桐皮 30g, 葱须 3 根, 艾叶 20g。每天 2 次。^[5]

二、血瘀痰阻

1. 痛风灵 (何天祥)

组成: 独活、苍术、黄柏、丹皮、泽泻各 15g, 白芷、郁金、当归、大黄、牛膝各 10g, 板蓝根 30g。

制法: 经加工制成浸膏, 用 5cm×10cm 无纺布三层浸渍成湿敷贴, 每贴约含生药 10g, 包装备用。

用法：将患处皮肤洗净后，将湿敷贴外贴于受累关节局部，用绷带包裹固定，每日更换1次，1周为1疗程。

功效：清热除湿解毒，凉血散瘀止痛，健脾护肾通络。

主治：痛风性关节炎，血尿酸增高，晚期或反复发作病例，X线检查可见受累关节局部膨隆，在关节骨缘邻近关节的骨质可有圆形或不规整呈穿凿样透明缺损，或有痛风石形成等。^[6]

2. 痛风方（方剑萍）

组成：桂枝、地龙、苍术、羌活、秦艽、牛膝各6g，蜈蚣3条，当归、茯苓、海风藤、乌药各10g。

用法：每日1剂，水煎服。

功效：散寒祛湿，通络止痛。

主治：痛风。

方解：方中用桂枝、地龙、蜈蚣、秦艽、羌活、海风藤等祛风湿、通经络；当归、丹参养血活血；乌药顺气、散寒、止痛，于是风去湿除，气行血活，经络疏通，痛风自己。^[7]

（张银柱）

参 考 文 献

- [1] 吕凤祥，程春葵. 秦蚕汤治疗急性痛风性关节炎75例报告. 中医正骨, 1996, 8 (1): 23~24
- [2] 夏涵，周蓉. 当归拈痛汤加减治疗痛风40例疗效小结. 中医杂志, 1987, (2): 60
- [3] 樊移山. 痛风饮治疗痛风14例. 云南中医学院学报, 1991, (3): 45~46
- [4] 韦家杰. 镇痛消风汤治疗痛风18例. 安徽中医学院学报, 1989, (2): 26

- [5] 叶伟洪. 消痛饮治疗痛风性关节炎 18 例报告. 中医杂志, 1990, (4): 40~41
- [6] 何浚治. 痛风灵湿敷贴治疗痛风性关节炎 168 例. 四川中医, 1997, (12): 43~44
- [7] 方剑萍. 痛风验案 2 则. 江苏中医, 1991, (9): 26

系统性红斑狼疮

一、阴虚内热证

苓丹片（青蒿鳖甲汤加减）（钟嘉熙、刘亚敏、张剑勇）

组成：青蒿、鳖甲、生地、知母、牡丹皮、秦艽、甘草、水牛角（冲）。

用法：水煎，日1剂。

功效：清热化湿，养阴透邪，活血化瘀。

主治：系统性红斑狼疮。

方解：方中青蒿化湿透邪，牡丹皮活血化瘀，秦艽化瘀通络，鳖甲入络搜邪，水牛角凉血解毒，甘草缓和诸药。诸药配合，共奏清热养阴透邪之功。^[1]

二、气营热盛证

1. 黄鹤仙饮（宫伟星、宋协德、孙祥荣等）

组成：生地黄、赤芍、仙鹤草、丹皮、紫草、白花蛇舌草、金银花、连翘、丹参、川芎、水蛭、甘草等。

用法：水煎，日1剂。

功效：凉血活血通络，清热解毒。

主治：系统性红斑狼疮。

方解：方中生地黄、丹皮、赤芍、紫草清热凉血化瘀；

白花蛇舌草、金银花、连翘清热解毒；仙鹤草既抗凝又止血；丹参、川芎、牛膝、水蛭活血通络，祛瘀生新；甘草解毒，调和诸药。^[2]

2. 清瘟败毒饮加减（邵性丽）

组成：水牛角、生石膏、土茯苓、苡仁各 30g，川桂枝、黄芩、生地、赤芍、丹皮、焦栀子、白花蛇、银花藤各 10g，炒知母 6g，黄连 3g，生甘草 5g。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：清热解毒，凉血护阴。

主治：系统性红斑狼疮（急性发作期）。

方解：方中水牛角、生石膏清热凉血；土茯苓、苡仁祛湿止痛，桂枝温经通络；黄芩、山栀、白花蛇、银花藤、黄连、知母清热解毒；生地护阴生津；赤芍、丹皮活血凉血；生甘草调和诸药。诸药合用，共奏清热解毒，凉血护阴之功。

加减：小关节疼痛隐隐加秦艽 15g。^[3]

3. 四妙勇安汤加味（曹建恒）

组成：玄参 75g，金银花 30g，当归 15g，生甘草 10g，连翘 30g，丹皮 15g，赤芍 15g，天花粉 20g，乳香 10g，没药 10g，三七粉 5g（另吞）。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：清热解毒，活血止痛。

主治：系统性红斑狼疮（热毒炽盛型）。

方解：方中玄参泻火解毒，凉血养阴，散结消痈，为除热毒蕴结，阴伤血瘀之要药；且得当归之助，散结之力更强；金银花清热解毒；当归活血散瘀，血行得畅，则蕴结之热毒也易于消散；甘草配金银花以加强清热解毒之功；

连翘、丹皮、赤芍、花粉、乳香、没药、三七凉血活血止痛。诸药合用，能使毒解血行，肿消痛止，阴伤得复。^[4]

4. 来氏汤（来春荣）

组成：忍冬藤 100g，藤梨、野荞麦各 10g，马鞭草、佛耳草、丹参、大力王、地丁草各 30g，海金沙、绞股蓝、一枝香各 20g。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：清热解毒，祛风散瘀。

主治：系统性红斑狼疮。

方解：方中藤梨、佛耳草祛风清热、凉血解毒；海金沙清热解毒、利水通淋；大力王散瘀消肿；野荞麦清热解毒、活血化瘀、祛风消肿；一枝香解毒祛风活血。

加减：气虚者，加太子参 30g；舌红少苔者，加天冬、麦冬各 20g；发热者，加淡豆豉或清水豆卷 20g；大便干结者，加生大黄 9g（后下）；水肿明显、有腹水者，加石韦 30g，商陆 20g；关节痛者，加青风藤 30g，雷公藤（去皮）12g；血热加茜草 20g，远志 6g。^[5]

5. 狼疮丸（王仲英）

组成：由金银花、连翘、丹参、赤芍、蒲公英、白鲜皮、桃仁、红花、蜈蚣等 17 味中药组成。

用法：配成蜜丸，每丸重 9g。每日 2 次，每次 2 丸。急性期每日 3 次，每次 4 丸。温开水送服。持续服用 3~5 年。

功效：清热解毒，凉血祛风，活血化瘀。

按：治疗系统性红斑狼疮 306 例，临床证实，总有效率达 85.0%。该药对身体无副作用，对部分患者可用狼疮丸代替激素的维持量。药理证明：该药对不同原因引起的

炎症,包括Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ型变态反应,均有抑制作用。但对免疫反应的致敏期和反应期均无作用。〔6〕

三、热郁积饮证

磁石丸(郭明、刘士敬、徐琦)

组成:磁石 60g,牛膝、川芎、赤芍、海桐皮、草薢、全蝎、秦艽、地龙、天麻、木瓜、白芷、白花蛇、白僵蚕、白附子、石楠叶、白蒺藜、苦参各 30g。

用法:上药共研末,过 100 目筛,制成蜜丸,每丸 10g,每次 2 丸,日 2 次,连服 60 天。

功效:驱解肾脏风毒,利湿止痛。

主治:系统性红斑狼疮。

方解:方中磁石辛咸微温,驱除肾脏风毒,主治周痹风湿;白花蛇、白附子、白僵蚕、白蒺藜合称四白散,古方中常以治肾脏风毒攻注,四肢头面生疮,遍身瘙痒;牛膝、全蝎、地龙、川芎、赤芍活血祛瘀,配天麻祛风解痉;海桐皮、秦艽、草薢、木瓜均有驱散风湿之毒,胜湿利水之功,海桐皮兼有杀虫止痒作用,对于湿疮、疥疮尤佳,草薢也兼有疗疮毒之功,治疗疮疡恶厉之疾;白芷祛风止痒,散风除湿;苦参祛风杀虫;石楠叶祛风通络,透疹止痒。诸药合用,共奏驱解肾脏风毒,利湿止痒之功。〔7〕

四、瘀热痹阻证

1. 秦艽丸加减(赵炳南)

组成:黄芪 30g,秦艽 15g,黄连 6g,乌梢蛇 6g,漏芦 10g。

用法：水煎服，日1剂。

功效：扶正祛邪消斑。

主治：系统性红斑狼疮。

方解：方中重用黄芪补虚益损，正气足则邪不可干；黄连、漏芦泻火解毒，一用苦寒，治在心经实火，一用咸寒，治在胃腑积热，颇合“诸痛痒疮，皆属于心”之旨；秦艽化湿通络，治在表；乌梢蛇透骨搜风，治在里，同为经络痹阻而设。

加减：壮热不退者，加玳瑁、沙参、鲜芦根、干地黄、水牛角、生地炭（取其凉血，解血分热毒）；低热缠绵，数月不退者，加南北沙参、地骨皮、石斛、玄参、青蒿，以清解肌肤乃至骨之虚热；肩、肘、腕、膝、踝关节痛者，加桂枝、松节、伸筋草、海桐皮、革薢；周身肌肉酸痛者加鸡血藤、延胡索、没药、乳香；腰痛拒按者加云南白药、路路通、天仙藤、丹参、茜草、鬼箭羽、豨薟草；腰痛喜按者加炒杜仲、胡桃核、川续断、徐长卿、五加皮；腰软乏力、难以支撑者，加人参、红人参、石斛、南北沙参、玉竹、当归、参茸卫生丸；麻木者加刘寄奴、徐长卿、桑寄生、丝瓜络、伸筋草；颜面蝶形红斑者加玫瑰花、凌霄花、鸡冠花、红花、金莲花（药味取花，花性轻扬，凡红斑在面部，病在血分者皆宜）；指（趾）端苍白、青紫、冰冷者加玄参、石斛、鸡血藤等甘寒通络之品；心慌、胸闷不舒，发时则不能自主，甚则心痛阵作者加桂圆肉、石斛、紫石英、石莲子、薄荷梗、老苏梗、蛇胆陈皮末、合欢花、全瓜蒌、薤白；两胁疼痛，食欲减退，或者食后腹胀不适者加沉香末、广木香、橘红、大腹皮、厚朴、陈皮、枳壳、白术、苡仁、伏龙肝；全身浮肿，小便量少，腰空痛者，加白人参、红人参、抽葫芦、防己、泽泻、楮实子、山茱萸、车

前子、生苡仁、仙人头、丹参、枸杞子、女贞子，益气扶阳、利水消肿；尿检红细胞增多者加银花炭、生地炭、白茅根、金钱草以凉血止血解毒；尿检蛋白++~+++者加海金沙、扁蓄、瞿麦、木通、水葱、赤小豆、石韦、韭子、山茱萸、楮实子、菟丝子以通利、温肾秘精。^[8]

2. 三虫散加味(王清国)

组成：全蝎 5g，蜈蚣 3 条，僵蚕 10g (研末，分二次吞服)，连翘、蒲公英、杭白菊、地肤子、黄柏、丹皮各 9g，苦参 10g，金银花、土茯苓各 15g，黄连、甘草各 9g。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：清热解毒，凉血消斑。

主治：系统性红斑狼疮(热毒炽盛型)。

方解：方中全蝎、蜈蚣、僵蚕熄风止痉、解毒散结、通络止痛；蒲公英、银花、连翘、杭白菊清热解毒；黄柏、黄连清热燥湿；丹皮凉血消斑；甘草甘缓和中。诸药配合，共奏清热解毒，凉血消斑之功。^[9]

3. 狼疮方(汪履秋)

组成：何首乌、桑椹子、生熟地、丹皮、土茯苓、紫草、水牛角、防风、防己、苡仁、虎杖、红花、雷公藤(均为常用量)。

主治：红斑狼疮初期、极期、缓解期、恢复期。^[10]

五、气血两亏证

补阳还五汤加味(赵喜荣、吴素花、梁淑娟等)

组成：黄芪 50g，川芎、地龙、当归、赤芍各 50g，生

地 5g, 麦冬 4g, 丹皮 7g, 白芍、茯苓各 3g。

用法: 日 1 剂, 水煎服。

功效: 益气活血, 养阴通络。

主治: 系统性红斑狼疮。

方解: 方中用大剂量黄芪益气活血; 川芎、赤芍、当归、丹皮活血化瘀; 生地、麦冬滋阴润燥; 白芍、茯苓健脾益气; 地龙通络化瘀。诸药合用, 共奏益气活血, 养阴通络之功。^[11]

六、瘀热伤肝证

桃红四物汤加减 (颜德馨)

组成: 生地 15g, 水牛角 45g (先煎), 赤芍 9g, 红花 9g, 桃仁 9g, 银花 15g, 黄芩 9g, 青黛 9g, 紫草 9g, 黄连 6g, 生甘草 6g。

用法: 日 1 剂, 水煎服。

功效: 清营活血。

主治: 系统性红斑狼疮。

方解: 方中取桃红四物汤活血化瘀; 配水牛角、黄连、银花等, 乃取清营汤之意, 清营凉血; 佐以青黛、紫草、黄芩、生甘草清热解毒。诸药合用, 共奏活血化瘀、清营解毒之功。

加减: 神疲乏力、五心烦热者加玄参 9g, 麦冬 9g, 生黄芪 15g, 知柏地黄丸 9g。^[12]

(陶晓华 张 林 贾鹰珏)

参考文献

[1] 钟嘉熙, 刘亚敏, 张剑勇. 苓丹片治疗系统性红斑狼疮 149 例.

新中医, 1997, 29 (11): 12~14

- [2] 宫伟星, 宋协德, 孙祥荣, 等. 黄鹤仙饮治疗系统性红斑狼疮 50 例. 山东中医药大学学报, 1997, 21 (5): 371~372
- [3] 邵性丽. 清瘟败毒饮的临床新用. 陕西中医, 1997, 18 (3): 133~134
- [4] 曹建恒. 四妙勇安汤加味临床治验. 河南中医, 1995, 15 (4): 245~246
- [5] 来春荣. 来氏汤治疗系统性红斑狼疮 42 例. 浙江中医杂志, 1995, 30 (4): 158
- [6] 王仲英. 狼疮丸治疗 SLE 的临床与实验研究. 中西医结合杂志, 1989, 9 (8): 465
- [7] 郭明, 刘士敬, 徐琦. 磁石丸加减治疗系统性红斑狼疮 36 例. 北京中医药大学学报, 1998, 21 (2): 59
- [8] 徐宜厚. 赵炳南治疗红斑狼疮的用药经验. 湖南中医杂志, 1986, (5): 29~30
- [9] 王清国. 三虫散加味治疗顽症二则. 安徽中医学院学报, 1996, 15 (6): 31~32
- [10] 叶果强. 汪履秋教授治疗红斑狼疮的经验. 南京中医学院学报, 1994, 10 (3): 26
- [11] 赵喜荣, 吴素花, 梁淑娟, 等. 补阳还五汤加味治疗红斑狼疮 15 例疗效观察. 中医药研究, 1997, 13 (6): 31~32
- [12] 颜乾珍. 颜德馨运用桃红四物汤治疗难治性疾病的经验. 江苏中医, 1997, 18 (7): 5~6

系统性硬皮病

一、阳虚寒凝

1. 助阳温经通脉汤（周伏初）

组成：麻黄 10g，桂枝 10g，细辛 6g，黄芪 20g，鹿角 30g，淫羊藿 10g，当归 15g，红花 6g。

用法：水煎服，每日 1 剂，分 2 次顿服。

功效：助阳温经通脉。

主治：阳虚，寒侵经络，气血痹阻之硬皮病。症见形寒畏冷，皮肤变硬，手指、足趾发紫变白，关节疼痛，或僵硬，出汗不畅，舌淡，脉沉细。

方解：麻黄、桂枝发汗解肌通痹；细辛通阳化气合桂枝散结温经，助鹿角、淫羊藿温肾助阳；当归为血中气药，甘温和血，辛温散寒；配红花而活血通痹力增；黄芪益气固表，防发汗过甚，诸药配合，共奏助阳温经通痹之功。

加减：伴雷诺现象者，加鸡血藤、丹参；伴关节疼痛者，加延胡索、乌梢蛇或白花蛇；伴色素减退者，加熟地、桑椹；伴吞咽欠畅者，加柿蒂；伴肾阳显著不足者，加巴戟天、仙茅、附片；伴脾阳虚弱者，加党参、干姜、白术；伴心悸气短易惊者，加红参；伴咽干咳嗽者，加炙枇杷叶、紫菀。^[1]

2. 当归四逆汤加减（纪伟）

组成：当归 10g，桂枝 10g，芍药 10g，细辛 3g，通草 10g，黄芪 15g，川芎 10g，全虫 2 条，甘草 5g，大枣 5 枚。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温阳活血，散寒通络。

主治：阳虚寒凝，经络痹阻型硬皮病，症见皮肤发硬，肢端青紫，肌温偏低，全身乏力，畏风怕冷等。

方解：本方为桂枝汤变法，即桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、细辛、通草、黄芪而成。用当归甘、辛、温养血补血，是温补肝血之要药，辅以芍药益阴和营；桂枝宣通阳气，温经通脉；芍药配当归酸甘化阴，增强养血之功；当归配桂枝辛甘化阳，温通血脉；芍药配桂枝，内疏厥阴，外和营卫；佐以细辛外温经脉，内温脏腑；以通草、甘草、大枣为使，通草通行血脉，大枣、甘草以补益脾胃，调生化之源。诸药配合，有和厥阴以散寒邪之功，调营卫以通阳气之效。

加减：皮肤明显变薄或发硬，宜加重祛风通络之力，可用乌梢蛇、地鳖虫、蝉衣、地龙等；若肤色变深，或肌肤甲错，宜选用桃仁、红花、穿山甲、地鳖虫、水蛭等活血化瘀药；若皮肤顽厚如木板状，乃瘀瘀胶着所致，除加重活血化瘀药，还可用海藻、昆布、牡蛎、白芥子、象贝等化痰软坚之品；若病邪内舍于脾，表现为吞咽困难、纳差、胃脘隐痛，则以本方与理中汤合用；若病邪内舍于肺，表现为咳嗽、气急，则合用补肺汤；寒凝肝脏者，出现肝区不适，肝肿大，肝功能异常，宜合用暖肝煎；若腰酸，怕冷，生殖功能低下、手足青紫，宜加强温经散寒通络之品，如巴戟天、菟丝子、鹿角胶等；若病人伴有低热、口

干、五心烦热、舌红脉细等阴虚内热之象，可去细辛，减量桂枝，加生地、丹皮、知母等。^[2]

3. 三地二甲汤（张国伦）

组成：熟地 30g，淫羊藿 30g，黄芪 30g，桂枝 9g，当归 10g，独活 12g，防风 10g，桃仁 9g，红花 9g，地龙 10g，山甲珠 15g，土鳖虫 9g，鳖甲 15g，白花蛇 1 条，牡蛎 30g，白芥子 10g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温阳散寒，搜风通络，活血化瘀，化痰软坚。

主治：阳虚寒凝，痰瘀阻络之硬皮病。

方解：熟地、黄芪、淫羊藿、当归温肾散寒，益气养血生肌；桂枝、独活、防风祛风通络；更以白花蛇、地龙搜风剔络；桃仁、红花、土鳖虫、山甲珠活血化瘀通络；白芥子、鳖甲、牡蛎化痰软坚通络。^[3]

二、血瘀经脉

郑占才方（郑占才）

组成：丹参 30g，川芎 10g，红花 10g，鬼箭羽 15g，威灵仙 10g，丝瓜络 10g，桂枝 6g，茯苓 15g，熟地 15g，黄芪 30g，仙茅 15g，仙灵脾 15g

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温肾补阳，活血化瘀。

主治：肾阳不足，瘀血阻络之硬皮病。

加减：局限性硬皮病，宜加重活血通络药如鸡血藤、桑枝，软坚药如夏枯草、贝母；系统性硬皮病，宜加温肾壮阳之品，如制附片、肉桂、鹿角胶；伴雷诺病现象加细

辛 3g，白芍 15g，甘草 10g；伴关节痛者，加秦艽 10g，木瓜 15g；伴心慌乏力等气虚症状者，加党参 15g，白术 10g。^[4]

三、气血两虚

参芪汤（张秉璋、裘求良）

组成：黄芪、人参（或党参代）、甘草、肉桂、蕲蛇、牡蛎。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温阳通痹，软坚散结。

主治：元气虚弱，脾肾阳虚，阴寒内盛，寒湿痰瘀凝聚肌腠，胶固而成皮痹、硬症。

方解：参芪汤是取古方保元汤加蕲蛇、生牡蛎而成。柯韵伯曰：“保元者，保守其元气之谓也。……此方用黄芪护表，人参固里，甘草和中，三气治而元气足矣。……桂能治血以推动其毒，扶阳益气以达周身。”元气旺盛，生化动力有源，阴阳和平，方能和阳通腠，破坚散结。方中加用蕲蛇者，取其走窜之力，引诸药入病所，祛风活血，温阳通痹，佐以生牡蛎咸寒软坚，又防亢阳之弊。综合诸药，共奏温阳通痹，软坚散结之功。

加减：寒凝经脉，阳气不伸，四肢肌肤色白、厥冷不仁，加温经通痹之桂枝、附子、当归、丹参；血瘀邪遏，面色紫暗，肌肤色紫、僵硬绷紧，加活血祛风通脉之穿山甲、广地龙、红花、鸡血藤、香白芷、乳香；脾肾阳虚，水湿泛滥，兼见肌肤浮肿，按之凹陷不起，加温肾健脾之仙灵脾、巴戟天、煨草蔻、干姜、炒白术、苍术；血压高，加葛根、夏枯草、五味子、羚角降压片；身热加柴胡、青

蒿、地骨皮；热重加生石膏、知母；关节疼痛加川楝子、玄胡、木瓜、防己、制乳香、没药。^[5]

(陶晓华 邬洪波)

参 考 文 献

- [1] 周伏初. 助阳温经通痹汤治疗进行性硬化症 36 例临床观察. 湖南中医杂志, 1997, (5): 13~14
- [2] 纪伟. 当归四逆汤加减治疗系统性硬化症的体会. 北京中医, 1997, (5): 19~20
- [3] 张国伦. 系统性硬皮病辨治一得. 中医杂志, 1998, (5): 275~276
- [4] 郑占才. 温经活血法治疗硬皮病 16 例. 中国医药学报, 1990, (6): 46~47
- [5] 张秉璋, 裘永良. 参芪汤治疗硬皮病经验. 中医杂志, 1995, (5): 275~276

血栓闭塞性脉管炎

一、血瘀证

1. 五虫汤（韩青科）

组成：廕虫、地龙、全蝎、水蛭各 10～20g，毛冬青 20～60g。

用法：加水 1 000ml 左右，文火浓煎 1 小时至 300ml，早晚饭后各服 150ml。1 日 1 剂，60 剂为 1 疗程，服 30 剂后观察疗效。

功效：活血通络。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：五虫汤之五种虫药均具有走窜之性，有活血通络之功。其中，水蛭一味，《本经》言其“逐恶血、瘀血、月闭、破血癥积聚无子”。《伤寒论》以本品配虻虫治疗蓄血证，历代医家均视为峻猛之药。韩氏根据《神农本草经百种录》关于“水蛭最善食人之血，而性又迟缓善入。迟缓则生血不伤，善入则坚积易破。借其力以攻积久之滞，自有利而无害”之论，又根据张锡纯关于“凡破血之药，多伤气分，惟水蛭味咸，专入血分，于气分丝毫无损，且服后不觉疼，并不开破，而瘀血默消于无形，其良药也”之说，通过多年亲身实践，获得水蛭可大剂量使用之经验。韩氏使用水蛭最大剂量达每日 60g 水煎服，未见患者有不

良反应（编者按：如此大剂量使用水蛭之经验仅供参考，读者用之宜慎）

加减：

（1）分型加减：虚寒型：五虫汤合阳和通瘀汤加减。药物：（五虫汤方略）熟地 60g，鹿角胶 30g，附子、干姜、肉桂、三棱、莪术、麻黄各 10g，桃仁、红花各 15g。血瘀滞型：五虫汤合活血逐瘀汤加减。药物：（五虫汤方略）当归、丹参、鸡血藤各 30g，桃仁、红花、昆布、海藻各 15g，赤芍 20g，三棱、莪术各 10g。湿热型：五虫汤合利湿化瘀汤加减。药物：（五虫汤方略）当归、银花、赤小豆、苡仁各 30g，元参 60g，黄芩、黄柏、栀子、泽泻各 10g，赤芍、桃仁、红花各 15g。热毒型：基础方合黄连解毒活血汤加减。药物：当归、玄参各 60g，银花、蒲公英、地丁各 30g，黄芩、黄柏、黄连、栀子、甘草各 10g，赤小豆 15g。气血两虚型：五虫汤合人参养荣活血汤加减。药物：（五虫汤方略）党参、黄芪各 60g，当归、丹参、赤芍、白芍、鸡血藤各 30g，白术、肉桂、熟地、牛膝、茯苓各 15g。

（2）分症加减：五型中有疼痛甚者，皆加乳香、没药、枳壳，重用五虫量至 30g（编者按：虫药用量已超出常规范围。此剂量系老中医经验，读者应用时宜慎之）；瘀血重者，除重用五虫之外，尚可倍赤芍、丹参、三棱、莪术、桃仁、红花，其用量可达 30g 左右（编者按：仅供参考）；肢体发凉者，加附子、干姜、肉桂；消化不良者，加山楂、神曲、麦芽等；伤口长期不愈，重用参芪；湿热盛加土茯苓、泽泻；热盛者，倍用银花、蒲公英、连翘。^[1]

2. 当归四逆汤加减（詹学斌）

组成：当归 15～20g，桂枝 8～12g，木通 6g，白芍

10~20g, 细辛 2~6g, 生甘草 6g, 川牛膝 10g, 丹参 15g, 赤芍 12g, 生黄芪 12~30g。

用法: 日 1 剂, 水煎服。

功效: 温经散寒, 祛瘀通脉, 补益气血。

主治: 血栓闭塞性脉管炎。

方解: 方中当归养血活血止痛; 桂枝为温经通络之要药, “赤色通心, 温能散寒, 甘能益气生血, 辛以发散外邪” (《名医方论》); 细辛“甚辛, 通三阴气血, 外达于毫端” (《名医方论》); 木通“通利九窍血脉关节” (《神农本草经》); 芍药养营血, 柔筋脉, “当归得芍药, 而生血于中” (《名医方论》); 芍药且能制桂枝、细心刚燥之性; 方中加赤芍、丹参、川牛膝以加强行瘀通脉之力; 黄芪、甘草益气通脉, 黄芪与当归相伍, 使“有形之血生于无形之气” (《名医方论》), 气为血帅, 气行则血行, 又能加强培本之力, 效力相得益彰。

加减: ①寒凝型: 治宜温经散寒, 通脉止痛。基本方重用桂枝、细辛, 加肉桂 6~10g, 淡附片 10g。②血瘀型: 治宜活血散瘀, 温经通脉。基本方酌加炮山甲、刺猬皮、红花、桃仁、泽兰各 10g。③郁火型: 治宜清热解毒, 祛瘀通脉。基本方去细辛, 加银花 30g, 玄参 15~30g, 蒲公英 15g, 连翘、黄芩各 10g, 即合四妙勇安汤加味。④气血亏损型: 治宜祛瘀通脉, 补益气血。基本方中重用黄芪、当归, 加党参 10g, 鸡血藤 30g。⑤寒热夹杂, 虚实并见, 或有各种兼症, 可在上述分型基础上随症加减。如: 寒凝型而兼郁火, 出现心烦, 口渴, 舌红绛, 舌苔薄黄等症, 可在寒凝方药基础上加四妙勇安汤; 郁火伤阴者, 加花粉、生地、石斛、麦冬等; 夹湿者, 加苍术、白术、茯苓等; 肾阳虚者, 加鹿角片、仙灵脾等。

对于疼痛剧烈者，则根据审因论治的原则分别加上止痛药。如寒凝型可加制川乌 4~8g，以散寒止痛；血瘀型加制乳没各 6g，以散瘀止痛；郁火型加玄胡 15g，忍冬藤 20g，重用玄参至 30g，以清热柔脉止痛。

对于已溃烂者，应注意及早清创，保持创面清洁，敷以消炎抗菌之品，必要时选用有效抗生素。^[2]

3. 活血通脉汤（冯永刚、王荣、铁刚）

组成：当归、丹参、赤芍、川芎、桃仁、红花、穿山甲、川牛膝、水蛭、地龙、皂刺。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：活血化瘀。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：方中以大剂量水蛭破血逐瘀为主，以当归、赤芍、川芎、丹参、桃仁、红花活血祛瘀治疗为辅，佐以穿山甲、皂刺、川牛膝、地龙活血通络止痛，并随寒热虚实诸证之不同加减变化而取效。

加减：阴寒型加鹿角胶、熟地、附子、桂枝；血瘀型加乳香、没药；湿热型加苍术、黄柏、苡仁；热毒型加金银花、玄参、地丁、生地；气血虚型加黄芪、党参、首乌。^[3]

4. 鸡花散（张从道）

组成：鸡血藤 25g，金银花 20g，玄参 10g，黄芪 25g，当归、姜半夏、茯苓各 15g，肉桂 3g，全蝎 6g，蜈蚣 2 条，陈皮、粉甘草各 10g。

用法：日 1 剂，水煎服，重症加倍。

功效：温阳通络。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：方中银花、蒲公英、薏苡仁清热利湿；姜半夏、茯苓祛痰；白芍、玄参敛营滋阴；黄芪、当归补气摄血；肉桂、桂枝温阳通络；鸡血藤、红花、川芎活血化瘀；全蝎、蜈蚣镇痛。

加减：寒型加桂枝、红花各 10g；湿热加薏苡仁 20g，防己 10g；热型加蒲公英 20g，白芍 15g；气血两虚型加熟地、红参各 10g。^[4]

5. 化栓通脉汤（刘斌）

组成：黄芪 30g，当归、丹参、赤芍、丹皮、桃仁、红花各 10g，升麻、连翘、生大黄各 15g，水蛭粉（吞）2g，甘草 5g。

用法：日 1 剂，水煎 2 次口服。

功效：养血活血，化瘀通络。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：方中黄芪补气升阳，托毒生肌。桃仁、红花、当归、丹参养血活血，水蛭破血化瘀，升麻升阳举陷；大黄通腑泄热，甘草调味和中。诸药组方，共奏养血活血、化瘀通络之功效，栓去脉通，肌生肉敛，达到临床治愈之目的。

加减：热毒甚者，加金银花、紫花地丁；湿浊重者，加苍术、厚朴；疼痛剧者，加延胡索、没药；虚寒著者，加附子、桑寄生等。^[5]

二、热毒证

1. 牛黄清络散（奚九一）

组成：人工牛黄、水牛角粉、三七各 2g，血竭 1.5g。

用法：水煎服，日1剂。

功效：清热凉营，化瘀止痛。

主治：血栓闭塞性脉管炎，急性期络热致瘀的发热，局部红肿，创面扩大，脓性分泌物增多，或伴有皮肤结节红斑，浅静脉呈索条状，大便秘结，小便黄赤，苔黄而腻等热毒闭阻络脉之症。

方解：方中以牛黄苦甘性凉，清心化热，能消痈疽疔毒；水牛角苦咸性寒，凉血解毒，清血热，破积血；三七甘微苦平，止血散瘀，消肿定痛；血竭甘咸性平，散瘀止痛生肌，“除血痛，为治积血之圣药”。四药配伍，具有清热凉营，化瘀止痛之功。

加减：如热毒壅盛，灼伤营分时，需加清热解毒药：生石膏、丹皮、紫草、知母、元参等，气营双清，邪有出路，使营分之邪热从气分而撤；若里热外寒者，坏死发展较快，但肢端皮温低，肤色苍白，创面肉芽暗紫，分泌物不多，局部肢端喜凉恶热，苔薄白腻者，需合并阳和汤，如麻黄、桂枝、干姜、附子、制川草乌等，温散外来之寒邪，使伏结营分之热毒易于清解。^[6]

2. 滋阴清热活血通脉汤（陈福恩、杨成林）

组成：金银花、当归、玄参、甘草各12g，乳香、没药各6g，牛膝、鸡血藤各25g，石斛15g。

功效：滋阴清热，解毒消肿。

主治：热毒型血栓闭塞性脉管炎。临床表现为：患者局部红肿剧痛，有汤泼火燃之感，晚期可出现溃疡，以拇趾及小趾多见，易向外蔓延，局部畏热，喜将患肢置于被外，疼痛难忍，抱膝呻吟，昼轻夜重，不能成寐，抱膝达旦，舌质红绛，苔黄厚，脉弦数。

方解：方中银花、石斛、玄参、甘草清热解毒、滋阴降火、软坚散结；当归、牛膝、乳香、没药活血通络、消肿止痛。^[7]

三、阳虚证

1. 温阳通脉汤（邱明朗）

组成：熟附子 40g（先煎），茯苓 12g，白术 15g，白芍 12g，干姜 10g，威灵仙 30g，毛冬青 30g，细辛 6g，白芥子 10g，甘草 10g。

用法：日 1 剂，水煎 2 次，早晚各 1 次温服。

功效：温阳通络。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：方中附子、干姜、白芍、茯苓、白术名真武汤，有回阳救逆，温中祛寒之功；黄芪温阳益气，扶正祛邪；威灵仙、毛冬青、细辛、麻黄辛温开腠，解痉止痛；白芥子温化寒湿；乳香、没药活血止痛；牛膝活血化瘀并引药下行；甘草调和诸药，缓急止痛。

加减：兼气虚者加黄芪、党参；血虚者加当归、阿胶；疼痛甚者加麻黄、乳香、没药；气血瘀滞明显者加桃仁、红花；痛在上肢者加桂枝；痛在下肢者加牛膝。^[8]

2. 温经通络汤（刘竹君、李福伟）

组成：附子、白芍、当归、川芎、桂枝、白术各 15g，党参、黄芪各 30g，干姜、肉桂、牛膝、丹参各 20g，甘草 10g。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：温经散寒通络，益气活血祛瘀。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：方中附子、干姜、肉桂、桂枝温经散寒通络；党参、黄芪、白术、甘草补气活血；丹参、当归、白芍、牛膝、川芎活血祛瘀。全方共奏温经散寒通络，益气活血祛瘀之功。^[9]

3. 温经活血汤（兰少敏）

组成：炮附子 15g，干姜 6g，当归 15g，赤芍 30g，地龙 12g，鸡血藤 30g，牛膝 15g，丹参 30g，炙甘草 6g，另用蜈蚣 1 条研细分冲。

用法：水煎服。

功用：温经散寒，活血通络。

加减：阴寒型者，加麻黄，重用炮附子 30g 以上，并先煎 20 分钟；血瘀型者，加桃仁，重用当归、蜈蚣；热毒型者，加金银花、地丁、赤小豆、玄参，去炮附子、干姜；气血两虚型者，加黄芪、党参等；肿胀加苡米；痛重加细辛、玄胡。根据需要少数病例可给一般止痛药辅助治疗。^[10]

4. 加减顾步汤（贾正红、王莉）

组成：银花 60g，川牛膝 30g，当归 20g，黄芪 15g，金石斛 30g。

加减：阳虚为主者，加熟附子 12g，气虚为主者，加人参 9g，血瘀为主者，加土鳖虫 10g，苏木 10g，伴有溃疡者，加虎杖 30g。

外用药：熟附子、透骨草、桂枝、鸡血藤各 30g，水煎去渣加入白酒 30g 浸泡患肢，每日 1 次，每次 30 分钟。^[11]

四、气血两虚证

1. 补阳还五汤加味(高维军)

组成：黄芪 50g，元参 25g，当归 20g，桂枝 15g，穿山甲(炮) 10g，赤芍、桃仁、红花、地龙各 8g，川芎、羚羊角(锉)各 6g，全蝎 3g。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：补气通经行血。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：方中黄芪补气行血，元参、羚羊角清热解毒；当归、赤芍、桃仁、红花、川芎活血化瘀；穿山甲、地龙、全蝎走窜经脉，通经络；桂枝温通阳气。全方合用能使气血充盛，经脉流通，血行肢端，肢端得到气血而愈。

加减：疼痛甚者，加玄胡 10g，洋金花 0.1g；肿胀明显者，加防己 20g；久治不愈，气虚明显者，黄芪逐渐加至 120g。^[12]

2. 益气通脉汤(曹科元)

组成：附片 20g，红参 15g，黄芪 30g，鸡血藤 20g，赤芍、红花、白芷、路路通各 10g。

用法：日 1 剂，水煎服。外洗方用麻黄 50g，桂枝 50g，透骨草 50g，浸洗 10~20 分钟。

功效：温经散寒，益气通脉。

主治：血栓闭塞性脉管炎。

方解：方中附片回阳通脉，合桂枝温经散寒宣痹；黄芪、红参补气，气为血帅，帅血运行；又有地龙扩张血管，加强通脉的作用；白芷使未溃者可消散，已溃者能排脓，具有生肌止痛之功效；丹参、赤芍、路路通、鸡血藤活血补血。

加减：热盛者去附片，加金银花、虎杖各 20g。^[13]

(陶晓华 张 林 贾鹰珏)

参 考 文 献

- [1] 韩青科. 五虫汤为主治疗血栓闭塞性脉管炎 81 例. 成都中医学院学报, 1991, 14 (4): 22
- [2] 詹学斌. 当归四逆汤加减治疗血栓闭塞性脉管炎. 浙江中医学院学报, 1985, (5): 24~25, 27
- [3] 冯永刚, 王荣, 铁刚. 活血通脉汤为主治疗血栓闭塞性脉管炎 60 例. 实用中医药杂志, 1996, 12 (4): 25~26
- [4] 张从道. 鸡花散治疗血栓闭塞性脉管炎 45 例. 辽宁中医杂志, 1995, 22 (12): 553
- [5] 刘斌. 化栓通脉汤治疗血栓闭塞性脉管炎 41 例. 四川中医, 1995, (9): 46
- [6] 奚九一. 牛黄清络散治疗血栓闭塞性脉管炎. 浙江中医杂志, 1986, (9): 404
- [7] 陈福恩, 杨成林. 滋阴清热活血通脉汤治疗脉管炎 100 例. 辽宁中医杂志, 1993, (5): 35
- [8] 邱明朗. 温阳通脉汤治疗阴寒型血栓闭塞性脉管炎 24 例. 国医论坛, 1995, (2): 30
- [9] 刘竹君, 李福伟. 温经通络汤治疗血栓闭塞性脉管炎 28 例. 陕西中医, 1998, 19 (12): 554~555
- [10] 兰少敏. 温阳活血法治疗血栓闭塞性脉管炎 23 例. 山东中医杂志, 1988, 7 (1): 23
- [11] 贾正红, 王莉. 顾步汤加减治疗血栓闭塞性脉管炎 20 例. 陕西中医, 1994, 10 (4): 22
- [12] 高维军. 补阳还五汤加味治疗血栓闭塞性脉管炎 36 例. 陕西中医, 1997, 18 (3): 126
- [13] 曹科元. 益气通脉汤治疗血栓闭塞性脉管炎的体会. 实用中西医结合杂志, 1995, 8 (6): 369

腰椎间盘突出症

1. 地龙舒腰汤（施维智）

组成：麻黄 3g，秦艽 9g，赤芍 9g，当归 9g，川芎 9g，地龙 9g，威灵仙 9g，川牛膝 9g，三七末 4g，陈皮 6g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：散寒祛湿，温经通络。

主治：腰椎间盘突出症，证属肾气虚感受风寒湿邪。症见腰部疼痛及下肢放射痛，腹压增高，疼痛加重。腰椎前屈生理弧度减弱或消失，腰椎侧弯畸形、椎旁压痛明显并放射至下肢，直腿抬高明显受限。

方解：腰痛病因甚多，其主要原因是感受风寒湿邪及肾气虚。当肾气虚时风寒湿邪乘虚而入，以致邪阻经脉，闭塞不通，筋脉失养而致疼痛，治以散寒祛湿，温经通络。地龙舒腰汤以麻黄散寒温经通络；威灵仙、川芎辛散温通，地龙活血通络利痹；赤芍、当归、三七辛散温通，祛瘀止痛，通利经络；秦艽治风湿痹痛，牛膝通经络，利关节。

加减：下肢疼痛剧烈者，加制川乌 6g，独活 9g；兼有游走窜痛者，加木瓜 6g，防己 9g；下肢麻木者，加土鳖虫 9g、蜈蚣 2 条；夜寐不安者，加合欢皮 9g，远志 9g，茯苓 9g；胃脘胀闷纳呆者，加生山楂 9g，佛手 9g，鸡内金 9g。^[1]

2. 海马全蝎汤（姚共和，李瑞霞）

组成：海马 10g，全蝎 3g，炙土鳖虫 10g，牛膝 10g，炮山甲 10g，木瓜 15g，蜈蚣 2 条。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：益肾壮腰，通痹止痛。

主治：腰椎间盘突出症。

方解：海马温肾壮阳，化结消肿，全蝎镇痉通络，为方中君药，以治突出物压迫神经根，神经根粘连水肿，腰腿痉挛疼痛等症；炙土鳖虫、炮山甲、蜈蚣性善走窜，能通经脉之痹阻，搜剔经络中风湿，是为臣；木瓜舒经活络，专治下肢麻木，用为佐药；牛膝入腰肾，引药下行，用为使。该方药专力胜，具有益肾壮腰，通痹止痛之功效，是为腰椎间盘突出症的有效良方。

加减：腰痛如刺，痛有定处，疼痛拒按，舌质紫暗，脉弦紧，或涩者，加三棱 10g，莪术 10g；腰腿冷痛重着，受寒及阴雨加重，肢体发凉，舌质淡，苔白或腻，脉沉紧，或濡缓者，加制川乌 6g，独活 10g；腰腿疼痛乏力，痛处伴有热感，恶热口渴，小便短赤，脉濡数，或弦数者，加川柏 10g，草薢 10g；腰酸痛，腿膝乏力，劳累更甚，手足不温，少气懒言，舌质淡，脉沉细者，加仙灵脾 15g，巴戟天 15g。^[2]

3. 痛安汤（伍新林，周继刚）

组成：制川乌、草乌各 5g，制乳香、没药各 10g，延胡索 15g，当归 10g，丹参 15g，牛膝 15g，蜈蚣 6g，全蝎 6g，白花蛇 6g，木瓜 6g 防风 10g，杜仲 15g，桑寄生 25g，独活 10g。

用法：水煎，早晚饭前分服，日1剂，15剂为1疗程。同时平卧硬板床休息。

功效：活血化瘀，散寒除湿，具有镇静、镇痛、解痉、抗炎、增强局部血液循环、改善神经根的粘连水肿炎症作用。

方解：中医学认为，本病属腰痛、痹证范畴，由于寒湿阻络或血瘀气滞，导致经络不通，不通则痛。方中制川乌、草乌温经散寒，麻醉止痛为主；延胡索、当归、丹参、制乳香、没药、牛膝养血活血；白花蛇、蜈蚣、全蝎、木香、独活、防风祛风通络解痉，抗炎散湿止痛；佐以杜仲、桑寄生强筋壮骨，抗炎镇痛止痛。^[3]

4. 扶正祛风利水方（安义贤）

组成：羌活 15g，独活 15g，秦艽 15g，当归 15g，川芎 10g，杜仲 15g，牛膝 6g，川断 15g，狗脊 20g，党参 20g，柴胡 15g，地龙 15g，土鳖虫 15g，泽兰 15g，姜黄 15g，白芷 15g，玄胡 15g，猪苓 15g，泽泻 15g，芦根 10g，木通 10g，丹参 15g。

用法：水煎服，1日1剂，分3次服，1周后复查。服药期间嘱患者减少活动，平卧硬板床。

功效：补肾强筋，祛风除湿，行气活血，利水消肿。

主治：急性腰椎间盘突出症和病程相对较短者。

方解：从中医角度来看，易致劳损之体，多以体质内虚为基础，劳损之后，又易遭风寒侵袭，治当补虚求源，祛除顽痹。故用当归、杜仲、牛膝、川断、狗脊、党参扶正补虚；羌活、独活、秦艽祛风除湿，一则补肾强筋，二则祛除宿邪，正所谓治病求本之意。椎间盘突出，压迫脊髓神经根产生疼痛、麻木、感觉减退等症状，同时压迫周

围的软组织产生充血水肿，又加重对神经根的压迫，治疗急当缓解压迫，解除症状，故以猪苓、泽泻、木通利水消肿；川芎、地龙、土鳖虫、泽兰、姜黄通行瘀血；玄胡、柴胡、白芷行气止痛。局部气血通畅，水肿消退，疼痛减轻，有利于椎间盘的回纳。全方合用则标本兼顾，既解标急症状，又能培本除痹以防再发。本方与众不同之处在于利水。观世人治该病皆以补肾强筋、祛风除湿、行气活血为法，本方亦不能脱离这个成熟之法，但配伍利水消肿药以治标，则是安义贤的独特经验。^[4]

(张银柱)

参考文献

- [1] 牛守国. 地龙舒腰汤治疗腰椎间盘突出症 80 例. 山东中医杂志, 1995, 14 (5): 213
- [2] 姚共和, 李瑞霞. 海马全蝎汤加中药电渗治疗腰椎间盘突出症. 中国中医骨伤科, 1996, 4 (3): 26~28
- [3] 伍新林, 周继刚. 痛安汤治疗腰椎间盘突出症 76 例. 河北中医, 1998, 20 (3): 168~169
- [4] 胡志俊. 安义贤扶正祛风利水方治疗腰椎间盘突出症 100 例观察. 中国医药学报, 1998, 13 (2): 76~77

坐骨神经痛

一、风寒湿滞型

1. 通经行痹汤（林沛湘）

组成：桂枝 10g，白芍 30g，炙甘草 8g，生姜 7g，大枣 15g，威灵仙 10g，独活 8g，徐长卿 20g，牛膝 10g，苏木 15g。

用法：清水煎服，每日 1 剂，5 天为 1 疗程，可连服 2~3 个疗程。

功能：散寒祛湿，调和气血，通经行痹。

主治：原发性坐骨神经痛，证属寒湿痹阻，气血凝滞者。

方解：坐骨神经痛中医多以痹证辨治。痹证的病因早在《内经》已有定论，此多因风寒湿邪留连筋骨，气血凝滞，营卫行涩，经脉不通所致。痹证病机大致相同，但其病位不同，则治疗有异。林氏善于根据痹证的病位，结合经络进行辨证施治，常收良效。坐骨神经的位置走向，与中医足太阳经脉相似。故方中借太阳经方桂枝汤之功，专通太阳经脉之阻滞，调和营卫气血之运行。用大量白芍配炙甘草，以缓经脉肌肉之拘急。独活长于祛腰以下风寒湿邪，合以威灵仙、徐长卿更能散寒祛湿，通络止痛。牛膝、苏木活血破瘀。其中牛膝、独活引药下行，使桂枝汤成为

有的之矢。全方证症对位，温通并用，峻而不燥。

加减：气虚加黄芪 15g；寒凝痛甚去徐长卿，加制乌头 6~10g（先煎）；腰痛酌加川断、杜仲、桑寄生；服药后偏热者加知母、黄柏各 10g。

禁忌：湿热及阴虚患者忌用。^[1]

2. 芍甘五藤汤（卢桂梅）

组成：白芍药、海风藤、宽筋藤、络石藤、鸡血藤、石楠藤各 30g，威灵仙 20g，入地金牛、延胡索各 15g，甘草 12g。

用法：以上中药水煎，成 300ml 药液，每日 1 剂，分两次空腹温服，药渣复煎外洗患肢 1 次。

功效：祛风通络，镇静止痛。

主治：坐骨神经痛，风湿所致者疗效较好，腰椎肥大骨质增生引起者效果次之，腰椎间盘突出引起者疗效欠佳，需结合其它方法治疗。

方解：芍甘五藤汤实为芍药甘草汤加藤类药物等组成。芍药甘草汤出自仲景《伤寒论》，该方有一定镇痛作用，从《伤寒论》的方药中可了解到仲景用芍药和甘草治疗痛症是颇为广泛的。论中 113 方中有用芍药甘草配伍的方剂计有 25 方，而 25 方中牵涉治疗各种痛证的方剂就占 11 条之多。其中治疗之痛症虽非全为芍甘之功，但也不能忽视其在止痛这方面的效能。白芍药味酸苦，性微寒，有养血和阴，平肝止痛作用。据药理研究，芍药的有效成分为芍药甙，对平滑肌有不同程度的松弛作用，能缓挛止痛。甘草性味甘平，有补脾益气，调和药性和缓急止痛的作用。现代药理研究甘草的主要成分为甘草甜素、甘草次酸、多种黄酮及甘草糖苷，具有肾上腺皮质样作用，有抗炎、抗过敏、

解痉、镇痛等作用，两药合用更加强缓急止痛之功。宽筋藤、海风藤、石楠藤、络石藤、鸡血藤等藤类药，都有祛风湿、舒筋活络的作用，性味均平和。鸡血藤还有补血活血作用。威灵仙性味辛温，能祛风湿，通络止痛走十二经。入地金牛有祛风消肿止痛作用，延胡索含延胡索甲、乙、丑素，亦有镇痛镇静作用。全方有祛风活络，镇静止痛之功。故运用此方治坐骨神经痛疗效确切。但白芍、甘草毕竟缓中之品，对中满、呕吐患者不一定适宜，服此方日久若食欲减退可停药，或稍用健脾理气之品而调治。本文所指芍药为白芍，赤芍亦有止痛之力，但有凉血活血作用，对血热有瘀血患者可用之。

加减：腰痛加桑寄生 30g，杜仲 15g，骨碎补 15g；下肢痛甚而又偏寒加川木瓜 15g，制川乌（先煎）6g；风湿热痛加桑枝、薏苡仁各 30g，黄柏 15g。^[2]

3. 独活寄生汤加减（吴学文）

组成：独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。

用法：每日 1 剂，水煎分 2 次服，9 天为 1 疗程，疗程中间隔 2~3 天。

功效：祛风逐湿，益肝补肾，宣痹止痛。

主治：坐骨神经痛，证属风寒湿邪阻滞经脉，气血运行失畅者。

方解：独活寄生汤出自《备急千金要方》，方中熟地、牛膝、杜仲、桑寄生补肝益肾，壮骨强筋；当归、白芍、川芎和营养血；人参、茯苓、甘草益气扶脾；独活、细辛搜其伏风，桂心祛寒；秦艽、防风祛风胜湿。据现代临床

药理研究，上方中牛膝、川芎、肉桂等均具有扩张周围血管作用；细辛、防风、当归、茯苓及独活等均有镇痛、抗炎、镇静等作用。临床应用此类西药往往亦具有一定疗效，但具有副作用较大，愈后易复发等缺点，与此相比，纯中药辨证加减之汤剂，就显略胜一等。当然，用药当首先排除一些坐骨神经痛的病因是否为肿瘤压迫所致。

加减：肾虚加仙灵脾；痛剧、拘挛不得屈伸重用川芎、白芍，并可酌加川乌、全虫；麻木不仁加鸡血藤；重着沉困加防己；热盛可去或少用细辛、肉桂心；寒盛可加附子；体壮之人可减地黄、人参。^[3]

4. 逐痹汤（林玉芬、陈本华）

组成：独活 15g，细辛 15g，制川乌 8～10g，牛膝 15g，木瓜 15～30g，防风 10～15g，甘草 5g。

用法：每日 1 剂，水煎服，煎煮 1 小时以上。

功效：散寒止痛，祛风除湿。

主治：坐骨神经痛，证属寒湿痛痹者。

方解：方中独活性味辛苦微温，具有祛风除湿、散寒止痛之功，且药性下行，为君药；细辛性味辛温，具有散寒止痛，祛风通络之用；制川乌性味辛苦热，温经止痛，祛风除湿，与细辛并用散寒之力有尤宏；防风辛甘微温，祛风解毒，胜湿解痛，可使邪从表散；三药均为臣药，助独活散寒止痛，祛风除湿；木瓜酸温，舒筋活络，与甘草共用，两药均可缓急止痛；甘草尚可解毒，能减轻细辛、制川乌的毒性作用，二药为佐；牛膝补肝肾，强腰膝，引药下行，为方中之使。

传统上认为“细辛不过钱”。作者从 10 多年的临床实践看，水煎剂毒性远远小于浸出剂和散剂，散剂和浸出剂

用量宜小，一般不要超过 3g。而汤剂用量可大，特别腰肢痹痛用量不能太小，少于 8g 疗效往往不佳。细辛一般用量在 10g 以内要煎煮半小时，用量在 10g 以上应煎煮 1 小时以上。因为其有效成分是甲基丁香酚，有毒成分是黄樟醚，后者挥发性强，长时间煎煮有毒成分大大下降，而不影响有效成分的煎出。

加减：寒甚加桂枝 10g，细辛用最大量 15g；湿重加薏米 30g，防己 15g；风邪重加秦艽 12g；化热现象制川乌、细辛用最小量 8g，加白芍 30g，海风藤 15g；兼有气虚加黄芪 15g；兼血瘀加丹参 15g，延胡索 15g；兼阳虚加肉桂 4g 冲服。^[4]

5. 蠲痹酒（刘安祥）

组成：鹿筋 150g，鹿衔草 100g，地龙 60g，川牛膝、杜仲、枸杞子各 50g，蜂蜜适量，饮用白酒（50°~55°）1 000ml。

制备：按酒剂冷浸法制备，上药除白酒及蜂蜜外，共研为粗粉合匀，装入布袋内扎紧，与蜜酒（取适量蜂蜜溶于白酒中搅匀即可）共入密闭容器内密封，浸泡 20 天。取出压榨过滤，滤液低温（1℃~10℃）静置沉淀 5 天，取清汁封装密封，置阴凉处储存备用。

用法：每次 10~20ml，温服，1 日 3 次，7 天为 1 疗程。

功效：祛风除湿，补肾壮阳，强筋健骨，活血通络，散寒止痛。

主治：坐骨神经痛。

方解：鹿筋、鹿衔草祛风除湿，补肾壮阳，强筋健骨；地龙活血通络，强筋治痿；川牛膝散瘀止痛，补肾壮骨，

可治寒湿痿痹，四肢拘挛；枸杞子、杜仲除风散寒，滋补肝肾，坚筋耐老，补益壮阳，以白酒为溶媒，可通血脉，御寒气，治风寒痹痛、筋脉挛急。诸药相伍可有祛风除湿，补肾壮阳，强筋健骨，活血通络，散寒止痛之功效。本品药源广泛，简便易行，无副作用，可供临床参考。^[5]

6. 漏痹镇痛汤（周天寒）

组成：制川乌、制草乌各 10g，细辛 6g，牛膝 15g，苍术 12g，防己 12g，制乳没各 10g，川芎 15g，桂枝 12g，甘草 6g。

功效：散寒除湿，通痹止痛。

主治：适用寒湿痹阻所致的坐骨神经痛。症见初起下半身酸痛，或不灵活，数日后出现坐骨神经部位的剧烈疼痛。痛由髋髂部向下，放射至大腿、小腿和足部，舌淡，苔白腻，脉弦紧，或缓。

方解：方中川草乌、细辛、苍术、防己散寒除湿；乳没、川芎活血化瘀，疏通经脉；桂枝温阳通络；牛膝引药下达病所；甘草调和诸药。诸药相合，共奏散寒除湿，通痹止痛之功效。

加减：若疼痛兼有血瘀加土鳖虫、桃仁以活血化瘀；腰腿胀甚者，加苏木、甲珠以行气通络；若筋脉挛急者，加白芍、木瓜以柔筋缓急。^[6]

7. 董建华自拟方（董建华）

组成：川乌 5g，麻黄 10g，桂枝 6g，白芍 6g，酒当归 10g，地龙 10g，木瓜 10g，甘草 5g。

功效：疏风阴破寒。

主治：坐骨神经痛，症见腰髋痛如掣，夜痛尤剧，形

寒肢麻，肢端不温，舌暗苔白，脉沉细。

方解：此方由《金匱要略》乌头汤化裁而来。乌头除寒开痹，善入经络，力能疏通痼阴沍寒，配伍麻黄宣透皮毛腠理，一表一里，内外搜散，止痛甚捷；桂枝通阳，地龙活络；当归、白芍开血痹以通经络；木瓜、甘草酸甘缓急。董氏认为川乌为治痹之必用之品，配伍麻黄，其力更宏。^[7]

二、气滞血瘀型

1. 坐骨神经痛煎剂（袁鸿雁）

组成：当归 30g，川芎 30g，忍冬藤 15g，鸡血藤 15g，制乳香 15g，制没药 15g，炒土元 15g，红花 20g，伸筋草 40g，川牛膝 15g，生麦芽 15g，三七粉（另冲服）。

用法：每日 1 剂，分 2 次服。

方解：方中当归、川芎、鸡血藤、三七粉、红花、土元活血化瘀，通络止痛；乳香、没药活血理气止痛；伸筋草舒筋活络，对筋脉拘急挛痛疗效甚佳；川牛膝既能活血柔筋，又能引药下行直达病所；麦芽健胃和中，以防大剂活血化瘀药损伤脾胃。全方共奏活血化瘀、通络柔筋、祛痹止痛之效。

加减：腰椎退行性变者，加生白芍 60g，炒杜仲 15g，木瓜 30g；腰椎间盘病变者，加川断 15g，炒杜仲 15g，狗脊 30g；闪腰岔气者，加黄芪 30g；遇寒者，加细辛 10～15g（先煎 30 分钟）；肢体麻木者，加马钱子 0.9g。

注：个别患者服用本煎剂后可出现恶心、胃脘不适等轻度胃肠道反应，此与体质有关。一般服用 3 剂后即可消失。若仍有反应，可改为饭后服药。此外，本病初起病势

较急，多用汤剂以控制病情，待疼痛去其大半可改用酒剂以巩固疗效。^[8]

2. 坐骨神经痛酒剂（袁鸿雁）

组成：小茴香 6g，木香 6g，陈皮 10g，玄胡 12g，穿山甲 5g，川牛膝 5g，独活 5g，甘草 3g。

用法：上药共为细末，加入 500ml 白酒中，浸泡 1 周后开始服用。每次 10～20ml，每天服 2～3 次，以饭前服为宜。

方解：酒剂量小药缓，主要用于坐骨神经痛日久痛缓，或巩固疗效之用。^[9]

三、肾阳虚衰型

固肾健步汤（娄多峰）

组成：熟地 30g，狗脊 20g，川牛膝 20g，木瓜 18g，制马钱子 1～6g（由 1g 渐加至 6g），当归 30g，白芍 30g，醋玄胡 15g，甘草 9g。

用法：水煎服，日 1 剂，10 天为 1 疗程，两个疗程间间隔 3 天。

方解：方中熟地、狗脊益肾精，补肾阳，固肾而养筋壮骨为主；当归、白芍养血而行血通络为辅；川牛膝、木瓜祛邪通络，兼养血柔筋，为治下肢痹痛之要药；制马钱子、玄胡止痛治标为协；甘草调和解毒。诸药相伍，固肾养筋骨为主，祛邪治标为兼。所以，遇急性外伤所致、新病实证者，不可套用。

方中马钱子有毒，但只要应用得当，非但不会发生毒性反应，而且会起到非常满意的效果。其诀窍有二：一是

要用制马钱子；二是要以小量逐渐加大剂量，可从 1g 渐加至 6g（每日增加 1g），一般病人用至 3g 即可，重者可用至 6g。

加減：寒盛痛剧者，加制川乌、草乌各 9g；湿盛重着者，去熟地，减甘草量，加草薢 20g，白术 20g，苡米 30g；风盛放射痛明显者，加威灵仙 20g，青风藤 30g，独活 20g；有热加白花蛇舌草 30g，败酱 30g；夹瘀加乳、没各 9g、田三七 6g（为末冲服）；病久者，加蜈蚣 3 条，全虫 9g，乌蛇 12g；气虚者，加黄芪 30g；肾阳虚者，加淫羊藿 15g，杜仲 15g。^[10]

四、肝肾阴虚型

四味芍药汤加味（贾松林、胡叶飞）

组成：白芍药 30g，生牡蛎 30g（布包先煎），丹参 25g，炙甘草 15g，醋延胡索 15g，苏木 18g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：柔肝养阴，缓急止痛。

主治：坐骨神经痛

方解：方中大剂白芍、甘草柔肝养阴舒筋，用于肝肾不足，筋脉拘急；丹参苦寒，活血通络；生牡蛎平肝潜阳。作者扩大该方的应用范围，加入延胡索、苏木二味，治疗坐骨神经痛，取得很好的疗效。作者认为，临床运用该方可根据偏寒、偏热、气血不足、肾虚及病程久暂增入不同药物，治疗原发性坐骨神经痛及腰椎肥大性脊椎炎所致的继发性坐骨神经痛，疗效显著。对腰椎间盘突出所致的继发性坐骨神经痛则无效。

加減：偏寒者，加独活 30g，制川乌 10g（先煎），附

片 10g (先煎); 偏热者, 加虎杖 18g, 忍冬藤 30g; 痛剧者, 加紫荆皮 15g, 丁公藤 10g; 痛久者, 加乌梢蛇 15g, 徐长卿 12g; 有骨质增生者, 加肉苁蓉 18g, 骨碎补 15g, 鹿角霜 15g。^[11]

(陶晓华 刘夕明)

参 考 文 献

- [1] 林沛湘. 通经行痹汤. 实用中西医结合杂志, 1992, (5): 307
- [2] 卢桂梅. 芍甘五藤汤治疗坐骨神经痛 52 例. 新中医, 1994, 26 (12): 34~35
- [3] 吴学文. 独活寄生汤化裁治疗坐骨神经痛 93 例. 黑龙江中医药, 1994, (1): 34
- [4] 林玉芬, 陈本华. 逐痹汤治疗坐骨神经炎 120 例. 福建中医药, 1994, 25 (4): 42
- [5] 刘安祥. 自拟蠲痹酒治疗坐骨神经痛 375 例. 辽宁中医杂志, 1993, (9): 29
- [6] 周天寒. 蠲痹镇痛汤治疗坐骨神经痛. 北京中医学院学报, 1989, (5): 30
- [7] 江一平, 沈桂祥, 储水鑫, 等. 中医辨证经验集萃·当代太湖地区医林聚英. 北京: 人民卫生出版社, 1995. 24
- [8]、[9] 袁鸿雁. 自拟坐骨神经痛方治疗坐骨神经痛 86 例. 国医论坛, 1997, 12 (5): 37
- [10] 娄玉铃, 娄高峰, 娄多峰. 固肾健步汤治疗坐骨神经痛 66 例. 中国骨伤, 1993, 6 (2): 29
- [11] 贾松林, 胡叶飞. 四味芍药汤加味治疗坐骨神经痛 46 例. 湖南中医杂志, 1997, 13 (2): 29

白 塞 病

一、 湿 热 熏 蒸

1. 白塞解毒汤（崔瑞阳、葛永久）

组成：石膏 100g，寒水石 50g，黄连 30g，黄药子 20g，白花蛇舌草 50g，蜈蚣 2 条，大黄 10g，芒硝 15g，当归 30g，甘草 30g，丹参 30g。

用法：每日 1 剂，水煎服，早晚 2 次服用。

功效：清热解毒，养血活血。

主治：白塞综合征。^[1]

2. 消溃散（崔瑞阳、葛永久）

组成：向日葵茎髓炭、香油。

用法：将两者调合，每日外敷溃疡面 2 次。

功效：消炎止痛，祛瘀生新。

主治：白塞病，由热毒内蕴过久所致。毒热内阻，营血失和，则发热，毒热蕴久，则腐气血而成溃疡。故应内外合治。内治宜清热解毒，养血活血；外治宜解毒消炎，祛瘀生新。白塞解毒汤中石膏、寒水石以清热为主，黄连、黄药子、白花蛇舌草、蜈蚣、大黄、芒硝有消炎止痛、解毒排毒之能；当归、甘草、丹参有养血活血、益气扶正之力。消溃散中向日葵茎髓炭、香油有消炎止痛，祛瘀生新

的作用。内外合治，彻底消解体内邪热痼毒。^[2]

3. 熊胆蒙花散（宫继宏、宫建雅）

组成：熊胆、黄连、蒙花、蒺藜、木贼、黄柏、竹叶。

用法：制成粉剂，每次 5g，每日 3 次，饭前服用。

主治：白塞病。方中集熊胆、黄连大苦大寒之品于一方，为君，以清泻心、肝、胆三经之火；辅以蒙花、蒺藜、木贼为臣，以祛风散热，明目退翳；佐以黄柏泻下焦之火；使以竹叶清泻三焦之火，导热下行，使邪热从小便出，上焦之热得解，乃火退目明。^[3]

4. 治惑丸（王子和）

组成：槐实、苦参各二两，芦荟一两，干漆（炒令烟尽）六分，广木香、桃仁（炒微黄）各二两，青箱子、明雄黄（飞）、各一两，水牛角三两。

用法：上九味，共研极细末，泛水为小丸，滑石为衣，每服一至二钱，每日二至三次。

方解：方中以苦参、槐实、芦荟为君，盖肝为厥阴之脏，木为生火之源，以其湿热蕴蒸，故投此三药直入厥阴以清其源，兼以燥湿凉血，清瘀化滞；方中伍以干漆以逐肠胃有形之积；桃仁破血行滞；青箱子清肝明目；水牛角清心除烦；雄黄辟邪解毒，并以木香之行气通滞，统领诸药而竟其功。

注：服用狐惑丸后，病者常有轻度腹痛，随后由大便排出大量粘液便，妇女或前阴排出浊液，或白粘如带，或乌褐如血，诸证亦常随之而轻解。^[4]

5. 升清降浊方（史方奇）

组成：柴胡 12g，银花 20g，地骨皮、苡仁、白茅根各

30g，厚朴 10g，板蓝根 10g。

用法：水煎分 6 次服，连服 7 剂。

功效：升清降浊，清热利湿。

主治：白塞病见口腔和二阴皆有痛性溃疡，溃疡面色淡红，脉濡者。

方解：本方用柴胡以升清阳；地骨皮以降浊为主，清浊既分，膈宣肠利而口糜烂自愈；佐以银花、苡仁、厚朴、板蓝根、白茅根清利湿热之品，倍增疗效。

加减：如溃疡面红色，舌红者，为热重于湿，宜加黄连 9g，菖蒲 3g 以泻心火；大便秘结者，加升大黄 3g，开水泡后兑药服；小便涩痛者，加菖蒲 15g，石韦 15g，黄柏 12g。^[5]

二、脾虚湿热

1. 补中益气汤加味（李孔定）

组成：党参 30g，黄芪 30g，白术 12g，当归 12g，升麻 12g，柴胡 12g，黄柏 15g，肉桂 3g，丹参 30，甘草 10g。

用法：水煎服，2 日 1 剂。

主治：白塞病。

方解：本病属虚实夹杂之证，其本为脾虚，其标为湿热瘀滞。故方用党参、黄芪、白术、陈皮、甘草补中益气，健脾除湿，以绝生湿之源；且黄芪有托毒生肌之功，“主痂疽久败疮”（《本经》），升麻“解百毒”（《本经》），柴胡疏肝，“平肝之热……兼治疮疡”（《本草正义》）；黄柏清热燥湿；当归、丹参活血化瘀；少佐肉桂引火归元，且能温运阳气，鼓舞气血生长，促进溃疡愈合。诸药合用，共奏补

中益气，清热除湿，活血化瘀之功，使脾气健运，则生湿之源绝；湿除、热清、瘀散，则溃疡自愈。

加减：舌苔厚腻，或白滑者，加苡仁，或苍术；口腔溃烂甚者，加栀子、淡豆豉；外生殖器溃烂甚者，加土茯苓；目赤者，加夏枯草、珍珠母；舌质暗红，或紫暗者，加红花。^[6]

2. 加味三才封髓汤（高辉远）

组成：太子参 10g，生地黄 15g，天门冬 10g，盐黄柏 10g，西砂仁 6g，炙甘草 3g，肥知母 10g，去皮桂枝 6g，赤芍药 10g，大红枣 5 枚。

主治：白塞病。

方解：方中太子参、炙甘草、砂仁、大枣补土行滞，黄柏、知母、生地、麦冬养阴泻火，赤芍、桂枝活血通络，全方共呈补土泻火，补虚不碍邪，泻火不伤阴，活血且通络。

加减：如若湿热毒邪亢盛，去桂枝加栀子、合成牛黄；低热不退者，加淡豆豉、丹皮；咽喉肿痛、口舌溃疡者，加莲子心、淡竹叶；眼色素膜炎、角膜溃疡者，加桑叶、晚蚕沙；龟头、阴唇、阴道、直肠溃疡明显者，加土茯苓、苍术；关节肿痛者，加薏米、桑枝；四肢皮肤红斑结节者，加紫草、泽兰；恶心呕吐者，去知母加姜半夏、竹茹；食欲不振者，加神曲、炒谷麦芽；气血两虚者，加生黄芪、白芍。^[7]

（张银柱）

参考文献

[1]、[2] 崔瑞阳，葛永久. 自拟白塞解毒汤治疗白塞氏综合征 38

- 例. 吉林中医药, 1998, (1): 41
- [3] 宫继宏, 宫建雅. “熊胆蒙花散”治疗白塞氏综合征 35 例. 北京中医, 1995, (5): 41
- [4] 王子和. 狐惑病的治疗经验介绍. 中医杂志, 1963, (11): 9~11
- [5] 史方奇. 升清降浊治白塞氏病. 中医杂志, 1990, (1): 60
- [6] 景洪贵, 张耀. 李孔定治疗白塞氏病的经验. 实用中西医结合杂志, 1993, (1): 5
- [7] 于有山, 王发渭. 高辉远治疗白塞氏综合征的经验. 吉林中医药, 1994, (2): 8

大动脉炎

一、气滞血瘀证

1. 当归四逆汤加减（陈治水）

组成：当归、桂枝、白芍、炙乳没各 15g，木通 10g，细辛 5g，大枣 5 枚，黄芪、鸡血藤各 15g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温经散寒，养血通脉。

主治：多发性大动脉炎（血虚感寒，经脉气血瘀滞）。

方解：桂枝、细辛温经散寒；当归、白芍、木通、大枣养血通脉；加入黄芪、鸡血藤以增强补气养血之功；乳香、没药增强活血通痹止痛之力。寒去脉通，气血充盛，则诸症消失。^[1]

2. 益气活血方（王进勇）

组成：生黄芪 60g，党参、丹参各 30g，桂枝 15~20g，牛膝 20g，银杏叶 9g，仙灵脾、麦冬各 24g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：益气活血。

主治：多发性大动脉炎。

方解：方中黄芪益气活血，鼓舞气血；党参、丹参益气活血祛瘀，重用桂枝，以通阳复脉；鉴于久病阳虚，责

之于肾，又选用了仙灵脾、肉苁蓉、鹿角胶等，以补精化气，温肾而不伤阴；银杏叶可通经活络，对血脉痹阻所致的头昏健忘，肢体困麻确有疗效，但胃脘胀痛或上逆者，用量酌减；伍麦冬以监制桂附辛温太过。全方通补兼施，辅佐得体，故久服无弊。

加减：气虚甚者，党参易红参；血瘀重者，加苏木、刘寄奴；肾阳亏损者，加附子、肉苁蓉、鹿角胶；气滞加陈皮、佛手，并服大黄廑虫丸 3g，日 2 次。^[2]

3. 黄芪桂枝五物汤加减（王春荣、李春雯）

组成：黄芪、桂枝、芍药、桃仁、红花、党参、白术。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：温运血行，活血通脉，软坚散结。

主治：多发性大动脉炎（气血双虚，瘀血阻络）。

方解：方中黄芪大补脾肺之气，取其“气行则血行”之意，黄芪又有调节免疫功能，增强网状内皮系统吞噬功能；配以桂枝温经通阳，协助黄芪达表而运行气血；芍药配当归、桃仁、红花养血活血化瘀，芍药行瘀，善行血滞，现代药理研究发现芍药有轻度扩血管、抗菌、消炎等作用，使之补中有行，行不伤正，则沉积易除，闭结易通，故肢体麻凉得缓。

加减：偏气虚瘀血阻络者，加党参、白术、当归、丹参；偏阳虚寒凝血瘀者，加附子、鹿角霜、土鳖虫、丹参、川芎；头晕头痛者，加葛根、丹参、川芎。^[3]

二、脾肾阳虚证

温阳益气通脉汤（王乾、陈建宗）

组成：干姜 10g，附子 10g，肉桂 10g，细辛 3g，黄芪

30g, 丹参 30g, 当归 10g, 川芎 10g, 水蛭 3g (研末冲服), 桂枝 10g, 川牛膝 12g。

用法: 每日 1 剂, 水煎服。

功效: 温阳益气通脉。

主治: 多发性大动脉炎。

方解: 方中干姜、附子、细辛、肉桂温阳通脉; 黄芪益气活血; 丹参、当归、川芎、水蛭活血化瘀通络; 桂枝温经通络; 川牛膝补益肝肾。诸药合用, 共奏温阳益气通络之功。

加减: 失眠加酸枣仁 12g, 石菖蒲 12g。^[4]

(陶晓华 张 林 贾鹰环)

参 考 文 献

- [1] 陈治水. 当归四逆汤治疗多发性大动脉炎. 四川中医, 1987, 5 (12): 27
- [2] 王进勇. 益气活血汤治疗多发性大动脉炎 70 例. 陕西中医, 1992, 13 (10): 433~434
- [3] 王春荣, 李春雯. 黄芪桂枝五物汤加减治疗多发性大动脉炎 34 例. 甘肃中医, 1992, 5 (1): 20~21
- [4] 王乾, 陈建宗. 温阳益气通脉汤治疗多发性大动脉炎 8 例. 陕西中医学院学报, 1991, 14 (4): 22

干燥综合征

一、阴津亏虚类

1. 玉女甘露汤（姜黎平、马影军）

组成：玉竹 30g，女贞子 20g，生晒参 5g（另煎），怀山药 20g，当归 15g，白花蛇舌草 15g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：滋阴润燥，调理脾肾。

主治：干燥综合征。

方解：玉竹、女贞子滋阴补肾，生津养液；生晒参、怀山药健脾胃，益气阴；当归养血活血；白花蛇舌草甘凉解毒。^[1]

2. 大补地黄丸加减（徐宜厚）

组成：生地、熟地各 12g，炒黄柏 10g，山药 15g，枸杞子 12g，当归 10g，炒知母 6g，山萸肉 12g，炒白芍 10g，肉苁蓉 10g，玄参 10g，花粉 10g，天冬、麦冬各 10g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：柔养肝肾，滋阴润燥。

主治：阴虚内热型干燥综合征。

加减：双目干涩和畏光者，加甘菊花、霜桑叶；视力下降者，加服石斛夜光丸；口干者，加花粉、乌梅；口苦

者，加焦山栀；鼻结血痂者，加黄芩、薄荷；关节肿痛者，加川断、老鹳草、鬼箭羽；进食困难者，加绿萼梅；腹胀者，加玫瑰花、佛手；口干少津者，加山豆根、挂金灯；腮肿者，加浙贝母、僵蚕、蜈蚣；龋齿者，加生石膏；干咳少痰者，加鱼腥草、紫菀；皮肤干燥发痒者，加何首乌、沙苑子、钩藤；大便干结者，加郁李仁、松子仁、麻仁；性欲淡漠者，加仙茅、仙灵脾、阳起石。^[2]

3. 石瑰芳方（石瑰芳）

组成：熟地、生地、玄参、枸杞子、茯苓、地骨皮、麦冬、天冬、石斛、玉竹各 15g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：补益肝肾，滋阴润燥。

主治：肝阴不足型干燥综合征。

方解：二地、二冬、沙参、玉竹、玄参、石斛均为滋阴补液之剂。枸杞滋肾养肝，山药补脾阴。用茯苓补脾渗湿，其意与六味丸用茯苓相同，诸药合用，共奏滋阴润燥，健脾渗湿之功。

加减：肝阴不足而兼气虚者，加太子参、黄芪、升麻；便秘者，加火麻仁。^[3]

4. 一贯煎加减（丁永敏、胡北平、戚清权）

组成：生地、天花粉、全瓜蒌、仙灵脾、大枣各 12g，知母、石斛、枸杞子、当归各 9g，太子参、淮小麦各 30g，生甘草 6g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：养阴清热，生津润燥。

主治：阴虚内热型干燥综合征。^[4]

5. 加味引火汤 (赵振兴、侯绍敏)

组成: 熟地黄 30~120g, 巴戟天 9~30g, 麦门冬 12~20g, 茯苓 6~9g, 石斛 15~30g, 沙参 15~30g, 五味子 6~9g。

用法: 水煎 2 次取汁, 分 2 次温服或频服, 日 1 剂。

功效: 补益肝肾, 滋阴清热。

方解: 方中选用《医方囊秘》载傅青主之引火汤(熟地黄、巴戟天、茯苓、麦门冬、五味子)重用熟地为君, 可由 30g 加至 120g, 其味甘, 性微温, 归肝、肾经, 大滋肾水补益真阴, 心、肝、肺、肾阴虚, 非此不能滋; 巴戟天辛甘微温, 能温补肾阳而性质柔润不燥, 一方面制约熟地滋腻, 一方面取其阳中求阴之义, 引火归源, 阴平阳秘, 诸证平和; 茯苓健脾益肾, 助津液运化输布使虚热下趋; 麦门冬、玄参、石斛、玉竹、沙参滋阴生津润燥; 五味子酸涩敛阴生津。阴液伤久必有虚火, 可酌加蒲公英、栀子、半枝莲清热除烦。诸药合用, 补肾滋阴润燥, 清降虚火, 肾水得滋, 津液生化有源, 输布有道, 故全身干燥可得到明显改善。

加减: 心烦躁热者, 加栀子、蒲公英; 咽干渴重者, 加知母、天花粉; 舌红有溃疡者, 加银柴胡、银花; 大便秘结者, 加大黄 5g, 芦荟 1g; 目干涩视物不清者, 加菊花、枸杞子; 咽痒声嘶者, 加乌梅、荆芥穗; 神疲乏力者, 加太子参、白术; 虚烦不寐者, 加炒酸枣仁、柏子仁。^[5]

二、脾胃虚弱类

1. 平胃散合二妙散加减 (章琴韵、沈小珩、茅声杰等)

组成: 制苍术 9g, 制川朴 6g, 藿香 9g, 佩兰 9g, 黄柏

9g, 陈皮 6g, 苡仁 12g, 广郁金 9g, 夏枯草 15g, 生甘草 3g。

用法: 每日 1 剂, 水煎服。

功效: 健脾和胃, 化湿清热。

主治: 脾胃湿热型干燥综合征。^[6]

2. 复方雷公藤制剂 (杨少锋、严碧玉、满红)

组成: 雷公藤 12g, 仙灵脾 12g, 黄精 15g, 牛膝 15g, 怀山药 20g, 枸杞子 20g, 茯苓 20g, 苡米 30g。

用法: 每日 1 剂, 水煎服。3 个月为 1 疗程观察疗效。病情好转以后应继续服药治疗, 或制成丸剂口服以巩固疗效。

功效: 健脾祛风除湿。

主治: 脾胃虚弱, 兼风湿痹证之干燥综合征。

加减: 肝肾亏虚为主配以杞菊地黄汤加减; 脾胃虚损为主配以四君子汤, 或参苓白术散; 若脾胃阴虚明显者, 加玉竹、麦冬、生地、西洋参等养阴润燥之品; 若湿热甚加川草薢、滑石等清热利湿之药。^[7]

3. 三仁汤合四君子汤加减 (石瑰芳)

组成: 杏仁 10g, 白豆蔻 10g, 砂仁 10g, 黄芩 10g, 厚朴 10g, 通草 15g, 滑石 15g, 竹叶 15g, 茯苓 15g, 苍术 15g, 白术 15g, 枸杞 15g, 黄芪 30g, 扁豆 30g。

用法: 每日 1 剂, 水煎服。

功效: 健脾益气, 清热利湿。

主治: 脾胃湿热型干燥综合征。

方解: 致病机理大致为脾虚不运, 水湿停聚, 湿遏化热乃成湿热。湿热内阻, 更兼脾虚不运, 津液敷布障碍, 口眼、肌肤、骨节、孔窍失其濡润, 故成此疾。故以三仁汤清其湿热, 以四君子汤补脾运湿。

加减：结膜充血加桑白皮、菊花、银花、赤芍；眼痒加木贼、蝉蜕、刺蒺藜；关节疼痛加桑寄生、威灵仙；口渴难忍加石膏、知母；角膜上皮脱落加石决明、密蒙花、乌贼骨。^[8]

三、气阴两虚类

1. 六味地黄丸合八珍汤加減（章琴韵、沈小珩、茅声杰等）

组成：生地、熟地各 9g，太子参 30g，炒党参 9g，全当归 9g，绵黄芪 12g，甘草 6g，怀山药 9g，制首乌 9g，黄精 9g，稽豆衣 9g，早莲草 15g，白术 9g，白芍 9g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：益气健脾，滋阴补肾。

主治：脾肾气阴两虚型干燥综合征。症见涎腺肿大，口眼干燥，伴有倦怠，便溏，易感冒，腰膝酸软，舌淡胖，边有齿印或有瘀斑，舌尖稍红，苔薄白腻，可见口糜。^[9]

2. 益气养阴法（洪用森、洪晓鸣）

组成：南沙参、北沙参、天冬、麦冬、太子参、元参、生地各 12g，生芪 15g，甘草、五味子各 10g，鲜石斛 30g。

用法：每日 1 剂，水煎服。服药 1 个月为 1 疗程，一般应用 2~3 个疗程。

功效：益气滋阴。

主治：气阴两虚型干燥综合征。

方解：太子参、黄芪、甘草甘温，补气要药，并能够影响环核苷酸代谢；生地、元参、麦冬等一派甘寒滋阴生津养液之品，对阴虚动物模型的核酸合成率有双向调节作用。由此推测，益气养阴法治疗本病可能是通过调整机体

自身免疫功能而起作用。

加减：脾胃虚损、纳呆脘胀者，加茯苓、白术；经脉痹阻、骨节疼痛者，加桑枝、海风藤；肾阴虚者，加仙灵脾、补骨脂。^[10]

3. 益气生津汤（王慕虹、张新、何止湘）

组成：炙黄芪 50g，党参 15g，炒白术 12g，麦冬 30g，生地 15g，玄参 15g，川石斛 12g，北沙参 15g，当归 15g，白芍 10g，熟地 25g，女贞子 24g。

用法：每日 1 剂，早晚煎服，30 剂为 1 疗程。

功效：益气养血，滋阴生津。

主治：脾、肝、肾功能受损，气阴两虚型干燥综合征。

方解：本方以黄芪、党参、白术益气健脾助运为主，辅以麦冬、生地、玄参、石斛养阴生津；当归、白芍、熟地、女贞子滋养肝肾。诸药相辅相成，能使阳生阴长、气旺津生，又可防止寒凉滋腻，损阳伤中。

加减：头晕耳鸣者，加枸杞子、甘菊花；手足麻木者，加丹参、鸡血藤；关节疼痛者，加桑寄生、络石藤；胃脘饱胀者，加木香、砂仁；口干疼痛、大便干燥者，加大生地、玄参用量。^[11]

四、外燥类

桑杏汤加减（章琴韵、沈小珩、茅声杰等）

组成：桑叶 9g，杏仁 9g，荆芥 9g，防风 9g，炙僵蚕 9g，半夏 9g，陈皮 6g，苦桔梗 6g，沙参 9g，麦冬 9g，板蓝根 30g，生甘草 9g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：疏风清热，宣肺布津。

主治：风热型干燥综合征。症见涎腺肿大，口眼干燥，伴有感冒诸症，腮腺反复肿胀，腺体导管口有混浊雪花样渗出物。舌偏红，或舌红、苔薄白或，薄白腻。^[12]

(陶晓华 邬洪波)

参 考 文 献

- [1] 姜黎平, 马影军. 玉女甘露汤治疗干燥综合征. 浙江中医学院学报, 1990, (3): 21
- [2] 徐宜厚. 大补地黄丸治疗 11 例干燥综合征报告. 中医杂志, 1990, (8): 42~43
- [3] 石瑰芳. 辨证治疗口眼粘膜干燥综合征 18 例. 成都中医药大学学报, 1996, (3): 33~35
- [4] 丁永敏, 胡北平, 戚清权. 中医辨证分型为主治疗口眼干燥、关节炎综合征. 上海中医药杂志, 1996, (8): 40~41
- [5] 赵振兴, 侯绍敏. 加味引火汤治疗干燥综合征 15 例临床观察. 河北中医, 1998, (4): 226~227
- [6] 章琴韵, 沈小珩, 茅声杰, 等. 口眼干燥关节炎综合征的中医治疗. 中医杂志, 1987, (2): 44~45
- [7] 杨少锋, 严碧玉, 满红. 继发性口眼干燥综合征 34 例疗效分析. 中国中西医结合杂志, 1993, (4): 230~231
- [8] 石瑰芳. 辨证治疗口眼粘膜干燥综合征 18 例. 成都中医药大学学报, 1996, (3): 33~35
- [9] 章琴韵, 沈小珩, 茅声杰, 等. 口眼干燥关节炎综合征的中医治疗. 中医杂志, 1987, (2): 44~45
- [10] 洪用森, 洪晓鸣. 益气养阴法治疗干燥综合征 7 例. 浙江中医杂志, 1987, (3): 118
- [11] 王慕虹, 张新, 何止湘. 益气生津汤治疗干燥综合征的体会. 实用中西医结合杂志, 1997, (5): 471
- [12] 章琴韵, 沈小珩, 茅声杰, 等. 口眼干燥关节炎综合征的中医治疗. 中医杂志, 1987, (2): 44~45

周 环 死

一、气滞血瘀型

1. 活血通瘀汤（李复耀）

组成：当归 20g，丹参、鸡血藤、牛膝、川断、骨碎补、补骨脂各 15g，全虫 6g，僵蚕 10g，蜈蚣 4 条。

用法：每日 1 剂，水煎分服。

功效：活血通瘀，通络接骨。

主治：股骨头无菌性坏死。

方解：方中当归、丹参、鸡血藤补血活血；骨碎补、补骨脂散瘀接骨；牛膝、川断通经引血；全虫、僵蚕、蜈蚣通络止痛。

加减：脾气虚弱加黄芪 30g，党参 15g；肾阴亏虚加生地 15g，山药 20g；寒湿凝结加细辛 6g，海桐皮 15g。^[1]

2. 复骨汤（袁兆昌、燕春茂）

组成：当归 12g，生熟地各 9g，赤芍 9g，川芎 9g，山萸肉 12g，附子 6g，肉桂 6g，补骨脂 9g，骨碎补 9g，山药 12g，淫羊藿 9g，仙茅 4g，独活 12g。

用法：每日 1 剂，水煎服，1 周为 1 疗程。

功效：活血化瘀，补肾壮骨。

主治：股骨头无菌性坏死。

方解：方中当归、赤芍、川芎等活血化瘀通经络；山萸肉、补骨脂、骨碎补、淫羊藿、仙茅等补益肝肾，壮筋骨为辅；山药健脾；附子、肉桂益肾壮阳为佐；以独活等祛风湿通痹止痛为使。诸药合用，具有促进新陈代谢、改善微循环、防止血液粘滞和溶血栓及使新的毛细血管再生。但对Ⅳ期病变，由于股骨头塌陷变扁，骨质硬化增生，血管的再生是很困难的。长期内服强的松和地塞米松片致骨质极度疏松，股骨头坏死Ⅳ期，也是如此。另外，治疗期间负重，不利于局部血液循环和血管的再生，应尽量避免。^[2]

3. 理气化瘀汤（张安楨等）

组成：当归、郁金、泽兰、枳壳、大黄、延胡索各6g，槟榔、赤芍、炙香附各9g，红花、陈皮、甘草、青皮各3g。

主治：股骨头坏死。^[3]

4. 活血镇痛汤（张安楨等）

组成：白芍、骨碎补、生地黄、枸杞子、当归、连翘、续断各9g，三七、川芎、炙乳香、炙没药各4.5g，桃仁、防风各6g，炙甘草3g，茯神12g。

主治：股骨坏死。^[3]

5. 跌打营养汤（张安楨等）

组成：西洋参3g（或党参15g），淮山药、熟地黄、枸杞子各15g，当归6g，白芍、黄芪、木瓜、骨碎补、续断、补骨脂各9g，砂仁、甘草各3g，川芎、三七各4.5g。

主治：股骨坏死。^[3]

6. 跌打补骨丸 (张安祯等)

组成：三七、血竭、酒大黄、川芎各 30g，五加皮、红花、苏木、酒防风、白芷、归尾、桃仁、扁豆、枳壳、木香、桔梗各 60g，杜仲、骨碎补、酒续断、白术、泽泻、茯苓各 90g，醋煅自然铜 150g。研细粉炼蜜为丸，每丸 9g，每日 2 丸。

主治：股骨坏死。^[3]

7. 梁氏活骨系列方 (梁红举)

(1) 生地黄、熟地黄、龙骨、牡蛎、龟甲、当归、红花、丹参、巴戟天、枸杞子。

(2) 牡丹皮、防己、茯苓、陈皮、薏苡仁、龟甲、鳖甲、黄芩、盐黄柏、盐知母。

(3) 丹参、当归、红花、川芎、陈皮、郁金、延胡索、枸杞子、熟地黄、龟甲。

(4) 再生散：鹿茸、人参、三七、海龙、海马、牛骨、紫河车、龟甲、鳖甲、何首乌、砂仁、黄芪、白豆蔻、肉苁蓉、淫羊藿。^[4]

二、肝肾不足型

1. 健骨汤 (孟庆荣、孟繁光)

组成：熟地 30g，菟丝子 20g，骨碎补 30g，川续断 15g，怀牛膝 15g，延胡索 12g，郁金 15g，制乳香、制没药各 9g，肉桂 6g，独活 12g，透骨草 20g，寻骨风 10g，自然铜 9g (醋淬，先煎)，鹿角胶 10g (烊化冲服)。

用法：水煎 400ml，早晚分服，每日 1 剂。

功效：益肾填精，强筋健骨，祛寒除湿，活血通脉。

主治：股骨头缺血性坏死症Ⅱ-Ⅳ期。

方解：方中熟地黄、菟丝子、鹿角胶补血益精填髓；川续断、怀牛膝、骨碎补、透骨草、寻骨风、自然铜补肝肾、强筋健骨；肉桂、独活祛风寒、胜湿止痛；郁金、延胡索、制乳香、制没药活血祛瘀止痛。

加减：气滞重者，加香附、陈皮；血瘀重者，加水蛭、土鳖虫；风寒湿重者，加制附子、威灵仙、苍术、苡仁；体虚者，加黄芪、紫河车；服激素引起者，加女贞子、何首乌。^[5]

2. 健髓汤（方臣芷）

组成：熟地黄 20g，鹿角胶（烔化）10g，骨碎补 15g，川牛膝 10g，续断 15g，蜈蚣 1 条，地龙 10g，黄芪 10g。

用法：每日 1 剂，水煎服，早晚各服 1 次。

功效：补益肝肾，化瘀活络。

方解：方中熟地黄滋阴养血，补肾生精；鹿角胶乃血肉有情之物，功擅益肾助阳，壮骨充髓；上两味合骨碎补、牛膝、续断共奏补益肝肾，强筋健骨之效；入蜈蚣、地龙可通瘀活络；方中伍以黄芪，取其益气且走而不守，促其气血畅旺。其中熟地黄、鹿角胶用量不宜减少，否则将明显降低疗效。倘若病人食欲欠佳，恐熟地过于滋腻，可用砂仁 5g 同杵。

加减：阳虚局部欠温，下肢畏寒乏力，久卧久坐痛甚，得适当活动痛略减者，加巴戟天 10g，桂枝 6g；阴虚五心烦热，盗汗，舌红少苔者，加龟甲 10g，鳖甲 10g；气滞血瘀，患髋刺痛，痛处不移，拒按者，加赤芍 10g，鸡血藤 10g；湿阻经络，下肢酸胀沉重，苔腻者，加薏苡仁 20g，

木瓜 10g^[6]

3. 益肾通络汤（滕内和等）

组成：熟地黄、肉苁蓉、山药、地龙、鸡血藤、牛膝。

加减：血瘀型去山药，加三棱、莪术；气血两虚加黄芪、党参。

效果：共治疗 70 例，优 40 例，良 16 例，可 9 例，差 5 例，优良率为 81.4%。^[7]

（张银柱）

参 考 文 献

- [1] 李复耀. 活血通瘀汤治疗股骨头无菌性坏死 18 例临床观察. 甘肃中医, 1994, 7 (3): 13~14
- [2] 袁兆昌, 燕春茂. 复骨汤治疗股骨头缺血性坏死 19 例疗效观察. 河北中医, 1997, 19 (2): 8~9
- [3] 张安祺, 等. 活血化瘀法治疗股骨头缺血性坏死. 福建中医药, 1981, (3): 19
- [4] 梁红举. 中药治疗 354 例成人股骨头无菌性坏死. 山东中医学院学报, 1993, (2): 46
- [5] 孟庆荣, 孟繁光. 健骨汤治疗股骨头缺血性坏死 37 例. 山东中医杂志, 1996, 15 (8): 354~355
- [6] 方臣芷. 健髓汤治疗股骨头缺血性坏死 60 例. 江西中医药, 1995, 26 (3): 41
- [7] 滕内和, 等. 成人股骨头缺血性坏死辨证分型与治疗. 中医药学报, 1992, (1): 31

过敏性紫癜

一、风热外袭型

1. 僵蚕防风汤（贾正生）

组成：僵蚕 12g，防风 12g，连翘 15g，地肤子 12g，苦参 10g，紫草 12g，丹皮 10g，赤芍 12g。

用法：水煎服，每日 1 剂，疗程长短据病情确定。

功效：清热利湿，凉血活血，解毒祛瘀。

主治：皮肤紫癜，骤然发病，发无定处，稍隆出皮面，伴轻度瘙痒，或有局部肿胀疼痛的特点。

方解：方中僵蚕、防风祛风；地肤子、苦参清热利湿；紫草、丹皮、赤芍、连翘凉血活血，解毒散瘀。此外，防风、苦参有抗过敏作用；紫草、丹皮、赤芍、连翘有抗炎、降低毛细血管通透性作用；防风、连翘有抗炎、解热镇痛作用；僵蚕、地肤子、苦参有抗菌消炎作用。

加减：舌暗或有瘀点者加桃仁、红花；关节肿痛者加秦艽、牛膝；并发感冒者加蝉衣、荆芥；腹痛、便血者加木香、地榆；血尿者加白茅根、旱莲草；便秘者加大黄；使用激素者，加生地、玄参。^[1]

2. 柴芩蝉衣煎（顾梯成、濮存莹）

组成：柴胡、黄芩、乌梅、防风、蝉衣、甘草、当归、

丹参、紫花地丁。

用法：水煎服，每日1剂，分2次服。

功效：疏风清热，活血化瘀。

主治：过敏性紫癜。

方解：方中柴胡、黄芩、蝉衣是疏风清热的要药，特别是黄芩，根据现代药理研究，能调节 cAMP 和抗变态反应，黄芩能抑制抗原与 IgE 结合，抑制肥大细胞释放组胺，而成为临床上较好的抗变态反应剂。

加减：肾型加益母草、荠菜花、扞扞活、白茅根、蒲黄炭等；腹型加白及、广木香、白芍、玄胡等；关节型选加寻骨风、络石藤等。^[2]

3. 抗敏消癜汤（魏玉姣）

组成：麻黄 4.5g，蝉蜕 15g，地龙 15g，荆芥 6g，防风 6g，丹参 15g，红花 9g，丹皮 10g，赤芍 9g，紫草 10g，牛膝 6g，甘草 6g。

用法：水煎服，每日1剂，7天为1疗程。

功效：疏风凉血消癜。

主治：血热型过敏性紫癜。

方解：方中麻黄抗过敏；地龙抗组织胺，可降低毛细血管的渗透性；蝉蜕清热疏风，有较强的脱敏作用；防风、荆芥祛风散邪；丹参、丹皮、紫草、赤芍、红花清热凉血，活血化瘀，有抗凝溶栓作用，可预防和治疗血管内瘀血及血栓；牛膝引药下行；甘草调和诸药。

加减：若腹痛者，加木香 9g，延胡索 9g 以理气止痛；关节肿痛者，加秦艽 9g，羌活 6g，独活 6g 以祛风通络；对紫癜性肾炎者，去麻黄加白茅根 30g，泽泻 9g，车前子 30g 以清热利湿。^[2]

4. 花蛇消癰汤（张廷伟）

组成：白花蛇 5～10g（先煎），蝉衣 10g，生地 15g，丹皮 10g，丹参 15g，防风 10g，牛膝 10g，甘草 6g。

用法：水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。10 天为 1 疗程。共观察 3 个疗程。

功效：祛风清热，凉血解毒。

主治：过敏性紫癜。

方解：方中白花蛇透骨搜风，药理研究证实具有抗炎、抗毒、抗过敏等作用，同时还可增强机体的免疫功能；防风、蝉衣疏风解毒；生地养阴清热，凉血止血；丹皮、丹参、牛膝活血化瘀，清热消斑。有研究证实，活血化瘀能扩张毛细血管，降低血管壁的通透性，改善微循环，加速皮肤紫癜的吸收。甘草清热解毒，调和诸药。本方功能祛风清热，凉血解毒，可使邪除瘀去，血归经脉，紫癜消退。

加减：腹痛甚者，加延胡索、白芍；尿血者，加白茅根、大、小蓟；便血者，加炒槐花、地榆；关节肿痛者，加秦艽、忍冬藤；气血两虚者，加黄芪、党参、大枣；阴虚火旺者，加知母、黄柏；热毒亢盛者，加金银花、生石膏。^[4]

5. 金蝉脱衣汤（倪菊秀、董幼祺）

组成：连翘、银花、防风、蝉衣、苡仁、茵陈、猪苓、苍术、赤芍、红枣、郁金、桂枝。

方解：方中以连翘、银花、猪苓、苍术清化湿浊；赤芍、红枣以和血脉；桂枝性温，力善宣通而散邪气，但用量不宜重；郁金既能解郁理气以助化湿，与桂枝、赤芍、红枣合用又能调和营卫。诸药合用，使热清湿化，血归经

脉，则紫癜自退。^[5]

6. 消风宁络饮（曹向平）

组成：炒防风 10g，炙黄芪 15g，炒赤芍 10g，大生地 15g，炒丹皮 10g，牛角腮、生槐花各 15g，炙甘草 5g，红枣 10 枚。

功效：消风凉血，散瘀宁络，调整营卫。

方解：方中防风为祛风之要药，可祛头面及全身之风邪；生槐花功能凉血，祛血中之风热，两药相伍共奏消风宁络之功；赤芍为清热凉血之佳品，丹皮功专散瘀，生地滋阴清热，凉血止血，牛角腮为黄牛或水牛角中的骨质角髓，味苦性温，为止血祛瘀之品，疗血症之要药，上药合伍而成凉血散瘀之功；黄芪、炙甘草、红枣、生地和营养阴益气，黄芪更有补气以加强活血散瘀，托里排毒之功效；芪、草、枣味甘性温，和营之同时能制约凉血药之寒遏；黄芪、防风有“玉屏风散”之意，主固护卫气，扶正固本。综观全方，药味虽少，然配伍精当，选药精练，内外结合，寒温并用。

加减：伴明显腹痛者，去丹皮、赤芍，加白芍 15g，木香 10g；下肢浮肿者，加黑大豆 15g，泽兰叶 10g；尿血者，加地肤子 10g，茜草、大小蓟各 15g。^[6]

二、血热妄行型

1. 抗敏汤（李炳绪）

组成：丹参、茜草、紫草、鸡血藤各 30g，大枣 6 枚。

用法：水煎服，每日 1 剂，分两次服，儿童减量。

功效：活血凉血，解毒透疹。

主治：过敏性紫癜（排除血小板减少性紫癜之诊断）。

方解：方中茜草苦寒，有凉血止血祛瘀之功，对各种出血或瘀滞之证均有效。现代药理研究表明，茜草对多种细菌有抑制作用，并能缩短出凝血时间，并有止咳化痰之功。紫草能活血凉血，解毒透疹，能解血分热毒；其性寒，能清解消化道之热毒，具有利大肠之功。丹参活血祛瘀，凉血消肿，并能养血安神。鸡血藤行血补血，舒筋活络，无论血瘀、血虚或血虚兼有瘀滞之证者，皆可适用。大枣具有补脾益胃养血之功，能加强脾的统血功能，以防血液外溢。本方配伍特点：一是清中有补，具有寒性的茜草、紫草、丹参能清热解毒，具有甘温的鸡血藤、大枣能补血健脾益气，祛邪而不伤正，扶正以助祛邪。二是通中寓止，前三味药皆能活血祛瘀通血脉，使离经之血消散，而茜草又有止血之效；鸡血藤、大枣益气健脾、舒筋活络，使脾健运，血脉通畅，在经之血既不得瘀滞又不能外溢。诸药配合起到了能清能补，能通能止之作用。

加减：单纯皮肤型加荆芥、金银花、防风、蝉衣；皮肤关节型加防己、威灵仙、秦艽、忍冬藤；腹型加生白芍、生甘草、山楂炭、大黄炭；肾型加旱莲草、车前子、白茅根；紫癜肾炎血尿严重者，加小蓟、蒲黄、仙鹤草；紫癜肾病加坤草、泽兰、泽泻、山药、生山楂；蛋白尿严重者，加党参、黄芪；痒甚者，加蝉衣、白鲜皮、地肤子；便血者，加云南白药、地榆、白及、三七粉；便秘者，加川军或川军炭；便溏者，加白术、炮姜、山药、薏米；心烦易躁、舌红绛者，加生地、麦冬、栀子、元参；咽痛者，加牛膝、连翘、山豆根；咳喘者，加杏仁、桔梗、黄芩；气血两虚者，加当归、党参、黄芪；月经多加生龙牡、阿胶。^[7]

2. 消斑汤 (孙培成)

组成：紫草、赤芍、生地各 10~20g，地榆、白鲜皮、蝉蜕、甘草各 5~10g。

用法：水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。

功效：凉血解毒，活血消斑。

主治：过敏性紫癜。胸腹四肢皮肤可见斑疹块，或有上下肢关节疼痛；或有腹痛、恶心；或腰痛、血尿等表现。

方解：方以紫草为主药，入血分，凉血解毒利尿，引邪气从尿中排出；生地黄清热滋阴，营养血管神经；地榆凉血止血；赤芍清理脉道瘀血；蝉蜕、白鲜皮、甘草分解毒素，提高人体免疫力，抗炎、抗过敏、抗凝血。诸药合伍，清热不伤阴，祛瘀不留邪，止血不留瘀。

加减：食欲不振者，加砂仁 5g；腹痛者，加白芍 6~15g；呕吐者，加竹茹 6~15g；上肢关节疼痛者，加羌活、桑枝 5~6g；下肢关节疼痛者，加独活、牛膝各 6~15g；伴小便不利者，加茯苓、泽泻各 5~10g；有血尿者，加白茅根 10~20g；热重者，加黄连、栀子各 5~9g；湿重者，加苍术、厚朴各 5~10g。^[8]

3. 化斑消癜汤 (李玉兰)

组成：土茯苓 15g，紫草 10g，生地 12g，丹皮 10g，当归 10g，川芎 10g，地龙 10g，防己 10g，苍术 10g，薏苡仁 12g，白鲜皮 12g，地肤子 12g。

用法：以上药量为 10 岁儿童用量，小可适当减量，大可适当加量。水煎服，每日 1 剂，早晚食远分服。

功效：凉血活血，祛风除湿。

主治：关节型过敏性紫癜。

方解：方中以土茯苓清热解毒，除湿利关节；紫草、生地、丹皮、当归、川芎、地龙清热解毒化瘀，疏通络脉，改善血管脆性，恢复其弹性；防己、苍术、薏苡仁祛除血道污浊湿邪，其中防己除有利水、消肿、祛风止痛之效外，还有抗过敏、清热镇痛、扩张血管及改变血管通透性的作用；白鲜皮、地肤子脱敏清热祛风胜湿。^[9]

4. 加味犀角（清热）地黄汤（叶进、孙秩秋）

组成：水牛角片（代犀角）15g，生地、丹皮、赤芍各12g，黄芩、紫草各5g，荆芥穗、蝉衣各10g，甘草3g。

用法：水煎服，每日1剂，分2次服。

功效：清热凉血，化瘀止血。

主治：过敏性紫癜。①近期内有感染，或食物、药物过敏等历史；②临床表现以皮肤紫斑为主，或伴有腹痛、便血、关节肿痛、蛋白尿；③血小板正常，尿常规可有红细胞、蛋白尿等。

方解：本方取水牛角清热凉血；紫草、丹皮、赤芍凉血活血；黑荆芥、蝉衣疏风止痒，祛瘀止血；黄芩、甘草清热解毒。

体会：激素能控制紫癜发作，但容易复发，采用中药加味犀角（清热）地黄汤能够控制紫癜发作，而且不容易复发，对激素治疗无效者，亦有效果。据现代药理研究，赤芍、丹皮有扩张血管，改善微循环作用；水牛角可增加血管收缩力，有利于渗出吸收；甘草有解毒抗炎、抗变态反应及糖皮质激素样作用。黄芩、紫草有抗炎作用。从而推测本方有解毒、抑制变态反应、调节血管透性、发挥止血作用。

加减：流涕咽痛者，加金银花、连翘各10g，薄荷3g；

关节红肿灼痛者，加怀牛膝、秦艽各 12g，忍冬藤 15g；腹痛者，加白芍 15g，玄胡 20g，煨木香 5g；便血者，加地榆炭、槐花各 10g；尿有蛋白者，加雷公藤、鸡血藤各 10g。^[10]

5. 青紫汤（李素亭、王瑞霞、陈熙）

组成：青黛 3g，紫草 9g，乳香 6g，白及 9g。

用法：上药加水 300～500ml，煎至 150～200ml，分 2～3 次口服，每日 1 剂。

功效：清热凉血退癜。

主治：过敏性紫癜（排除血小板减少性紫癜之诊断）。

方解：方中青黛清五脏之热，平肝凉血；紫草凉血，走皮肤，透邪于外，与青黛相伍，清透内外之热而宁血；白及苦、甘、涩、凉，入肺肾，苦凉清肺治其本，甘缓止痛，能解除胃肠平滑肌痉挛，治疗腹痛及胃肠出血，涩则收敛止血治其急，入肾经兼以治肾护阴；乳香活血通络，一去凉血之弊，一为新血开道。四药合用，妄行之血可宁，越府之血可归，热去血平，适用于各型紫癜。

加减：单纯皮肤型：若皮疹颗粒小而稀疏，伴有表证者，加金银花 9g，板蓝根 12g，白芷 6g，焦山楂 9g；紫癜量多呈片状，伴气营热证去乳香，加寒水石 15g，丹皮 9g，水牛角粉（代犀角粉）10g（冲）；皮肤关节型：加钩藤 6g，木瓜 6g，威灵仙 6g，忍冬藤 12g；腹型：大便下血，色鲜红，伴肛门灼热，大便不爽者，加地榆 10g，白头翁 6g，黄连 4g，赤小豆 30g；大便色黑呈柏油样，紫癜色淡者，加伏龙肝 15g，干姜 5g，阿胶珠 9g，黄芪 15g，黄精 9g；腹部窜痛，攻冲起块者，加白芍 15g，延胡索 9g，沉香末 0.5g（冲），甘草 6g。肾型：血尿加大、小蓟各 9g，

白茅根 15g，旱莲草 9g，生地 12g，凤尾草 9g，倒扣草 9g；
肾病型：加益母草 15g，凤尾草 9g，倒扣草 9g，泽兰 15g，
泽泻 30g，生山楂 15g，山药 15g，生地 12g。

体会：皮肤改变以“疹”为主，不融合成片者，宜从肺治；皮肤改变以“斑”为主融合成片者，宜从胃治；紫癜反复出现，宜从脾治；紫癜合并肾炎、肾病宜从肾、从瘀治。^[11]

6. 加减四物汤（余克涌）

组成：当归尾、赤芍各 6g，生地、荆芥、陈皮各 7g，
川芎、蝉蜕各 5g，甘草 3g。

用法：以上为 2~5 岁儿童用量，6~9 岁各加 2g，10
岁以上各加 3g。每日 1 剂，水煎两次，分四次服。

功效：活血化瘀消斑。

主治：过敏性紫癜。

方解：方中荆芥、蝉蜕开发腠理，透解在表风邪；生地清热凉血；当归尾、川芎、赤芍活血化瘀。“故凡血证，
总以祛瘀为要”，陈皮理气，“气行则血亦行”，甘草调药和中。

加减：血热妄行加紫草、丹参；气不摄血加太子参、
黄芪。^[12]

7. 三参二白汤（谷壅安）

组成：党参、苦参、丹参、茜草、仙鹤草、白蒺藜各
15g，白鲜皮、地肤子各 12g，地榆、丹皮、赤芍、广木香
各 10g。

用法：水煎服，每日 1 剂，分两次服。

功效：活血化瘀，凉血止血，泻火解毒，祛风健脾。

主治：过敏性紫癜。①有过敏史及接触某些变应原而引起之皮肤紫癜、关节痛、腰痛、肾脏损害者；②血小板计数、出、凝血时间、血块收缩时间均正常；毛细血管脆性实验阳性，嗜酸性粒细胞增多；血尿；③骨髓象正常者。

方解：方中党参甘温以补中益气，配丹参、丹皮则益气活血而散瘀，并清热以凉血，主治血热妄行之斑疹瘀血；茜草、地榆、苦参、白鲜皮均系苦寒之品，以凉血止血，并清热解毒，祛风燥湿；白蒺藜微温，疏肝祛风，配芍药、丹皮和阴血而泻肝火及血中之伏火。诸药配合，祛瘀凉血，清热消肿，可缓解关节及腹部不适。

加减：肾阳不足，气血两虚明显者，加黄芪、当归、枸杞、菟丝子、生地、地骨皮、升麻；湿热犯血、脾阴不足者，加藕节、地骨皮、蝉蜕、玄参、防风、苍术、蛇床子、僵蚕。^[13]

8. 加减化斑汤（刘凤莲）

组成：丹参 15g，生地 15g，茜草 30g，紫草 10g，丹皮 10g，连翘 15g，鸡血藤 20g，生甘草 10g，大枣 5 枚。

用法：日 1 剂，水煎 300ml，早晚两次分服。小儿酌减。

功效：清热凉血化斑。

主治：过敏性紫癜。

方解：方中丹参活血祛瘀消肿为君；生地、丹皮、茜草、紫草、鸡血藤、连翘清热解毒，凉血止血为臣；伍以大枣、甘草益血止血，调和诸药。全方共奏清热凉血化斑之效。

加减：①血热型：症见紫癜密集，色鲜红，腹痛便血，

舌红苔黄，上方加赤芍、地榆炭各 15g，大青叶 20g。②湿热型：症见紫癜色暗或起疱，关节肿痛、血尿，舌质红，苔黄腻，加苍术 15g，牛膝 10g，薏苡仁 15g，白茅根、小蓟各 30g。③风热型：紫癜鲜红，皮肤瘙痒，或有表证，加防风 12g，牛蒡子 10g，白鲜皮 15g，蝉蜕 10g，去丹皮。④阴虚型：紫癜反复发作，低热盗汗，舌质红少苔，脉细数，加知母 15g，黄柏 10g，旱莲草 15g。⑤气虚型：紫癜反复发作，色淡，面色萎黄，加黄芪、党参各 15g，阿胶 10g。腹痛便血重，不能进食者，给予补液及氟美松治疗。^[14]

9. 二蓟饮（任晓黎）

组成：鲜小蓟 300g，鲜大蓟 200g，生地 10g，赤芍 10g，丹皮 10g，当归 10g，茜草 10g，紫草 10g，仙鹤草 10g，连翘 10g，黑山栀衣 10g，三七粉 6g（冲服）。

用法：先将干药浸泡后文火煎 20 分钟，然后纳入鲜二蓟（洗净、切碎），文火煎 10 分钟。留取药液分 2~3 次温服，三七粉分 2 次冲服，每日 1 剂，7 天为 1 疗程。临床症状消失后，一般应继续服用 2~3 个疗程。

功效：清热凉血，活血止血。

主治：过敏性紫癜。

方解：方中大、小蓟凉血止血功效卓著，且鲜品功效优于干品，故清热解毒，凉血止血效果显著；配合生地、连翘、山栀以清热解毒；赤芍、丹皮、茜草、紫草、仙鹤草以凉血、活血、止血，且止血不留瘀。

加减：关节痛加牛膝、鸡血藤、伸筋草各 10g；腹痛加木香、白芍、玄胡各 10g；合并紫癜性肾炎加黄芪、白茅根、车前草各 15g，同时口服雷公藤多甙片。^[15]

10. 紫参化斑汤 (郑昌发、王仁飞)

组成：紫草、丹参、车前子各 9g，当归、牛膝、葛根各 6g，银花、连翘各 12g，生地榆、侧柏叶、白茅根各 15g，生甘草 3g。

用法：每日 1 剂，水煎服 3 次。

功效：凉血止血化斑。

主治：小儿过敏性紫癜。

加减：风热型属风热搏结期，加防风、蝉衣各 9g；属热盛期，加生地、玄参各 9g，丹参 12g；腹痛甚加白芍 10g，甘草增至 5g；湿热型加薏苡仁 12g，六一散 6g；若下肢水肿，加泽泻 9g；关节痛甚加威灵仙 9g；血滞型加干姜 6g，桂枝 9g，茯苓 12g；若气虚血滞加黄芪、茯苓各 12g，白术 9g，大枣 6 枚；阴虚型加黄柏、知母各 9g，柏子仁 6g。^[16]

11. 龟杞汤 (刘玉梅、杜秀英)

组成：龟甲 30g，枸杞子 20g，仙鹤草 15g，丹皮 10g，丹参 12g，三七粉 1.5g (冲服)。

用法：水煎服，每日 1 剂。

功效：补阴清热，凉血活血。

主治：儿童过敏性紫癜。

方解：在治疗本病的过程中，重用了补阴药，目的在于补阴以清血中之热，并加用了凉血活血的药物。方中龟甲、枸杞子补阴清热以治其本，仙鹤草、丹皮清热凉血，丹参、三七粉活血化瘀，促进紫斑的消退以治其标。诸药合用，共奏滋阴清热，凉血活血，标本兼治之功效。

加减：风热重者加防风、白鲜皮、紫草；热毒盛者，

加金银花、蒲公英。^[17]

三、脾胃湿热型

泻黄散(许德军、何文华)

组成:石膏、山栀、藿香、防风、紫草各 10~15g, 生地 20~25g, 大黄 3~6g。

用法:热盛用生大黄且后入煎剂;紫癜颜色鲜红,或伴有鼻衄、牙龈出血者用大黄炭;病久、反复发作,紫癜色紫暗者,用酒炙大黄。水煎服,每日 1 剂。

功效:清泻脾胃,活血化瘀。

主治:过敏性紫癜。

方解:方中石膏辛寒以治其热;山栀苦寒以泻其火,共奏清上撤下之功。防风升散脾中伏火,与石膏、山栀同用,清降与升散并进,使之不伤脾胃之阳;藿香芳香醒脾,一以恢复脾胃气机,一以防防风升散脾胃伏火;生地既能清热凉血,养阴生津,又能活血化瘀,开通闭塞;大黄“止血而不留瘀,尤为妙用”,“入血分,破一切瘀血”,又善清热解毒,更可荡涤污浊之邪,生用清热泻下,炒炭偏于止血,酒炙则活血为主;紫草清热,凉血活血。

加减:紫癜密集、融合成片者,加丹皮;紫癜高出皮面,或伴瘙痒者,加秦艽、荆芥;手足背肿胀者,加白茅根、车前草;四肢关节胀痛者,加川牛膝、鸡血藤;腹部刺痛或绞痛者,加用失笑散;腹痛隐隐者,加白芍、生甘草;血尿者,加白茅根、仙鹤草,另吞琥珀末 0.5~1g,加冲三七粉 1~3g;蛋白尿者,加益母草、石韦;紫癜反复发作,加生黄芪、干地龙。^[18]

(陶晓华 张 林 贾鹰珏)

参 考 文 献

- [1] 贾正生. 僵蚕防风汤治疗过敏性紫癜 48 例疗效观察. 甘肃中医学院学报, 1994, (3): 29~30
- [2] 顾梯成, 璞存莹. 柴芩蝉衣煎加味治疗过敏性紫癜 68 例分析. 中医杂志, 1994, 35 (6): 349~350
- [3] 魏玉姣. 小儿过敏性紫癜 32 例治验. 国医论坛, 1997, 12 (5): 33
- [4] 张廷伟. 花蛇消癜汤治疗过敏性紫癜 52 例. 江苏中医, 1997, 18 (10): 23
- [5] 倪菊秀, 董幼祺. 小儿过敏性紫癜治验. 上海中医药杂志, 1982, (6): 25
- [6] 殷晓明. 曹向平教授治疗过敏性紫癜的临床经验. 江苏中医, 1991, (10): 1
- [7] 李炳绪. 抗敏汤治疗过敏性紫癜 38 例. 实用中西医结合杂志, 1994, (6): 334~335
- [8] 孙培成. 消斑汤治疗过敏性紫癜 18 例. 安徽中医学院学报, 1994, (3): 29
- [9] 李玉兰. 自拟化斑消癜汤治疗关节型过敏性紫癜 230 例. 内蒙古中医药, 1992, (4): 2
- [10] 叶进, 孙铁秋. 加味犀角地黄汤治疗儿童过敏性紫癜 52 例. 江苏中医, 1991, (9): 16~17
- [11] 李素亭, 王瑞霞, 陈熙. 青紫汤治疗过敏性紫癜 200 例报告. 中医杂志, 1990, (5): 32~33
- [12] 余克涌. 四物汤加减治疗小儿过敏性紫癜 25 例. 湖北中医杂志, 1988, (6): 18
- [13] 谷壘安. 三参二白汤治疗过敏性紫癜——附 42 例临床观察. 湖南中医杂志, 1985, (4): 15~16
- [14] 刘凤莲. 化斑汤加减治疗过敏性紫癜 96 例. 山东中医杂志, 1997, 16 (12): 547
- [15] 任晓黎. 二萸饮治疗过敏性紫癜 42 例小结. 国医论坛, 1997,

12 (5): 35

- [16] 郑昌发, 王任飞. 紫参化斑汤治疗小儿过敏性紫癜 52 例. 浙江中医杂志, 1997, 32 (7): 323
- [17] 刘玉梅, 杜秀英. 龟杞汤治疗儿童过敏性紫癜 42 例. 陕西中医, 1997, 18 (8): 349
- [18] 许得军, 何文华. 泻黄散治疗过敏性紫癜. 浙江中医杂志, 1997, 32 (6): 273

肩关节周围炎

一、气血不通，经络凝滞

1. 肩凝散（阮孝廉、黄秀真）

组成：皂角 60g，羌活 30g，桂枝 30g，灵仙 30g，白芷 30g，姜黄 30g，乳香 30g，没药 30g，绞股蓝 30g，制马钱子 20g，细辛 20g，冰片 5g，蜈蚣 20g，陈醋适量。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：活血通络，温阳止痛。

主治：肩关节炎，气血不通，症见上肢上举不过 90°，活动严重受限。

方解：肩凝症多因老年气衰，血脉不充，筋骨失养所致；或因睡卧露肩，风寒湿邪外袭，三阳脉络凝滞，气血不通而痛。虽不危及生命，然病程长，采用辛温走窜，通络散结之皂角、灵仙、细辛直达病所，以治肩臂屈伸不利；配羌活、桂枝祛风寒湿邪，温经通阳而止肩臂酸痛；白芷、乳香、没药、姜黄祛瘀通络，消肿生肌以疗痛利臂；制马钱子、蜈蚣通络散结，消肿止痛；冰片透窍启闭，绞股蓝、陈醋养血活血。诸药合用，使寒凝散，血脉通，舒筋痛止。药症相符，方法简便易行，故临床用之，多获桴鼓之效。^[1]

2. 消痛方(杨素兰、潘小郑)

组成:全蝎6g,蜈蚣2条,羌活10g,当归10g,赤芍12g,秦艽10g,地龙10g,穿山甲6g,生姜10g,细辛5g,杜仲10g,桑寄生10g。

方解:方中蜈蚣、全蝎搜风通经,当归、赤芍、穿山甲破宿血生新血,使邪祛血充营卫调和,羌活、秦艽祛风湿止痹痛,善走上肢;生姜、细辛散温通,外散风寒,内行气血,活血通痹止痛;杜仲、桑寄生补益肝肾;地龙为入血通络之良品,专入血分而不伤气分,现代药理研究有抗凝血的作用,诸药合用,共奏其效。

加减:若肩部冷痛者,加制川、草乌各10g;痛如针刺者,加桃仁、红花各10g;痰湿较重者,加半夏、苍术各10g。^[2]

3. 乌头葛根汤(唐凯)

组成:制川乌5~15g(先煎20~30分钟),黄芪20g,葛根20g,麻黄8g,桂枝10g,芍药10g,川芎15g,熟地12g,鸡血藤20g,乳香10g,全蝎5g,土鳖5g,生姜6g,大枣6g,甘草5g。

方解:以经方乌头葛根汤加味治疗肩周炎,首选峻剂乌头汤散寒除湿,通阳除痹;葛根汤中葛根升津和营,濡润筋脉;麻黄、桂枝发表散寒,宣通卫阳;芍药、甘草和营血,柔筋止痛;姜枣益中焦,助胃气。二方合用,刚柔相济,动静结合,使正气充,寒气去,筋脉舒。加川芎、熟地、鸡血藤养血活血,乳香、全蝎、土鳖逐瘀通络,改善局部血液循环。诸药共奏温经养血,散寒除湿,和营濡筋,化瘀止痛之效。

加减：疼痛较剧者，加片姜黄、蜈蚣、蕲蛇；关节拘挛较重活动迟缓者，加枣皮 30g。^[3]

二、气血虚弱 络脉瘀阻

黄芪桂枝四物汤加减（宫钦爽、尹学花）

组成：生黄芪 30g，桂枝 18g，白芍 12g，当归 12g，川芎 6g，熟地 15g，党参 15g，鸡血藤 30g，片姜黄 12g，地龙 9g，大枣 9g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：益气养血，祛瘀通络。

主治：肩关节炎，证属气血虚弱，络脉瘀阻。症见左肩关节酸痛，左臂不能上举，后伸、外展时均感疼痛，左上肢时感麻木，夜间痛甚，端碗吃饭也感困难，不能参加农田劳动，舌质淡红，边有瘀血，脉虚细无力。

体会：

（1）气血虚弱，腠理空疏，复感外邪是形成肩凝症的主因：临床所见，有平素气血不足，劳累过度，汗出，腠理空疏，感受风寒所致者；有产后耗气伤血，卫气失和而受凉者，也有少数原因不明者，但以前两者最为多见。病程较长是本病证的特点，久痛入络，进一步耗气伤血，筋骨关节失养，不荣则痛。从发病的年龄上也说明了这一点。本组病例女性患者占其大半，是因男女生理上存在着差异。女子以血为本，经孕产乳易耗气伤血，形成气血虚弱，营卫失和机会较多，风寒湿邪乘虚而入，阻滞气血经络，留连筋骨关节而发为本病。《济生方》中“皆因体虚，腠理空疏，受风寒湿气而成痹”的论述就是好的概括。

（2）益气须温阳，久痹须活血：气血虚弱是本证共有的表现，受凉又是其最常见的诱因，故治疗须处处照顾到

气血不足。益气佐以温阳，可相得益彰，寒不得虚，就无从诱发。《素问·痹论》中说：“其入脏者死，其留连筋骨间者痛久，其留皮肤间者易已。”病邪久留筋骨关节之间，凝滞气血，故在益气养血的基础上，适当佐以活血通络之品，使凝滞得去，筋骨关节通利，则痹痛可止。

（3）调和营卫，以防复发：《痹论》中说：“逆其气则病，从其气则愈，不与风寒湿气合，故不为痹。”营卫的强弱和痹证的发生有着密切的关系，在气血虚弱的情况下，调和营卫更有必要，气血和平，营卫调畅，邪不内侵，则不易复发。^{〔4〕}

三、中阳不振，水停湿阻，络脉失养，寒湿浸淫

指迷茯苓丸加味（蒋仁发）

组成：茯苓 15g，白术 15g，姜半夏 10g，枳壳 10g，川乌 10g，地龙 10g，姜黄 10g，北细辛 6g，桑枝 12g，风化硝 5g（冲），生姜 8g。

用法：每日 1 剂，水煎服。

功效：健脾化痰，行气散结，活血舒筋。

主治：肩周炎，证属水停湿阻，络脉失养。症见臂酸胀疼痛，活动受限，形体肥胖，三角肌轻度萎缩，结节间沟部压痛明显，外展＜30 度，外旋＜15 度，肩有冷感，舌质淡薄，苔薄白，脉沉细而滑。

方解：脾胃者，水谷之海。脾气濡则宗筋润而关节滑利。若年老体衰，中阳不振，水湿停聚，脾气不达四肢，经脉失养，复感风寒之邪，滞留于肩胛、筋骨肌肉之间，壅塞经络，着而不去，则成是证。若论治法，历代医家多宗“痹”、“痿”而论之，鲜有从脾从痰论之者。《素问·至真要

大论》云：“必伏其所主，而先其所因。”经旨昭然。张景岳亦明训后学：“惟停积肠胃，而痰则无处不到，水谷不化而停为饮者，其病全由脾胃；……故治此者，当知所辨，而不可不按其本也。”指迷茯苓丸出自《全生指迷方》，为肺热咳嗽而设，清·喻昌《医门法律》引而裁之，用治脾虚痰阻，臂痛难举。药切病机，痰去气和，筋脉舒畅，故臂痛自除。^[5]

四、风寒袭络，血虚痹阻

当归四逆汤加味（刘康平）

组成：当归 15g，桂枝 15g，白芍 20g，细辛 6g，通草 6g，鸡血藤 30g，甘草 5g，大枣 6 枚。

用法：水煎服，每日 1 剂。

功效：温经散寒，调营通滞。

主治：肩周炎证属风寒袭表，血虚寒凝，症见肩关节活动逐渐受限，不能上举及外展、外旋，穿脱衣服均很困难，疼痛夜间尤甚，近日加重，舌质淡，苔薄白，脉沉弦。

方解：本病多有风寒侵袭，血虚寒凝，瘀阻经脉所致。方中当归性味甘温，生血、逐瘀、生新，桂枝通阳舒筋，二药相伍，温补散寒祛瘀；细辛温经散寒，白芍、大枣、甘草调营通滞，温通经脉，鸡血藤性温，补血通络。血虚血瘀，风寒痹证用之最宜。诸药相合，共奏养血散寒，祛瘀止痛之力。^[6]

五、营卫两虚，风湿痹着

调痹汤加味（康鼎尧）

组成：羌活 10g，姜黄 10g，当归 15g，炙黄芪 15g，

赤芍 12g, 防风 12g, 甘草 5g, 生姜 5 片, 大枣 3 枚。

用法: 水煎服, 每日 1 剂。

功效: 补气和营, 祛风除湿。

主治: 肩周炎, 风湿痹证。症见: 身体疼痛, 颈背拘急, 举动艰难, 手足麻痹, 肢体温, 时并伴有头晕, 纳差, 乏力, 舌质淡而有瘀点, 苔滑腻, 口不渴, 脉细涩, 指按无力。

按: 蠲痹汤属疏散外风之剂, 主治营卫两虚, 风寒湿邪乘虚而侵袭的痹痛症, 虚风内动者不宜, 肩周炎大多以营卫两虚为主要病机。《素问·调经论》云: “营虚则不仁, 卫虚则不用, 营卫俱虚则不仁不用。”故治宜和营卫, 行瘀滞, 通经络, 祛风湿。^[7]

(陶晓华 王 琦)

参 考 文 献

- [1] 阮孝廉, 黄秀真. 肩凝散治疗肩凝症 56 例. 四川中医, 1994, 12 (6): 34
- [2] 杨素兰, 潘小郑. 对肩周炎的认识和治疗. 河南中医杂志, 1998, 18 (3): 143
- [3] 唐凯. 乌头葛根汤治疗肩关节周围炎 40 例. 湖南中医杂志, 1992, 8 (6): 26
- [4] 宫钦爽, 尹学花. 黄芪桂枝四物汤治疗肩凝证 24 例临床体会. 黑龙江中医药, 1994, (3): 10~17
- [5] 蒋仁发. 化痰行气法治疗肩凝症 40 例. 湖南中医杂志, 1988, (2): 49
- [6] 刘康平. 当归四逆汤加味治疗肩关节周围炎. 四川中医, 1989, (2): 31
- [7] 康鼎尧. 蠲痹汤治疗肩周炎三例初探. 北京中医, 1987, (4):

颈椎病

一、风寒痹阻证

1. 蛇灵丸（刘玉梅、崔利中、王君、张月珍、高雪梅）

组成：白花蛇 4 条，威灵仙 72g，当归、土鳖虫、血竭、透骨草、防风、川芎各 36g，白芍、葛根各 60g，桂枝 40g。

用法：将以上药物放在烘干箱（60℃以下）内烘干，取出粉碎为细末，过 100 目筛，炼蜜为丸，每丸 6g。日 2 次，每次 1 丸，温水送服，1 个月为 1 疗程。

功效：温经散寒，活血化瘀，通络止痛。

主治：颈椎病（气滞血瘀型、风寒湿痹型、营卫不和型）。

方解：方中白花蛇有较强的祛风通络、胜湿除痹作用，能入骨，除顽痹，搜经络之风；威灵仙辛咸走散，性温通，能通行十二经，有散风祛湿、行气通络之效。同时尚有解痉止痛以除肌肉痉挛、软坚散结以消骨刺之功，对于顽痰久痹有特效，两药伍用，相得益彰。川芎能行血逐瘀，葛根为阳明经药，善走督脉，解肌和营，与川芎配伍，对颈椎-基底动脉供血不足所致的头晕、头痛有特效。桂枝、白芍相伍，调和营卫，解肌祛风，适用于颈椎病骨质增生压迫所致的肌体麻木；当归、白芍补血和血生血，滋养肝肾，

柔润筋脉。透骨草祛风寒，除湿痹。土鳖虫、血竭皆为活血破瘀之品，协同上药通经络，解挛急。^[1]

2. 颈安散（贾存恩）

组成：白芍 24g，伸筋草 90g，狗脊 90g，葛根 60g，红花 60g，炒乳香 60g，炒没药 60g，木瓜 60g，甘草 30g，桃仁 10g。

用法：共为细末，每服 6g，日 3 次，饭后服。一般治疗 2 个疗程。

功效：祛瘀通络，祛风散寒止痛。

主治：颈椎病。

方解：本方能改善周围神经的营养代谢，有利于消除慢性炎症。乳香、没药、红花、桃仁活血化瘀，改善局部的血液循环，有利炎症的消除；白芍、伸筋草、狗脊、木瓜、甘草、葛根能缓解疼痛，解除肌肉的痉挛，有良好的止痛作用，而利于关节运动，有利于骨赘的治疗，从而达到治疗目的。^[2]

3. 威芥汤（谭继雪、毛则先）

组成：威灵仙、桑枝、千年健、当归各 15g，葛根、金银花各 24g，羌活、防风、白芷、白芥子、制南星、红花、川芎各 10g，龙胆草 6g。

用法：日 1 剂，水煎服。10 天为 1 疗程，需服 2~4 个疗程。

功效：祛风通络，活血止痛。

主治：神经根型颈椎病。

方解：方中威灵仙、千年健、桑枝祛风湿、疏经络，健筋骨；羌活、防风、白芷祛风散寒；葛根生津舒筋；白

芥子祛痰，通络止痛；制南星化痰，祛风止痉；当归、川芎、红花养血活血；金银花、龙胆草清热通络；黄芪益气通阳；穿山甲走窜通络，缓急止痛。诸药协同而奏效佳。

加减：麻木者，加黄芪；冷痛者，去金银花、龙胆草，加制川乌；疼痛剧者，加姜黄、没药；掣痛者，加穿山甲；舌苔白腻者，加苡仁、白术；口干者，加生地、石斛；血虚者，加熟地、鸡血藤。^[3]

4. 芍葛汤（吴福财）

组成：白芍 30g，葛根、威灵仙各 20g，白芷、秦艽、当归各 12g，川芎 9g，细辛 3g。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：祛风解肌，活血止痛。

主治：颈椎病。

方解：方中葛根解肌散寒；威灵仙祛风散寒；白芍、白芷、细辛缓急通络止痛；秦艽祛风除湿；当归、川芎活血化瘀。

加减：偏风盛者，加防风、羌活；偏寒盛者，加桂枝、麻黄；偏湿盛者，加苡仁、苍术；巅顶痛者，加藁本；上肢麻木痛者，加桑枝；下肢麻木痛者，加牛膝、木瓜；肾虚腰痛者，加杜仲、枸杞、巴戟；背痛者，加狗脊、淫羊藿；气虚血滞者，加黄芪、党参、丹参。^[4]

5. 颈椎方（鲁永新）

组成：葛根 30g，当归、路路通各 15g，黄芪 15g，全虫 9g，蜈蚣 2 条，山甲珠 10g，鹿衔草 20g，寻骨风 15g，桂枝 9g，甘草 8g。

用法：日 1 剂，水煎服。

功效：祛风散寒除湿，通经活血化瘀。

主治：颈椎病。

方解：方中葛根解肌止痛；黄芪、当归益气活血；路路通、全虫、蜈蚣、山甲珠、鹿衔草、寻骨风、桂枝通络止痛；甘草调和诸药。

加减：伴上肢麻木疼痛较重者，加桑枝 30g，姜黄 12g；眩晕较重者，加川芎 12g，天麻 15g。^[5]

6. 麻醉止痛酊（尚锁绸、张孟屯）

组成：生川乌 15g，生草乌 15g，生半夏 15g，生南星 15g，细辛 10g，草拔 10g，黑胡椒 10g，生乳没各 10g，白芷 10g，透骨草 50g。

制法：共研细末，加樟脑 10g，95%酒精 500ml，装瓶密闭，经常摇动，使其充分溶解，1 周后过滤备用。

用法：用棉签蘸取过滤液涂搽患部，使局部皮肤发红为止，涂药后用手法整复按摩，每日 2 次，10 天为 1 个疗程。皮肤有创伤或溃疡者忌用。

主治：颈椎病（神经根型）。^[6]

7. 中药离子导入方（刘献忠）

组成：川乌、威灵仙、蒲公英、赤芍、乳香、没药、鸡血藤、桑寄生各 20g，川芎、玄胡、姜黄、独活、葛根各 15g。

用法：上药水煎两次，滤药液约 500ml，选用北京无线电仪器厂生产的 DZY-1 型骨质增生治疗仪治疗，将中药垫泡在上述药液中加温，大约吸收 200ml 左右的药，再将药垫放在颈椎部位，依次放上衬垫和阳极电极板，盖上橡皮布，酌情固定，阴极电极板放在患肢的外关穴或曲池

穴处,电流量从小开始因人而调节,一般在8~10mA左右,有针刺感即可,治疗时间每日1次,每次25分钟,10次为1疗程。每疗程间歇3~5天。

主治:颈椎病(神经根型)。^[7]

二、气滞血瘀证

1. 葛根二藤汤(高飞、王明喜、曹贻训)

组成:葛根15g,钩藤15g,鸡血藤15g,当归15g,川芎9g,黄芪15g,桑寄生15g,姜黄9g,白芍12g,白芥子9g,地龙9g,牛膝9g,桂枝9g,丹参15g,全蝎9g,蜈蚣2条,土鳖虫9g,木香9g,甘草6g。

用法:日1剂,煎取药液400ml,分2次于饭后1~1.5小时温服,15剂为1个疗程,服药期间毋须牵引或外敷药物等治疗方法。

功效:活血化瘀,通络止痛。

主治:各型颈椎病。

方解:方中以葛根、钩藤、鸡血藤解痉止痛,以全蝎、蜈蚣、土鳖虫、地龙等虫类搜剔之品逐瘀通络,以当归、川芎、丹参等活血化瘀,以桑寄生、姜黄、桂枝通经祛邪治其标;以鹿角胶、补骨脂、牛膝等补养精血培其本;巧用白芥子以祛经络之痰,通络止痛,化瘀散结,从而增强了该方祛经络之瘀的功效。

加减:椎动脉型与交感型患者,加鹿角胶15g,骨碎补9g。^[8]

2. 葛根桃红汤(刘广合,毛秉环)

组成:葛根30g,黄芪、丹参、白芍各15g,制首乌、

全狗脊各 12g, 桃仁、红花、川芎、羌活、威灵仙、地龙各 10g。

用法: 日 1 剂, 煎水 400ml, 分早晚 2 次服。每 10 天为 1 疗程, 服药 2~3 个疗程, 评定疗效。

功效: 益气活血, 除痹止痛。

主治: 颈椎病。

方解: 方中葛根解肌治项背强痛, 舒筋解痉以利关节; 金狗脊、制首乌、白芍补肝肾、强筋骨、柔肝止痛; 黄芪补气, 气旺则血行; 桃仁、红花、丹参、川芎活血化瘀; 羌活、威灵仙祛风除湿散寒; 地龙通经活络止痛。诸药配伍, 共奏补肝肾、强筋骨、益气活血、除痹止痛之功。

加减: 眩晕明显者, 加天麻 10g; 恶心呕吐者, 加姜半夏 10g; 肩臂麻木甚者, 加桑枝 15g; 气虚明显者, 黄芪增至 30g。^[9]

3. 除痹逐瘀汤 (吕同杰)

组成: 当归 15g, 川芎 12g, 红花 9g, 刘寄奴 15g, 姜黄 12g, 路路通 30g, 羌活 9g, 白芷 12g, 灵仙 12g, 桑枝 30g, 胆南星 9g, 白芥子 9g。

用法: 水煎服, 每日 1 剂, 服 6 剂停药 1 天, 12 天为 1 疗程。

功效: 活血化瘀, 行气通络, 除湿涤痰。

主治: 颈椎病。

方解: 本方共分三组药物, 第一组活血化瘀药: 当归甘补辛散, 苦泄温通, 既能补血又能活血, 有推陈致新之功; 川芎辛温香窜, 能上行巅顶, 下达血海, 旁通四肢, 外至皮毛, 为活血行气之良药; 姜黄辛苦而温, 外散风寒, 内行气血, 有活血通经、行气止痛、去风疗痹之效, 以其

辛散横行，对上肢之疼痛尤为专长；红花辛散，通经活血，去瘀止疼；刘寄奴破血通经，消瘀止痛，为破血行痹之要药；路路通既能行气又能通络，与刘寄奴相伍有通行十二经，驱除经络瘀滞之效。第二组去风湿通络药：羌活气味雄烈，散风之力胜于防风，长于去风除湿，又可通利关节而止痛；白芷气味芳香，偏重于止痛开窍；灵仙辛散善走，能通十二经，既可去在表之风，又可化在里之湿，通经达络可导可宣，为治痹证之要药，对筋骨酸痛肌肉麻痹，皆有一定的作用；桑枝苦平，善于去风湿通经络，达四肢利关节，对风湿痹痛、四肢麻木拘挛皆有良好的效果。第三组药物燥湿理痰：南星苦温辛烈，走窜燥湿作用很强，对中风痰壅眩晕或风痰引起的麻痹、口眼喎斜，破伤风引起的项强口噤，皆有一定的作用；白芥子辛温气锐，性善走散，能搜剔胸膈经络之痰，风痰阻滞或痰留经络肢体疼痛之症皆可取效。

加减：气虚体弱手麻明显者，加黄芪 30g；项背强急者，加葛根 24g；热郁经络者，加忍冬藤 30g；湿热内蕴，心烦口苦者，加黄芩 9g，或栀子 9g、胆草 4.5g。^[10]

三、痰瘀交阻证

痰瘀膏（阎明华、朱雅琴）

组成：生半夏、生南星、皂角刺各 30g，生大黄、生乳香、生没药各 15g，片姜黄 20g，制马钱子、樟脑各 10g。

用法：上药共为细末，加凡士林适量调成软膏。治疗时将药膏摊于敷料上，外敷于颈部患处，48 小时更换 1 次，10 次为 1 疗程。

功效：祛痰散结，化瘀定痛，通络透达。

主治：老年神经根型颈椎病。

方解：方中以生半夏、生南星、皂角刺燥湿祛痰，消肿散结；生大黄、片姜黄、赤芍、乳香、没药活血化瘀，通络止痛；加马钱子更增消肿散结，活络定痛之力；樟脑辛香走窜，迅速渗透于皮下，引导诸药发挥作用。凡士林为基质的药物软膏可提高皮肤的水合作用，使角质层膨胀为多孔状态，更有利于有效成分释放、渗透、吸收。痰瘀膏集祛痰散结、化瘀定痛、通络透达之药于一方，又外敷于患部，使药力直达病所，改善局部的血液循环，消除患处组织及神经根的炎症水肿；解除对神经根的压迫与刺激，从而使该病证得以迅速康复。^[11]

四、肝肾不足证

1. 山茱萸汤（周秋兰）

组成：山茱萸 45g，天麻 10g，党参 20g，白芍 30g，威灵仙 10g，桂枝 10g，法夏 10g，川芎 10g，鸡血藤 30g，葛根 20g，甘草 12g。

用法：日 1 剂，每次 150ml，分 2 次服。7 天为 1 疗程，一般可服用 2 个疗程，6 个月后统计疗效。

功效：补益肝肾，活血通络。

主治：椎动脉型颈椎病。

方解：方中山茱萸、天麻滋肝肾，熄风镇眩；党参、白芍益气养血；威灵仙、桂枝祛风散寒，胜湿除痹；法夏化浊除痰；川芎、鸡血藤活血化瘀，通络止痛；甘草调和诸药，且有缓急止痛之能；葛根气质轻扬，能载药上行，直达病所。现代药理研究表明葛根中的黄酮有扩张血管，增加脑血流量的作用，川芎有扩张血管，解痉挛，改善微

循环的功效。^[12]

2. 鹿地补髓丹（朱士伏）

组成：鹿角片、熟地、桑椹子、龟甲、枸杞子、生黄芪、骨碎补、炒白芍、当归各 300g，威灵仙、羌活、独活、杜仲、补骨脂、川桂枝、红花、蜈蚣、木瓜、秦艽、蘘本、川芎、葛根、全毛狗脊、草乌头各 100g，蚕蛹 1 000g。

用法：上方晒干或烘干，共研细末，过 60 目筛，以猪脊髓 500g，蒸熟后捣烂，加入适量蜂蜜为丸，如黄豆大，淡盐汤送服。日 3 次，10~20g/次。饭后服用。1 个月为 1 疗程，一般服用 3~6 个月。

功效：滋肾强筋，填精益髓，活血化瘀，通络散寒。

主治：颈椎病。

方解：方中重用鹿角片补肾填髓，活血通督，配熟地、猪脊髓、蚕蛹阴阳双补，当归、川芎、白芍、黄芪调和营卫，补气生血，使骨正筋柔，气血和调。再加葛根、红花、威灵仙等活血化瘀，乌头、秦艽、木瓜、狗脊祛风散寒，化湿通络。全方标本兼顾，使肝肾强健，气血冲和，其痛自己。^[13]

3. 寄生当归汤（杨和民）

组成：寄生 15g，当归 15g，川断 10g，枸杞子 20g，山茱萸 10g，川芎 10g，丹参 15g，三七 6g，桃仁 6g，白菊花 10g，法夏 15g，生姜 10g。

用法：每日 1 剂，日服 2 次，10 天为 1 疗程。

功效：补益肾精，活血通脉。

主治：椎动脉型颈椎病。

方解：方中川断、寄生、枸杞子、山萸肉滋补肝肾、填精补血；丹参、川芎、桃仁、三七、当归活血通脉；枸杞子、菊花益精明目；半夏、生姜和胃降逆。全方共奏补肾益精，活血通脉之功，治疗本病收到较好疗效。

加减：伴口渴者，加沙参 15g，麦冬 15g；伴肢冷者，加附子 10g，干姜 6g；伴口苦、尿赤者，加知母 10g，黄柏 10g。^[14]

4. 蚂蚁风湿消（李汉俊）

组成：蚂蚁 110g，全蝎、蜈蚣、白花蛇各 10g，僵蚕、炮山甲、露蜂房、地龙、土鳖虫、乌梢蛇各 15g。

用法：上药加工为细末，装入胶囊（每粒 0.5g），4 粒/次，日 3 次。1 个月为 1 疗程。

功效：补肾益精，活血化瘀。

主治：颈椎病。

方解：蚂蚁具有补益肾精、养肝荣筋、活血行瘀的作用，对该病具有治病求本作用，能从根本上改善颈椎退行性病变发生的内在因素，故本方重用蚂蚁为君药。现代医学研究证明：该药含有多种游离氨基酸、微量元素、矿物质、维生素、酶类，并促进性腺发育，对机体免疫呈双向调节作用，是一种有效的免疫抗衰老剂，并且具有抗炎、镇痛、镇静、解痉、抗风湿、抗肿瘤、护肝等作用。本方佐以全蝎、蜈蚣、土鳖虫、乌梢蛇、僵蚕、炮山甲、地龙、蜂房、白花蛇助其疏经活血，搜风剔络。部分具有毒性药物用量宜小。^[15]

5. 壮颈汤（周胜利、周招花、潘子毅等）

组成：炙黄芪 45g，当归 25g，生地 25g，熟地 25g，

赤芍 15g, 白芍 15g, 川芎 9g, 丹参 30g, 牛膝 15g, 续断 10g, 桑寄生 30g, 羌活 9g, 桑枝 9g, 防风 9g, 地龙 9g, 炮山甲 9g (先煎)。

主治: 椎动脉型颈椎病。^[16]

(陶晓华 张 林 贾鹰珏)

参 考 文 献

- [1] 刘玉梅, 崔利中, 王君, 等. 蛇灵丸治疗颈椎病 40 例. 山东中医杂志, 1997, 16 (8): 349
- [2] 贾存恩. 颈安散治疗颈椎病 100 例观察. 内蒙古中医药, 1997, (3): 7
- [3] 谭继雪, 毛则先. 威芥汤治疗神经根型颈椎病 70 例. 新疆中医药, 1997, 15 (2): 13
- [4] 吴福财. 芍葛汤治疗颈椎病 12 例. 福建中医药, 1986, 17 (1): 23
- [5] 鲁永新. 颈椎方治疗颈椎病 60 例. 湖北中医杂志, 1988, (2): 55~56
- [6] 尚锁卿, 张孟屯. 麻醉止痛酊治疗神经根型颈椎病 50 例疗效观察. 中医正骨, 1997, (3): 44
- [7] 刘献忠. 中药离子导入治疗神经根型颈椎病 91 例. 实用中西医结合杂志, 1997, 10 (13): 1277
- [8] 高飞, 王明喜, 曹贻训. 葛根二藤汤治疗颈椎病疗效观察. 中医正骨, 1997, 9 (3): 43
- [9] 刘广合, 毛秉环. 自拟葛根桃红汤治疗颈椎病 52 例. 黑龙江中医药, 1997, (2): 35
- [10] 吕同杰. 除痹止痛汤. 实用中西医结合杂志, 1991, 4 (11): 692
- [11] 阎明华, 朱雅琴. 痰瘀膏治疗老年神经根型颈椎病 68 例. 新中医, 1997, 29 (9): 59
- [12] 周秋兰. 山茱萸汤治疗颈椎病 (椎动脉型) 110 例. 内蒙古中

医药, 1997, (3): 16

[13] 朱士伏. 鹿地补髓丹治疗颈椎病 60 例. 浙江中医杂志, 1997, (4): 158

[14] 杨和民. 寄生当归汤治疗椎动脉型颈椎病 89 例. 江苏中医, 1997, (5): 18

[15] 李汉俊. 蚂蚁风湿消治疗颈椎病 63 例. 陕西中医, 1997, 18 (5): 202

[16] 周胜利, 周招花, 潘子毅, 等. 自拟壮颈汤配合牵引和激光照射治疗椎动脉型颈椎病. 中医正骨, 1997, 9 (3): 31~32

雷诺综合征

一、气滞血瘀型

1. 柔肝解痉汤（曹忠、门理章）

组成：生白芍 30g，钩藤 30g，炙甘草 9g，柴胡 9g，木瓜 9g，僵蚕 9g，全蝎 6g。

用法：水煎服，每日 1 剂。

功效：柔肝解痉，活血化痰，通痹止痛。

主治：肝郁血瘀型雷诺病。

方解：方中生白芍、钩藤为主，二药入肝经，芍药和肝血，养肝阴，柔肝解痉，钩藤疏肝风，调肝气，解痉止痛；柴胡、木瓜疏肝解郁，舒筋活络，与大量芍药配伍刚柔相济，动静结合；僵蚕、全蝎缓急相得，祛风邪，缓拘挛以定痛；甘草调和诸药，延药效。七味主辅相和，标本同治，共起濡润筋脉，通经活络，解痉止痛的作用。

加减：阳虚寒凝型：以肢端逆冷，麻木为主，遇冷则疼痛加重，指（趾）发白，进而变轻，遇热缓解，疼痛渐轻，指（趾）由青转暗红，病久指（趾）皮肤变硬，皮下空虚，甚者破溃。此乃阳气虚损，寒凝经脉，使血行不畅。阳虚不能温和，寒滞不能通运，气血不能营养四末。治以兴阳散寒，活血通脉，解郁止痛。方以柔肝解痉汤加当归、

桂枝、附子、鸡血藤、党参、通草、细辛、大枣。气虚血瘀型：患指(趾)青紫或苍白，常冷麻、胀痛，困倦乏力，遇劳诸症加重。此谓气血虚弱，气滞血瘀，使气血不能达于四末温养四肢，治以益气通脉，和肝活血。方以柔肝解痉汤加当归、川芎、桃仁、红花、黄芪、党参、地龙、鸡血藤、桂枝。肝郁气滞型：患者四肢多冷、麻、胀、痛，情绪不遂或激动时，疼痛加甚。女子常伴有月经不调或痛经。此型乃情志所伤，肝气不舒，气机不利，致血行不畅。治宜疏肝、行气、活血。方以柔肝解痉汤加枳实、陈皮、香附、当归、姜黄、鸡血藤。^[1]

2. 加味当归四逆汤(徐玉健)

组成：全当归、炙黄芪、炙桂枝、制川乌、丹参、桃仁、红花、炙地龙各 10g，细辛 5g，木通 8g，炙甘草 5g，大枣 8 枚。

用法：每日 1 剂，水煎服。^[2]

二、阳虚寒盛

1. 活络祛寒汤(游开泓)

组成：黄芪 15g，当归 10g，丹参 12g，桂枝 9g，白芍 15g，乳香，没药各 6g，生姜 3g。

用法：每日 1 剂，水煎 2 次分服，服药 15 剂判定疗效。

功效：温经散寒，活血通脉。

主治：寒凝经络之雷诺病。

方解：桂枝、生姜散寒通阳；白芍敛阴和营，桂、芍二者合用能调营卫，和阴阳；加黄芪补气固表，当归、丹

参养血活血；乳香、没药祛瘀通络。诸药合用，共奏活络祛寒，调和气血之功，使寒邪除，经络通，营卫和则手足厥冷、苍白、紫绀之症自愈。

加减：寒甚加细辛、吴茱萸；瘀重加红花、王不留行；血热加生地、丹皮；气滞者加香附、乌药。^[3]

2. 加味阳和汤（张秀玲）

组成：每 100ml 阳和汤含：熟地 30g，麻黄、白芥子各 6g，鹿角胶、干姜、熟附子、肉桂各 9g，黄芪、鸡血藤各 30g，川芎 15g，甘草 6g。

用法：每日服 2 次，每次 50ml，连服 1 个月为 1 疗程。

功效：益气活血，温阳通络。

主治：气虚寒凝型雷诺病。症见发作性手指苍白、紫绀，手凉、手麻、手胀、手无力，指关节痛，畏寒。寒冷、情绪改变及经期常为诱发因素。^[4]

3. 加味活络祛寒汤（徐斯科、刘胜美）

组成：生黄芪 20g，当归、丹参各 15g，白芍 12g，桂枝、生乳香、生没药各 10g，炮附片、生姜各 10g，鸡血藤 20g，炙甘草 6g。

用法：水煎服，日 1 剂。

功效：温经散寒，活血通络。

主治：素体虚弱，外感寒邪，客于经络致经络不通，瘀血阻滞之雷诺病。

方解：用黄芪之温补为君药；佐以当归、丹参、白芍活血补血，俾其形体健，自能胜邪；再伍以温阳行气通络药味，不但能祛寒，且能散风。此所谓：“血行风自灭也”。盖风寒去则血脉通，肢端小动脉痉挛亦自解矣。^[5]

4. 温经通络汤 (孟祥全)

组成: 熟附子(先煎) 15g, 当归 20g, 桂枝 25g, 威灵仙 30g, 鸡血藤 25g, 丹参 20g, 干姜 15g, 黄芪 20g, 细辛 5g, 肉桂(后下) 15g, 白芍 10g。

用法: 每日 1 剂, 早晚分服。

功效: 温经通络。

主治: 寒邪凝滞经络之雷诺病。

加减: 针刺样疼痛者, 加王不留行 20g, 乳香、没药各 15g; 痒痛者, 加川芎 15g, 防风 15g; 肢端冷而麻木者, 加红花 10g, 乌梢蛇 20g。^[6]

(陶晓华 邬洪波)

参考文献

- [1] 曹忠, 门理章. 柔肝解痉汤为主辨治雷诺氏病. 中医药学报, 1994, (2): 30
- [2] 徐玉健. 加味当归四逆汤治疗雷诺氏病 20 例. 江苏中医, 1992, (10): 16~17
- [3] 游开泓. 活络祛寒汤治疗雷诺氏病十二例. 辽宁中医杂志, 1988, (10): 14
- [4] 张秀玲. 阳和汤治疗雷诺氏综合征疗效观察. 山东医药, 1994, (2): 57
- [5] 徐斯科, 刘胜美. 加味活络祛寒汤治疗雷诺氏病 15 例. 湖南中医杂志, 1993, (1): 29, 52
- [6] 孟祥全. 自拟温经通络汤治疗雷诺氏病 10 例. 北京中医, 1992, (4): 62